

PCI Guide Wire SION series

SYMBOLS	1
English [EN]	4
Dansk [DA]	7
Nederlands [NL]	10
Suomi [FI]	14
Français [FR]	17
Deutsch [DE]	20
Ελληνικά [EL]	24
Magyar [HU]	28
Italiano [IT]	31
Polski [PL]	35
Português [PT]	39
Español [ES]	42
Svenska [SV]	46
Česky [CS]	49
Norsk [NO]	52
Slovenský [SK]	55
Eesti keel [ET]	58
Latviešu [LV]	61
Lietuvių kalba [LT]	64
Türkçe [TR]	67
Русский [RU]	70
Български [BG]	74
Hrvatski [HR]	78
Română [RO]	81
Slovenščina [SL]	85
Malti [MT]	88

SYMBOLS

English	Dansk	Nederlands	Suomi	Français	Deutsch	Ελληνικά	Magyar	Italiano
 Legal manufacturer	Autoriseret producent	Wettelijke fabrikant	Laillinen valmistaja	Fabricant légal	Juristischer Hersteller	Νόμιμος κατασκευαστής	Hivatalos gyártó	Produttore legale
 Do not use if package is damaged	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Nicht verwenden, falls Packung beschädigt ist	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	Ne alkalmazza az eszközt, ha a csomagolás sérült.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
 Do not reuse	Må ikke genbruges	Niet opnieuw gebruiken	Älä käyttää uudelleen	Ne pas réutiliser	Nicht wiederverwenden	Μην επαναχρησιμοποιήσετε	Ne használja újból.	Non riutilizzare
 Do not resterilize	Må ikke resteriliseres	Niet opnieuw steriliseren	Älä steriloï uudelleen	Ne pas restériliser	Nicht erneut sterilisieren	Μην επανααστεριώσετε	Ne fertőtlenítse újbóli használatához.	Non risterilizzare
 Caution, consult accompanying documents	Forsigtig, se de medfølgende dokumenter	Let op, zie bijgevoegde documentatie	Varoituu, katso mukana toimitetut asiakirjat	Avertissement, consulter la documentation d'accompagnement	Vorsicht, beiliegende Dokumente beachten	Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα	Figyelem, olvassa el a mellékelt dokumentumokat	Attenzione, consultare la documentazione di accompagnamento
 Use by	Anvendes inden	Uiterste gebruiksdatum	Viimeinen käyttöpäivä	Expiration	Verwenden bis	Χρήση από	Lejárat	Utilizzare entro
 Keep dry	Opbevars tørt	Droog bewaren	Pidä kuivana	À conserver au sec	Vor Nässe schützen	Διατηρήστε το στεγνό	Száras helyen tárolja	Conservare in luogo asciutto
 Keep away from sunlight	Undgå direkte sol	Niet aan zonlicht blootstellen	Pidä poissa auringonvalosta	À conserver à l'abri de la lumière	Vor Sonneneinstrahlung schützen	Κρατήστε το μακριά από το φως του ήλιου	Tartsa távol napfénytől	Tenere lontano dai raggi solari
 Authorized Representative in the European Union	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union	Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie	Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa	Représentant habilité dans l'Union européenne	Bevollmächtigter in der Europäischen Union	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
 LOT number	Lotnummer	Partijnummer	Eränumero	Numéro de LOT	Losnummer	Αριθμός παρτίδας	Helyrajzi szám	Numero di LOTTO
 Catalogue number	Katalognummer	Catalogusnummer	Tuotenumero	Numéro de référence	Katalognummer	Αριθμός καταλόγου	Katalógusszám	Numero di catalogo
 Sterilized using ethylene oxide	Steriliseret med ethylenoxid	Gesteriliseerd met ethylenoxide	Steriloitu etyleenioksidilla	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Αποστειρώνεται με χρήση οξείδιου του αιθυλενίου	Etilén-oxiddal fertőtlenítve	Sterilizzato mediante ossido di etilene
 Unit	Produkt	Eenheid	Määrä	Unité	Einheit	Μονάδα	Egység	Unità
 Consult instructions for use or consult electronic instructions for use	Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning	Zie de (elektronische) gebruiksaanwijzing	Katso käyttöohjeet tai sähköiset käyttöohjeet	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi en format électronique	Bitte die beiliegende Gebrauchsanweisung oder die elektronische Gebrauchsanweisung lesen	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης.	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót	Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche
 Straight	Lige	Recht	Suora	Droit	Gerade	Ίσιο	Egyenes	Dritto
 J-shaped	J-formet	J-vorm	J:n muotoinen	En forme de J	J-förmig	Αγκιστροειδές	J-alakú	Sagomato a J
 J-shaped	J-formet	J-vorm	J:n muotoinen	En forme de J	J-förmig	Αγκιστροειδές	J-alakú	Sagomato a J
 Pre-shaped	Præformet	Voorgevormd	Valmiiksi muotoiltu	Préformé	Vorgeformt	Προδιαμορφωμένο	Előre kialakított	Presagomato
 Pre-shaped	Præformet	Voorgevormd	Valmiiksi muotoiltu	Préformé	Vorgeformt	Προδιαμορφωμένο	Előre kialakított	Presagomato
 Medical device	Medicinsk udstyr	Medisch instrument	Lääkinnällinen laite	Dispositif médical	Medizingerät	Ιατρική συσκευή	Orvostechikai eszköz	Dispositivo medico
 Single sterile barrier system	Enkelt steril barriersystem	Enkelvoudig steriel barriersysteem	Yksinkertainen steriili estejärjestelmä	Système de barrière stérile unique	Individuelles Sterilbarriersystem	Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού	Egyszeres steril gátrendszer	Sistema a barriera sterile singola
 Contains hazardous substances	Indeholder farlige stoffer	Bevat gevaarlijke stoffen	Sisältää haitallisia aineita	Contient des substances dangereuses	Enthält gefährliche Inhaltstoffe	Περιέχει επικίνδυνες ουσίες	Veszélyes anyagot tartalmaz	Contiene sostanze pericolose
 Importer	Importør	Importeur	Maahantuoja	Importateur	Importeur	Εισαγωγέας	Importőr	Importatore

	Polski	Português	Español	Svenska	Česky	Norsk	Slovenský	Eesti keel	Latviešu
	Legalny producent	Fabricante legal	Fabricante legal	Juridisk tillverkare	Výrobce	Produsent	Legálny výrobca	Juridiline tootja	Likumīgs ražotājs
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	No lo utilice si el envase está dañado	Använd inte om förpackningen är skadad	V případě, že je obal poškozený, výrobek nepoužívejte	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Nepoužívajte, ak je poškodený obal.	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud	Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts
	Nie używać ponownie	Não reutilizar	No lo reutilice	Får inte återanvändas	Nepoužívejte opakovaně	Må ikke gjenbrukes	Nepoužívajte opakovane.	Mitte korduvalt kasutada	Nelietojiet atkārtoti
	Nie sterylizować ponownie	Não reesterilizar	No lo reesterilice	Får inte omsteriliseras	Nesterilizujte opakovaně	Må ikke resteriliseres	Znovu nesterilizujte.	Mitte uuesti steriliseerida	Nesterilizējiet atkārtoti
	Uwaga, zapoznać się z dołączonymi dokumentami	Cuidado, consulte os documentos anexos	Precaución, consulte los documentos que se incluyen	Varning, läs medföljande dokument	Upozornění – přečtěte si průvodní dokumentaci	Forsiktig, se vedlagte dokumenter	Upozornenie, pozrite si sprievodné dokumenty.	Ettevaatus! Lugege seadmega kaasasolevaid juhendeid.	Ievērojiet piesardzību, skatiet komplektācijā iekļauto dokumentāciju
	Data ważności	Utilizar até	Fecha de caducidad	Använd före	Spotřebujte do	Brukes innen	Dátum expirácie	Aegumiskuupäev	Izmantot līdz
	Chronić przed wilgocią	Manter seco	Manténgalo seco	Förvaras torrt	Uchovávejte v suchu	Må oppbevares tørt	Udržiavajte v suchu.	Hoida kuivas	Uzturiet sausu
	Chronić przed światłem słonecznym	Manter distante da luz do sol	Manténgalo alejado de la luz del sol	Håll undan från solljus	Chraňte před slunečním světlem	Må ikke oppbevares i sollys	Nevystavujte slnečnému svetlu.	Hoida eemal päikesevalgusest	Sargāt no saules gaismas
	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej	Representante autorizado na União Europeia	Representante autorizado en la Unión Europea	Auktoriserad representant i EU	Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii	Autorisert representant i EU	Autorizovaný zástupca v Európskej únii	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā
	Numer partii	Número de LOTE	Número del lote	LOT-nummer	Číslo šarže	Parti/Batchnummer	Číslo šarže	Partii number	Partijas numurs
	Numer katalogowy	Número de catálogo	Número del catálogo	Katalognummer	Katalogové číslo	Katalognummer	Katalógové číslo	Kataloogi number	Kataloga numurs
	Sterylny z tylenkiem etylenu	Esterilizado com óxido de etileno	Esterilizado con óxido de etileno	Steriliserad med etylenoxid	Sterilizováno pomocí ethylenoxidu	Sterilisert med etylenoksid	Sterilizované pomocou etylénoksidu.	Steriliseeritud etüleenoksiidiga	Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu
	Jednostka	Unidade	Unidad	Enhet	Jednotka	Enhet	Jednotka	Üksus	Vienība
	Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub z elektroniczną instrukcją użytkowania	Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrônicas	Consulte las instrucciones de uso en papel o en formato electrónico.	Se bruksanvisningen eller elektronisk bruksanvisning	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití	Se bruksanvisningen eller se elektroniske instruksjoner for bruk	Prečítajte si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie	Lugege kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit	Skatiet lietošanas norādījumus vai elektroniskos lietošanas norādījumus
	Prosty	Reto	Recto	Rak	Rovný	Rett	Rovný	Sirge	Taisns
	W kształcie litery J	Em forma de J	En forma de J	J-formad	Ve tvaru J	J-formet	V tvare J	J-kujuline	J-veida
	W kształcie litery Z	Em forma de Z	En forma de Z	J-formad	Ve tvaru Z	J-formet	V tvare Z	J-kujuline	Z-veida
	Wstępnie formowany	Pré-moldado	Preconformado	Förhandsformad	Tvarovaný	Forhåndsformet	Predvarovaný	Eelvormitud	Iepriekš izveidota forma
	Wstępnie formowany	Pré-moldado	Preconformado	Förhandsformad	Tvarovaný	Forhåndsformet	Predvarovaný	Eelvormitud	Iepriekš izveidota forma
	Wyrób medyczny	Dispositivo médico	Dispositivo médico	Medicinteknisk produkt	Zdravotnický prostředek	Medisinsk enhet	Zdravotnícka pomôcka	Meditsiiniisade	Medicīnas ierīce
	System pojedynczej sterylnej bariery	Sistema de barreira estéril único	Sistema de barrera estéril único	Enkelt steril barriärsystem	Jednoduchý sterilní bariérový systém	Enkelt sterilt barriersystem	Systém jednej sterilnej bariéry	Ühekordne steriilse barjääri süsteem	Vienas sterīlās barjeras sistēma
	Zawiera substancje niebezpieczne	Contém substâncias perigosas	Contiene sustancias peligrosas	Innehåller farliga ämnen	Obsahuje nebezpečné látky	Inneholder farlige stoffer	Obsahuje nebezpečné látky	Sisaldab ohtlikke aineid	Satur bīstamas vielas
	Importer	Importador	Importador	Importör	Dovozce	Importør	Dovozca	Importija	Importētājs

	Lietuvių kalba	Türkçe	Русский	Български	Hrvatski	Română	Slovenščina	Malti
	Teisėtas gamintojas	Yasal üretici	Официальный производитель	Легален производител	Proizvodač	Producător legal	Legalni proizvajalec	Manifattur legali
	Jeigu pažeista pakuotė, naudoti negalima	Ambalajı hasar görmüşse ürünü kullanmayın	Не использовать, если упаковка повреждена	Не използвайте, ако опаковката е повредена	Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno	A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana	Tużax jekk hemm ħsara fil-pakkett
	Nenaudoti pakartotinai	Tekrar kullanmayın	Повторное использование запрещено	Да не се използва повторно	Nemojte ponovno koristiti	A nu se refolosi	Ne uporabljajte ponovno	Tużax iktar minn darba
	Nesterilizuoti pakartotinai	Tekrar sterilize etmeyin	Повторная стерилизация запрещена	Да не се стерилизира повторно	Nemojte ponovo sterilizirati	A nu se resteriliza	Ne sterilizirajte ponovno	Tisterilizax mill-ġdid
	Dėmesio, žr. kartu pateikiamus dokumentus	Dikkat, birlikte gelen belgelere bakın	Внимание! См. сопроводительные документы	Внимание, консултирайте се с придружаващите документи	Oprez, pogledati prateće dokumente	Atenție, a se consulta documentele de însoțire	Pozor, glejte spremne dokumente	Attenzjoni, ikkonsulta d-dokumenti ta' akkumpanjament
	Tinka iki	Son kullanma tarihi	Срок годности	Използвайте до	Upotrijebiti do	A se utiliza de către	Uporabno do	Uża sa
	Laikyti sausai	Kuru tutun	Не допускать попадания влаги	Пазете сухо	Čuvati na suhom	A se păstra uscat	Hraniti na suhem	Żomm niexef
	Saugoti nuo saulės šviesos	Güneş ışığından uzak tutun	Не допускать попадания солнечного света	Пазете от слънчева светлина	Čuvati dalje od sunčevog svjetla	A se păstra departe de lumina soarelui	Hranite stran od sončne svetlobe	Żomm 'il boghod mid-dawl tax-xemx
	Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje	Avrupa Birliği'nde Yetkili Temsilci	Уполномоченный представитель в Европейском союзе	Овлаштен представител в Европейския съюз	Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană	Poodlaščen zastopnik v Evropski uniji	Rappreżentant Awtorizzat fl-Unjoni Ewropea
	Serijos numeris	LOT numarası	Номер партии	Партиден номер	LOT broj	Număr LOT	LOT številka	Numru tal-LOTT
	Katalogo numeris	Katalog numarası	Номер по каталогу	Каталожен номер	Kataloški broj	Număr de catalog	Kataloška številka	Numru tal-katalogu
	Sterilizuota etileno oksidu	Etilen oksitle sterilize edilmiştir	Стерилизовано этиленоксидом	Стерилизиран чрез этиленов оксид	Sterilizirano etilen oksidom	S-a sterilizat folosind oxid de etilenă	Sterilizirano z etilen oksidom	Sterilizat bl-ossidu tal-etilen
	Elementas	Birim	Упаковка	Изделие	Jedinica pakiranja	Unitate	Enota	Unità
	Žr. naudojimo instrukciją arba elektroninę naudojimo instrukciją	Kullanım talimatlarına bakın veya elektronik kullanım talimatlarına bakın	Ознакомьтесь с инструкцией по применению или ознакомьтесь с электронной инструкцией по применению	Консултирайте се с инструкциите за употреба или вижте електронните инструкции за употреба	Pogledajte upute za uporabu ili pogledajte elektroničke upute za uporabu	A se consulta instrucțiunile de utilizare sau a se consulta instrucțiunile electronice de utilizare	Preberite navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu jew ikkonsulta l-istruzzjonijiet elettronici għall-użu
	Tiesi	Düz	Прямой	Направо	Ravno	Drept	Ravna	Dritt
	J raidės formos	J şeklinde	J-образный	J-образна форма	U obliku slova J	Preformat în formă de J	V obliki črke J	Fil-forma ta' J
	J raidės formos	J şeklinde	J-образный	J-образна форма	U obliku slova J	Preformat în formă de J	V obliki črke J	Fil-forma ta' J
	Iš anksto suformuotas	Önceden şekillendirilmiş	С предварительно приданной формой	Предварительно оформено	Unaprijed oblikovano	Preformat	Predhodno oblikovano	Preformat
	Iš anksto suformuotas	Önceden şekillendirilmiş	С предварительно приданной формой	Предварительно оформено	Unaprijed oblikovano	Preformat	Predhodno oblikovano	Preformat
	Medicinos priemonė	Tıbbi cihaz	Медицинское изделие	Медицинско изделие	Medicinski proizvod	Dispozitiv medical	Medicinski pripomoček	Apparat mediku
	Vientisa sterilaus barjero sistema	Tekli steril bariyer sistemi	Одиная стерильная барьерная система	Система с единична стерилна бариерна	Sustav jednostruke sterilne barijere	Sistem unic de bariere sterile	Enojni sterilni sistem pregrad	Sistema ta' barriera sterili unika
	Sudėtyje yra pavojingų medžiagų	Tehlikeli maddeler içerir	Содержит опасные вещества	Съдържа опасни вещества	Sadrži opasne tvari	Conține substanțe periculoase	Vsebuje nevarne snovi	Fih sustanzi perikoluži
	Importuotojas	İthalatçı	Импортер	Вносител	Uvoznik	Importator	Uvoznik	Importatur

PCI Guide Wire SION series

INSTRUCTIONS FOR USE

Read these instructions carefully before using this guide wire and observe the Indications for Use, Contraindications, Warnings, Precautions, and How to Use sections in this Instructions for Use. Failure to do so may result in complications, including serious injury to the patient or death.

If a user and/or a patient comes to know a serious incident that has occurred in relation to the guide wire, report the fact to the manufacturer and the competent authority of the Member State.

These Instructions for Use apply to the PCI Guide Wire SION series. For details (length of the guide wire, length of radiopaque section, etc.), refer to the product label.

Descriptions

PCI Guide Wire SION series has been developed as a soft-tip guide wire to reduce the risk of vascular perforation when held in a vessel, as holding a guide wire with a hard tip in a vessel may result in vascular perforation.

The basic structure of SION consists of a taper core wire, two types of distal coils (an outer coil and an inner coil) and a safety wire. The taper core wire, the coils and the safety wire are soldered. A partial length of the outer coil is radiopaque so that its position can be easily confirmed under radioscapy. SION has a flexible tip load of 0.7gf* to ensure safety in the blood vessel. An inner coil made of rope is placed inside the outer coil, and the safety wire is bonded to the inner coil and the tip so that the safety wire will not come off, even in the unlikely event that the taper core wire comes off the tip, preventing the outer coil and taper core wire from coming off. The distal side of SION is coated with hydrophilic polymer.

SION blue has the same basic structure as SION, but some of the coating on the outer coil tip is silicone coating, making the tip more flexible than that of SION, and the tip load is 0.5gf*.

The basic structure of the distal side of SION blue ES is the same as that of SION blue and the tip load is 0.5gf*, but the outer coil length is shorter and the shaft stiffness is higher. The internal structure does not have a safety wire inside, but the distal design of the taper core wire is devised so that the proximal side of the guide wire is not easily dislodged. As with SION blue, the coating of SION blue ES is silicone coating at the distal and hydrophilic at the proximal, and the hydrophilic coating length is longer than that of SION blue.

SION black differs from SION and SION blue in that it has a polyurethane resin coating on the outer coil, and a hydrophilic coating on top of that. The tip load is 0.8gf*.

The basic structure of SUOH 03 is the same as those of SION blue and SION blue ES, but it uses an outer coil made of rope, resulting in the lowest tip load in the SION series at 0.3gf*. The distal surface is coated with hydrophilic coating.

In all PCI Guide Wire SION series, the proximal side of the taper core wire is coated with PTFE (polytetrafluoroethylene). The nominal outer diameter of the product is 0.36 mm (0.014 inch) over the complete length. At the proximal end of the devices less than 300 cm, there is a connection for an extension wire, which is used to replace the combined device; ASAHI INTECC's Extension Wire can be connected.

	Tip Load*	Outer Diameter	Coating Length	Coil Length	Radiopaque Length
SION	0.7gf	0.36mm (0.014")	Hydrophilic coating : 28.5cm	28cm	3cm
SION blue	0.5gf	0.36mm (0.014")	Silicone coating : 1.5cm Hydrophilic coating : 19.0cm	20cm	3cm
SION blue ES	0.5gf	0.36mm (0.014")	Silicone coating : 2.5cm Hydrophilic coating : 39.5cm	8.5cm	3cm
SION black	0.8gf	0.36mm (0.014")	Polyurethane coating : 20.0cm Hydrophilic coating : 40.0cm	12cm	3cm
SUOH 03	0.3gf	0.36mm (0.014")	Hydrophilic coating : 52.0cm	19cm	3cm

Indications for Use

This guide wire is intended for general percutaneous coronary intervention (PCI). This guide wire is intended to facilitate the placement of balloon dilatation catheters or other interventional therapeutic devices within cardiovascular. The average duration of use is expected to be 120 minutes.

This guide wire is not intended for use in the neurovasculature and peripheral vasculature.

Target Treated Population

PCI Guide Wire SION series are intended for patients who meet indications for PCI procedures. It is not indicated for use on neonates, infants, or children as well as patients who are pregnant, have impaired renal function, and who have an allergic reaction to contrast media or polyethylene glycol (PEG).

Contraindications

- Confirm the compatibility of guide wire diameter with other interventional device before actual use.
- Do not use the guide wire in patients who have an allergic reaction to contrast media or who have impaired renal function.
- This guide wire contains PEG400 in its hydrophilic coating. Do not use the guide wire in patients who have allergic reactions to polyethylene glycol (PEG).
- Do not use the guide wire for pregnant patients or patients who may be pregnant (X-ray may affect the fetus).
- This guide wire must be used in an institution where emergency surgical operation can be performed immediately. If an emergency surgical operation is unavailable, in the worst case, life-threatening events may occur.
- This guide wire is presterilized with ethylene oxide gas (EOG) and is intended for single use only. Do not reuse or resterilize. If reused or resterilized, the performance or quality of this guide wire and package may be compromised and there is a risk of complications, including infection.

Warnings

- This guide wire must be used only by a physician who is fully trained in PCI treatment.
- Never use this guide wire in combination with catheters having metal parts that may directly contact the surface of this guide wire (e.g. atherectomy catheters, metal dilators), metal needles or metal sheath inserters.
- During use of the guide wire, check and monitor the movement of its tip under fluoroscopy. Do

not use in areas of vessel that are not or cannot be visualized.

- Do not connect this guide wire with detachable extension wires produced by manufacturers other than ASAHI INTECC. Do not manipulate this

guide wire while the detachable extension wire is connected. Otherwise, the guide wire may be damaged, or the detachable extension wire may be unintentionally detached.

- Do not modify this guide wire for any reason.

Precautions

- Do not use the guide wire after the expiration date indicated on the label. Discard any guide wire that exceeds the expiration date.
- Guide wires are delicate instruments and should be handled carefully.
- If the package is opened or damaged, do not use the guide wire. Do not open the package until just prior to use. Use aseptic technique in handling and using the guide wire.
- Always keep the guide wire in a wet state to prevent damage to its hydrophilic coating.
- Do not wipe this guide wire using an organic solution such as alcohol.
- Take preventive measures against infection after use. Discard this guide wire and package as medical waste.
- Never push, auger, withdraw, or torque this guide wire that meets resistance. Torquing or pushing this guide wire against resistance may cause damage and/or tip separation of this guide wire or direct damage to a vessel. Failure to do so may cause damage to this guide wire. Determine the cause of resistance under fluoroscopy and take any necessary remedial action.
- Always advance or withdraw the guidewires slowly and carefully.
- When torquing this guide wire inside the blood vessel, do not torque continuously in the same direction. When torquing the guide wire, rotate it clockwise and counterclockwise alternately. Do not rotate more than two rotations (720°) in the same direction.
- Flush the guide wire with heparinized and sterilized saline or other suitable solution while removing and reinserting it to prevent air from entering the interventional device. Perform exchange of this guide wire carefully to prevent air entry and/or trauma. When reintroducing the guide wire, confirm that the interventional device tip is free within the vessel lumen and is not against the vessel wall. Failure to do so may result in trauma. Use the radiopaque marker of the interventional device to confirm position.
- Free movement of the guide wire within the interventional device is an important feature of a

steerable guide wire system because it gives the user valuable tactile information. Test the system for any resistance prior to use. Adjust or replace the hemostasis valve with an adjustable valve if it is found to inhibit the guide wire movement.

- Do not perform stent placement using more than one guide wire or wire operation through stent strut. Otherwise, the stent may be damaged or the guide wire may break or break apart.
- Before use, confirm that this guide wire is appropriate in size and shape for the procedure and is compatible with the device to be used in combination.
- Refer to the Instruction for Use attached to the medical device (e.g. balloon dilatation catheters or other interventional devices) to be used in combination with this guide wire.
- When connecting the detachable extension wire with this guide wire, it should be securely inserted to the boundary line between non PTFE coating and PTFE coating at the proximal end of the guide wire. If any abnormality is found in the connection, stop using the guide wire immediately.
- Inspect the guide wire carefully for bends, kinks, or other damage prior to use and whenever possible during the procedure. Do not use the guide wire if it is damaged.
- When shaping the tip, be careful not to damage the coil.
- Before inserting the guide wire, check which end is the distal end and make sure to insert it from the distal end.
- Maintain a continuous saline flush between the guiding catheter and the interventional device and between the interventional device and the guide wire during the procedure. Flushing prevents contrast media formation and/or clotting on the guide wire and in the catheter lumen.
- For the holder with the distal end protection tube (refer to How to Use, Figure 1), do not remove or insert the distal end protection tube while the guide wire is housed in the holder.
- For the holder with the distal end protection tube (refer to How to Use, Figure 1), remove the distal

end protection tube before housing the guide wire in the holder again.

- This device contains the following substance defined as CMR 1A/1B and endocrine-disrupting

substance in a concentration above 0.1% weight by weight; Cobalt: CAS No. 7440-48-4.

Malfunctions and Adverse Events

Possible malfunctions and adverse events through usage of this guide wire include, but are not limited to the following:

1. Malfunctions

Failure to cross a lesion	Breakage or bending of the guide wire	Damage such as separation
Difficulty in removal	Coming off of coating	Debris from a damaged guide wire

2. Adverse events

Death	Infection	Vessel dissection
Vessel perforation	Bleeding complications	Embolism
Thrombus	Infarction	Ischemia
Arrhythmia	Vasospasm	Vascular occlusion
Blood pressure reduction	Allergic reaction	

How to Use

1. Inspection prior to use

- Before use, inspect carefully and confirm the guide wire and package are undamaged.
- Before use, confirm that the guide wire is compatible with the interventional devices to be used.

2. Preparation

- Select the most suitable guide wire for the affected area and remove the holder tube containing the guide wire from the sterile pack.
- Fill up the holder tube with heparinized and sterilized saline using a syringe to soak the entire device. Take note that heparinized and sterilized saline may spill out of the holder tube during at this time. For the holder with the distal end protection tube (Figure 1), a syringe can be connected to the distal end protection tube.
- Fill the lumen of the interventional device with the heparinized and sterilized saline before inserting the guide wire.
- Release the guide wire from the tail clip and

slide the guide wire slowly, push distal end of the guide wire through the holder tube(B).(Figure 2)

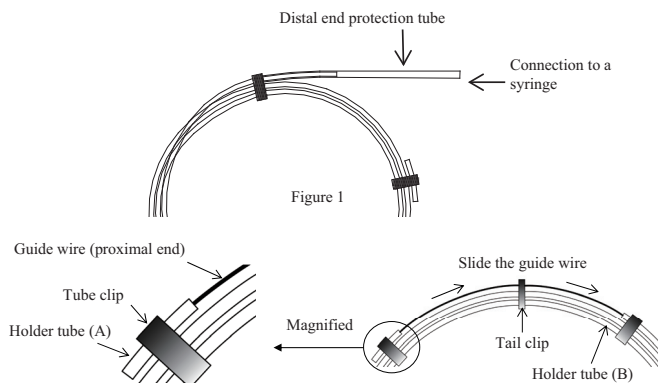


Figure 1

Figure 2

visible during interventional device manipulations.

■ Rapid exchange system

- Engage the guiding catheter.
- Insert the guide wire introducer into the Y connector of the guiding catheter.
- Carefully insert the guide wire tip into the introducer.
- Advance the guide wire through the guiding catheter under fluoroscopy until the guide wire tip is just proximal to the tip of the guiding catheter.
- Attach the torque device to the guide wire if necessary.
- Advance the guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.

g) Observe the guide wire movement in the vessels.

h) Remove the guide wire torque device and the guide wire introducer.

i) Track the interventional device over the guide wire while preventing the guide wire from moving, and advance until the lesion is reached. Ensure that the guide wire distal tip and its location in the vessel are visible during interventional device manipulations.

4. Procedures to exchange the guide wire

■ Over-the-wire system

- Remove this guide wire slowly while monitoring the movement of this guide wire under fluoroscopy.
- Insert the next guide wire in accordance with the directions in this "How to Use" section.

e) When the distal end of the guide wire is extended 5 to 6 cm beyond the other end of the holder tube (or the distal end protection tube), if necessary, shape the tip in accordance with standard practice.

f) Gently grasp the guide wire which came out from the distal end of the holder tube (or the distal end protection tube), at the point as close to the holder tube as possible and pull the guide wire out slowly and carefully.

g) If resistance is felt when removing the guide wire from the holder tube, inject heparinized and sterilized saline into the holder tube again. Continue removing the guide wire after the resistance is not felt anymore. Be sure to inject enough heparinized and sterilized saline to the holder tube because hydrophilic coating may be damaged when removing the coated guide wire forcefully.

h) After pulling the guide wire out of the holder tube, inspect it to make sure that it is not damaged.

b) Advance this guide wire carefully until its tip is just proximal to the interventional device tip.

c) Engage the guiding catheter and insert the interventional device system (with guide wire) into the Y connector.

d) Advance the interventional device system through the guiding catheter until the tip of the guide wire system is just proximal to the tip of the guiding catheter.

e) Tighten the hemostasis valve of Y connector to create a seal around the interventional device. Ensure the guide wire movement is still permitted.

f) Check to make sure the guide wire moves smoothly.

g) Attach the torque device to the guide wire if necessary.

h) Advance this guide wire under fluoroscopy to pass through the lesion. Confirm by angiography that the guide wire has passed the narrowed target lesion.

i) Observe the guide wire movement in the vessels.

j) Advance the interventional device until the lesion is reached while preventing the guide wire from moving. Ensure that guide wire distal tip and its location in the vessel are

Storage Method

Do not keep the guide wire and package in a bent and/or heavily-loaded condition. This guide wire and package must be kept out of water. Store in a cool, dark, and dry place.

Expiration Date

The expiration date is indicated on the label of the guide wire package.

Contents

5 pieces / box

Liability Disclaimer

By no means shall "ASAHI INTECC CO., LTD. and its affiliated companies" (hereinafter referred to as the "Company") be liable for accidents, personal injuries, adverse events due to any improper use of the product(s) or any other use inconsistent with these instructions. In no event shall the Company be liable for any damages either (i) arising out of storage of the product(s) after the shipment from the Company or (ii) due to selection of patients, surgery techniques, or any other medical activities by the medical institution that uses the product(s).

"SION" and "SUOH" are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.

*Tip load values represent the mean values of product specification values measured according to the internal standard testing method assuming the force applied to the lesion by the guide wire tip.

3. Procedures for insertion

■ Over-the-wire system

- Insert the distal end of the guide wire carefully into the guide wire lumen of the interventional device.

Serien PCI Sion-guidewire

Brugsanvisning

Læs omhyggeligt disse anvisninger for brug af denne guidewire, og overhold indikationer for brug, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og afsnittet "Anbefalet procedure" i denne brugsanvisning. Hvis dette undlades, kan det medføre komplikationer, herunder alvorlig kvæstelse af patienten eller dødsfald.

Når en bruger og/eller en patient bliver bekendt med en alvorlig hændelse, der er sket på grund af guidewiren, skal dette indberettes til producenten og myndighederne i det pågældende medlemsland.

Denne brugsanvisning gælder for serien PCI SION-guidewire. Nærmere specifikationer (længden af guidewiren, længden af den røntgenfaste del mv.) fremgår af mærkaten på produktpakken.

Beskrivelser

Serien PCI SION-guidewire er fremstillet med en blød spids for at reducere risikoen for vaskulær perforering, når den anvendes i kar, da en guidewire med en hård spids kan resultere i vaskulær perforering af kar.

SIONs grundstruktur består af en konisk kernetråd, to typer distale spoler (en udvendig spole og en indvendig spole) og en sikkerhedstråd. Den koniske kernetråd, spolerne og sikkerhedstråden er lodret. En del af den udvendige spolelængde er røntgentæt, så det er let at bekræfte dens position under radioskopi. SION har en fleksibel spidsbelastning på 0,7 gf* for at sikre sikkerheden i blodkarret. En indvendig rebspole er placeret inde i den udvendige spole, og sikkerhedstråden er fastbundet til henholdsvis den indvendige spole og spidsen, så sikkerhedstråden ikke falder af, selv i det usandsynlige tilfælde, at den koniske kernetråd falder af spidsen, da det forhindrer, at den udvendige spole og den koniske kernetråd falder af. Den distale side af SION er belagt med hydrofil polymer.

SION Blue har samme grundstruktur som SION, men en del af belægningen på den udvendige spolespids er silikonebelægning, hvilket gør spidsen mere fleksibel end SION og giver en spidsbelastning på 0,5 gf*.

Grundstrukturen af den distale side af SION Blue ES er den samme som hos SION Blue, og spidsbelastningen er også 0,5 gf*, men den udvendige spolelængde er kortere, og skaffets stivhed er højere. Den indvendige struktur har ikke en sikkerhedstråd, men det distale design af den koniske kernetråd er udformet, så den proksimale ende af guidewiren ikke uden videre kan rive sig løs. Som på SION Blue er belægningen på SION BLUE ES silikonebelægning i den distale ende og hydrofil belægning i den proksimale ende, og længden af den hydrofile belægning er længere end hos SION Blue.

SION Black adskiller sig fra SION og SION Blue ved, at den har polyuretanharpiksbelægning på den udvendige spole og hydrofil belægning oven på den. Spidsbelastningen er 0,8 gf*.

Grundstrukturen af SUOH 03 er den samme som hos SION Blue og SION Blue ES, men den har en udvendig rebspole, hvilket giver den laveste spidsbelastning i SION-serien på 0,3 gf*. Den distale overflade har hydrofil belægning.

I alle PCI SION-guidewireserier er den proksimale ende af den koniske kernetråd belagt med PTFE (polytetrafluorethylen). Produktets nominelle udvendige diameter er 0,36 mm (0,014 tommer) i hele længden. I den proksimale ende af enheden, som er mindre end 300 cm, er der en forbindelse til en

forlængerledning, som anvendes til at erstatte den samlede enhed; ASahi INTECCs forlængerledning kan tilsluttes.

	Spidsbelastning*	Udvendige diameter	Belægningslængde	Spolelængde	Røntgenfast længde
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofil belægning: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION Blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonebelægning: 1,5 cm Hydrofil belægning: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION Blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonebelægning: 2,5 cm Hydrofil belægning: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION Black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polyuretanbelægning: 20,0 cm Hydrofil belægning: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofil belægning: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikationer for brug

Denne guidewire er beregnet til generel perkutan koronar intervention (PCI). Denne guidewire er beregnet til at lette placeringen af kateter til ballonudvidelse eller andet interventionelt terapeutisk udstyr inden for kardiovaskulær. Den gennemsnitlige anvendelsesvarighed forventes at være 120 minutter. Denne guidewire er ikke beregnet til brug i neurovaskulær og den perifere vaskulær.

Målpopulation

Serien PCI SION-guidewire er beregnet til patienter, der opfylder indikationerne for PCI-procedurer. Den er ikke indiceret til brug hos nyfødte, spædbørn og børn samt patienter, der er gravide, har nedsat nyrefunktion eller er allergiske over for kontrastmidler eller polyethylenlykcol (PEG).

Kontraindikationer

- Bekræft, at diameteren af guidewiren er kompatibel med andet interventionelt udstyr, før den anvendes.
 - Guidewiren må ikke anvendes hos patienter, der er allergiske over for kontrastmidler eller har nedsat nyrefunktion.
 - Denne guidewire indeholder PEG400 i sin hydrofile belægning. Brug ikke guidewiren på patienter, der har allergiske reaktioner over for polyethylenlykcol (PEG).
 - Brug ikke guidewiren til gravide patienter eller patienter, der kan være gravide (røntgenstråler kan påvirke fosteret).
- Guidewiren skal bruges på institutioner, hvor det er muligt øjeblikkeligt at udføre akutte kirurgiske indgreb. Hvis det ikke er muligt at udføre akutte kirurgiske indgreb, kan der i værste fald forekomme livstruende situationer.
 - Guidewiren er præsteriliseret med ethylenoxidgas (EOG) og er udelukkende beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges eller resteriliseres. Genbrug eller resterilisering af guidetråden kan have en negativ indvirkning på guidetråden og emballagen og dermed vil være risiko for komplikationer, herunder infektioner.

Advarsler

- Guidewiren må kun bruges af en læge, der er fuldt uddannet i PCI-behandling.
 - Brug aldrig denne guidewire i kombination med kateter med metaldele, der kan berøre overfladen af denne guidewire direkte (f.eks. kateter til
- atherektomi, dilatatorer af metal), metalnåle eller indsætter af metalskeder.
 - Under brug af guidewiren skal spidsens bevægelse kontrolleres og overvåges under

fluoroskopi. Må ikke anvendes i dele af kar, der ikke er tagtaget eller kan iagtages.

- Guidewiren må ikke sammenkobles med aftagelige forlænger-wirer, der er fremstillet af andre producenter end ASAHI INTECC.

Forholdsregler

- Guidewiren må ikke anvendes efter udløbsdatoen på mærkaten. Kassér alle guidewirer, der har overskredet udløbsdatoen.
- Guidewirer er skrøbelige instrumenter, der skal behandles forsigtigt.
- Guidewiren må ikke anvendes, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget. Emballagen må først åbnes lige inden brug. Guidewiren skal håndteres og anvendes aseptisk.
- Hold altid guidewiren våd for at undgå beskadigelse af den hydrofile belægning.
- Undlad at aførre guidewiren med en organisk opløsning, som f.eks. spirit.
- Træf forebyggende foranstaltninger mod infektion efter anvendelse. Kassér guidewiren og emballagen som medicinsk affald.
- Guidewiren må aldrig skubbes, drejes, trækkes ud eller vrides rundt, hvis der mærkes modstand. Hvis guidewiren vrides rundt eller skubbes til på trods af modstand, kan det beskadige spidsen af guidewiren, og/eller få spidsen til at gå af, eller det kan direkte medføre skade på karret. Hvis du ikke gør det, kan det beskadige denne guidewire. Find årsagen til modstanden under gennemlysning, og træf de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.
- Før eller træk altid guidewiren langsomt og forsigtigt frem eller tilbage.
- Når guidewiren vrides rundt inde i blodkarret, må den ikke konstant vrides i samme retning. Guidewiren skal skiftevis vrides med og mod uret. Guidewiren må ikke drejes mere end to gange (op til 720°) rundt i samme retning.
- Skyl guidewiren med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning eller anden velegnet opløsning, samtidig med at den tages ud og føres ind igen for at hindre luft i at komme ind i interventionsudstyret. Udvis forsigtighed under udskiftning af guidewiren, så der ikke kommer luft ind og/eller forårsages skade. Under genindføring af guidewiren skal det sikres, at spidsen, der bruges til indgrebet, ligger frit inde i karrets lumen, og at den ikke ligger op mod karvæggen. I modsat fald kan der opstå traumer.

Guidewiren må ikke manipuleres, mens den aftagelige forlænger-wire er koblet til. I modsat fald kan guidewiren blive beskadiget, eller den aftagelige forlænger-wire kan løses utilsigtet.

- Guidewiren må ikke ændres uanset grunden.

- Brug den røntgenfaste markør på interventionsudstyret til at fastslå positionen.
- Det er en vigtig del af det styrbare guidewiresystem, at guidewiren kan bevæge sig frit inde i interventionsudstyret, da brugeren derved kan føle sig frem til væsentlige informationer. Afprøv systemet før brug for at se, om der er modstand. Reguler, eller udskift hæmostaseventilen med en regulerbar ventil, hvis den viser sig at begrænse guidewirens bevægelsesmuligheder.
 - Anlæg ikke nogen stent ved hjælp af flere end én guidewire, og før ikke guidewiren gennem stentens stivere. Ellers kan stenten blive beskadiget eller guidewiren kan lide skade eller gå i stykker.
 - Før brug skal det bekræftes, at denne guidewire har en hensigtsmæssig størrelse og form til proceduren og er kompatibel med den enhed, den skal bruges sammen med.
 - Se brugsanvisningen, der er vedlagt det medicinske udstyr (f.eks. kateter til ballonudvidelse eller andet interventionelt udstyr), der skal bruges sammen med denne guidetråd.
 - Når den aftagelige forlænger-wire kobles til denne guidewire, skal den sættes godt fast til grænsefladen mellem den belægning, der ikke er PTFE, og den belægning, der er PTFE, ved guidewirens proximale ende. der konstateres en afvigelse i forbindelsen, skal du straks stoppe med at bruge guidewiren.
 - Se omhyggeligt efter, om guidewiren er bøjet, knækket eller på anden vis beskadiget før brug, og når det kan lade sig gøre under indgrebet. Brug ikke guidewiren, hvis den er beskadiget.
 - Når du former spidsen, skal du være forsigtig med ikke at beskadige spolen.
 - Før du indsætter guidewiren, skal du kontrollere, hvilken ende der er den distale ende, og sikre dig, at du indsetter den fra den distale ende.
 - Der skal opretholdes en kontinuerlig saltvandsskyllning mellem kateteret til indføring og interventionskatetret og mellem interventionskatetret og guidewiren under

proceduren. Skyllning forhindrer, at der dannes kontraststoffer og/eller koaguleringer på guidewiren og i lumen i kateteret.

- Ved opbevaringsrøret med det distale endebeskyttelsesrør (se Anbefalet procedure, figur 1) må du ikke fjerne eller isætte det distale endebeskyttelsesrør, mens guidewiren er i opbevaringsrøret.

- Ved opbevaringsrøret med det distale endebeskyttelsesrør (se Anbefalet procedure, figur 1) skal du fjerne det distale endebeskyttelsesrør, før du sætter guidewiren tilbage i opbevaringsrøret.
- Denne enhed indeholder følgende stof defineret som CMR 1A/1B og hormonforstyrrende stof i en koncentration på over 0,1 vægtprocent; Cobalt: CAS No. 7440-48-4.

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser

Fejlfunktioner og bivirkninger/uønskede hændelser, der kan forekomme ved brugen af denne guidewire, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

1. Fejlfunktioner

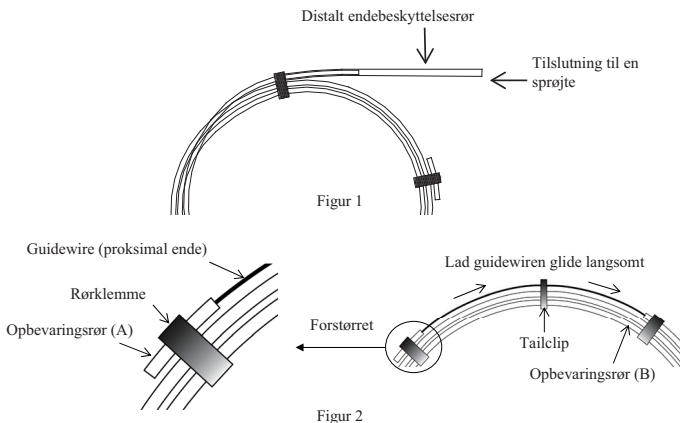
Mislykket krydsning af læsion	Brud eller bøjning af guidewiren	Skader såsom adskillelse
Vanskeligheder med at fjerne	Belægning forsvinder	Rester fra en beskadiget guidewire

2. Bivirkninger/uønskede hændelser

Død	Infektion	Kardissektion
Karperforation	Komplikationer ved blødning	Emboli
Trombe	Infarkt	Ischemia
Arrhythmia	Vasospasme	Vaskulær okklusion
Reduktion af blodtrykket	Allergisk reaktion	

Anbefalet procedure

- Undersøg for brug
 - Kontrollér omhyggeligt for brug, at guidewiren og emballagen er ubeskadigede.
 - Kontrollér for brug, at guidewiren er kompatibel med det interventionsudstyr, der skal anvendes.
- Klargøring
 - Vælg den mest velegnede guidewire til det berørte område, og tag opbevaringsrøret med guidewiren ud af den sterile emballage.
 - Fyld opbevaringsrøret med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning ved hjælp af en sprøjte for at lægge hele enheden i blød. Vær opmærksom på, at hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning kan spildes fra opbevaringsrøret på dette tidspunkt. For holderen med det distale endebeskyttelsesrør (figur 1) kan en sprøjte tilsluttes det distale endebeskyttelsesrør.
 - Fyld interventionsudstyrets lumen med hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning, før guidewiren indføres.
 - Løsn guidewiren fra endeklipsen, og lad den glide langsomt igennem opbevaringsrøret (B), idet der skubbes på den distale ende af guidewiren (figur 2).



Figur 2

- Når den distale ende af guidewiren stikker mere end 5-6 cm ud af den anden ende af opbevaringsrøret (eller den distale ende af beskyttelsesrøret), kan spidsen eventuelt formes i henhold til standardpraksis.
- Hold forsigtigt om guidewiren, der udgår fra den distale ende af opbevaringsrøret (eller den distale ende af beskyttelsesrøret). Hold så tæt ved røret som muligt, og træk langsomt og forsigtigt guidewiren ud.
- Hvis der mærkes modstand, når guidewiren tages ud af opbevaringsrøret, injiceres der igen hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret. Fortsæt med at tage guidewiren ud, når der ikke længere mærkes modstand. Sørg for at injicere tilstrækkelig hepariniseret og steriliseret saltvandsopløsning i opbevaringsrøret, fordi den hydrofile belægning kan blive beskadiget, når den belagte guidewire tages ud ved anvendelse af for meget kraft.
- Når guidewiren er trukket ud af opbevaringsrøret, skal den undersøges for at sikre, den ikke har lidt skade.

3. Indføringsmetoder

■ Over the wire-metoden

- Før forsigtigt den distale ende af guidewiren

- ind i guidewire-lumenen på interventionsudstyret.
- Fremfør forsigtigt guidewiren, til dens spids er lige netop proksimalt for spidsen af interventionsudstyret.
- Hold i indføringskatetret, og før interventionsudstyret (med guidewire) ind i Y-konnektor.
- Før interventionsudstyret ind gennem indføringskatetret, til spidsen af guidewiren er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskatetret.
- Spænd hæmostaseventilen på Y-konnektor, så der dannes en forsejling rundt om interventionsudstyret. Sørg for, at guidewiren fortsat kan bevæges.
- Se efter, om guidewiren kan bevæges uindret.
- Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- Før denne guidewire frem, under gennemlysning, og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mællæsion.
- Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger sig inden i karrene.
- Før interventionsudstyret frem, til læsionen er nået, samtidig med at guidewires hindres i at bevæge sig. Sørg for, at guidewires distale

spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

■ Hurtig udkiftning

- Hold fast i indføringskatetret.
- Før guidewires indføringsinstrumentet ind i Y-konnektor på indføringskatetret.
- Før forsigtigt guidewires spids ind i indføringsinstrumentet.
- Før guidewiren ind gennem indføringskatetret under gennemlysning, til guidewires spids er lige netop proksimalt for spidsen af indføringskatetret.
- Sæt evt. vrideren på guidewiren.
- Før under gennemlysning guidewiren frem og gennem læsionen. Kontrollér med angiografi, at guidewiren har passeret den indsnævrede mællæsion.
- Hold øje med, hvordan guidewiren bevæger

sig inden i karrene.

- Fjern vrideren til guidewiren og indføringsinstrumentet.
- Før interventionsudstyret hen over guidewiren, samtidig med at guidewiren hindres i at bevæge sig, og før det frem, til læsionen er nået. Sørg for, at guidewires distale spids og dens placering i karret er synlige under manipulation med interventionsudstyret.

4. Metoder til udkiftning af guidewire

■ Over the wire-metoden

- Tag langsomt guidewiren ud, samtidig med at der holdes øje med dens bevægelse under gennemlysning.
- Før den næste guidewire ind i overensstemmelse med anvisningerne i afsnittet "Anbefalet procedure".

Opbevaringsmetode

Opbevar ikke guidewiren og emballagen bøjet eller således, at guidewiren og emballagen udsættes for stor belastning. Denne guidewire og emballagen skal holdes væk fra vand. Opbevares på et køligt, mørkt og tørt sted.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er angivet på etiketten af guidewires emballage.

Indhold

5 stk. / æske

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder kan "ASAHI INTECC CO., LTD. og dens tilknyttede selskaber" (herefter kaldet "Virksomheden") gøres ansvarlig for uheld, persontilskadekomst eller bivirkninger der skyldes ukorrekt brug af produktet/produkterne eller enhver anden brug, der ikke følger disse anvisninger. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der enten (i) opstår som følge af opbevaring af produktet efter forsendelse fra Firmaet eller (ii) på grund af valg af patienter, kirurgisk teknik eller andre medicinske aktiviteter, der udføres af den medicinske institution, der bruger produktet.

"SION" og "SUOH" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende ASAHI INTECC CO.,LTD. i Japan og andre lande.

*Spidsbelastningsværdier repræsenterer middelværdierne af produktspecifikationsværdier målt i henhold til den interne standardtestmetode, hvor der tages udgangspunkt i den kraft, som guidewirespidsen påfører læsionen.

SION-serie geleidedraad voor PCI

Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze geleidedraad gebruikt en neem de hoofdstukken Gebruiksindicaties, Contra-indicaties, Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Aanbevolen procedure in deze Gebruiksaanwijzing in acht. Als u dat niet doet, kunnen er bij de patiënt complicaties optreden, waaronder ernstig letsel, en kan deze zelfs komen te overlijden.

Als een gebruiker en/of patiënt een ernstig incident waarneemt in verband met de geleidedraad, meld dit dan aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de SION-serie PCI-geleidedraad. Voor de details (lengte van de geleidedraad, lengte van het radiopaak gedeelte enz.) verwijzen we naar het productlabel.

Beschrijving

De SION-serie PCI-geleidedraad is ontwikkeld als een geleidedraad met een zacht uiteinde om het risico op vaatperforatie te verminderen wanneer deze in een bloedvat wordt geplaatst, omdat het plaatsen van een geleidedraad met een hard uiteinde in een bloedvat kan leiden tot vaatperforatie.

De basisstructuur van SION bestaat uit een conische kerndraad, twee soorten distale spoelen (een buitenste spoel en een binnenste spoel) en een veiligheidsdraad. De conische kerndraad, de spoelen en de veiligheidsdraad zijn gesoldeerd. Een deel van de buitenste spoel is radiopaak, zodat de positie eenvoudig kan worden bevestigd onder radioscopie. SION heeft een flexibele belasting aan het uiteinde van 0,7gf* om de veiligheid in het bloedvat te garanderen. Een binnenste spoel van touw wordt in de buitenste spoel geplaatst en de veiligheidsdraad wordt aan de binnenste spoel en het uiteinde vastgemaakt zodat de veiligheidsdraad niet losraakt, zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de conische kerndraad van het uiteinde losraakt, waardoor wordt voorkomen dat de buitenste spoel en de conische kerndraad losraken. De distale zijde van SION is gecoat met een hydrofiele polymeer.

SION blue heeft dezelfde basisstructuur als SION, maar een deel van de coating op het buitenste spoeluiteinde is een coating van siliconen, waardoor het uiteinde flexibeler is dan dat van SION, en de belasting van het uiteinde is 0,5gf*.

De basisstructuur van de distale zijde van SION blue ES is hetzelfde als die van SION blue en de belasting van de uiteinden is 0,5gf*, maar de lengte van de buitenste spoel is korter en de stijfheid van de schacht is hoger. De interne structuur heeft geen veiligheidsdraad, maar het distale ontwerp van de conische kerndraad is zo ontworpen dat de proximale kant van de geleidedraad niet gemakkelijk losraakt. Net als bij SION blue is de coating van SION blue ES aan de distale zijde een coating van siliconen en aan de proximale zijde hydrofiel en de lengte van de hydrofiele coating is langer dan die van SION blue.

SION black verschilt van SION en SION blue doordat het een coating van polyurethaanhars op de buitenste spoel heeft en een hydrofiele coating daarbovenop. De belasting van het uiteinde is 0,8gf*.

De basisstructuur van SUOH 03 is hetzelfde als die van SION blue en SION blue ES, maar deze gebruikt een buitenste spoel van touw, wat met 0,3gf* de laagste belasting van het uiteinde in de SION-serie oplevert. Het distale oppervlak is bedekt met een hydrofiele coating.

In alle PCI-geleidedraden uit de SION-serie is de proximale zijde van de conische kerndraad gecoat met PTFE (polytetrafluorethyleen). De nominale buitendiameter van het product is 0,36mm (0,014 inch) over

de gehele lengte. Aan het proximale uiteinde van het instrument, op minder dan 300cm, bevindt zich een aansluiting voor een verlengdraad om het gecombineerde instrument te vervangen; de verlengdraad van ASAHİ INTECC kan worden aangesloten.

	Belasting aan het uiteinde*	Buitendiameter	Lengte coating	Lengte spoel	Lengte radiopaak
SION	0,7gf	0,36mm (0,014")	Hydrofiele coating : 28,5cm	28cm	3cm
SION blue	0,5gf	0,36mm (0,014")	Siliconen coating : 1,5cm Hydrofiele coating : 19,0cm	20cm	3cm
SION blue ES	0,5gf	0,36mm (0,014")	Siliconen coating : 2,5cm Hydrofiele coating : 39,5cm	8,5cm	3cm
SION black	0,8gf	0,36mm (0,014")	Polyurethaan coating : 20,0cm Hydrofiele coating : 40,0cm	12cm	3cm
SUOH 03	0,3gf	0,36mm (0,014")	Hydrofiele coating : 52,0cm	19cm	3cm

Gebruiksindicaties

Deze geleidedraad is bedoeld voor algemene percutane coronaire interventie (PCI). Deze geleidedraad is bedoeld om de plaatsing van ballondilatatiekatheters of andere interventionele therapeutische hulpmiddelen in de cardiovasculatuur te vergemakkelijken. De gemiddelde gebruiksduur is naar verwachting 120minuten.

Deze geleidedraad is niet bedoeld voor gebruik in het vaatstelsel van het zenuwstelsel en het perifere vaatstelsel.

Behandelde doelgroep

SION-serie PCI-geleidedraden zijn bedoeld voor patiënten die voldoen aan de indicaties voor PCI-procedures. Het is niet geïndiceerd voor gebruik bij pasgeborenen, zuigelingen of kinderen en patiënten die zwanger zijn, een verminderde nierfunctie hebben en allergisch reageren op contrastmiddelen of polyethyleenglycol (PEG).

Contra-indicaties

- Controleer vóór gebruik de compatibiliteit van de diameter van de geleidedraad met andere interventie-instrumenten.
 - Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor contrastmiddelen of die een verminderde nierfunctie hebben.
 - Deze geleidedraad bevat PEG400 in zijn hydrofiele coating. Gebruik de geleidedraad niet bij patiënten die allergisch zijn voor polyethyleenglycol (PEG).
 - Gebruik de geleidedraad niet bij zwangere patiënten of patiënten die zwanger kunnen zijn (röntgenstraling kan de foetus aantasten).
 - Deze geleidedraad moet worden gebruikt in instellingen waar dringende chirurgische ingrepen kunnen worden verricht. Als er geen
- chirurgische noodingrepen kunnen worden verricht, kunnen in het ernstigste geval levensbedreigende situaties ontstaan.

 - Deze geleidedraad is vooraf gesteriliseerd met ethyleenoxidegas (EOG) en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik of hernieuwde sterilisatie kunnen de prestaties of kwaliteit van deze geleidedraad in het gedrang komen en bestaat het risico op complicaties, waaronder infecties.

Waarschuwingen

- Deze geleidedraad mag uitsluitend worden gebruikt door een arts die volledig bevoegd is PCI-behandelingen uit te voeren.
- Gebruik deze geleidedraad nooit in combinatie met katheters met metalen onderdelen die direct in contact kunnen komen met het oppervlak van deze geleidedraad (bijv. atherectomiekatetheters of metalen dilatatoren), metalen naalden of metalen hulsinbrengers.
- Controleer en bewaak tijdens het gebruik van de geleidedraad de beweging van het uiteinde ervan met behulp van fluoroscopie. Niet gebruiken in vaatgedeelten die niet zichtbaar zijn of niet zichtbaar kunnen worden gemaakt.
- Sluit deze geleidedraad niet aan op loskoppelbare verlengdraden die zijn vervaardigd door andere producenten dan ASAHI INTECC. Bewerk deze geleidedraad niet las de loskoppelbare verlengdraad is aangesloten. Anders kan de geleidedraad beschadigd raken of kan de loskoppelbare verlengdraad ongewild losraken.
- Breng om geen enkele reden aanpassingen aan deze geleidedraad aan.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de geleidedraad niet na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket. Gooi een geleidedraad waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, weg.
- Geleidedraden zijn delicate instrumenten en er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
- Gebruik de geleidedraad niet wanneer de verpakking open of beschadigd is. Open de verpakking altijd vlak voor gebruik. Gebruik een aseptische techniek bij het werken met en gebruiken van de geleidedraad.
- Houd de geleidedraad altijd nat om beschadiging van de hydrofiele coating te voorkomen.
- Veeg deze geleidedraad niet schoon met een organisch oplosmiddel zoals alcohol.
- Neem na gebruik maatregelen om infecties te voorkomen. Gooi deze geleidedraad en de verpakking weg bij het medisch afval.
- Duw, druk of draai deze geleidedraad niet verder of trek deze niet terug wanneer u op weerstand stuit. Wanneer u deze geleidedraad tegen weerstand in duwt of tordeert, kan dit schade en/of losraken van het uiteinde ervan of directe beschadiging van het bloedvat tot gevolg hebben. Bovendien kan de geleidedraad beschadigd raken. Stel middels fluoroscopie de oorzaak van de weerstand vast en onderneem de actie die nodig is om deze te verhelpen.
- Geleidedraden moeten altijd langzaam worden ingebracht en teruggetrokken.
- Wanneer u de geleidedraad in het bloedvat tordeert, moet u dat niet voortdurend in dezelfde richting doen. Wanneer u de geleidedraad draait, roteer dan afwisselend rechtsom en linksom.
- Draai nooit meer dan twee volledige omwentelingen (720°) in dezelfde richting.
- Spoel de geleidedraad met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine of een andere geschikte oplossing tijdens het verwijderen en weer invoeren, zodat wordt voorkomen dat er lucht in het interventie-instrument terecht komt. Vervang deze geleidedraad op een zorgvuldige manier zodat binnendringen van lucht en/of trauma's worden voorkomen. Controleer bij het opnieuw invoeren van de geleidedraad of het uiteinde van het interventie-instrument vrij in het vaatlumen kan bewegen en niet tegen de vaatwand zit. Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot een trauma. Controleer de positie met behulp van de radiopakke markering van het interventie-instrument.
- Vrije verplaatsing van de geleidedraad in het interventie-instrument is een belangrijke eigenschap van een stuurbaar geleidedraadsysteem, omdat het de gebruiker waardevolle tactiele informatie verschaft. Test voorafgaand aan gebruik het systeem op eventuele weerstand. Pas de hemostaseklep aan of vervang deze door een verstelbare klep als blijkt dat deze de beweging van de geleidedraad hindert.
- Plaats geen stent met meer dan één geleidedraad en gebruik de geleidedraad niet door een stentsteun. Zo niet dan kan de stent beschadigd worden of kan de geleidedraad breken of uit elkaar vallen.
- Controleer vóór gebruik of deze geleidedraad qua grootte en vorm geschikt is voor de procedure en

compatibel is om samen met het te gebruiken instrument te worden gebruikt.

- Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het medische instrument (bijv. ballondilatatiekatetheters of andere interventie-instrumenten) dat samen met deze geleidedraad wordt gebruikt.
- Wanneer u de loskoppelbare verlengdraad op deze geleidedraad aansluit, moet u deze stevig aansluiten op de grenslijn tussen de non- PTFE-coating en de PTFE-coating aan het proximale uiteinde van de geleidedraad. Als er een afwijking in de aansluiting wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de geleidedraad.
- Inspecteer de geleidedraad vóór gebruik en, voor zover mogelijk, ook tijdens de procedure zorgvuldig op buigingen, knikken of andere beschadigingen. Gebruik de geleidedraad niet als deze beschadigd is.
- Let er bij het vormen van het uiteinde op dat u de spoel niet beschadigt.
- Voordt u de geleidedraad inbrengt, moet u controleren welk uiteinde het distale uiteinde is

en ervoor zorgen dat u de draad vanaf het distale uiteinde inbrengt.

- Zorg tijdens de procedure voor een continue zoutspoeling tussen de geleidekatheter en het interventie-instrument en tussen het interventie-instrument en de geleidedraad. Spoelen voorkomt contrastmiddelvorming en/of stolling op de geleidedraad en in het katheterlumen.
- Bij de houder met de beschermbuis voor het distale uiteinde (zie Aanbevolen procedure, afbeelding 1) mag de beschermbuis voor het distale uiteinde niet verwijderd of geplaatst worden terwijl de geleidedraad in de houder zit.
- Bij de houder met de beschermbuis voor het distale uiteinde (zie Aanbevolen procedure, afbeelding 1) moet de beschermbuis voor het distale uiteinde worden verwijderd voordat de geleidedraad weer in de houder wordt geplaatst.
- Dit instrument bevat de volgende stof gedefinieerd als CMR 1A/1B en hormoononregelende stof in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent; Kobalt: CAS-nr. 7440-48-4.

Storingen en negatieve effecten

Mogelijke storingen en negatieve effecten als gevolg van het gebruik van deze geleidedraad zijn onder meer (maar niet uitsluitend) de volgende:

1. Storingen

Onmogelijkheid een laesie te passeren	Breuk of buiging van de geleidedraad	Schade zoals scheiding
Moelijke verwijdering	Loskomen van coating	Afval van een beschadigde geleidedraad

2. Negatieve effecten

Overlijden	Infectie	Vaatsdissectie
Vaatperforatie	Complicaties in de vorm van bloedingen	Embolie
Trombus	Infarct	Ischemia
Hartritmestoomis	Vasospasm	Vasculaire occlusie
Verlaagde bloeddruk	Allergische reactie	

Aanbevolen procedure

- Inspectie voorafgaand aan gebruik
 - Controleer vóór gebruik zorgvuldig of de geleidedraad en de verpakking niet beschadigd zijn.
 - Stel voor gebruik vast dat de geleidedraad geschikt is voor de te gebruiken interventie-

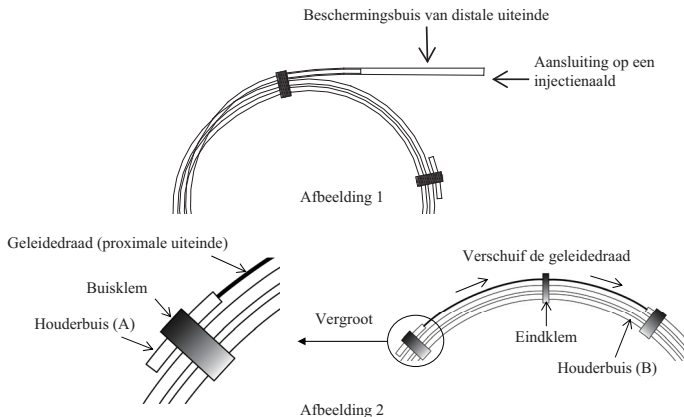
instrumenten.

2. Preparatie

- Selecteer de meest geschikte geleidedraad voor het aangedane gebied en neem de houderbuis waarin de geleidedraad zit uit de steriele verpakking.
- Vul de houderbuis met een gesteriliseerde zoutoplossing met heparine met behulp van een injectienaald om het hele instrument mee nat te maken. Houd er rekening mee dat de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine

tijdens het vullen uit de houderbuis kan morsen. Voor de houder met de beschermingsbuis aan het distale uiteinde (afbeelding 1) kan een injectiespuit worden aangesloten op de beschermingsbuis aan het distale uiteinde.

- Vul het lumen van het interventie-instrument met de gesteriliseerde oplossing met heparine voordat u de geleidedraad invoert.
- Maak de geleidedraad los uit de eindklem en schuif de geleidedraad langzaam, duw het distale uiteinde van de geleidedraad door de houderbuis (B) (Afbeelding 2).



- Wanneer het distale uiteinde van de geleidedraad 5 tot 6cm voorbij het andere uiteinde van de houderbuis (of de beschermingsbuis aan het distale uiteinde) is geschoven, moet u, indien nodig, het uiteinde volgens de standaardpraktijk vormen.
- Pak voorzichtig de geleidedraad vast uit het distale uiteinde van de houderbuis (of de beschermingsbuis aan het distale uiteinde) is gekomen, op het punt dat zo dicht mogelijk bij de houderbuis ligt en trek de geleidedraad er langzaam en voorzichtig uit.
- Als u weerstand voelt bij het uit de houderbuis verwijderen van de geleidedraad, moet u de gesteriliseerde zoutoplossing met heparine wederom in de houderbuis injecteren. Zet de

verwijdering van de geleidedraad voort wanneer u geen weerstand meer voelt. Zorg ervoor dat u voldoende gesteriliseerde zoutoplossing met heparine in de houderbuis injecteert omdat de hydrofiele coating beschadigd kan raken bij een krachtige verwijdering van de gecoate geleidedraad.

- Wanneer u de geleidedraad uit de houderbuis hebt getrokken, inspecteer u de geleidedraad zodat u zeker weet dat deze niet beschadigd is.

3. Procedures voor inbrengen

■ Over-de-draad-systeem

- Voor het distale uiteinde van de geleidedraad voorzichtig in de geleidedraad-lumen van het interventie-instrument in.

- Geleid deze geleidedraad voorzichtig door totdat de tip ervan net proximaal is aan het uiteinde van het interventie-instrument.
- Maak de geleidekatheter vast en voer het systeem van het interventie-instrument (met geleidedraad) in de Y-aansluiting.
- Voor het systeem van het interventie-instrument door de geleidekatheter totdat het uiteinde van het systeem van de geleidedraad net proximaal is aan de tip van de geleidekatheter.
- Draai de hemostaseklep van de Y-aansluiting dicht zodat een afdichting ontstaat rond het interventie-instrument. Controleer dat verplaatsing van de geleidedraad nog mogelijk is.
- Controleer nogmaals dat de geleidedraad gemakkelijk kan bewegen.
- Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.
- Voor deze geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- Voor het interventie-instrument in tot de laesie wordt bereikt, terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de locatie ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u het interventie-instrument manipuleert.

■ Systeem voor snelle verwisseling

- Bevestig de geleidekatheter.

- Voor de geleidedraad-introducer in de Y-aansluiting van de geleidekatheter in.
- Voor voorzichtig het uiteinde van de geleidedraad in de introducer in.
- Voor de geleidedraad onder fluoroscopie door de geleidekatheter tot het uiteinde van de geleidedraad net proximaal is aan het uiteinde van de geleidekatheter.
- Bevestig het torsie-instrument aan de geleidedraad, als dat nodig is.
- Voor de geleidedraad in met behulp van fluoroscopie tot voorbij de laesie. Bevestig door middel van angiografie dat de geleidedraad de vernauwde doellaesie heeft gepasseerd.
- Observeer de verplaatsing van de geleidedraad in de bloedvaten.
- Verwijder het torsie-instrument en de introducer van de geleidedraad.
- Leid het interventie-instrument over de geleidedraad terwijl u voorkomt dat de geleidedraad wordt verplaatst en ga door tot de laesie is bereikt. Zorg ervoor dat het distale uiteinde van de geleidedraad en de plaatsing ervan in het bloedvat zichtbaar zijn wanneer u met het interventie-instrument werkt.

4. Procedures voor het verwisselen van de geleidedraad

■ Over-de-draad-systeem

- Verwijder deze geleidedraad langzaam terwijl u onder fluoroscopie de verplaatsing van deze geleidedraad in de gaten houdt.
- Breng de volgende geleidedraad in volgens de aanwijzingen in dit hoofdstuk "Aanbevolen procedure".

Opslagmethode

Bewaar de geleidedraad en toebehoren niet in een gebogen en/of zwaar belaste toestand. Deze geleidedraad en toebehoren mogen niet nat worden. Bewaren op een koele, donkere en droge plek.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum van de geleidedraad staat vermeld op het etiket van de verpakking.

Inhoud

5 stuks/doors

Aansprakelijkheidsverklaring

Op geen enkele manier zal "ASAHI INTECC CO., LTD." en aan haar gelieerde bedrijven (hierna 'Bedrijf' genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, persoonlijke verwondingen,

negatieve effecten als het gevolg van een foutief gebruik van het(de) product(en) of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies. Het Bedrijf is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade (i) voortvloeiend uit de opslag van het product en/of de producten na verzending vanuit het Bedrijf of (ii) als gevolg van de keuze van patiënten, operatietechnieken of enige andere medische activiteiten door de medische instelling die het product en/of de producten gebruikt.

"SION" en "SUOH" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan en andere landen.

*De waarden van de belasting van het uiteinde vertegenwoordigen de gemiddelde waarden van de productspecificatiewaarden gemeten volgens de testmethode met interne standaard, uitgaande van de kracht die door het uiteinde van de geleidedraad op de laesie wordt uitgeoefend.

SION-sarjan PCI-ohjainvaijeri

Käyttöohjeet

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän ohjainvaijerin käyttöä ja noudata niiden kohtia ”Käyttötarkoitukset”, ”Vasta-aiheet”, ”Varoitukset”, ”Varoitimet ennen käyttöä” ja ”Käyttö”. Muuton seurauksena voi olla komplikaatioita, mukaan lukien potilaan vakava vammautuminen tai kuolema.

Jos käyttäjä ja/tai potilas havaitsee vakavan vaaratilanteen, joka liittyy ohjainvaijeriin, ilmoita siitä valmistajalle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Nämä käyttöohjeet koskevat SION-sarjan PCI-ohjainvaijeria. Katso lisätiedot (ohjainvaijerin pituus, röntgenpositiivisen osan pituus, jne.) tuotteen etiketistä.

Kuvaus

SION-sarjan PCI-ohjainvaijeri on kehitetty pehmeäkärkiseksi ohjainvaijeriksi, jotta voidaan minimoida verisuonen perforaation riski, sillä kovakärkisen ohjainvaijerin pitäminen verisuonessa saattaa johtaa verisuonen perforaatioon.

SION-vaijerin perusrakenne koostuu kapenevasta kierukkavaijerista, kahdesta erilaisesta distaalisesta kierukasta (ulkokierukasta ja sisäkierukasta) ja turvavaijerista. Kapeneva kierukkavaijeri, kierukat ja turvavaijeri on juotettu. Ulkokierukan pituus on osittain röntgenpositiivinen, jotta sen sijainti voidaan helposti vahvistaa läpivalaisuilla. SION-vaijerissa on taipuisa 0,7 gF^m:n kärkivoima, jotta voidaan varmistaa verisuonen turvallisuus. Nauhasta valmistettu sisäkierukka asetetaan ulkokierukan sisälle, ja turvavaijeri liitetään sisäkierukkaan ja kärkeen, jotta turvavaijeri ei irtoa myöskään siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että kapeneva kierukkavaijeri irtoaa kärkestä; tämä estää ulkokierukkaa ja kapenevaa kierukkavaijeria irtoamasta. SION-vaijerin distaalinen pää on pinnoitettu hydrofiilisella polymeerillä.

Sinissä SION-vaijerissa on sama perusrakenne kuin SION-vaijerissa, mutta osa pinnoitteesta ulkokierukan kärjessä on silikoinen, jolloin kärki on taipuisampi kuin SION-vaijerissa ja kärkivoima on 0,5 gF^m.

Sinisen SION ES -vaijerin distaalisessa päässä on sama perusrakenne kuin sinisessä SION-vaijerissa ja kärkivoima on 0,5 gF^m, mutta ulkokierukka on lyhyempi ja varsi on jäykempi. Sisärakenteessa ei ole turvavaijeria, mutta kapenevan kierukkavaijerin distaalinen rakenne on kehitetty, jotta ohjainvaijerin proksimaalinen puoli ei irtoa helposti. Kuten sinisessä SION-vaijerissa, sinisen SION ES -vaijerin pinnoite on silikoinen distaalisessa päässä ja hydrofiilinen proksimaalisessa päässä, ja hydrofiilinen pinnoite on piempi kuin sinisessä SION-vaijerissa.

Musta SION-vaijeri eroaa SION-vaijerista ja sinisestä SION-vaijerista siten, että sen ulkokierukassa on polyuretaaninen pinnoite ja sen päällä hydrofiilinen pinnoite. Kärkivoima on 0,8 gF^m.

SUOH 03 -vaijerin perusrakenne on sama kuin sinisessä SION-vaijerissa ja sinisessä SION ES -vaijerissa, mutta siinä käytetään nauhasta valmistettua ulkokierukkaa, joten siinä on SION-sarjan pienin kärkivoima eli 0,3 gF^m. Distaalisessa pinnassa on hydrofiilinen pinnoite.

Kaikissa SION-sarjan PCI-ohjainvaijerissa kapenevan kierukkavaijerin proksimaalinen puoli on pinnoitettu PTFE:llä (polytetrafluorieteeni). Tuotteen nimellinen ulkohalkaisija on 0,36 mm (0,014 tuumaa) koko pituuden matkalta. Laitteiden proksimaalinen pää on alle 300 cm pitkä ja siinä on liitäntä

jatkovaijerille, jolla korvataan yhdistetty laite. Ohjainvaijeriin voidaan liittää ASAHI INTECCin valmistama jatkovaijeri.

	Kärkivoima*	Ulkohalkaisija	Pinnoitteen pituus	Kierukan pituus	Röntgenpositiivinen pituus
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofiilinen pinnoite : 28,5 cm	28 cm	3 cm
Sininen SION	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonipinnoite : 1,5 cm Hydrofiilinen pinnoite : 19,0 cm	20 cm	3 cm
Sininen SION ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonipinnoite : 2,5 cm Hydrofiilinen pinnoite : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
Musta SION	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polyuretaanipinnoite : 20,0 cm Hydrofiilinen pinnoite : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofiilinen pinnoite : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Käyttötarkoitukset

Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu tyypillisiin perkutaanisiin sepelvaltimotoimenpiteisiin (PCI). Tämä ohjainvaijeri on tarkoitettu helpottamaan pallolaajennuskatetrien tai muiden toimenpidevälineiden asettamista verisuonistoon. Käytön keskimääräisen keston odotetaan olevan 120 minuuttia. **Tätä ohjainvaijeria ei ole tarkoitettu käytettäväksi neurovaskulaarisissa eikä ääreisverisuoniston toimenpiteissä.**

Hoidettava kohderyhmä

SION-sarjan PCI-ohjainvaijerit on tarkoitettu potilaille, jotka täyttävät PCI-toimenpiteiden käyttöaiheet. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi imeväisillä, sylilapsilla tai lapsilla, eikä potilailla, jotka ovat raskaana, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai jotka ovat allergisia varjoaineelle tai polyeteeniglykolille (PEG).

Vasta-aiheet

- Varmista, että ohjainvaijerin halkaisija sopii yhteen muiden toimenpidevälineiden kanssa, ennen kuin alat käyttää sitä.
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia varjoaineelle tai joilla on munuaisten vajaatoiminta.
- Tämän ohjainvaijerin hydrofiilisessa pinnoitteessa on PEG400:aa. Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat allergisia polyeteeniglykolille (PEG).
- Älä käytä ohjainvaijeria potilailla, jotka ovat raskaana tai saattavat olla raskaana (röntgenkuvaus voi vaikuttaa sikiöön).
- Tätä ohjainvaijeria saa käyttää vain hoitolaitoksessa, jossa voidaan tarvittaessa tehdä välittömästi hätäleikkaus. Jos hätäleikkauksen ei ole valmiutta, pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla hengenvaara.
- Ohjainvaijeri on steriloitu valmiiksi etyleenioksidikaasulla ja se on kertakäyttöinen. Älä käytä tätä steriloitu sitä uudelleen. Uudelleenkäyttö tai -sterilointi voi heikentää ohjainvaijerin ja pakkauksen toimintaa tai laaturia ja aiheuttaa komplikaatioita, kuten infektion.

Varoitukset

- Ohjainvaijeria saa käyttää vain lääkäri, joka hallitsee PCI-toimenpiteen.
- Älä koskaan käytä tätä ohjainvaijeria yhdessä katetrien, joissa on metalliosia, jotka voivat olla suoraan kosketuksissa ohjainvaijerin pinnan kanssa (esim. aterektoimakatetrit, metalliset laajentimet), metallineulujen tai metallisten sisäänvientiholkkien kanssa.

- Tarkkaile ohjainvaijerin kärjen liikettä fluoroskopian avulla, kun käytät laitetta. Älä käytä ohjainvaijeria verisuonen kohdissa, jotka eivät näy tai joita ei voi kuvantaa.
- Älä kytkä tätä ohjainvaijeria muiden kuin ASAHI INTECCin valmistamiin irrotettaviin

Varotoimet ennen käyttöä

- Älä käytä ohjainvaijeria etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivän umpeuduttua. Hävitä ohjainvaijerit, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut.
- Ohjainvaijerit ovat helposti vaurioituvia instrumentteja, minkä vuoksi niitä on käsiteltävä varoen.
- Jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut, älä käytä ohjainvaijeria. Avaa pakkaus vasta juuri ennen käyttöä. Käsittele ja käytä ohjainvaijeria aseptisesti.
- Pidä ohjainvaijeri aina märkänä, jotta sen hydrofiilinen pinnote ei vaurioidu.
- Älä pyyhi ohjainvaijeria orgaanisella liuoksella, kuten alkoholilla.
- Huolehdi infektioerjunnasta käytön jälkeen. Hävitä ohjainvaijeri ja sen pakkaus sairaalajätteenä.
- Älä koskaan työnnä, kairaa, vedä tai pyöritä ohjainvaijeria, jos siinä tuntuu vastusta. Ohjainvaijerin pyörittäminen tai työntäminen vastusta vastaan voi aiheuttaa vaurioita ja/tai kärjen irtoamisen ohjainvaijerista tai verisuonen suoran vaurioitumisen. Ohjeen noudattamisen laiminlyönti voi vaurioittaa ohjainvaijeria. Selvitä vastuksen syy fluoroskopian avulla ja poista se tarvittavilla korjaustoimenpiteillä.
- Työnnä ja vedä ohjainvaijereita aina hitaasti ja varovasti.
- Kun pyörität ohjainvaijeria verisuonessa, älä pyöritä sitä jatkuvasti samaan suuntaan. Kun pyörität ohjainvaijeria, pyöritä sitä vuoroin myötä- ja vastapäivään. Pyöritä enintään kaksi täyttä kierrosta (720°) samaan suuntaan.
- Huuhtelee ohjainvaijeria heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella tai muulla soveltuvalla liuoksella sen poiston ja sisäänviennin aikana, jotta toimenpidevälineeseen ei pääse ilmaa. Vaihda ohjainvaijeri erityisen varovasti, jotta suoneen ei pääse ilmaa ja/tai se ei vaurioidu. Kun viet ohjainvaijerin uudelleen sisään, varmista, että toimenpidevälineen kärki on vapaana verisuonen lumenissa eikä kosketa verisuonen seinämää.

- jatkovaijereihin. Älä käsittele ohjainvaijeria, kun siihen on kytketty irrotettava jatkovaijeri. Muutoin ohjainvaijeri voi vaurioitua tai irrotettava jatkovaijeri voi vahingossa irrota.
- Älä muuntele ohjainvaijeria mistään syystä.

- Muutoin se saattaa aiheuttaa vamman. Varmista sijainti toimenpidevälineen röntgenpositiivisen merkitsimen avulla.
- Ohjainvaijerin vapaa liikkuvuus toimenpidevälineen sisällä on ohjattavan ohjainvaijerin keskeinen ominaisuus, koska se antaa käyttäjälle arvokasta tunteen perustuvaa tietoa. Tarkista järjestelmä vastuksen varalta ennen käyttöä. Jos havaitset hemostaasiventtiilin häiritsevän ohjainvaijerin liikkumista, säädä hemostaasiventtiiliä tai korvaa se säädettävällä venttiilillä.
 - Älä asenna stenttiä käyttäen useampaa kuin yhtä ohjainvaijeria äläkä käytä ohjainvaijeria stentin tuen läpi. Muutoin stentti saattaa vaurioitua ja ohjainvaijeri murtua tai katketa.
 - Varmista ennen käyttöä, että tämä ohjainvaijeri on toimenpiteen kannalta sopivan kokoinen ja muutoin ja että se sopii yhteen sen kanssa käytettävän laitteen kanssa.
 - Katso yhdessä ohjainvaijerin kanssa käytettävän lääkinällisen laitteen (esim. pallolajajennuskatetrin tai muun toimenpidevälineen) käyttöohjeet.
 - Kun kytket ohjainvaijeriin irrotettavan jatkovaijerin, työnnä se kunnolla ei-PTFE-pinnoitteen ja PTFE-pinnoitteen rajaviivaan asti ohjainvaijerin proksimaalisessa päässä. Jos havaitset kytkennässä jotakin epätavallista, lopeta ohjainvaijerin käyttö välittömästi.
 - Tarkista ohjainvaijeri huolellisesti ennen käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteen aikana mutkien, taittumisen tai muiden vaurioiden varalta. Älä käytä ohjainvaijeria, jos se on vaurioitunut.
 - Varo vahingoittamasta kierukkaa, kun muotoilet kärkeä.
 - Tarkista ennen ohjainvaijerin sisäänvientiä, kumpi pää on distaalinen pää, ja varmista, että viet ohjainvaijerin sisään distaalisesta päästä.
 - Pidä yllä toimenpiteen ajan jatkuvaa keittosuolaliuoshuuteltua ohjainkatetrin ja toimenpidevälineen sekä toimenpidevälineen ja ohjainvaijerin välillä. Huuhtelu estää

- varjoaineen kertymisen ja/tai hyytymisen ohjainvaijeriin ja katetrin lumeniin.
- Pakkausputki distaalisen päään suojaputkella (katso kohta Käyttö, kuva 1): älä poista tai aseta distaalisen päään suojaputkea, kun ohjainvaijeri on pakkausputkessa.
 - Pakkausputki distaalisen päään suojaputkella (katso kohta Käyttö, kuva 1): poista distaalisen

- pään suojaputki, ennen kuin asetat ohjainvaijerin uudelleen pakkausputkeen.
- Tämä laite sisältää seuraavaa CMR-aineiden 1A/1B-luokkaan luokiteltua ja hormonitoimintaa häiritsevää ainetta yli 0,1paino-% pitoisuutena; koboltti CAS-nro: 7440-48-4.

Toimintahäiriöt ja haittatapahtumat

Ohjainvaijerin käyttöön liittyy muun muassa seuraavia mahdollisia toimintahäiriöitä ja haittatapahtumia:

1. Toimintahäiriöt

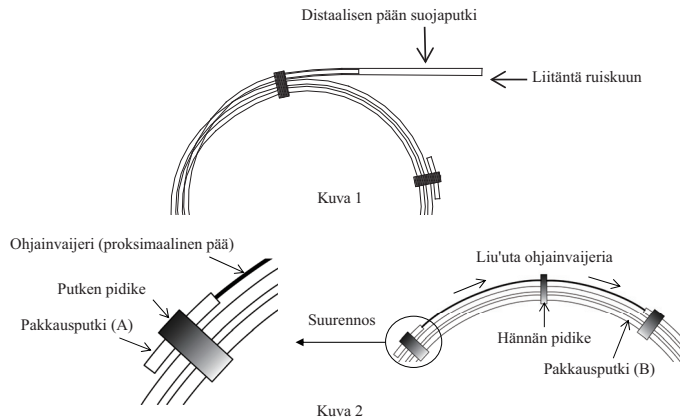
leesion ohittamisen epäonnistuminen	ohjainvaijerin rikkoutuminen tai taipuminen	vaurioituminen, kuten katkeaminen
poistamiseen liittyvät vaikeudet	pinnoitteen irtoaminen	vaurioituneesta ohjainvaijerista irtoavat kappaleet

2. Haittatapahtumat

kuolema	infektio	verisuonen dissekoituma
verisuonen perforaatio	verenvuotokomplikaatit	embolia
trombi	infarkti	iskemia
eteisvärinä	vasospasmi	verisuonen okklusio
verenpaineen lasku	allerginen reaktio	

Käyttö

1. Tarkistus ennen käyttöä
 - a) Tarkista ohjainvaijeri ja sen pakkaus huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia.
 - b) Varmista ennen käyttöä, että ohjainvaijeri on yhteensopiva käytettävien toimenpidevälineiden kanssa.
2. Valmistelu
 - a) Valitse hoidettavalle alueelle sopivin ohjainvaijeri ja poista ohjainvaijerin sisältävä pakkausputki steriilistä pakkauksesta.
 - b) Täytä pakkausputki ruiskun avulla heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella, jotta koko laite huuhtoutuu. Huomaa, että pakkausputkesta voi tässä vaiheessa vuotaa ulos heparinoitua ja steriloitua keittosuolaliuosta. Distaalisella päällä varustetussa pidikkeessä (kuva 1), ruisku voidaan liittää distaaliseseen päään suojaputkeen.
 - c) Täytä toimenpidevälineen lumen heparinoidulla ja steriloidulla keittosuolaliuoksella ennen ohjainvaijerin sisäänvientiä.
 - d) Irrota ohjainvaijerin pääsi hännän pidikkeestä ja liu'uta ohjainvaijeria hitaasti painamalla sen distaalista päätä pakkausputken (B) läpi (kuva 2).



e) Kun ohjainvaijerin distaalinen pää on tullut yli 5–6 cm ulos pakkausputken (tai distaalisen pään suojaputken) toisesta päästä, muotoile kärkeä tarvittaessa vakiomenetelmän mukaisesti.

f) Ota varovasti kiinni pakkausputken distaalisesta päästä (tai distaalisen pään suojaputkesta) ulos tulleesta ohjainvaijerista mahdollisimman läheltä pakkausputkea ja vedä ohjainvaijeri ulos hitaasti ja varovasti.

g) Jos tunnet vastusta ottaessasi ohjainvaijeria pois pakkausputkesta, ruiskuta pakkausputkeen lisää heparinointia ja steriloitua keittosuolaliuosta. Jatka ohjainvaijerin poistamista putkesta vasta sitten, kun vastusta ei enää tunnu. Varmista, että ruiskutat pakkausputkeen riittävästi heparinointia ja steriloitua keittosuolaliuosta, sillä hydrofiilinen pinnoite saattaa vaurioitua, jos pinnoitetta ohjainvaijeri otetaan putkesta väkisin.

h) Kun olet vetänyt ohjainvaijerin pakkausputkesta, tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

3. Sisäänvientä

■ Over-the-wire-järjestelmä

a) Vie ohjainvaijerin distaalinen pää varovasti

toimenpidevälineen ohjainvaijeriluumeniin.

b) Työnnä ohjainvaijeria varovasti eteenpäin, kunnes sen kärki on aivan toimenpidevälineen kärjen proksimaalisella puolella.

c) Kiinnitä ohjainkatetri ja vie toimenpidevälinejärjestelmä (ohjainvaijerin kanssa) Y-liitoskappaleeseen.

d) Työnnä toimenpidevälinejärjestelmää ohjainkatetrin läpi, kunnes ohjainvaijerijärjestelmän kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.

e) Kiristä Y-liitoskappaleen hemostaasiventtiiliä niin, että se tiivistyy toimenpidevälineen ympärille. Varmista, että ohjainvaijeria voi vielä liikuttaa.

f) Varmista, että ohjainvaijeri liikkuu tasaisesti.

g) Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.

h) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtaautuneen kohdelesion.

i) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.

j) Työnnä toimenpidevälinettä eteenpäin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin

liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

■ Rapid exchange -järjestelmä

a) Kiinnitä ohjainkatetri.

b) Työnnä ohjainvaijerin sisäänviejä ohjainkatetrin Y-liitoskappaleeseen.

c) Vie ohjainvaijerin kärki varovasti sisäänviejään.

d) Työnnä ohjainvaijeria ohjainkatetrin läpi fluoroskopiassa, kunnes ohjainvaijerin kärki on aivan ohjainkatetrin kärjen proksimaalisella puolella.

e) Liitä ohjainvaijeriin tarvittaessa pyöritin.

f) Työnnä ohjainvaijeria fluoroskopian avulla leesion läpi. Varmista angiografialla, että ohjainvaijeri on ohittanut ahtaautuneen

kohdelesion.

g) Tarkkaile ohjainvaijerin liikettä verisuonissa.

h) Irrota ohjainvaijerin pyöritin ja ohjainvaijerin sisäänviejä.

i) Kuljeta toimenpideväline ohjainvaijeria pitkin leesiokohtaan ja estä samalla ohjainvaijerin liikkuminen. Varmista, että ohjainvaijerin distaalinen kärki ja sen sijainti verisuonessa ovat näkyvissä toimenpidevälineen käsittelyn aikana.

4. Ohjainvaijerin vaihto

■ Over-the-wire-järjestelmä

a) Poista ohjainvaijeri varovasti ja seuraa samalla sen liikettä fluoroskopian avulla.

b) Vie seuraava ohjainvaijeri paikalleen kohdan "Käyttö" ohjeiden mukaisesti.

Säilytys

Älä säilytä ohjainvaijeria ja pakkausta taivutettuna ja/tai raskaasti kuormitettuna. Tämä ohjainvaijeri ja sen pakkaus on pidettävä poissa vedestä. Säilytettävä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Viimeinen käyttöpäivä

Viimeinen käyttöpäivä on merkitty ohjainvaijerin pakkauksen etikettiin.

Sisältö

5 kpl / laatikko

Vastuuvapauslauseke

"ASAHI INTECC CO., LTD. ja sen konserniyhtiöt" (jäljempänä "yritys") eivät vastaa millään tavoin vahinkotapahtumista, henkilövammoista tai haittatapahtumista, jotka johtuvat tuotteen (tuotteiden) epäasianmukaisesta käytöstä tai mistä tahansa muusta näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä. Yritys ei missään tapauksessa vastaa vahingoista, jotka johtuvat joko (i) tuotteen (tuotteiden) säilytyksestä sen jälkeen kun yritys on ne lähettänyt tai (ii) potilaiden valinnasta, leikkaustekniikoista tai mistä tahansa muista tuotetta (tuotteita) käyttävän hoitolaitoksen lääkinnällisistä toimenpiteistä.

"SION" ja "SUOH" ovat ASAHI INTECC CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Japanissa ja muissa maissa.

*Kärkivoiman arvot tarkoittavat tuotteen teknisten tietojen keskiarvoja, jotka on mitattu sisäisen vakiotestausmenetelmän mukaisesti, jossa mitataan leesion ohjainvaijerin kärjellä kohdistettu voima.

Fil guide pour ICP de la série SION

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce fil guide et respecter les rubriques Indications d'utilisation, Contre-indications, Avertissements, Précautions, et Méthode d'utilisation de ce mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des complications, notamment des blessures graves ou le décès du patient.

Si un utilisateur et/ou un patient a connaissance d'un incident grave lié au fil guide, il doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre.

Ce mode d'emploi concerne le fil guide pour ICP de la série SION. Pour plus de détails (longueur du fil guide, longueur de la partie radio-opaque, etc.), consulter l'étiquette du produit.

Descriptions

Contrairement à un fil guide à pointe rigide qui risque d'entraîner une perforation vasculaire, le fil guide pour ICP de la série SION a été conçu avec une pointe souple afin de réduire le risque de perforation vasculaire lors de son maintien dans un vaisseau.

La structure de base de SION se compose d'un fil central conique, de deux types de spirales distales (une spirale externe et une spirale interne) et d'un fil de sécurité. Le fil central conique, les spirales et le fil de sécurité sont soudés. Une partie de la spirale extérieure est radio-opaque, ce qui permet de vérifier facilement sa position par radioscopie. SION a une charge de pointe flexible de 0,7 gf* pour garantir la sécurité dans les vaisseaux sanguins. Une spirale intérieure en corde est placée à l'intérieur de la spirale extérieure, et le fil de sécurité est fixé à la spirale intérieure et à la pointe de manière à ce que le fil de sécurité ne se détache pas, même dans le cas improbable où le fil central conique se détacherait de la pointe, empêchant ainsi la spirale extérieure et le fil central conique de se détacher. Le côté distal de SION est recouvert d'un polymère hydrophile.

SION blue a la même structure de base que SION, mais une partie du revêtement de la pointe de la spirale extérieure est en silicone, ce qui rend la pointe plus flexible que celle de SION, et la charge de pointe est de 0,5 gf*.

La structure de base du côté distal de SION blue ES est la même que celle de SION blue et la charge de pointe est de 0,5 gf*, mais la spirale extérieure est plus courte et la gaine plus rigide. La structure interne ne comporte pas de fil de sécurité, mais la conception distale du fil central conique est pensée de manière à ce que le côté proximal du fil guide ne soit pas facilement délogé. Comme pour SION blue, le revêtement de SION blue ES est en silicone sur la partie distale et hydrophile sur la partie proximale, et la longueur du revêtement hydrophile est plus importante que celle de SION blue.

SION black diffère de SION et de SION blue en ce qu'il possède un revêtement en résine polyuréthane sur la spirale extérieure et un revêtement hydrophile par-dessus. La charge de pointe est de 0,8 gf*.

La structure de base de SUOH 03 est la même que celle de SION blue et de SION blue ES, mais il possède une spirale extérieure en corde, ce qui explique qu'il a la charge de pointe la plus faible de la série SION, à savoir 0,3 gf*. La surface distale est recouverte d'un revêtement hydrophile.

Dans tous les fils guides pour ICP de la série SION, le côté proximal du fil central conique est revêtu de PTFE (polytétrafluoroéthylène). Le diamètre extérieur nominal du produit est de 0,36 mm (0,014 po) sur toute la longueur. À l'extrémité proximale des dispositifs de moins de 300 cm se trouve une connexion pour

un prolongateur, qui est utilisé pour remplacer le dispositif combiné ; le prolongateur d'ASAHI INTECC peut y être connecté.

	Charge de pointe*	Diamètre extérieur	Longueur du revêtement	Longueur de la spirale	Longueur radio-opaque
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 po)	Revêtement hydrophile : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014 po)	Revêtement en silicone : 1,5 cm Revêtement hydrophile : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 po)	Revêtement en silicone : 2,5 cm Revêtement hydrophile : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014 po)	Revêtement en polyuréthane : 20,0 cm Revêtement hydrophile : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 po)	Revêtement hydrophile : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indications d'utilisation

Ce fil guide est conçu pour les interventions coronariennes percutanées (ICP) courantes. Ce fil guide est destiné à faciliter la mise en place de cathéters de dilatation à ballonnet ou d'autres dispositifs thérapeutiques d'intervention dans le système cardiovasculaire. La durée moyenne d'utilisation attendue est de 120 minutes. **Ce fil guide n'est pas destiné à être utilisé dans le système neurovasculaire ni dans le système vasculaire périphérique.**

Population traitée cible

Le fil guide pour ICP de la série SION est destiné aux patients qui répondent aux indications des procédures d'ICP. Le fil guide n'est pas indiqué pour les nouveau-nés, les nourrissons ou les enfants, ainsi que pour les patientes enceintes, les personnes souffrant d'insuffisance rénale et celles qui ont une réaction allergique aux produits de contraste ou au polyéthylène glycol (PEG).

Contre-indications

- Vérifier la compatibilité du diamètre du fil guide avec d'autres dispositifs d'intervention avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont une réaction allergique aux produits de contraste ou qui présentent une insuffisance rénale.
- Ce fil guide contient du PEG400 dans son revêtement hydrophile. Ne pas utiliser le fil guide chez des patients qui ont des réactions allergiques au polyéthylène glycol (PEG).
- Ne pas utiliser le fil guide chez des patientes enceintes ou susceptibles de l'être (les rayons X peuvent affecter le fœtus).
- Ce fil guide doit être utilisé dans un établissement médical en mesure de réaliser immédiatement une intervention chirurgicale d'urgence. S'il n'est pas possible de réaliser d'intervention chirurgicale d'urgence, dans le pire des cas, des événements potentiellement mortels peuvent survenir.
- Ce fil guide est pré-stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène et il est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser. En cas de réutilisation ou de restérilisation, des performances ou la qualité de ce fil guide et de l'emballage peuvent être affectées et il existe un risque de complications, voire d'infection.

Avertissements

- Ce fil guide doit être utilisé uniquement par un médecin ayant reçu une formation complète sur le traitement par ICP.

- Ne jamais utiliser ce fil guide en association avec des cathéters comportant des parties métalliques susceptibles d'entrer directement en contact avec la surface du fil guide (p. ex., cathéters d'athérectomie, dilateurs métalliques), des aiguilles métalliques ou des insérateurs de gaines métalliques.
- Vérifier et surveiller le mouvement de la pointe du fil guide sous radioscopie pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans des zones du

- vaisseau qui ne sont pas visibles ou ne peuvent être visualisées.
- Ne pas relier ce fil guide à des prolongateurs détachables de fabricants autres que ASAHI INTECC. Ne pas manipuler ce fil guide lorsque le prolongateur détachable est connecté. Autrement, le fil guide pourrait s'endommager, ou le prolongateur détachable pourrait se détacher involontairement.
- Ne pas modifier ce fil guide pour quelque raison que soit.

Précautions

- Ne pas utiliser le fil guide au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Jeter tout fil guide ayant dépassé la date de péremption.
- Les fils guides sont des instruments fragiles et doivent être manipulés avec soin.
- Si l'emballage est ouvert ou endommagé, ne pas utiliser le fil guide. Ne pas ouvrir l'emballage avant l'emploi. Prendre des mesures aseptiques au cours de la manipulation et de l'utilisation du fil guide.
- Maintenir en permanence le fil guide à l'état humide afin de ne pas endommager son revêtement hydrophile.
- Ne pas essuyer ce fil guide à l'aide d'une solution organique telle que l'alcool.
- Après utilisation, prendre des mesures préventives contre les infections. Mettre au rebut ce fil guide et l'emballage en tant que déchets médicaux.
- Ne jamais pousser, vriller, rétracter le fil guide ou lui appliquer une torsion lorsqu'il rencontre une résistance. Le fait d'appliquer une torsion ou de pousser ce fil guide alors qu'il rencontre une résistance risque de l'endommager et/ou d'entraîner la séparation de la pointe du fil guide ou de léser directement un vaisseau. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le fil guide. Déterminer la cause de la résistance sous radioscopie et prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème.
- Toujours faire avancer ou retirer les fils guides lentement et avec précaution.
- Lorsque ce fil guide est soumis à une torsion dans le vaisseau sanguin, ne pas appliquer de torsion continue dans la même direction. Lors de la torsion du fil guide, le faire tourner alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Ne pas effectuer plus de deux rotations (720°) dans la même direction.
- Rincer le fil guide avec une solution saline héparinisée et stérilisée ou toute autre solution adéquate lors du retrait ou de la réinsertion afin d'éviter toute pénétration d'air dans le dispositif d'intervention. Changer ce fil guide avec précautions afin d'éviter l'entrée de l'air et/ou un traumatisme. Au moment de réintroduire le fil guide, vérifier que la pointe du dispositif d'intervention n'est pas coincée dans la lumière du vaisseau et ne se trouve pas contre la paroi du vaisseau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un traumatisme. Utiliser le marqueur radio-opaque du dispositif d'intervention pour vérifier la position.
- Le libre mouvement du fil guide dans le dispositif d'intervention est une caractéristique importante d'un système de fil guide orientable puisqu'il donne à l'utilisateur de précieuses informations tactiles. Tester la résistance du système avant toute utilisation. Régler la valve hémostatique ou la remplacer par une valve réglable s'il s'avère qu'elle empêche le mouvement du fil guide.
- Ne pas pratiquer la pose de stent en utilisant plus d'un fil guide, ne pas manipuler le fil guide à travers les entretours du stent. Sinon, le stent peut être endommagé ou le fil guide peut se rompre ou se disloquer.
- Avant utilisation, s'assurer que ce fil guide est de taille et de forme appropriées pour la procédure et qu'il est compatible avec le dispositif à utiliser en association.
- Consulter le mode d'emploi joint au dispositif médical (p. ex., cathéters de dilatation à ballonnet ou autres dispositifs d'intervention) qui sera utilisé en association avec ce fil guide.
- Lors de la connexion du prolongateur détachable à ce fil guide, celui-ci doit être inséré en toute sécurité à la ligne de démarcation entre le

- revêtement non PTFE et le revêtement PTFE à l'extrémité proximale de ce fil guide. Si une anomalie est constatée au niveau de la connexion, cesser immédiatement d'utiliser le fil guide.
- Inspecter soigneusement le fil guide à la recherche de plis, torsions ou autres dommages avant toute utilisation et à chaque fois que cela est possible au cours de la procédure. Ne pas utiliser le fil guide s'il est endommagé.
- Faire attention à ne pas endommager la spirale lors de la mise en forme de la pointe.
- Avant d'insérer le fil guide, vérifier quelle est l'extrémité distale et veiller à l'insérer à partir de l'extrémité distale.
- Maintenir un rinçage à la solution saline continu entre le cathéter de guidage et le dispositif d'intervention et entre le dispositif d'intervention et le fil guide pendant la procédure. Le rinçage

empêche la formation de produit de contraste et/ou la coagulation sur le fil guide et dans la lumière du cathéter.

- Pour le support avec le tube de protection de l'extrémité distale (voir Méthode d'utilisation, Figure 1), ne pas retirer ou insérer le tube de protection de l'extrémité distale lorsque le fil guide est introduit dans le support.
- Pour le support avec le tube de protection de l'extrémité distale (voir Méthode d'utilisation, Figure 1), retirer le tube de protection de l'extrémité distale avant de réintroduire le fil guide dans le support.
- Ce dispositif contient la substance suivante classée CMR 1A/1B et perturbateur endocrinien à une concentration supérieure à 0,1 % de fraction massique ; Cobalt : N° CAS 7440-48-4.

Dysfonctionnements et effets indésirables

Les dysfonctionnements et effets indésirables dérivés de l'utilisation de ce fil guide comprennent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

1. Dysfonctionnements

Non-franchissement d'une lésion	Rupture ou déformation du fil guide	Dommages tels que la séparation
Difficulté de retrait	Décollement du revêtement	Débris provenant d'un fil guide endommagé

Mort	Infection	Dissection de vaisseau
Perforation de vaisseau	Complications hémorragiques	Embolie
Thrombose	Infarctus	Ischémie
Arrythmie	Vasospasme	Occlusion vasculaire
Baisse de la tension artérielle	Réaction allergique	

Méthode d'utilisation

1. Examen préalable à l'utilisation

- Avant utilisation, effectuer un examen attentif et s'assurer que le fil guide et l'emballage ne sont pas endommagés.
- Avant utilisation, s'assurer que le fil guide est compatible avec les dispositifs d'intervention qui seront utilisés.

2. Préparation

- Sélectionner le fil guide le plus adapté pour la zone concernée et retirer le support tubulaire

- contenant le fil guide de l'emballage stérile.
- Remplir le support tubulaire avec une solution saline héparinisée et stérilisée en utilisant une seringue de manière à faire tremper l'ensemble du dispositif. Il est à noter que la solution saline héparinisée et stérilisée peut s'écouler du support tubulaire à ce moment-là. Pour le support avec tube de protection d'extrémité distale (Figure 1), une seringue peut être raccordée au tube de protection d'extrémité distale.
- Remplir la lumière du dispositif d'intervention

- avec la solution saline héparinisée et stérilisée avant d'insérer le fil guide.
d) Libérer le fil guide de l'attache et faire glisser

lentement le fil guide, pousser l'extrémité distale du fil guide à travers le support tubulaire (B) (Figure 2).

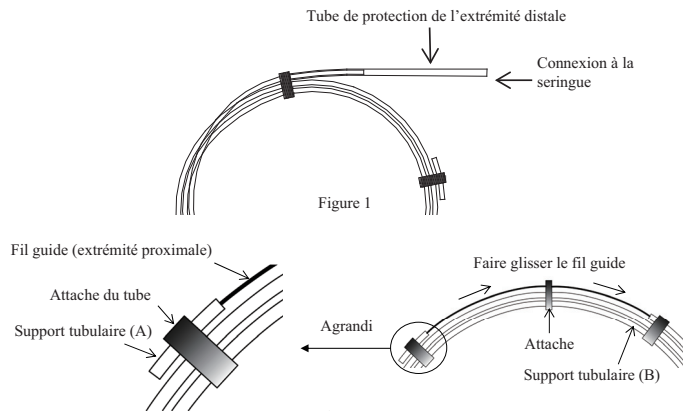


Figure 2

- e) Quand l'extrémité distale du fil guide s'étend de 5 à 6 cm au-delà de l'autre extrémité du support tubulaire (ou du tube de protection de l'extrémité distale), si nécessaire, former la pointe conformément aux pratiques courantes.
f) Saisir doucement le fil guide qui sort de l'extrémité distale du support tubulaire (ou du tube de protection de l'extrémité distale), à un point aussi proche que possible du support tubulaire, et sortir le fil guide lentement et avec précautions.
g) En cas de résistance lors du retrait du fil guide du support tubulaire, injecter de nouveau de la solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Une fois que la résistance a disparu, continuer à retirer le fil guide. S'assurer d'injecter suffisamment de solution saline héparinisée et stérilisée dans le support tubulaire. Le retrait forcé du fil guide revêtu peut en effet endommager le revêtement hydrophile.
h) Après avoir retiré le fil guide du support tubulaire, l'examiner pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

3. Procédures d'insertion

■ Système sur fil

- a) Insérer soigneusement l'extrémité distale du fil guide dans la lumière du fil guide du dispositif d'intervention.
b) Faire progresser doucement ce fil guide jusqu'à ce que sa pointe soit toute proche de la pointe du dispositif d'intervention.
c) Engager le cathéter-guide et insérer le dispositif d'intervention (avec le fil guide) dans le connecteur en Y.
d) Faire progresser le dispositif d'intervention dans le cathéter-guide jusqu'à ce que la pointe du système de fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
e) Serrer la valve hémostatique du connecteur en Y pour sceller le tout autour du dispositif d'intervention. S'assurer que le fil guide peut encore bouger.
f) Vérifier que le fil guide se déplace sans difficulté.
g) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.
h) Faire progresser ce fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide

a franchi la lésion cible rétrécie.

- i) Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
j) Faire progresser le dispositif d'intervention jusqu'à ce qu'il atteigne la lésion tout en évitant que le fil guide ne bouge. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

■ Système d'échange rapide

- a) Engager le cathéter-guide.
b) Insérer l'introducteur de fil guide dans le connecteur en Y du cathéter-guide.
c) Insérer soigneusement la pointe du fil guide dans l'introducteur.
d) Faire avancer le fil guide dans le cathéter-guide sous radioscopie jusqu'à ce que la pointe du fil guide soit toute proche de la pointe du cathéter-guide.
e) Fixer, si nécessaire, le dispositif de couple au fil guide.

- f) Faire progresser le fil guide sous radioscopie pour franchir la lésion. Confirmer par angiographie que le fil guide a franchi la lésion cible rétrécie.
g) Observer le mouvement du fil guide dans les vaisseaux.
h) Retirer le dispositif de couple de fil guide et l'introducteur de fil guide.
i) Suivre le dispositif d'intervention sur le fil guide tout en empêchant le fil guide de bouger, et le faire avancer jusqu'à atteindre la lésion. S'assurer que la pointe distale du fil guide et son emplacement dans le vaisseau soient visibles pendant les manipulations du dispositif d'intervention.

4. Procédures de changement du fil guide

■ Système sur fil

- a) Retirer lentement ce fil guide en surveillant ses mouvements sous radioscopie.
b) Insérer le fil guide suivant conformément aux instructions de la section « Méthode d'utilisation ».

Méthode d'entreposage

Ne pas plier le fil guide et l'emballage et/ou ne pas mettre de poids dessus. Le fil guide et l'emballage ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Conserver dans un lieu frais, sombre et sec.

Date de péremption

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette de l'emballage du fil guide.

Contenu

5 pièces/coffret

Clause de non-responsabilité

En aucun cas « ASAHI INTECC CO., LTD. et ses filiales » (ci-après appelées l'« Entreprise ») ne seront tenues responsables des accidents, des blessures corporelles, des effets indésirables causés par un mauvais usage du ou des produit(s) ou par un usage ne respectant pas les présentes instructions. En aucun cas, l'Entreprise ne sera tenue pour responsable de tout dommage (i) résultant du mode d'entreposage du ou des produits suite à leur expédition depuis les locaux de l'Entreprise ou (ii) dû à la sélection des patients, des techniques chirurgicales ou de toute autre procédure médicale effectuée par l'établissement de santé utilisant le ou les produits en question.

« SION » et « SUOH » sont des marques de commerce ou des marques déposées de ASAHI INTECC CO., LTD. au Japon et dans d'autres pays.

*Les valeurs de charge de pointe représentent les valeurs moyennes des valeurs de spécification du produit mesurées selon la méthode de test standard interne en supposant la force exercée sur la lésion par la pointe du fil guide.

PCI-Führungsdraht Baureihe SION

Gebrauchsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Führungsdraht verwenden, und beachten Sie die Indikation, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die Hinweise im Abschnitt „Anwendung“ in der Gebrauchsanweisung. Andernfalls kann es zu Komplikationen einschließlich schwerer Verletzungen und zum Tod des Patienten kommen.

Wenn ein Benutzer und/oder ein Patient auf einen schweren Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Führungsdraht aufmerksam wird, sollte dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

Diese Gebrauchsanweisungen gelten für den PCI Führungsdraht den PCI-Führungsdraht der Baureihe SION. Details (Länge des Führungsdrahtes, Länge des röntgendichten Abschnitts usw.) finden Sie auf dem Etikett des Produkts.

Beschreibungen

Der PCI-Führungsdraht der Baureihe SION besitzt eine weiche Spitze, um bei Eingriffen die Gefahr einer Gefäßperforation zu verringern, die von Führungsdrähten mit harter Spitze ausgeht.

Der SION besteht standardmäßig aus einem zulaufenden Kerndraht, zwei Distalspulen außen und innen sowie einem Sicherheitsdraht. Kerndraht, Spulen und Sicherheitsdraht sind verlötet. Ein Teilabschnitt der Außenspule ist röntgendicht, so dass seine Position unter Röntgendurchleuchtung kontrolliert werden kann. Der SION hat eine flexible Spitzenbelastung von 0,7 gF*, damit die Sicherheit der Gefäße gewährleistet bleibt. In der Außenspule ist eine aus Seil ausgeführte Innenspule angelegt. Der Sicherheitsdraht ist an Innenspule und Spitze befestigt, so dass er sich auch in dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Kerndraht aus der Spitze austreten sollte, nicht ablöst und Außenspule und Kerndraht somit nicht abfallen können. Die Distalseite des SION ist mit einem hydrophilen Polymer beschichtet.

Der SION blau ist wie der SION aufgebaut, jedoch besteht die Beschichtung der äußeren Spulenspitze teilweise aus Silikon; die Spitze ist somit flexibler als die des SION bei einer Belastung von 0,5 gF*.

Die Grundstruktur der Distalseite des SION blau ES entspricht der des SION blau. Die Belastung der Spitze beträgt 0,5 gF*, aber die Außenspule ist kürzer und der Schaft ist steifer. Innen ist kein Sicherheitsdraht vorgesehen, der Kerndraht ist distal jedoch so gestaltet, dass die proximale Seite des Führungsdrahtes nicht so leicht verrutschen kann. Wie beim SION blau ist der SION blau ES an der Distalseite silikonbeschichtet und an der Proxalseite hydrophil. Die hydrophile Beschichtung ist jedoch länger als bei SION blau.

Der SION schwarz unterscheidet sich vom SION und vom SION blau durch eine Polyurethanharzbeschichtung auf der Außenspule und eine darüber gezogene hydrophile Beschichtung. Die Belastung der Spitze beträgt 0,8 gF*.

Der SUOH 03 ist von der Grundstruktur her identisch mit dem SION blau und dem SION blau ES, setzt jedoch eine Außenspule aus Garn ein, so dass er mit 0,3 gF* die geringste Spitzenbelastung der Baureihe SION vorweist. Die Distaloberfläche ist mit einer hydrophilen Beschichtung versehen.

Bei allen PCI-Führungsdrähten der Baureihe SION ist die proximale Seite des Kerndrahts mit PTFE (Polytetrafluorethylen) beschichtet. Der Nennaußendurchmesser beträgt 0,36 mm (0,014 Zoll) über die gesamte Länge. Am proximalen Ende des weniger als 300 cm langen Instruments befindet sich ein

Anschluss für einen Verlängerungsdraht, der das Kombiinstrument ersetzt; es kann ein Verlängerungsdraht von ASAHI INTECC angeschlossen werden.

	Spitzenbelastung*	Außendurchmesser	Länge der Beschichtung	Spulenlänge	Röntgendichte Länge
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 Zoll)	Hydrophile Beschichtung: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blau	0,5 gf	0,36 mm (0,014 Zoll)	Siliziumbeschichtung : 1,5 cm Hydrophile Beschichtung: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blau ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 Zoll)	Siliziumbeschichtung : 2,5 cm Hydrophile Beschichtung: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION schwarz	0,8 gf	0,36 mm (0,014 Zoll)	Polyurethanbeschichtung: 20,0 cm Hydrophile Beschichtung: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 Zoll)	Hydrophile Beschichtung: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikation

Dieser Führungsdraht ist für die allgemeine perkutane Koronarintervention (PCI) vorgesehen. Dieser Führungsdraht soll die Stelle von Ballonkathetern oder anderen interventionellen Therapiegeräten in der Kardiovaskulatur erleichtern. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt voraussichtlich 120 Minuten. **Dieser Führungsdraht ist nicht für eine Verwendung im neurovaskulären und peripheren Gefäßsystem geeignet.**

Behandelte Zielgruppe

Die PCI-Führungsdrähte der SION-Serie sind zur Behandlung von Patienten bestimmt, die die Indikationen von PCI-Eingriffen erfüllen. Sie dürfen nicht bei Neugeborenen, Säuglingen oder Kindern sowie bei Patienten eingesetzt werden, die schwanger sind, an eingeschränkter Nierenfunktion leiden oder allergisch auf Kontrastmittel oder Polyethylenglykol (PEG) reagieren.

Gegenanzeigen

- Stellen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität des Führungsdrahtdurchmessers mit anderen interventionellen Instrumenten sicher.
- Der Führungsdraht darf nicht bei Patienten eingesetzt werden, die allergisch auf Kontrastmittel reagieren oder an eingeschränkter Nierenfunktion leiden.
- Die hydrophile Beschichtung dieses Führungsdrahtes enthält PEG400. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Patienten, die allergisch auf Polyethylenglykol (PEG) reagieren.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht bei Schwangeren oder möglicherweise schwangeren Patientinnen (Röntgenstrahlen können den Fötus schädigen).
- Der Führungsdraht darf nur in einer Einrichtung verwendet werden, in der unverzüglich Notfalloperationen durchgeführt werden können. Wenn keine Notfalloperationen möglich sind, können schlimmstenfalls lebensbedrohliche Situationen auftreten.
- Der Führungsdraht wurde mit Ethylenoxidgas (EOG) sterilisiert und ist ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung oder erneute Sterilisierung kann die Leistungsqualität des Führungsdrahts beeinträchtigen, und es besteht das Risiko von Komplikationen wie z. B. Infektionen.

Warnhinweise

- Dieser Führungsdraht darf nur von einem für die Durchführung von PCI-Eingriffen qualifizierten Arzt verwendet werden.
- Dieser Führungsdraht darf niemals zusammen mit Kathetern mit Metallteilen, die direkt mit der Oberfläche dieses Führungsdrahtes in Berührung kommen können (z. B. Atherektomiekatether, Dilatoren aus Metall), Kanülen oder Dilatoren aus Metall verwendet werden.
- Während der Verwendung des Führungsdrahtes ist die Bewegung seiner Spitze unter Fluoroskopie zu kontrollieren und zu überwachen. Nicht in Bereichen von Gefäßen verwenden, die nicht mittels Bildgebung dargestellt werden oder werden können.
- Verbinden Sie den Führungsdraht nicht mit abnehmbaren Verlängerungsdrähten, die von anderen Herstellern als ASAHI INTECC hergestellt werden. Bewegen Sie den Führungsdraht nicht, solange der abnehmbare Verlängerungsdraht noch angeschlossen ist. Der Führungsdraht kann sonst beschädigt werden oder das abnehmbare Verlängerungskabel sich ungewollt lösen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Führungsdraht vor.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Führungsdraht darf nach dem auf der Produktverpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Entsorgen Sie jeden Führungsdraht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Führungsdrähte sind empfindliche Instrumente und müssen vorsichtig behandelt werden.
- Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Öffnen Sie die Verpackung immer erst kurz vor der Verwendung. Verwenden Sie bei der Handhabung und Verwendung des Führungsdrahtes aseptische Techniken.
- Achten Sie darauf, dass der Führungsdraht immer feucht gehalten wird, um eine Beschädigung seiner hydrophilen Beschichtung zu vermeiden.
- Reinigen Sie diesen Führungsdraht nicht mit einer organischen Lösung, wie z. B. Alkohol.
- Ergreifen Sie nach der Anwendung vorbeugende Maßnahmen gegen Infektionen. Entsorgen Sie diesen Führungsdraht als medizinischen Abfall.
- Dieser Führungsdraht darf niemals gegen einen Widerstand geschoben, gebohrt, herausgezogen oder gedreht werden. Das Drehen oder Schieben des Führungsdrahtes gegen einen Widerstand kann zur Beschädigung bzw. Ablösung seiner Spitze oder zur unmittelbaren Beschädigung eines Gefäßes führen. Zuwiderhandlungen können zur Beschädigung des Führungsdrahtes führen. Ermitteln Sie die Ursache des Widerstands mittels Fluoroskopie und ergreifen Sie notwendige Abhilfemaßnahmen.
- Führungsdrähte grundsätzlich langsam und vorsichtig vorschieben oder zurückziehen.
- Drehen Sie den Führungsdraht im Inneren des Blutgefäßes nicht kontinuierlich in dieselbe Richtung. Drehen Sie den Führungsdraht abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn. Drehen Sie ihn nicht häufiger als zweimal (720°) in dieselbe Richtung.
- Spülen Sie den Führungsdraht während des Herausziehens und Wiedereinführens mit heparinisierter und sterilisierter Kochsalzlösung oder einer anderen geeigneten Lösung, damit keine Luft in das interventionelle Instrument eintreten kann. Führen Sie den Austausch dieses Führungsdrahtes vorsichtig durch, um Lufteintritt bzw. Traumata zu vermeiden. Achten Sie beim Wiedereinführen des Führungsdrahtes darauf, dass die Spitze des interventionellen Instruments frei im Gefäßlumen liegt und nicht an der Gefäßwand anliegt. Es besteht ansonsten die Gefahr eines Traumas. Verwenden Sie zur Kontrolle der Position die röntgendichte Markierung des interventionellen Instruments.
- Die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes innerhalb des interventionellen Instruments ist eine wesentliche Eigenschaft eines lenkbaren Führungsdrahtsystems, da sie dem Anwender wertvolle haptische Informationen liefert. Untersuchen Sie das System vor dem Gebrauch auf eventuelle Widerstände. Verstellen Sie das hämostatische Ventil oder ersetzen Sie es durch ein verstellbares Ventil, wenn es die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes verhindert.
- Verwenden Sie bei der Platzierung des Stents nicht mehr als einen Führungsdraht und führen

- Sie den Führungsdraht nicht durch Stent-Stege. Der Stent kann dadurch beschädigt werden oder der Führungsdraht kann abreißen oder abbrechen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Führungsdraht in Größe und Form für den Eingriff geeignet und mit dem zu verwendenden Instrument kompatibel ist.
- Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des medizinischen Instruments (z. B. Ballonkatheter oder sonstige interventionelle Instrumente), das zusammen mit diesem Führungsdraht verwendet werden soll.
- Beim Anschluss des abnehmbaren Verlängerungsdrahtes an diesen Führungsdraht sollte dieser fest an der Übergangslinie zwischen dem unbeschichteten und dem mit PTFE beschichteten Bereich am proximalen Ende des Führungsdrahtes eingeführt werden. Sollte eine Anomalie an der Verbindung festgestellt werden, ist die Verwendung des Führungsdrahts sofort zu beenden.
- Überprüfen Sie den Führungsdraht vor der Verwendung und nach Möglichkeit auch während des Eingriffs sorgfältig auf Biegungen, Knicke oder sonstige Schäden. Verwenden Sie den Führungsdraht nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Achten Sie beim Ausformen der Spitze darauf, die Spule nicht zu beschädigen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einführen des Führungsdrahtes, welches Ende das distale Ende ist, und führen Sie den Draht von der distalen Seite her ein.
- Sorgen Sie während des Eingriffs für eine kontinuierliche Spülung mit Kochsalzlösung zwischen dem Führungskatheter und dem interventionellen Instrument sowie zwischen dem interventionellen Instrument und dem Führungsdraht. Die Spülung verhindert die Bildung von Kontrastmittel bzw. eine Klumpenbildung auf dem Führungsdraht und im Lumen des Katheters.
- Bei der Halterung mit einem Schutzrohr am Distalende (siehe Anwendung, Abbildung 1) darf dieses nicht entfernt oder angebracht werden, während der Führungsdraht an der Halterung befestigt ist.
- Bei der Halterung mit einem Schutzrohr am Distalende (siehe Anwendung, Abbildung 1) muss dieses entfernt werden, bevor der Führungsdraht wieder an der Halterung befestigt wird.
- Dieses Gerät enthält den folgenden, als CMR 1A/1B und endokrinschädigend bestimmten Stoff in einer Konzentration von über 0,1 Gew.-%: Kobalt: CAS No. 7440-48-4.

Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse

Mögliche Fehlfunktionen und unerwünschte Ereignisse beim Gebrauch dieses Führungsdrahts sind unter anderem:

1. Fehlfunktionen

Eine Läsion ist nicht passierbar	Bruch oder Verbiegen des Führungsdrahtes	Beschädigung wie z. B. Ablösung
Schwierigkeiten beim Herausziehen	Ablösen der Beschichtung	Rückstände eines beschädigten Führungsdrahtes

2. Unerwünschte Ereignisse

Tod	Infektion	Gefäßdissektion
Gefäßperforation	Komplikationen aufgrund von Blutungen	Embolie
Thrombus	Infarkt	Ischämie
Arrhythmie	Vasospasmus	Gefäßverschluss
Blutdruckabfall	Allergische Reaktion	

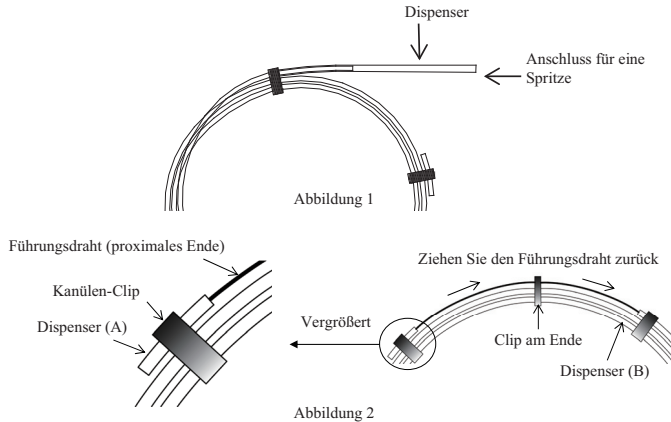
Anwendung

1. Überprüfung vor der Verwendung
 - a) Vor dem Gebrauch alle Führungsdrähte und Verpackungen kontrollieren und auf Unversehrtheit prüfen.
 - b) Vor dem Gebrauch überprüfen, ob der Führungsdraht mit den zu verwendenden interventionellen Instrumenten kompatibel ist.

damit zu tränken. Beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung aus dem Dispenser austreten kann. Bei dem Halter mit Schutzrohr am distalen Ende kann eine Spritze an dieses Schutzrohr angeschlossen werden (Abbildung 1).

2. Vorbereitung
 - a) Wählen Sie den am besten geeigneten Führungsdraht für den betroffenen Bereich aus und entnehmen Sie den Dispenser mit dem Führungsdraht aus der sterilen Verpackung.
 - b) Befüllen Sie den Dispenser mithilfe einer Spritze mit heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung, um das gesamte Instrument

- c) Befüllen Sie das Lumen des interventionellen Instruments vor dem Einführen des Führungsdrahts mit heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung.
- d) Lösen Sie den Führungsdraht aus dem hinteren Clip und schieben Sie das Distalende des Führungsdrahtes langsam durch das Halterrohr (B) (Abbildung 2).



- e) Wenn das Distalende des Führungsdrahtes 5 bis 6 cm über das andere Ende des Halteröhrchens (oder des Schutzöhrchens am Distalende) hinausragt, ggf. die Distalspitze entsprechend der Norm formen.
- f) Fassen Sie den Führungsdraht, der aus dem Distalende des Halteröhrchens (oder des Schutzöhrchens für das Distalende) gekommen ist, vorsichtig an der Stelle, die so

nah wie möglich am Halteröhrchen liegt, und ziehen Sie den Führungsdraht langsam und vorsichtig heraus.

- g) Injizieren Sie erneut heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser, falls beim Herausziehen des Führungsdrahts vom Dispenser Widerstand spürbar ist. Ziehen Sie den Führungsdraht erst dann weiter heraus, wenn kein Widerstand mehr spürbar ist.

- Achten Sie darauf, ausreichend heparinisierte und sterilisierte Kochsalzlösung in den Dispenser zu injizieren, da die hydrophile Beschichtung des Führungsdrahtes durch gewaltsames Herausziehen beschädigt werden kann.
- h) Untersuchen Sie den Führungsdraht nach dem Herausziehen, um sicherzugehen, dass er nicht beschädigt ist.

3. Anleitung zum Einführen

- System über den Draht
 - a) Führen Sie das distale Ende des Führungsdrahtes vorsichtig in das Führungsdrahtlumen des interventionellen Instruments ein.
 - b) Schieben Sie den Führungsdraht vorsichtig vorwärts, bis sich seine Spitze direkt proximal zur Spitze des interventionellen Instruments befindet.
 - c) Schließen Sie den Führungskatheter an und schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem (mit Führungsdraht) in den Y-Anschluss.
 - d) Schieben Sie das interventionelle Instrumentensystem durch den Führungskatheter, bis die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
 - e) Ziehen Sie zum Abdichten des interventionellen Instruments das hämostatische Ventil des Y-Anschlusses an. Vergewissern Sie sich, dass sich der Führungsdraht noch nicht bewegen lässt.
 - f) Prüfen Sie, ob der Führungsdraht leicht gleitet.
 - g) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
 - h) Schieben Sie diesen Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
 - i) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
 - j) Schieben Sie das interventionelle Instrument bis zur Läsion vor und achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen

Instrument sichtbar sind.

■ Schnellwechselsystem

- a) Schieben Sie den Führungskatheter ein.
- b) Setzen Sie das Einführbesteck für den Führungsdraht in den Y-Anschluss des Führungskatheters ein.
- c) Schieben Sie die Spitze des Führungsdrahtes vorsichtig in das Einführbesteck.
- d) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch den Führungskatheter, bis sich die Spitze des Führungsdrahtes direkt proximal zur Spitze des Führungskatheters liegt.
- e) Befestigen Sie die Rotationshilfe bei Bedarf am Führungsdraht.
- f) Schieben Sie den Führungsdraht unter Fluoroskopie durch die Läsion vorwärts. Kontrollieren Sie mittels Angiographie, ob der Führungsdraht die verengte Zielläsion passiert hat.
- g) Beobachten Sie die Bewegung des Führungsdrahtes in den Gefäßen.
- h) Entfernen Sie die Rotationshilfe und das Einführbesteck für den Führungsdraht.
- i) Folgen Sie dem interventionellen Instrument mit dem Führungsdraht. Achten Sie darauf, dass sich der Führungsdraht dabei nicht bewegt, und schieben Sie ihn bis zur Läsion vor. Vergewissern Sie sich, dass die distale Spitze des Führungsdrahtes und seine Position im Gefäß während der Eingriffe mit dem interventionellen Instrument sichtbar sind.

4. Auswechseln des Führungsdrahtes

- System über den Draht
 - a) Entfernen Sie diesen Führungsdraht langsam und überwachen Sie seine Bewegung dabei unter Fluoroskopie.
 - b) Führen Sie den nächsten Führungsdraht gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Anwendung“ ein.

Lagerbedingungen

Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung nicht in einem gebogenen Zustand und nicht unter schweren Gegenständen. Führungsdraht und die Verpackung vor Nässe schützen. Lagern Sie den Führungsdraht und die Verpackung an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett auf der Führungsdrahtverpackung angegeben.

Inhalt

5 Stück/Schachtel

Haftungsausschluss

„ASAHI INTECC CO., LTD. und dessen Partnerunternehmen“ (im Folgenden als das „Unternehmen“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle, Personenschäden und Zwischenfälle infolge des unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts/dieser Produkte oder jeder anderen Verwendung, die im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anweisungen steht. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Schäden, die (i) aus der Lagerung des Produkts/der Produkte nach dem Versand durch das Unternehmen oder (ii) aufgrund der Auswahl der Patienten, der Operationsmethoden oder aufgrund irgendwelcher sonstigen medizinischen Tätigkeiten seitens der medizinischen Einrichtung, die dieses Produkt verwendet, entstehen.

„SION“ und „SUCH“ sind in Japan und weiteren Ländern eingetragene Warenzeichen von ASAHI INTECC CO.,LTD.

*Die Spitzenbelastungswerte stellen die Mittelwerte der technischen Daten dar, die nach der internen Normprüfungsmethode gemessen wurden, unter Annahme, dass die Kraft durch die Spitze des Führungsdrahts auf die Läsion aufgebracht wird.

Καθοδηγητικό σύρμα PCI της σειράς SION

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τηρήστε τις ενδείξεις χρήσης, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και το πώς χρησιμοποιείται, στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιπλοκές, όπως σοβαρός τραυματισμός του ασθενούς ή θάνατος.

Εάν ο χρήστης ή/και ο ασθενής λάβει γνώση ενός σοβαρού περιστατικού που συνέβη σε σχέση με το καθοδηγητικό σύρμα, πρέπει να αναφέρει το γεγονός στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για το Καθοδηγητικό σύρμα PCI της σειράς SION. Για λεπτομέρειες (μήκος του καθοδηγητικού σύρματος, μήκος του ακτινοσκοπικού τμήματος κ.λπ.), ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.

Περιγραφές

Το καθοδηγητικό σύρμα PCI της σειράς SION έχει αναπτυχθεί ως ένα καθοδηγητικό σύρμα μαλακού άκρου με σκοπό να μειώσει την αγγειακή διάτρηση, όταν κρατείται σε ένα αγγείο, καθώς η κράτηση ενός καθοδηγητικού σύρματος με ένα σκληρό άκρο μπορεί να οδηγήσει σε αγγειακή διάτρηση.

Η βασική δομή της SION αποτελείται από ένα κοινικό σύρμα πυρήνα, δύο τύπους περιφερικών σπειραμάτων (ένα εξωτερικό σπείραμα και ένα εσωτερικό σπείραμα) και ένα σύρμα ασφαλείας. Το κοινικό σύρμα πυρήνα, τα σπειράματα και το σύρμα ασφαλείας είναι συγκολλημένα. Ένα μερικό μήκος του εξωτερικού σπειράματος είναι ακτινοσκοπικό, ώστε η θέση του να μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί υπό ακτινοσκόπηση. Η SION έχει φορτίο εύκαμπτου άκρου 0,7 gf*, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στο αμοφόρο αγγείο. Ένα εσωτερικό σπείραμα φτιαγμένο από σχοινί είναι τοποθετημένο μέσα σε εξωτερικό σπείραμα και το σύρμα ασφαλείας είναι δεσμευμένο στο εσωτερικό σπείραμα και το άκρο, ώστε το σύρμα ασφαλείας να μην βγει ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που το κοινικό σύρμα πυρήνα βγει από το άκρο αποτρέποντας το εξωτερικό σπείραμα και το κοινικό σύρμα πυρήνα από το να βγει. Η περιφερική πλευρά της SION είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλο πολυμερές.

Η SION blue έχει την ίδια βασική δομή όπως η SION, αλλά κάποιο μέρος της επικάλυψης στο άκρο του εξωτερικού σπειράματος είναι επικάλυψη σιλικόνης, κάνοντας έτσι το άκρο πιο εύκαμπτο από αυτό της SION και το φορτίο του άκρου είναι 0,5 gf*.

Η βασική δομή της περιφερικής πλευράς της SION blue ES είναι η ίδια με αυτήν της SION blue και το φορτίο του άκρου είναι 0,5 gf*, αλλά το μήκος του εξωτερικού σπειράματος είναι μικρότερο και η ακαμψία του άξονα είναι μεγαλύτερη. Η εσωτερική δομή δεν έχει σύρμα ασφαλείας μέσα, αλλά ο περιφερικός σχεδιασμός του κοινικού σπείραματος πυρήνα είναι έτσι ανεπτυγμένο, ώστε η εγγύς πλευρά του καθοδηγητικού σύρματος να μην εκτοπίζεται εύκολα. Όπως με τη SION blue, η επικάλυψη της SION blue ES είναι επικάλυψη σιλικόνης στην περιφερική πλευρά και υδρόφιλη στην εγγύς πλευρά, ενώ το μήκος της υδρόφιλης επικάλυψης είναι μεγαλύτερο από αυτό της SION blue.

Η SION black διαφέρει από τη SION και τη SION blue ως προς το ότι έχει επικάλυψη ρητίνης πολυουρεθάνης στο εξωτερικό σπείραμα και υδρόφιλη επικάλυψη πάνω από αυτήν. Το φορτίο του άκρου του 0,8 gf*.

Η βασική δομή της SUOH 03 είναι ίδια με αυτήν των SION blue και SION blue ES, αλλά χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό σπείραμα φτιαγμένο από σχοινί, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο φορτίο άκρου στη σειρά SION στα 0,3 gf*. Η περιφερική επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη.

Σε όλα τα προϊόντα καθοδηγητικού σύρματος PCI της σειράς SION, η εγγύς πλευρά του κοινικού σπείραματος πυρήνα είναι επικαλυμμένη με PTFE (πολυτετραφθοροαιθYLEνιο). Η ονομαστική εξωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 0,36 mm (0,014 ίντσες) από το πλήρες μήκος. Στο εγγύς άκρο του τεχνολογικού προϊόντος, το οποίο είναι μικρότερο από 300 cm, υπάρχει μια σύνδεση για ένα σύρμα επέκτασης που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του συνδυασμένου τεχνολογικού προϊόντος. Μπορεί να συνδεθεί το σύρμα επέκτασης της ASAHI INTECC.

	Φορτίο άκρου*	Εξωτερ. διάμετρος	Μήκος επικάλυψης	Μήκος σπειράματος	Ακτινοσκοπικό μήκος
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 ίντσες)	Υδρόφιλη επικάλυψη : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014 ίντσες)	Επικάλυψη σιλικόνης : 1,5 cm Υδρόφιλη επικάλυψη : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 ίντσες)	Επικάλυψη σιλικόνης : 2,5 cm Υδρόφιλη επικάλυψη : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014 ίντσες)	Επικάλυψη πολυουρεθάνης : 20,0 cm Υδρόφιλη επικάλυψη : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 ίντσες)	Υδρόφιλη επικάλυψη : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Ενδείξεις χρήσης

Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα προορίζεται για γενική διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI). Αυτό το οδηγό σύρμα προορίζεται για να διευκολύνει την τοποθέτηση καθετήρων διαστολής μπαλονιού ή άλλων παρεμβατικών θεραπευτικών τεχνολογικών προϊόντων εντός του καρδιαγγειακού συστήματος. Η μέση διάρκεια χρήσης αναμένεται να είναι 120 λεπτά. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα δεν προορίζεται για χρήση στο νευροαγγειακό και περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Στοχευόμενος πληθυσμός θεραπείας

Το καθοδηγητικό σύρμα PCI της σειράς SION προορίζεται για ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις για διαδικασίες PCI. Δεν ενδείκνυνται για χρήση σε νεογνά, βρέφη ή παιδιά όπως και σε ασθενείς που κωσφορούν, έχουν νεφρική δυσλειτουργία ή έχουν αλλεργική αντίδραση σε σκιαγραφικά μέσα ή πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG).

Αντενδείξεις

- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα της διαμέτρου του καθοδηγητικού σύρματος με άλλη επεμβατική συσκευή πριν από την πραγματική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό υλικό ή με νεφρική δυσλειτουργία.
- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα περιέχει PEG400 στην υδρόφιλη επικάλυψή του. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις στην πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG).
- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα σε έγκυες ασθενείς ή σε ασθενείς που μπορεί να

είναι έγκυρες (η ακτινογραφία μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο).

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ίδρυμα όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Εάν μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση δεν είναι διαθέσιμη, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να συμβούν απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Προειδοποιήσεις

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό που είναι πλήρως εκπαιδευμένος στη θεραπεία PCI.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα σε συνδυασμό με καθετήρες με μεταλλικά μέρη που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιφάνεια αυτού του καθοδηγητικού σύρματος (π.χ. καθετήρες αθηρεκτομής, μεταλλικοί διαστολείς), μεταλλικές βελόνες ή μεταλλικούς υποδοχείς θήκης.
- Κατά τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος, ελέγχετε και παρακολουθείτε την κίνηση του άκρου του υπό ακτινοσκόπηση. Μην το

- Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα είναι προαστοποιημένο με αέριο οξείδιο του αιθυλίου (EOG) και προορίζεται μόνο για μία χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναποστερώνετε. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης ή επαναποστείρωσης, η απόδοση ή η ποιότητα αυτού του καθοδηγητικού σύρματος και της συσκευασίας μπορεί να υποβαθμιστεί και υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως η μόλυνση.

- χρησιμοποιείτε σε σημεία του αγγείου που δεν είναι ή δεν μπορούν να απεικονιστούν.
- Μην συνδέετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα με αποσπώμενα σύρματα επέκτασης τα οποία παράγονται από κατασκευαστές διαφορετικούς από την ASAHI INTECC. Μην χειρίζεστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα όσο είναι συνδεδεμένο το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καθοδηγητικό σύρμα ή να αποκολληθεί ακούσια το αποσπώμενο σύρμα επέκτασης.
- Μην τροποποιείτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα για κανέναν λόγο.

Προφυλάξεις

- Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Απορρίψτε κάθε καθοδηγητικό σύρμα όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του.
- Τα καθοδηγητικά σύρματα είναι εναισθητα εργαλεία και πρέπει να τα χειρίζεστε προσεκτικά.
- Εάν η συσκευασία έχει ανοίξει ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα. Μην ανοίγετε τη συσκευασία μέχρι λίγο πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ασηπτική τεχνική κατά το χειρισμό και τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Διατηρείτε πάντα το καθοδηγητικό σύρμα σε γυρή κατάσπαση για να αποφύγετε τη φθορά της υδρόφιλης επικάλυψής του.
- Μην σκουπίζετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα χρησιμοποιώντας οργανικό διάλυμα, όπως οινόπνευμα.
- Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά της μόλυνσης μετά τη χρήση. Απορρίψτε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία ως ιατρικά απόβλητα.
- Ποτέ μην σπράχνετε, βιδώνετε, αποσύρετε ή στρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα που συνταfé αντίστασης. Η στρέψη ή η πίεση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ενάντια στην αντίσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή και αποκόλληση του άκρου αυτού του καθοδηγητικού σύρματος ή άμεση ζημιά σε ένα αγγείο. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα. Προσδιορίστε την αντίσταση υπό ακτινοσκόπηση και λάβετε κάθε αναγκαία διορθωτική ενέργεια.
- Πάντα να προωθείτε ή να αποσύρετε τα καθοδηγητικά σύρματα αργά και προσεκτικά.
- Όταν περιστρέφετε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα στο εσωτερικό του αιμοφόρου αγγείου, μην περιστρέφετε συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση. Κατά την περιστροφή του καθοδηγητικού σύρματος, περιστρέψτε το εναλλάξ δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Μην περιστρέφετε περισσότερο από δύο περιστροφές (720°) προς την ίδια κατεύθυνση.
- Ξεπλύνετε το καθοδηγητικό σύρμα με ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό

- ορό ή άλλο κατάλληλο διάλυμα κατά την αφαίρεση και την επαντοποθέτησή του για να αποτρέψετε την είσοδο αέρα στην επεμβατική συσκευή. Πραγματοποιήστε την αλλαγή αυτού του καθοδηγητικού σύρματος προσεκτικά για να αποφύγετε την είσοδο αέρα και/ή τραυματισμό. Κατά την επανεισγωγή του καθοδηγητικού σύρματος, επιβεβαιώστε ότι το άκρο της επεμβατικής συσκευής είναι ελεύθερο εντός του αυλού του αγγείου και δεν ακουμπά στο τοίχωμα του αγγείου. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιήστε τον ακτινοσκοπικό δείκτη της επεμβατικής συσκευής για να επιβεβαιώσετε τη θέση.
- Η ελεύθερη κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εντός της επεμβατικής συσκευής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος κατευθυνόμενου καθοδηγητικού σύρματος, διότι παρέχει στο χρήστη πολύτιμες πληροφορίες αφής. Δοκιμάστε το σύστημα για τυχόν αντίσταση πριν από τη χρήση. Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τη βελβίδα αμύδασης με ρυθμιζόμενη βελβίδα, εάν διαπιστωθεί ότι εμποδίζει την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Μην εκτελέστε τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα καθοδηγητικά σύρματα ή λειτουργία σύρματος μέσω του στηρίγματος της ενδοπρόθεσης (stent). Διαφορετικά, η ενδοπρόθεση (stent) μπορεί να υποστεί βλάβη ή το καθοδηγητικό σύρμα μπορεί να σπάσει ή να διαλυθεί.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έχει το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για τη διαδικασία και είναι συμβατό με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στην ιατρική συσκευή (π.χ. καθετήρες διαστολής μεταλλικού ή άλλες επεμβατικές συσκευές) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα.
- Κατά τη σύνδεση του αποσπώμενου σύρματος επέκτασης με αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, θα

- πρέπει να εισάγεται με ασφάλεια στη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της επικάλυψης χωρίς PTFE και της επικάλυψης PTFE στο εγγύς άκρο του καθοδηγητικού σύρματος. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία στη σύνδεση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του καθοδηγητικού σύρματος.
- Ελέγξτε προσεκτικά το καθοδηγητικό σύρμα για καμπύλες, στροφές ή άλλες ζημιές πριν από τη χρήση και όποτε είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην χρησιμοποιείτε το καθοδηγητικό σύρμα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά τη διαμόρφωση του άκρου, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πνιόν.
- Πριν εισαγάγετε το καθοδηγητικό σύρμα, ελέγξτε ποιο άκρο είναι το άνω άκρο και βεβαιωθείτε ότι το εισάγετε από το άνω άκρο.
- Διατηρήστε συνεχή έκπλυση φυσιολογικού ορού μεταξύ του καθοδηγητικού καθετήρα και της επεμβατικής συσκευής και μεταξύ της επεμβατικής συσκευής και του καθοδηγητικού σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η έκπλυση αποτρέπει το σχηματισμό σκαυγραφικού και/ή τη δημιουργία θρόμβων στο καθοδηγητικό σύρμα και στον αυλό του καθετήρα.
- Για την υποδοχή που κρατάει τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου (βλ. ενότητα «Πώς χρησιμοποιείται», εικόνα 1), μην αφαιρέσει ή εισαγάγετε τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου, ενώ το καθοδηγητικό σύρμα στεγάζεται στην υποδοχή.
- Για την υποδοχή που κρατάει τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου (βλ. ενότητα «Πώς χρησιμοποιείται», εικόνα 1), αφαιρέστε τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου πριν στεγαστεί ξανά το καθοδηγητικό σύρμα στην υποδοχή.
- Το παρόν τεχνολογικό προϊόν περιέχει την παρακάτω ουσία, η οποία ορίζεται ως CMR 1A/1B και ενδοκρινικός διαταρακτήρας σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος, Κοβάλτιο: Ar. CA 7440-48-40.

Δυσλειτουργίες και αντίξοα περιστατικά

Οι πιθανές δυσλειτουργίες και τα αντίξοα περιστατικά από τη χρήση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δυσλειτουργίες

Αδυναμία διαπέρασης μιας βλάβης
Δυσκολία στην αφαίρεση

Σπασμοί ή κάμψη του
καθοδηγητικού σύρματος
Αφαίρεση επικάλυψης

Ζημιές όπως διαχωρισμός
Υπολείμματα από
καθοδηγητικό σύρμα που έχει
υποστεί ζημιά

2. Αντίζοα περιστατικά

Θάνατος
Διάτρηση αγγείου
Θρόμβος
Αρρυθμία
Μείωση της αρτηριακής
πίεσης

Μόλυνση
Αιμορραγικές επιπλοκές
Έμφραγμα
Αγγειοσπασμός
Αλλεργική αντίδραση

Διατομή αγγείου
Εμβολή
Ισχαιμία
Αγγειακή απόφραξη

Πώς χρησιμοποιείται

1. Έλεγχος πριν από τη χρήση

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά και επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι το καθοδηγητικό σύρμα είναι συμβατό με τις επεμβατικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

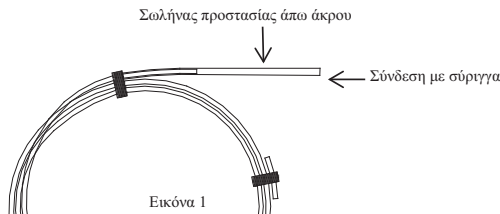
2. Προετοιμασία

- Επιλέξτε το καταλληλότερο καθοδηγητικό σύρμα για την πληγείσα περιοχή και αφαιρέστε το σωληνάριο υποδοχής που περιέχει το καθοδηγητικό σύρμα από την αποστειρωμένη συσκευασία.
- Γεμίστε τον σωλήνα υποδοχής με ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό χρησιμοποιώντας μια

σύριγγα για να εμποτίσετε ολόκληρη τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι ο ηπαρινισμένος και αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός μπορεί να χυθεί από τον σωλήνα υποδοχής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι δυνατή η σύνδεση σύριγγας στο σωληνάκι προστασίας του άνω άκρου που βρίσκεται στην υποδοχή που είναι εξοπλισμένη με το εν λόγω σωληνάκι (Εικόνα 1).

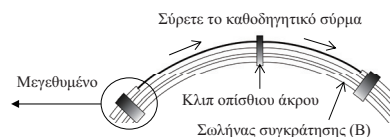
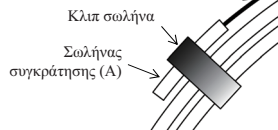
- Γεμίστε τον αυλό της επεμβατικής συσκευής με τον ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό πριν από την εισαγωγή του καθοδηγητικού σύρματος.

δ) Απελευθερώστε το καθοδηγητικό σύρμα από το κλιπ, σύρετε αργά το καθοδηγητικό σύρμα και σπρώξτε το περιφερικό άκρο του καθοδηγητικού σύρματος μέσα από το σωλήνα υποδοχής (B) (Εικόνα 2).



Εικόνα 1

Καθοδηγητικό σύρμα (εγγύς άκρο)



Εικόνα 2

ε) Όταν το περιφερικό άκρο του καθοδηγητικού σύρματος εκτείνεται κατά 5 ως 6 cm πέρα από το άλλο άκρο του σωλήνα υποδοχής (ή το περιφερικό άκρο του σωλήνα προστασίας), εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε το άκρο σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.

στ) Πιάστε απαλά το καθοδηγητικό σύρμα που βγήκε από το περιφερικό άκρο του σωλήνα υποδοχής (ή τον σωλήνα προστασίας περιφερικού άκρου), στο σημείο που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον σωλήνα υποδοχής και τραβήξτε το καθοδηγητικό σύρμα αργά και προσεκτικά προς τα έξω.

η) Εάν αισθανθείτε αντίσταση κατά την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος από το σωλήνα συγκράτησης, εγχύστε ξανά ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης. Συνεχίστε την αφαίρεση του καθοδηγητικού σύρματος αφού η αντίσταση δεν είναι πλέον αισθητή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγχύσει αρκετό ηπαρινισμένο και αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό στο σωλήνα συγκράτησης, διότι η υδροφιλία επιστροφή μπορεί να καταστραφεί κατά τη βίαιη αφαίρεση του επικαλυμμένου καθοδηγητικού σύρματος.

θ) Αφού βγάλετε το καθοδηγητικό σύρμα από το σωλήνα υποδοχής, ελέγξτε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

3. Διαδικασίες για την τοποθέτηση

■ Σύστημα μέσω καλωδίου

α) Εισάγετε προσεκτικά το άνω άκρο του καθοδηγητικού σύρματος στον αυλό του καθοδηγητικού σύρματος της επεμβατικής συσκευής.

β) Προωθήστε προσεκτικά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα έως ότου το άκρο του βρεθεί ακριβώς κοντά στο άκρο της

επεμβατικής συσκευής.

γ) Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό καθετήρα και εισαγάγετε το σύστημα επεμβατικής συσκευής (με το καθοδηγητικό σύρμα) στον σύνδεσμο Υ.

δ) Προωθήστε το σύστημα επεμβατικής συσκευής μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα έως ότου το άκρο του συστήματος καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλυσίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.

ε) Σφίξτε τη βολβίδα αιμόστασης του συνδέσμου Υ για να δημιουργήσετε στεγανοποίηση γύρω από την επεμβατική συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος εξακολουθεί να είναι ερκτική.

ς) Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καθοδηγητικό σύρμα κινείται ομαλά.

η) Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.

θ) Προωθήστε αυτό το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.

ι) Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.

κ) Προωθήστε την επεμβατική συσκευή έως ότου φτάσει στη βλάβη, αποτρέποντας παράλληλα τη μετακίνηση του καθοδηγητικού σύρματος. Βεβαιωθείτε ότι το άνω άκρο του οδηγού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.

■ Σύστημα ταχείας ανταλλαγής

α) Ενεργοποιήστε τον καθοδηγητικό

- καθετήρα.
- β) Εισάγετε τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού σύρματος στον σύνδεσμο Υ του καθοδηγητικού καθετήρα.
- γ) Εισάγετε προσεκτικά το άκρο του οδηγού σύρματος στον εισαγωγέα.
- δ) Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα μέσω του καθοδηγητικού καθετήρα υπό ακτινοσκόπηση έως ότου το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος βρεθεί ακριβώς πλησίον του άκρου του καθοδηγητικού καθετήρα.
- ε) Συνδέστε τη συσκευή περιστροφής στο καθοδηγητικό σύρμα, εάν είναι απαραίτητο.
- ζ) Προωθήστε το καθοδηγητικό σύρμα υπό ακτινοσκόπηση για να περάσει μέσα από τη βλάβη. Επιβεβαιώστε με αγγειογραφία ότι το καθοδηγητικό σύρμα έχει διέλθει από τη στενωμένη βλάβη-στόχο.
- η) Παρατηρήστε την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος στα αγγεία.
- θ) Αφαιρέστε τη συσκευή ροπής του καθοδηγητικού σύρματος και τον εισαγωγέα του καθοδηγητικού σύρματος.
- ι) Παρακολουθήστε την επεμβατική συσκευή πάνω από το καθοδηγητικό σύρμα αποτρέποντας την κίνηση του καθοδηγητικού σύρματος και προχωρήστε μέχρι να φτάσετε στη βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος και η θέση του στο αγγείο είναι ορατά κατά τη διάρκεια των χειρισμών της επεμβατικής συσκευής.
4. Διαδικασίες για την αντικατάσταση του καθοδηγητικού σύρματος
- Σύστημα μέσω καλωδίου
- α) Αφαιρέστε αργά αυτό το καθοδηγητικό σύρμα, ενώ παρακολουθείτε την κίνηση αυτού του καθοδηγητικού σύρματος υπό ακτινοσκόπηση.
- β) Τοποθετήστε το επόμενο καθοδηγητικό σύρμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας ενότητας «Πώς χρησιμοποιείται».

Μέθοδος φύλαξης

Μην διατηρείτε το καθοδηγητικό σύρμα και τη συσκευασία σε λυγισμένη ή/και βαριά φορτισμένη κατάσταση. Αυτό το καθοδηγητικό σύρμα και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται μακριά από νερό. Φυλάσσεται σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του καθοδηγητικού σύρματος.

Περιεχόμενα

5 τεμάχια / κουτί

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η «ASAHI INTECC CO., LTD. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της» (εφεξής η «Εταιρεία») σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για ατυχήματα, σωματικές βλάβες, αντίξοα περιστατικά που οφείλονται σε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση του(ων) προϊόντος(ων) ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνάδει με τις παρούσες οδηγίες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές είτε (i) που προκύπτουν από την αποθήκευση του προϊόντος (των προϊόντων) μετά την αποστολή από την Εταιρεία είτε (ii) που οφείλονται στην επιλογή ασθενών, τεχνικών χειρουργικής επέμβασης ή άλλων ιατρικών δραστηριοτήτων από το ιατρικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί το προϊόν (τα προϊόντα).

Οι επωνυμίες «SION» και «SUOH» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ASAHI INTECC CO.,LTD. στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

*Οι τιμές φορτίου άκρου αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές των τιμών προδιαγραφών του προϊόντος όπως έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμασίας εσωτερικού προτύπου υποθέτοντας τη δύναμη που εφαρμόζεται στη βλάβη από το άκρο του καθοδηγητικού σύρματος.

SION sorozatú PCI vezetődrt

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a vezetődrtöt, alaposan olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa be a jelen használati útmutató Felhasználási javallatok, Ellenjavallatok, Figyelmeztetések, Övintézkedések és Használati fejezetében foglaltakat. A leírtak figyelmen kívül hagyása nem várt eredményeket, a páciens súlyos testi sérülését vagy halálát okozhatja.

Amennyiben a felhasználónak és/vagy a páciensnek a vezetődrről kapcsolatos súlyos incidens jut tudomására, jelentse a tényt a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának.

Ez a Használati útmutató a SION sorozatú PCI vezetődrrőlra vonatkozik. A részleteket (a vezetődrt hossza, a röntgensugárzást nem áteresztő rész hossza stb.) lásd a termékcímkén.

Leírások

A PCI vezetődrt SION sorozatot lágy csúcú vezetődrtként fejlesztették ki, hogy csökkentse az érperforáció kockázatát, amikor az érben tartják, mivel a kemény csúcú vezetődrt érben tartása érperforációhoz vezethet.

A SION alapszerkezete egy kúpos maghuzalból, kétféle disztális tekercsből (egy külső és egy belső tekercsből) és egy biztonsági drótból áll. A kúpos maghuzal a tekercsek és a biztonsági drót forrasztott. A külső tekercs részleges hossza röntgensugárzást nem áteresztő, így annak pozíciója könnyen ellenőrizhető radioszkópia alatt. A SION hajlékony csúcának terhelése, 0,7 gf*, hogy biztosítsa a biztonságot az érben. A külső tekercs belsejébe kötélből készült belső tekercset helyeznek, és a biztonsági drótot a belső tekercshez és a csúcshoz ragasztják, hogy a biztonsági drót ne váljon le, még abban a valószínűtlen esetben sem, ha a kúpos maghuzal leválik a csúcslól, megakadályozva a külső tekercs és a kúpos maghuzal leválását. A SION disztális oldala hidrofíl polimerrel van bevonva.

A SION blue-nak ugyanaz az alapszerkezete, mint a SION-nak, de a külső tekercscsúcson bevonatának egy része szilikon bevonat, így a csúc rugalmasabb, mint a SION-é, és a csúc terhelése 0,5 gf*.

A SION blue ES disztális oldalának alapszerkezete megegyezik a SION blue-ével, és a csúc terhelése 0,5 gf*, de a külső tekercs hossza rövidebb és a szár merevsége nagyobb. A belső szerkezetben nincs biztonsági drót, de a kúpos maghuzal disztális kialakítását úgy tervezték, hogy a vezetődrt proximális oldala ne mozduljon el könnyen. A SION blue-hoz hasonlóan a SION blue ES bevonata a disztális oldalon szilikon bevonat, a proximális oldalon pedig hidrofíl bevonat, és a hidrofíl bevonat hossza nagyobb mint a SION blue-é.

A SION black abban különbözik a SION-tól és a SION blue-tól, hogy a külső tekercsen poliuretán gyanta bevonat, és annak tetején hidrofíl bevonat található. A csúc terhelése 0,8 gf*.

A SUOH 03 alapszerkezete megegyezik a SION blue és a SION blue ES alapszerkezetével, de kötélből készült külső tekercset használ, ami a SION sorozatban a csúc legkisebb terhelését eredményezi: 0,3 gf*. A disztális felület hidrofíl bevonattal van bevonva.

Az összes SION sorozatú PCI vezetődrtől a kúpos maghuzal proximális oldala PTFE-vel (poli-tetrafluor-étlennel) van bevonva. A termék teljes hosszán a néveleges külső átmérő 0,36 mm (0,014 hüvelyk). A készülék proximális végén, melynek hossza kevesebb, mint 300 cm, egy csatlakozó található egy

hosszabbító vezetékhez, amely a kombinált eszköz helyettesítésére használható; ASAHI INTECC hosszabbító vezeték csatlakoztatható.

	Csúc terhelése*	Külső átmérő	Bevonat hossza	Tekercs hossza	Röntgensugárzást nem áteresztő hossz
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofíl bevonat : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Szilikon bevonat : 1,5 cm Hidrofíl bevonat : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Szilikon bevonat : 2,5 cm Hidrofíl bevonat : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Poliuretán bevonat : 20,0 cm Hidrofíl bevonat : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofíl bevonat : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Felhasználási javallatok

Ez a vezetődrt általános perkután koronária intervenció (PCI) céljára szolgál. Ez a vezetődrt a ballonos tágitókatéterek vagy más intervencióos terápiás eszközök kardiiovaszkuláris rendszerben történő elhelyezésének megkönnyítésére szolgál. A használat átlagos időtartama várhatóan 120 perc.
 A vezetődrt az idegrendszeri és perifériás érrendszerben nem használható.

Kezelt célcsoport

A SION sorozatú PCI vezetődrtöket olyan betegek számára készülték, akik megfelelnek a PCI-eljárások javallatainak. Használata nem javallott újszülöttek, csecsemők vagy gyermekek, valamint terhes, csökkent vesefunkciójú és kontrasztanyagra vagy poli-étlén-glikolra (PEG) allergiás betegek esetében.

Ellenjavallatok

- A tényleges használat előtt erősítse meg a vezetődrt átmérőjét másik intervencióos eszközzel.
 - Ne használja a vezetődrtöt olyan betegeknél, akik allergiás reakcióit mutatnak a kontrasztanyagra, vagy akiknek csökkent a vesefunkciója.
 - A vezetődrt hidrofíl bevonata PEG400 anyagot tartalmaz. Ne használja a vezetődrtöt polietilén-glikolra (PEG) allergiás páciensek esetében.
 - Ne használja a vezetődrtöt terhes vagy gyaníthatóan terhes páciensek (a röntgensugárzás hatással lehet a magzatra).
- Ezt a vezetődrtöt csak olyan intézményben szabad használni, ahol azonnal végrehajthatók a sürgősségi sebészi beavatkozások. Ha sürgősségi sebészi beavatkozás nem érhető el, a legrosszabb esetben életveszéllyel fenyegető események is bekövetkezhetnek.
 - A vezetődrt etilén-oxid gázzal (EOG) van elősterilizálva és kizárólag egyszeri használatra készült. Ne használja vagy sterilizálja újra. Ismételt felhasználás vagy újristilizálás esetén a vezetődrt teljesítménye és minősége csökkenhet, továbbá komplikációkat, pl. fertőzést okozhat.

Figyelmeztetések

- A vezetődrtöt kizárólag a PCI eljárásokban megfelelően jártas orvos használhatja.
- Soha ne használja ezt a vezetődrtöt olyan katéterekkel együtt, amelyeknek fém részei közvetlenül érintkezhetnek a vezetődrt

felületével (pl. atherectomiás katéterek, fémtagítók), illetve fémtekével vagy fém hüvelybehelyezőkkel.

- A vezetődórt használatán során fluoroszkópiás megfigyeléssel ellenőrizze és kövesse nyomon a csűcs mozgását. Ne használja olyan erekben, amelyek nem lehet vagy tud megtekinteni.
- Ne csatlakoztassa a vezetődórt olyan leválasztható hosszabbító vezetékekhez,

amelyeket nem az ASAHI INTECC, hanem más gyártó gyártott. Ne manipulálja a vezetődórt, ha a leválasztható hosszabbító drót csatlakoztatva van. Ellenkező esetben a vezetődórt megsérülhet, illetve a leválasztható hosszabbító vezeték véletlenül megsérülhet.

- Semmilyen ok miatt ne módosítsa a vezetődórt!

Övintézkedések

- Használja fel a vezetődórt csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül. Dobjon el minden olyan vezetődórt, amelynek letelt a lejárata.
- A vezetődórtok törékeny műszerek, és óvatosan kell kezelni őket.
- Ne használja a vezetődórt, ha a csomagolás kinyílt vagy megsérült. Kizárólag közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki a csomagolást. A vezetődórt kezeléséhez és használatához aszeptikus technikákat használjon.
- A vezetődórt mindig tartson nedves állapotban, hogy meggátolja a hidrolízis bevonat károsodását.
- Semmilyen szerves oldattal (pl. alkohol) ne törölje át a vezetődórt.
- Használat után alkalmazzon megelőző intézkedéseket a fertőzések elkerülésére. A vezetődórtot és a csomagolást orvosi hulladékként dobja ki.
- Soha ne tolja, csavarja be vagy húzza ki a vezetődórtot és soha ne fejtessen ki nyomteket rá, ha ellenállást tapasztal. Az eszköz erővel történő nyomása vagy tolása sérülést okozhat, és/vagy a vezetődórt csűcsának leválásához vezethet, illetve közvetlen érkárosodást okozhat. Ennek elmulasztása esetén a vezetődórt károsodhat. Fluoroszkópiával állapítsa meg az ellenállás okát, és járjon el annak megfelelően.
- Mindig lassan és óvatosan vezesse be ill. húzza vissza a vezetődórtot.
- Ha a vezetődórtot nyomattékkal terheli az ér belsejében, ne terhelje folyamatosan ugyanabba az irányba. Ha nyomattékkal terheli a vezetődórtot, felváltva forgassa az óramutató járásával ellentétes és megegyező irányokba. Ne forgassa több mint két fordulatnyit (720°) ugyanabba az irányba.
- Annak elkerülése érdekében, hogy levegő kerüljön az intervenció eszközbe, a vezetődórt eltávolítása és a behelyezése során folyamatosan öblítse le a vezetődórtot heparinizált és sterilizált sóoldattal vagy egyéb megfelelő oldattal. A

- levegőbejutás és/vagy a trauma elkerülése érdekében óvatosan hajtja végre a vezetődórt cseréjét. A vezetődórt ismételt bevezetésekor győződjön meg róla, hogy az intervenció eszköz csűcsa szabadon mozog az ér lumenben, és nem ütöközik az érfalnak. Ennek elmulasztása sérüléshez vezethet. A helyzet megállapításához alkalmazzon sugár át nem eresztő jelzést az intervenció eszközön.
- A vezetődórt szabad mozgása a beavatkozási eszközön belül fontos tulajdonság az irányítható vezetődórtnál, mivel a felhasználónak értékes, kézzelfogható visszajelzést ad. Ellenőrizze a rendszert használat előtt, nem tapasztal-e ellenállást. Állítsa be vagy cserélje ki a hemosztázis-szelepet egy állítható szelepre, ha úgy látja, hogy akadályozza a vezetődórt mozgását.
- Ne végezzen sztent behelyezést, ha több vezetődórtot használ, vagy a sztent bordán keresztül vezeti a drótot. Ellenkező esetben a sztent megsérülhet vagy a vezetődórt elszakadhat vagy széttröhet.
- Használat előtt erősítse meg, hogy a vezetődórt mérete és formája megfelel-e a beavatkozásnak, és kompatibilis-e az azzal együtt használni kívánt eszközzel.
- Olvassa el a vezetődórttal együtt használandó orvostechnikai eszközökhöz (pl. ballonos tágitó katéterekhez vagy egyéb intervenció eszközökhöz) mellékelt használati utasítást.
- Amikor a leválasztható hosszabbító drótot ehhez a vezetődórhoz csatlakoztatja, azt megfelelően kell behelyezni a vezetődórt proximális végén található nem PTFE bevonat és PTFE bevonat közti határvonalba. Ha a csatlakozás során bármilyen rendellenességet észlel a csatlakozásban, azonnal függesztse fel a vezetődórt használatát.
- Használat előtt, és amikor csak lehetséges a használat során, ellenőrizze a vezetődórtot,

- nincs-e rajta meghajlás, megtörés vagy egyéb sérülés. Ne használja a vezetődórtot, ha az sérült.
- A csűcs formázásakor ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg a tekercset.
- A vezetődórt behelyezése előtt ellenőrizze, hogy melyik a disztális vége, és ügyeljen arra, hogy azt a disztális végénél helyezze be.
- Az eljárás során a vezetó katéter és az intervenció eszköz, valamint az intervenció eszköz és a vezetődórt között folyamatos sóoldatos öblítést kell alkalmazni. Az öblítés megakadályozza a kontrasztanyag és/vagy a vérrögök képződését a vezetődórtot és a katéter lumenében.

- A disztális végi védőcsővel ellátott tartó esetében (lásd Használat, 1. ábra) ne vegye ki vagy helyezze be a disztális végi védőcsövet, amíg a vezetődórt a tartóban van.
- A disztális végi védőcsővel ellátott tartó esetében (lásd Használat, 1. ábra) azelőtt vegye ki a disztális végi védőcsövet, mielőtt a vezetődórt visszahelyezné a tartóba.
- Ez az eszköz a következő CMR 1A/1B és endokrin rendszert károsító anyagként meghatározott anyagot tartalmazza 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban; Kobalt: CAS-szám: 7440-48-4.

Működési problémák és nemkívánatos események

A vezetődórt használatára révén fellépő lehetséges működési problémák és nemkívánatos események többek között az alábbiak lehetnek:

1. Működési problémák

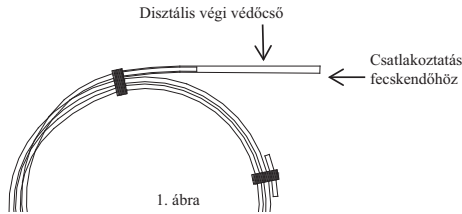
Sikertelen átjutás a sérülésen	A vezetődórt törése vagy meghajlása	Sérülések, pl. szétválás
Nehézség az eltávolítás során	A bevonat leválása	Sérült vezetődórtból származó törmelék

2. Nemkívánatos események

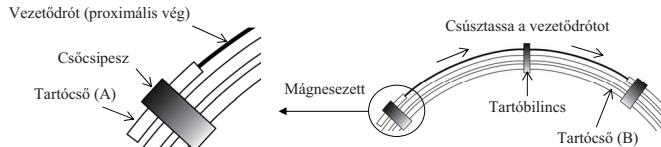
Halál	Fertőzés	Érszakadás
Az ér perforációja	Vérzési komplikációk	Légembólia
Thrombus	Infarktus	Iszkémia
Aritmia	Érgörcs	Érelzáródás
A vérnyomás csökkenése	Allergiás reakciók	

Használat

- Ellenőrzések a használat előtt
 - Használat előtt vizsgálja meg figyelmesen, és győződjön meg róla, hogy a vezetődórt és csomagolása sértetlen-e.
 - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vezetődórt kompatibilis-e a használni tervezett intervenció eszközökkel.
- Előkészítés
 - Válassa ki az érintett területhez legmegfelelőbb vezetődórtot, és távolítsa el a vezetődórtot tartalmazó csőtartót a steril csomagolásból.
 - Fecskendő segítségével töltse fel a csőtartót heparinizált és sterilizált sóoldattal, és áztassa be a teljes eszközt. Vigyázzon arra, hogy a heparinizált és sterilizált sóoldat ennél a műveletnél kifolyhat a csőtartóból. A disztális végén védőcsővel ellátott tartónál (1. ábra) a fecskendőt a disztális vég védőcsővéhez lehet csatlakoztatni.
 - A vezetődórt behelyezése előtt töltse fel az intervenció eszköz lumenjét heparinizált és sterilizált sóoldattal.
 - Vegye ki a vezetődórtot a tartóbilincsből, és lassan csúsztassa ki a vezetődórtot, majd tolja át a vezetődórt disztális végét a tartócsövön (B) (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

e) Amikor a vezetődrót disztális vége legalább 5 - 6 cm-re van a tartócső másik végétől (vagy disztális végi védőcsőtől), akkor szükség esetén alakítsa a csúcst a normál gyakorlatnak megfelelően.

f) Fogja meg óvatosan a vezetődrótot, amely a tartócső disztális végéből (vagy a disztális végi védőcsőből) jött ki, mégpedig a tartócsőhöz legközelebbi ponton, majd húzza ki a vezetődrótot lassan és óvatosan.

g) Ha ellenállás érezhető a vezetődrót csőtartóból történő eltávolítása során, fecskendezzen ismét heparinizált és sterilizált sóoldatot a csőtartóba. Az ellenállás megszűnése után folytassa a vezetődrót eltávolítását. Győződjön meg arról, hogy elegendő mennyiségű heparinizált és sterilizált sóoldatot fecskendezzen be a csőtartóba, mert a hidrofílvonatot megsérülhet a bevonatos vezetődrót erővel történő eltávolításakor.

h) Miután kihúzta a vezetődrótot a tartócsőből, vizsgálja meg, és győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg.

3. A behelyezés műveletei

■ Over-the-wire rendszer

a) Óvatosan nyomja be a vezetődrót disztális végét az intervenciós eszköz vezetődrót

lumenébe.

b) Óvatosan vezesse be a vezetődrótot, míg a csúcsa az intervenciós eszköz csúcsának közelébe nem ér.

c) Kösse be a vezetőkatétert, és nyomja be az intervenciós eszközrendszert (a vezetődróttal) az Y-csatlakozóba.

d) Tolja át az intervenciós eszközrendszert a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót-rendszer csúcsa meg nem közelíti a vezetőkatéter hegyét.

e) Az intervenciós eszköz körüli szigetelés létrehozása érdekében szorítsa meg az Y-csatlakozó mosztázis-szelepet.

Győződjön meg róla, hogy a vezetődrót mozgása továbbra is lehetséges-e.

f) Ellenőrizze, hogy a vezetődrót simán mozog-e.

g) Szükség esetén csatlakoztassa a nyomátéskészítőt a vezetődróthoz.

h) Fluoroszkópia alatt tolja előre ezt a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.

i) Figyelje a vezetődrót mozgását az erekben.

j) A lézió eléréséig tolja be az intervenciós eszközt, miközben megakadályozza a vezetődrót mozgását. Biztosítsa, hogy a

vezetődrót disztális csúcsa és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenciós eszköz használata során is látható legyen.

■ Gyors cserélőrendszer

a) Kösse be a vezetőkatétert.

b) Nyomja be a vezetődrót bevezetőjét a vezetőkatéter Y-csatlakozójába.

c) Óvatosan tolja be a vezetődrót csúcsát a bevezetőbe.

d) Fluoroszkópia mellett tolja át a vezetődrótot a vezetőkatéteren, míg a vezetődrót csúcsa a vezetőkatéter csúcsának közelébe nem kerül.

e) Szükség esetén csatlakoztassa a nyomátéskészítőt a vezetődróthoz.

f) Fluoroszkópia alatt tolja előre a vezetődrótot, hogy átjusson a lézió. Angiográfia segítségével erősítse meg, hogy a vezetődrót áthaladt-e a beszűkült részen.

g) Figyelje a vezetődrót mozgását az erekben.
h) Távolítsa el a vezetődrót nyomátéskészítőt és a vezetődrót bevezetőjét.

i) Kövesse nyomon az intervenciós eszközt a vezetődrót mentén, miközben megakadályozza a vezetődrót mozgását, és addig tolja előre, míg el nem éri a léziót. Biztosítsa, hogy a vezetődrót disztális csúcsa, és annak érbén történő elhelyezkedése az intervenciós eszköz használata során is látható legyen.

4. A vezetődrót cseréjének eljárásai

■ Over-the-wire rendszer

a) Lassan távolítsa el a vezetődrótot annak folyamatos, fluoroszkópiás megfigyelése során.

b) A „Használat” fejezetben leírtaknak megfelelően helyezze be a következő vezetődrótot.

A tárolás módja

Ne tartsa a vezetődrótot és csomagolását hajlított vagy erősen terhelt állapotban. Ezt a vezetődrótot és csomagolását víztől távol kell tárolni. Hűvös, sötét és száraz helyen tárolja.

Lejárat

A lejárat dátumát lásd a vezetődrót csomagolásának címkéjén.

A csomag tartalma

5 darab / doboz

Felelősség kizárása

Az „ASAHI INTECC CO., LTD. és partnervállalatai” (a továbbiakban a „Vállalat”) semmilyen esetben sem vonható felelősségre az olyan balesetek, személyi sérülések vagy mellékhatások miatt, melyek a termék(ek) nem megfelelő, illetve a jelen utasításokkal összhangban nem lévő használatából adódnak. A vállalat semmiképpen nem felel azokért a károkért, amelyek vagy (i) a termék(ek)nek a vállalattól való kiszállítása utáni tárolására, vagy (ii) a betegek, sebészeti eljárások vagy más orvosi tevékenység megválasztására vezethetők vissza.

A „SION” és a „SUOH” az ASAHI INTECC CO., LTD. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Japánban és egyéb országokban.

*A csúcs terhelésének értékei a belső szabványos vizsgálati módszerrel mért termékspecifikációs értékek átlagértékeit jelentik, feltételezve a vezetődrót csúcsa által a lézióra kifejtett erőt.

Filo guida per ICP serie SION

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il filo guida, leggere attentamente e attenersi a quanto riportato nelle sezioni “Indicazioni per l’uso”, “Controindicazioni”, “Avvertenze”, “Precauzioni” e “Modalità di utilizzo” delle presenti Istruzioni per l’uso. In caso contrario potrebbero verificarsi complicanze, comprese gravi lesioni al paziente, anche mortali.

Se l’utente e/o il paziente vengono a conoscenza di un incidente grave che si è verificato in correlazione al filo guida, sono tenuti a segnalarlo al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro.

Le presenti Istruzioni per l’uso si applicano al Filo guida per ICP serie SION. Per ulteriori informazioni (lunghezza del filo guida, lunghezza della sezione radiopaca, ecc.), consultare l’etichetta del prodotto.

Descrizioni

Il Filo guida per ICP serie SION è stato progettato per avere una punta morbida e ridurre così il rischio di perforazione vascolare durante la permanenza del filo nel vaso, che potrebbe al contrario verificarsi se si utilizza un filo guida con punta dura.

La struttura base di SION prevede un filo conico animato, due tipologie di spirali distali (una spirale esterna e una interna) e un filo di sicurezza. Il filo conico animato, le spirali e il filo di sicurezza sono saldati. Una parte della spirale esterna è radiopaca, in modo che possa essere facilmente individuata con una radioscopia. Il filo SION ha un carico flessibile della punta di 0,7 gr* per proteggere il vaso sanguigno. Una spirale interna in corda è inserita all’interno della spirale esterna e il filo di sicurezza è fissato sia alla spirale interna sia alla punta, in modo tale che non si stacchi neanche nell’eventualità (altamente improbabile) in cui il filo conico animato dovesse staccarsi dalla punta, impedendo così il distacco della spirale esterna e del filo conico animato. Il lato distale del SION è rivestito di un polimero idrofilico.

SION blu ha la stessa struttura di base di SION, ma una parte del rivestimento della punta della spirale esterna è di silicone e questo la rende più flessibile di quella di SION e con un carico della punta pari a 0,5 gr*.

La struttura di base del lato distale di SION blu ES è la stessa di SION blu con un carico della punta di 0,5 gr*, tuttavia la lunghezza della spirale esterna è inferiore e la rigidità dello stelo è maggiore. La struttura interna non presenta un filo di sicurezza, tuttavia il design distale del filo conico animato è stato concepito in modo tale che il lato prossimale del filo guida non si sganci facilmente. Come nel caso di SION blu, il rivestimento di SION blu ES è in silicone nella parte distale e idrofilico in quella prossimale, ma con una lunghezza del rivestimento idrofilico superiore a quella presente in SION blu.

SION nero si differenzia da SION e SION blu per la presenza di un rivestimento in resina poliuretanicca sulla spirale esterna a cui si aggiunge un rivestimento idrofilico. La punta ha un carico di 0,8 gr*.

La struttura di base del filo SUOH 03 è identica a quella di SION blu e SION blu ES, anche se utilizza una spirale esterna in corda, garantendo il carico della punta più basso della serie SION pari a 0,3 gr*. La superficie distale ha un rivestimento idrofilico.

In tutti i formati del Filo guida per ICP serie SION, il lato prossimale del filo conico animato è rivestito di PTFE (politetrafluoroetilene). Il diametro nominale esterno del prodotto è di 0,36 mm (0,014 pollici) per tutta la lunghezza. Sull’estremità distale del dispositivo, inferiore a 300 cm, è presente un collegamento per

un filo di prolunga, utilizzato per sostituire il dispositivo abbinato; a tale estremità può essere collegato il filo di prolunga ASAHI INTECC.

	Carico della punta*	Diametro esterno	Lunghezza del rivestimento	Lunghezza della spirale	Lunghezza radiopaca
SION	0,7 gr	0,36 mm (0,014 pollici)	Rivestimento idrofilico: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blu	0,5 gr	0,36 mm (0,014 pollici)	Rivestimento in silicone: 1,5 cm Rivestimento idrofilico: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blu ES	0,5 gr	0,36 mm (0,014 pollici)	Rivestimento in silicone: 2,5 cm Rivestimento idrofilico: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION nero	0,8 gr	0,36 mm (0,014 pollici)	Rivestimento in poliuretano: 20,0 cm Rivestimento idrofilico: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gr	0,36 mm (0,014 pollici)	Rivestimento idrofilico: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indicazioni per l'uso

Il filo guida è progettato per interventi coronarici percutanei (ICP). Questo filo guida è progettato per facilitare il posizionamento dei cateteri per dilatazione a palloncino, o altri dispositivi interventistici a scopo terapeutico, nel sistema cardiovascolare. La durata media di utilizzo prevista è di 120 minuti.

Il filo guida non è destinato all'uso nel sistema neurovascolare e nei vasi periferici.

Popolazione target trattata

Il Filo guida per ICP serie SION è pensato per essere utilizzato su pazienti che rientrano nei canoni previsti per le procedure ICP. Non deve essere utilizzato su neonati, lattanti o bambini, né su pazienti in stato di gravidanza, affetti da disfunzione renale e allergici al mezzo di contrasto o al polietilenglicole (PEG).

Controindicazioni

- Prima dell’uso effettivo, verificare la compatibilità del diametro del filo guida con gli altri dispositivi interventistici.
- Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici ai mezzi di contrasto o affetti da disfunzione renale.
- Il rivestimento idrofilico del filo guida contiene PEG400. Non utilizzare il filo guida nei pazienti allergici al polietilenglicole (PEG).
- Non utilizzare il filo guida nelle pazienti in stato di gravidanza, anche presunto, (i raggi X possono nuocere al feto).
- Il filo guida deve essere utilizzato in strutture sanitarie in grado di eseguire prontamente un intervento chirurgico d’urgenza. Nel caso in cui sia impossibile eseguire un intervento chirurgico d’urgenza, nel peggiore dei casi possono verificarsi eventi con rischio per la vita del paziente.
- Il filo guida è presterilizzato con ossido di etilene (EOG) ed è inteso esclusivamente monouso. Non riutilizzare né risterilizzare. Se riutilizzato o risterilizzato, le prestazioni o la qualità del filo guida e della confezione possono risultare compromesse, con rischio di complicanze, comprese infezioni.

Avvertenze

- Il filo guida deve essere utilizzato esclusivamente da un medico qualificato per i trattamenti ICP.
- Non utilizzare il filo guida in abbinamento a cateteri con parti metalliche che possano entrare direttamente a contatto con la superficie del filo

guida (p.es. cateteri per aterectomia, dilatatori metallici), aghi metallici o inserter con guaina metallica.

- Durante l'uso del filo guida, controllare e monitorare il movimento della punta sotto guida fluoroscopica. Non utilizzare in aree vascolari non visualizzate o impossibili da visualizzare.

Precauzioni

- Non utilizzare il filo guida oltre la data di scadenza riportata sull'etichetta. Eliminare il filo guida se la data di scadenza è stata superata.
- I fili guida sono strumenti delicati che vanno maneggiati con cura.
- Non utilizzare il filo guida se la confezione è aperta o danneggiata. Non aprire la confezione fino al momento immediatamente precedente all'uso. Maneggiare e utilizzare il filo guida in condizioni asettiche.
- Mantenere sempre umido il filo guida, in modo da evitare danni al rivestimento idrofilico.
- Non pulire il filo guida con soluzioni organiche come alcol.
- Dopo l'utilizzo adottare misure preventive contro le infezioni. Smaltire il filo guida e la relativa confezione come rifiuti medicali.
- In caso di resistenza, non spingere, ruotare, ritrarre o torcere il filo guida. Torcere o spingere il filo guida a fronte di resistenza può danneggiarlo e/o causarne il distacco della punta ovvero danneggiare direttamente un vaso. In caso contrario, il filo guida può subire danni. Determinare le cause della resistenza tramite fluoroscopia e intraprendere le necessarie azioni correttive.
- Far avanzare o ritrarre il filo guida sempre lentamente e con cautela.
- Durante la torsione del filo guida all'interno di un vaso sanguigno, non procedere sempre nella stessa direzione, bensì ruotarlo alternativamente in senso orario e antiorario. Non eseguire più di due rotazioni (720°) nello stesso senso.
- Durante la rimozione o il reinserimento del filo guida, irrigarlo con soluzione salina eparinata e sterilizzata o con altra soluzione idonea per evitare l'ingresso di aria nel dispositivo interventistico. Eseguire con cautela la sostituzione del filo guida per evitare l'ingresso di aria e/o traumi. Quando si introduce nuovamente il filo guida, verificare che la punta del dispositivo interventistico sia libera

- Non collegare il filo guida a fili di prolunga scollegabili prodotti da aziende diverse da ASAHI INTECC. Non maneggiare il filo guida con il filo di prolunga scollegabile collegato. In caso contrario, il filo guida può subire danni o la prolunga rimovibile può staccarsi accidentalmente.
- Non modificare il filo guida per nessun motivo.

- all'interno del lume del vaso e non urti contro la parete del vaso stesso. In caso contrario, si possono provocare traumi. Utilizzare il marcatore radiopaco del dispositivo interventistico per verificare la posizione.
- Il movimento libero del filo guida all'interno del dispositivo interventistico è una caratteristica importante dei sistemi a filo guida orientabile perché fornisce all'operatore utili informazioni tattili. Prima dell'uso verificare la presenza di resistenze nel sistema. Se si nota che la valvola emostatica si oppone al movimento del filo guida, regolarla o sostituirla con una valvola regolabile.
- Non eseguire il posizionamento di stent utilizzando più di un filo guida o facendo passare il filo attraverso le maglie dello stent. In caso contrario, lo stent può danneggiarsi o il filo guida può rompersi o spezzarsi.
- Prima dell'uso, verificare che il filo guida abbia le dimensioni e la forma corrette per la procedura specifica e sia compatibile con il dispositivo da abbinare.
- Vedere le Istruzioni per l'uso allegate al dispositivo medico (p.es. cateteri per dilatazione a palloncino o altri dispositivi interventistici) da abbinare al filo guida.
- Quando si collega il filo di prolunga scollegabile al filo guida, questo deve essere inserito saldamente tra il segmento rivestito in PTFE e il segmento non rivestito in PTFE sull'estremità prossimale del filo guida. In caso di anomalia durante l'inserimento, interrompere immediatamente l'uso del filo guida.
- Controllare attentamente l'eventuale presenza di piegature, torsioni o altri danni del filo guida prima dell'uso e, se possibile, durante la procedura. Non utilizzare il filo guida se è danneggiato.
- Durante la sagomatura della punta, prestare attenzione a non danneggiare la spirale.

- Prima di inserire il filo guida, individuare l'estremità distale e verificare che venga inserito con questa estremità.
- Durante la procedura, mantenere un'irrigazione continua tra il catetere guida e il dispositivo interventistico, e tra il dispositivo interventistico e il filo guida. L'irrigazione impedisce la presenza di mezzo di contrasto e/o la formazione di coaguli sul filo guida e nel lume del catetere.
- Per il contenitore con tubo di protezione dell'estremità distale (vedere Modalità di utilizzo, Figura 1), non rimuovere o inserire il

- tubo di protezione dell'estremità distale mentre il filo guida è alloggiato nel contenitore.
- Per il contenitore con tubo di protezione dell'estremità distale (vedere Modalità di utilizzo, Figura 1), rimuovere il tubo di protezione dell'estremità distale prima di alloggiare nuovamente il filo guida nel contenitore.
- Questo dispositivo contiene la seguente sostanza definita come CMR 1A/1B e interferente endocrino in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso; Cobalto: N. di CAS: 7440-48-4.

Malfunzionamenti ed eventi avversi

I possibili malfunzionamenti ed eventi avversi durante l'uso del filo guida comprendono, tra gli altri:

1. Malfunzionamenti

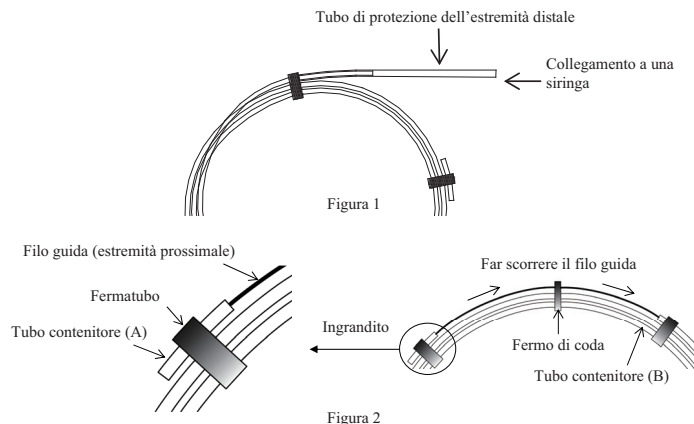
Mancato attraversamento di una lesione	Rottura o piegatura del filo guida	Danni quali distacco
Difficoltà di rimozione	Distacco del rivestimento	Frammenti di un filo guida danneggiato

2. Eventi avversi

Decesso	Infezioni	Dissezione vascolare
Perforazione vascolare	Complicanze emorragiche	Embolia
Trombo	Infarto	Ischemia
Aritmia	Vasospasmo	Occlusione vascolare
Riduzione della pressione arteriosa	Reazione allergica	

Modalità di utilizzo

- Ispezione prima dell'uso
 - Prima dell'uso, eseguire un'ispezione accurata e verificare che il filo guida e la relativa confezione non siano danneggiati.
 - Prima dell'uso, verificare che il filo guida sia compatibile con il dispositivo interventistico da utilizzare.
- Preparazione
 - Selezionare il filo guida più adatto per l'area interessata e rimuovere dalla confezione sterile il tubo contenitore con il filo guida.
 - Riempire il tubo contenitore con soluzione salina eparinata e sterilizzata utilizzando una siringa, in modo da immergere l'intero dispositivo. Durante l'operazione, la soluzione salina eparinata e sterilizzata può fuoriuscire dal tubo contenitore. Per il contenitore con il tubo di protezione dell'estremità distale (Figura 1), è possibile collegare una siringa al tubo di protezione dell'estremità distale.
 - Prima di inserire il filo guida, riempire il lume del dispositivo interventistico con la soluzione salina eparinata e sterilizzata.
 - Rilasciare il filo guida dal fermo di coda e farlo scorrere lentamente, spingendone l'estremità distale attraverso il tubo contenitore (B) (Figura 2).



- e) Quando l'estremità distale del filo guida sporge di 5 o 6 cm oltre l'altra estremità del tubo contenitore (o dell'estremità distale del tubo di protezione), se necessario, sagomare la punta secondo le pratiche standard.
- f) Afferrare delicatamente il filo guida fuoriuscito dall'estremità distale del tubo contenitore (o dell'estremità distale del tubo di protezione), il più vicino possibile al tubo contenitore, ed estrarlo lentamente e con cautela.
- g) In caso di resistenza durante la rimozione del filo guida dal tubo contenitore, iniettare altra soluzione salina eparinata e sterilizzata nel tubo contenitore. Continuare a rimuovere il filo guida quando non si avverte più resistenza. Assicurarsi di iniettare nel tubo contenitore sufficiente soluzione salina eparinata e sterilizzata perché il rivestimento idrofobico potrebbe subire danni se si rimuove con forza il filo guida rivestito.
- h) Dopo avere estratto il filo guida dal tubo contenitore, ispezionarlo per verificare che non sia danneggiato.

3. Procedure per l'inserimento

- Sistema Over-the-wire
 - a) Inserire con attenzione l'estremità distale

- del filo guida nel lume del filo guida del dispositivo interventistico.
- b) Far avanzare con cautela il filo guida finché la punta non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del dispositivo interventistico.
- c) Innestare il catetere guida e inserire il sistema del dispositivo interventistico (con il filo guida) nel connettore a Y.
- d) Far avanzare il sistema del dispositivo interventistico attraverso il catetere guida finché la punta del sistema del filo guida non si trovi in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
- e) Serrare la valvola emostatica del connettore a Y per creare una chiusura ermetica attorno al dispositivo interventistico. Verificare che il movimento del filo guida sia ancora possibile.
- f) Verificare che il filo guida si muova agevolmente.
- g) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- h) Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione. Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.

- i) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- j) Far avanzare il dispositivo interventistico fino a raggiungere la lesione, evitando che il filo guida si sposti. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

■ Sistema di sostituzione rapida

- a) Innestare il catetere guida.
- b) Inserire l'introduttore del filo guida nel connettore a Y del catetere guida.
- c) Inserire con cautela la punta del filo guida nell'introduttore.
- d) Far avanzare il filo guida attraverso il catetere sotto guida fluoroscopica finché la punta del filo guida non si trova in posizione appena prossimale rispetto alla punta del catetere guida.
- e) Se necessario, applicare sul filo guida il dispositivo di controllo della torsione.
- f) Far avanzare il filo guida sotto guida fluoroscopica attraverso la lesione.

Verificare mediante angiografia che il filo guida abbia superato la lesione target sede del restringimento.

- g) Osservare il movimento del filo guida nei vasi.
- h) Rimuovere il dispositivo di controllo della torsione del filo guida e l'introduttore del filo guida.
- i) Guidare il dispositivo interventistico sul filo guida evitando lo spostamento e avanzare fino a raggiungere la lesione. Verificare che la punta distale del filo guida e la sua posizione nel vaso siano visibili durante la manipolazione del dispositivo interventistico.

4. Procedure per la sostituzione del filo guida

■ Sistema Over-the-wire

- a) Rimuovere lentamente il filo guida, controllandone il movimento sotto guida fluoroscopica.
- b) Inserire il nuovo filo guida secondo le indicazioni contenute nella presente sezione "Modalità di utilizzo".

Metodo di conservazione

Non conservare il filo guida e la relativa confezione ripiegati e/o sottoposti a carichi pesanti. Il filo guida e la relativa confezione devono essere conservati lontano dall'acqua. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Data di scadenza

La data di scadenza è indicata sull'etichetta applicata sulla confezione del filo guida.

Contenuto

5 pezzi / scatola

Esclusione di responsabilità

In nessun modo "ASAHI INTECC CO., LTD. e le sue affiliate" (in seguito denominate "Azienda") possono essere ritenute responsabili per incidenti, lesioni personali ed eventi avversi dovuti a qualsiasi utilizzo improprio di questo/i prodotto/i in contravvenzione alle presenti istruzioni. In nessun caso l'Azienda può essere ritenuta responsabile dei danni derivanti (i) dalla conservazione dei prodotti dopo la spedizione dall'Azienda stessa o (ii) causati dalla selezione di pazienti, tecniche chirurgiche o altre attività mediche effettuate dalla struttura medica che utilizza i prodotti.

"SION" e "SUOH" sono marchi commerciali o marchi registrati di ASAHI INTECC CO., LTD. in Giappone e in altri Paesi.

*I valori di carico della punta rappresentano le medie dei valori delle specifiche tecniche del prodotto misurate secondo il metodo di prova standard interno, ipotizzando la pressione applicata alla lesione dalla punta del filo guida.

Prowadnik PCI z serii SION

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem przewodnika należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w punktach „Wskazania do stosowania”, „Przeciwwskazania”, „Przestrogi”, „Środki ostrożności” oraz „Sposób korzystania z produktu”, będących częścią niniejszej instrukcji użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować powikłaniami, które mogą prowadzić do poważnych urazów u pacjenta bądź do jego śmierci.

Jeżeli użytkownik i/lub pacjent dowie się o poważnym zdarzeniu związanym z przewodnikiem, powinien zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w państwie członkowskim.

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy przewodnika PCI z serii SION. Informacje szczegółowe (długość przewodnika, długość odcinka nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, itd.) podano na etykiecie produktu.

Opis

Prowadnik PCI z serii SION został opracowany jako przewodnik z miękką końcówką, aby zmniejszyć ryzyko perforacji naczyń podczas utrzymywania go w naczyniu, ponieważ przewodnik z twardą końcówką może spowodować perforację naczyń.

Podstawowa struktura SION składa się ze stożkowego przewodu głównego, dwóch rodzajów spirali dystalnych (spirali zewnętrznej i spirali wewnętrznej) oraz przewodu zabezpieczającego. Stożkowy przewód główny, spirale i przewód zabezpieczający są lutowane. Część długości spirali zewnętrznej nie przepuszcza promieni rentgenowskich, dzięki czemu jej położenie można łatwo sprawdzić za pomocą radioskopii. SION ma elastyczne obciążenie końcówki wynoszące 0,7 gf*, aby zapewnić bezpieczeństwo w naczyniu krwionośnym. Wewnętrzna spirala wykonana ze skręcanego drutu jest umieszczona wewnątrz zewnętrznej spirali, a przewód zabezpieczający jest połączony z wewnętrzną spiralą i końcówką, dzięki czemu przewód zabezpieczający nie odłączy się, nawet w mało prawdopodobnym przypadku odłączenia się stożkowego przewodu głównego od końcówki, zapobiegając odłączeniu się zewnętrznej spirali i stożkowego przewodu głównego. Dystalna strona SION jest pokryta hydrofilnym polimerem.

SION blue ma taką samą podstawową strukturę jak SION, ale część powłoki na końcówce spirali zewnętrznej stanowi silikon, dzięki czemu końcówka jest bardziej elastyczna niż w przypadku SION, a obciążenie końcówki wynosi 0,5 gf*.

Podstawowa struktura dystalnej strony SION blue ES jest taka sama jak SION blue, a obciążenie końcówki wynosi 0,5 gf*, ale długość spirali zewnętrznej jest krótsza, a sztywność trzonu jest większa. Wewnętrzna struktura nie ma wewnątrz przewodu zabezpieczającego, ale dystalna konstrukcja stożkowego przewodu głównego została opracowana w taki sposób, aby proksymalna strona przewodu przewodnika nie ulegała łatwemu przemieszczeniu. Podobnie jak w przypadku SION blue, powłoka SION blue ES jest silikonowa w części dystalnej i hydrofilna w części proksymalnej, a długość powłoki hydrofilnej jest dłuższa niż w przypadku SION blue.

SION black różni się od SION i SION blue tym, że ma powłokę z żywicy poliuretanowej na zewnętrznym zwoju oraz powłokę hydrofilną na wierzchu. Obciążenie końcówki wynosi 0,8 gf*.

Podstawowa struktura SUOH 03 jest taka sama jak SION blue i SION blue ES, ale wykorzystuje zewnętrzną cewkę wykonaną ze skręcanego drutu, co skutkuje najniższym obciążeniem końcówki w serii SION na poziomie 0,3 gf*. Dystalna powierzchnia pokryta jest powłoką hydrofilną.

We wszystkich seriach przewodników PCI SION proksymalna strona stożkowego przewodu głównego jest pokryta PTFE (politetrafluoroetylenem). Nominalna średnica zewnętrzna produktu wynosi 0,36 mm (0,014 cala) na całej długości. Na proksymalnym końcu wyrobów o długości mniejszej niż 300 cm znajduje się przyłącze przewodu przedłużającego, który służy do wymiany wyrobu używanego w połączeniu; można podłączyć przewód przedłużający ASAHI INTECC.

	Obciążenie końcówki*	Średnica zewnętrzna	Długość powłoki	Długość spirali	Długość fragmentu nieprzepuszczającego promieniowania rentgenowskiego
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Powłoka hydrofilna : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Powłoka silikonowa : 1,5 cm Powłoka hydrofilna : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Powłoka silikonowa : 2,5 cm Powłoka hydrofilna : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Powłoka poliuretanowa : 20,0 cm Powłoka hydrofilna : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Powłoka hydrofilna : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Wskazania do stosowania

Ten przewodnik jest przeznaczony do ogólnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Ten przewodnik jest przeznaczony do ułatwiania umieszczania balonowych cewników dylatacyjnych lub innych interwencyjnych wyrobów terapeutycznych w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Oczekuje się, że średni czas użytkowania wyniesie 120 minut. Ten przewodnik nie jest przeznaczony do stosowania w strukturach nerwowo-naczyniowych i naczyniach obwodowych.

Docelowa populacja poddawana leczeniu

Przewodniki PCI z serii SION są przeznaczone dla pacjentów spełniających wskazania do zabiegów PCI. Nie jest wskazany do stosowania u noworodków, niemowląt lub dzieci, a także u pacjentów w ciąży, z zaburzeniami czynności nerek i reakcjami alergicznymi na środki kontrastowe lub glikol polietylenowy (PEG).

Przeciwwskazania

- Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność średnicy przewodnika z innym urządzeniem interwencyjnym.
- Nie należy stosować przewodnika u pacjentów, u których występuje reakcja alergiczna na środki kontrastowe lub z zaburzeniami czynności nerek.
- Ten przewodnik zawiera w swojej powłoce hydrofilnej PEG400. Nie stosować przewodnika u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne na glikol polietylenowy (PEG).
- Nie stosować przewodnika u pacjentek w ciąży lub pacjentek, które mogą być w ciąży (promieniowanie rentgenowskie może szkodliwie oddziaływać na płód).
- Przewodnik musi być używany w instytucji, w której można przeprowadzać zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym. Jeśli

przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym będzie niemożliwe, w najgorszym przypadku może dojść do zdarzeń zagrażających życiu.

- Prowadnik jest wstępnie sterylizowany tlenkiem etylenu (EOG) i jest przeznaczony do

jednorazowego użytku. Nie używać ponownie ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie lub ponowna sterylizacja mogą negatywnie wpłynąć na działanie lub jakość przewodnika i opakowanie, a także sprzyjają ryzyku wystąpienia powikłań, z zakażeniem włącznie.

Przestrogi

- Prowadnik może być używany wyłącznie przez lekarza, który został w pełni przeszkolony w zakresie PCI.
- Nigdy nie należy używać tego przewodnika w połączeniu z cewnikami posiadającymi metalowe części, które mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią tego przewodnika (np. cewniki do ateroskтомii, metalowe rozszerzacze), metalowymi igłami lub wkładkami w osłonie metalowej.
- Podczas stosowania przewodnika należy sprawdzać i monitorować ruch jego końcówki

- pod kontrolą fluoroskopii. Nie używać w obszarach naczyń, które nie są lub nie mogą zostać uwidocznione.
- Nie należy łączyć tego przewodnika z przedłużaczami wyprodukowanymi przez firmy inne niż ASAHI INTECC. Nie ruszać przewodnikiem, gdy podłączony jest przedłużacz. W przeciwnym razie przewodnik może zostać uszkodzony lub przedłużacz może zostać nieumyślnie odłączony.
- W żaden sposób nie modyfikować przewodnika.

Środki ostrożności

- Nie używać tego przewodnika po upływie daty ważności wskazanej na etykiecie. Wszystkie przewodniki, których data ważności upłynęła, należy wyrzucić.
- Prowadniki to delikatne instrumenty i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, nie należy używać przewodnika. Produkt należy rozpakować zawsze bezpośrednio przed użyciem. Podczas przenoszenia i użycia przewodnika należy zachować zasady aseptyki.
- Należy zawsze utrzymywać przewodnik w stanie wilgotnym, aby nie uszkodzić jego powłoki hydrofilnej.
- Nie należy wycierać tego przewodnika używając roztworu organicznego, np. alkoholu.
- Po użyciu narzędzia należy podjąć środki zapobiegające zakażeniu. Zutilizować przewodnik i opakowanie jako odpad medyczny.
- Nigdy nie należy pchać, wkręcać, wyciągać ani obracać przewodnika, który napotyka na opór. Obracanie lub pchanie przewodnika wbrew napotkanemu oporowi może spowodować uszkodzenie i/lub oddzielenie końcówki przewodnika lub uszkodzić bezpośrednio naczynie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia tego przewodnika. Należy określić fluoroskopowo przyczynę oporu i podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze.

- Prowadniki należy zawsze wsuwać i wyjmować powoli i ostrożnie.
- Obracając ten przewodnik w naczyniu krwionośnym, nie należy obracać go ciągle w tym samym kierunku. Obracając przewodnik, należy to czynić naprzemiennie zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie należy obracać o więcej niż dwa obroty (720°) w tym samym kierunku.
- Podczas wyciągania i ponownego wprowadzania przewodnika należy przepłukać go heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej lub innym odpowiednim roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do urządzenia zabiegowego. Prowadnik należy wymieniać ostrożnie, aby nie dopuścić powietrza i/lub nie spowodować urazu. Wprowadzając przewodnik ponownie, należy upewnić się, czy końcówka urządzenia zabiegowego jest swobodna w świetle naczynia i czy nie jest nastawiona na ścianę naczynia. W przeciwnym razie może dojść do urazu. Aby potwierdzić położenie, należy zastosować nieprzepuszczający promieni rentgenowskich znacznik urządzenia zabiegowego.
- Swobodny ruch przewodnika w urządzeniu zabiegowym jest ważną cechą sterowalnego systemu przewodnika, ponieważ daje użytkownikowi cenne, realne informacje. Przed

- użyciem należy sprawdzić system pod kątem występowania oporu. Wyregulować lub wymienić zastawkę hemostaticzną na zastawkę regulowaną jeśli hamuje ruch przewodnika.
- Nie umieszczać stentu przy użyciu więcej niż jednego przewodnika lub operując przewodnikiem za pośrednictwem rozpórki stentu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stentu bądź pęknięcia lub rozpadnięcia się przewodnika.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ten przewodnik ma odpowiedni rozmiar i kształt do zabiegu oraz czy jest kompatybilny z urządzeniem, które będzie używane w połączeniu z nim.
- Należy zapoznać się z Instrukcją użycia dołączoną do wyrobu medycznego (np. balonowych cewników dylatacyjnych lub innych urządzeń interwencyjnych), który ma być używany w połączeniu z tym przewodnikiem.
- Podłączając przedłużacz do tego przewodnika należy go bezpiecznie włożyć do linii granicznej pomiędzy powłoką niewykonaną z PTFE a powłoką z PTFE na proksymalnym końcu przewodnika. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w połączeniu, należy natychmiast zaprzestać używania przewodnika.
- Dokładnie sprawdzić przewodnik, czy nie uległ zgięciu, zagięciu lub innemu uszkodzeniu przed użyciem, a także dokładnie go sprawdzić, jeśli to

możliwe, podczas wykonywania zabiegu. Nie używać uszkodzonego przewodnika.

- Podczas formowania końcówki należy uważać, aby nie uszkodzić spirali.
- Przed wprowadzeniem przewodnika należy sprawdzić, który koniec jest końcem distalnym i upewnić się, że jest on wprowadzany od strony distalnej.
- Podczas zabiegu należy utrzymywać ciągłe płukanie solą fizjologiczną pomiędzy cewnikiem prowadzącym a urządzeniem interwencyjnym oraz pomiędzy urządzeniem interwencyjnym a przewodnikiem. Płukanie zapobiega gromadzeniu się środka kontrastowego i/lub tworzeniu się skrzepów na przewodniku i w świetle cewnika.
- W przypadku uchwytu z ręką zabezpieczającą końcówkę dystalną (patrz Sposób korzystania z produktu, Rysunek 1), nie wyjmuj i nie wkładaj rurki zabezpieczającej końcówkę dystalną, gdy przewodnik jest umieszczony w uchwycie.
- W przypadku uchwytu z ręką zabezpieczającą końcówkę dystalną (patrz Sposób korzystania z produktu, Rysunek 1), wyjmij rękę zabezpieczającą końcówkę dystalną przed ponownym umieszczeniem przewodnika w uchwycie.
- Wyrob ten zawiera następującą substancję zdefiniowaną jako CMR 1A/1B i substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną w stężeniu wagowym powyżej 0,1 %; Kobalt: Nr CAS 7440-48-4.

Usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane

Eventualnie usterki, uszkodzenia i zdarzenia niepożądane związane z użyciem przewodnika obejmują m.in.:

1. Nieprawidłowe działania

Niemożliwość przejścia za zmianę	Złamanie lub wygięcie przewodnika	Uszkodzenia takie jak oddzielenie
Trudności w wyjęciu	Odchodzenie powłoki	Odlamki uszkodzonego przewodnika

2. Zdarzenia niepożądane

Śmierć	Zakażenie	Rozwarstwienie ściany naczynia
Perforacja naczynia	Powikłania związane z krwawieniem	Zator
Powstanie zakrzepu	Zawał	Ischemia
Arytmia	Skurcz naczyń	Okluzja naczyniowa

Sposób korzystania z produktu

1. Sprawdzenie przed użyciem

- Przed użyciem dokładnie sprawdzić i potwierdzić, czy przewód i opakowanie nie są uszkodzone.
- Przed użyciem potwierdzić, że przewód jest kompatybilny z mającymi zostać użytymi urządzeniami interwencyjnymi.

2. Przygotowanie

- Wybrać najbardziej odpowiedni przewód dla zmienionego chorobowo miejsca i wyciągnąć rękę uchwytu zawierającą przewód ze sterylnego opakowania.
- Napełnić rękę uchwytu heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej przy

- użyciu strzykawki, aby nawilżyć całe urządzenie. Należy pamiętać, że heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej może wtedy wylać się z ręki uchwytu. W przypadku uchwytu z ręką ochronną na końcu dystalnym (rysunek 1), strzykawkę można podłączyć do ręki ochronnej na końcu dystalnym.
- Przed włożeniem przewodu należy napełnić światło urządzenia zabiegowego heparynizowanym i jałowym roztworem soli fizjologicznej.
 - Zwolnić przewód z tylnego klipsa i wolno go przesunąć, pchnąć dystalną końcówkę przewodu przez rękę uchwytu (B) (Rys. 2).

Rurka zabezpieczająca końcówkę dystalną

Podłączenie do strzykawki

Rysunek 1

Prowódnik (proksymalna końcówka)

Klips ręki

Rurka uchwytu (A)

Przesuwać przewód

Powiększone

Tylny klips

Rurka uchwytu (B)

Rysunek 2

- Gdy końcówka dystalna przewodu zostanie wysunięta o 5 do 6 cm poza drugi koniec uchwytu ręki (lub ręki zabezpieczającej końcówkę dystalną), w razie potrzeby należy uformować końcówkę zgodnie ze standardową praktyką.
- Delikatnie chwycić przewód wychodzący z końcówki dystalnej ręki uchwytu (lub ręki

- zabezpieczającej końcówkę dystalną), w miejscu jak najbliższej ręki uchwytu i powoli i ostrożnie wyciągnąć przewód.
- Jeśli odczuwalny jest opór podczas wyjmowania przewodu z ręki uchwytu, należy ponownie wstrzyknąć heparynizowany i jałowy roztwór soli fizjologicznej do ręki uchwytu. Kiedy opór przestanie być

- wyczuwalny, należy kontynuować wyciąganie przewodu. Należy upewnić się, że wstrzyknięto odpowiednią ilość heparynizowanego i jałowego roztworu soli fizjologicznej do ręki uchwytu, ponieważ podczas wyjmowania powlekanego przewodu z użyciem dużej siły może dojść do uszkodzenia powłoki hydrofilnej.
- Wyciągnąć przewód z ręki uchwytu, sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.

3. Procedury wkładania

■ System over-the-wire

- Włożyć dystalną końcówkę przewodu ostrożnie w światło przewodu urządzenia interwencyjnego.
- Wprowadzić ten przewód ostrożnie do momentu, gdy jego końcówka jest w pozycji proksymalnej do końcówki urządzenia interwencyjnego.
- Zacząć cewnik prowadzący i włożyć urządzenie interwencyjne (z przewodem) do złącza Y.
- Wprowadzić urządzenie interwencyjne przez cewnik prowadzący do momentu, gdy końcówka przewodu będzie w pozycji proksymalnej w stosunku do końcówki cewnika prowadzącego.
- Zacisnąć zastawkę hemostatyczną złącza Y, aby utworzyć uszczelnienie dookoła urządzenia interwencyjnego. Upewnić się, czy ruch przewodu jest ciągle dozwolony.
- Sprawdzić, czy przewód porusza się gładko.
- Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodu, jeśli to konieczne.
- Wprowadzić przewód pod obserwacją fluoroskopową, aby przejść przez zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
- Obserwować ruch przewodu w naczyniach.
- Wprowadzić urządzenie interwencyjne do

momentu osiągnięcia zmiany zapobiegając ruchowi przewodu. Zapewnić, by dystalna końcówka przewodu i jego umiejscowienie były widoczne podczas poruszania urządzeniem interwencyjnym.

■ System szybkiej wymiany

- Zacząć cewnik prowadzący.
- Wprowadzić introduktor przewodu do złącza Y cewnika prowadzącego.
- Ostrożnie włożyć końcówkę przewodu do introduktora.
- Wprowadzić przewód przez cewnik wprowadzający pod kontrolą fluoroskopową do momentu, gdy końcówka przewodu znajdzie się w pozycji proksymalnej do końcówki cewnika wprowadzającego.
- Dołączyć urządzenie obrotowe do przewodu, jeśli to konieczne.
- Wprowadzić przewód pod kontrolą fluoroskopową, aby przejść za zmianę. Potwierdzić za pomocą angiografii, że przewód przeszedł przez docelową zwężoną zmianę.
- Obserwować ruch przewodu w naczyniach.
- Usunąć urządzenie obrotowe przewodu oraz introduktor przewodu.
- Śledzić urządzenie interwencyjne za przewodem, zapobiegając ruszaniu się przewodu, wprowadzać do momentu dotarcia do zmiany. Zadbać o to, by dystalna końcówka przewodu i jej miejsce w naczyniu były widoczne w trakcie wykonywania ruchów urządzeniem interwencyjnym.

4. Procedury wymiany przewodu

■ System over-the-wire

- Usunąć wolno przewód, monitorując ruch przewodu fluoroskopowo.
- Włożyć następny przewód zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Sposób korzystania z produktu”.

Przechowywanie

Nie przechowywać przewodu i opakowania w pozycji zgiętej i/lub silnie obciążonej. Przewód i opakowanie należy przechowywać z dala od wody. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

Data ważności

Data ważności jest podana na etykiecie umieszczonej na opakowaniu przewodnika.

Zawartość

5 sztuk / pudełko

Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Firma „ASAHI INTECC CO., LTD. i jej podmioty zależne” (odtąd nazywane „Firmą”) w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, obrażenia osób, zdarzenia niepożądane spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu lub produktów albo jakimkolwiek innym działaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe (i) wskutek nieprawidłowego przechowywania produktu po jego wysyłce z Firmy lub (ii) wskutek niewłaściwego wyboru pacjentów, technik chirurgicznych lub jakichkolwiek innych działań lekarskich powziętych przez instytucję medyczną korzystającą z produktu.

„SION” i „SUOH” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ASAHI INTECC CO., LTD. w Japonii i innych krajach.

*Wartości obciążenia końcówki reprezentują średnie wartości specyfikacji produktu zmierzone zgodnie ze standardową wewnętrzną metodą testowania przy założeniu siły przyłożonej do zmiany przez końcówkę przewodnika.

Fio guia PCI série SION

Instruções de utilização

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este fio guia e observe o estipulado nas secções Indicações de utilização, Contraindicações, Advertências, Precauções e Procedimento recomendado nestas Instruções de Utilização. A não observação pode resultar em complicações, incluindo lesão grave ou morte do paciente.

Se um utilizador e/ou um paciente tomar conhecimento de um incidente grave relacionado com o fio guia, comunique o facto ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro.

Estas Instruções de Utilização aplicam-se ao fio guia PCI série SION. Para informações (comprimento do fio guia, comprimento da secção radiopaca, etc.), consulte a etiqueta do produto.

Descrição

O fio guia PCI série SION foi desenvolvida como um fio guia de ponta macia para reduzir o risco de perfuração vascular quando colocado num vaso, pois segurar um fio guia com ponta dura num vaso pode resultar em perfuração vascular.

A estrutura básica do SION consiste num cabo principal cónico, dois tipos de bobinas distais (uma bobina externa e uma bobina interna) e um cabo de segurança. O cabo principal cónico, as bobinas e o cabo de segurança são soldados. Um comprimento parcial da bobina externa é radiopaca para que a sua posição possa ser facilmente confirmada através de radioscopia. O SION tem uma carga da ponta flexível de 0,7 gf* para garantir a segurança no vaso sanguíneo. Uma bobina interna feita de corda é colocada dentro da bobina externa, e o fio de segurança é preso à bobina interna e à ponta para que o fio de segurança não se solte, mesmo no caso improvável do fio principal cónico sair da ponta , evitando que a bobina externa e o fio principal cónico se soltem. O lado distal do SION é revestido com polímero hidrófilo.

O SION blue tem a mesma estrutura básica do SION, mas parte do revestimento na ponta externa da bobina é de silicone, tornando a ponta mais flexível do que a do SION, e a carga da ponta é de 0,5 gf*.

A estrutura básica do lado distal do SION blue ES é a mesma do SION blue e a carga da ponta é de 0,5 gf*, mas o comprimento da bobina externa é menor e a rigidez da haste é maior. A estrutura interna não possui um fio de segurança no seu interior, mas o desenho distal do fio principal cónico é projetado de modo que o lado proximal do fio guia não seja facilmente desalocado. Tal como acontece com o SION blue, o revestimento do SION blue ES é um revestimento de silicone na parte distal e hidrófilo na parte proximal, e o comprimento do revestimento hidrófilo é maior do que o do SION blue.

O SION black difere do SION e do SION blue porque possui um revestimento de resina de poliuretano na bobina externa e um revestimento hidrófilo na parte superior. A carga da ponta é de 0,8 gf*.

A estrutura básica do SUOH 03 é a mesma do SION blue e do SION blue ES, mas utiliza uma bobina externa feita de corda, resultando na menor carga da ponta da série SION de 0,3 gf*. A superfície distal é revestida com um revestimento hidrófilo.

Em todos os fios guia PCI da série SION, o lado proximal do fio principal cónico é revestido com PTFE (politetrafluoroetileno). O diâmetro externo nominal do produto é de 0,36 mm (0,014 polegadas) em todo o comprimento. Na extremidade proximal dos dispositivos inferiores a 300 cm, existe uma conexão para um

fio de extensão, que é utilizado para substituir o dispositivo combinado; O fio de extensão do ASAHI INTECC pode ser conectado.

	Carga da Ponta*	Diâmetro Externo	Comprimento do Revestimento	Comprimento da Bobina	Comprimento Radiopaco
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Revestimento hidrófilo: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Revestimento do silicone: 1,5 cm Revestimento hidrófilo: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Revestimento do silicone: 2,5 cm Revestimento hidrófilo: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Revestimento de poliuretano: 20,0 cm Revestimento hidrófilo: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Revestimento hidrófilo: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indicações de utilização

Este fio guia tem como finalidade a intervenção coronária percutânea (ICP) geral. Este fio guia destina-se a facilitar a colocação de cateteres de dilatação por balão ou outros dispositivos terapêuticos intervencionistas na cardiovascular. A duração média da utilização deverá ser de 120 minutos.

Este fio guia não se destina a utilização na neurovasculatura ou na vascularização periférica.

População-alvo tratada

O fio guia PCI série SION destina-se a pacientes elegíveis de acordo com as indicações para procedimentos de ICP. Não é indicado para uso em neonatos, bebés ou crianças, bem como em pacientes grávidas, com função renal prejudicada e que tenham reação alérgica a meios de contraste ou polietileno glicol (PEG).

Contraindicações

- Confirmar a compatibilidade do diâmetro do fio guia com outro dispositivo de intervenção antes da utilização efetiva.
- Não utilizar o fio guia em doentes que façam reação alérgica ao meio de contraste ou que tenham disfunção renal.
- O fio guia contém PEG400 no seu revestimento hidrófilo. Não utilizar o fio guia em doentes que façam reações alérgicas ao polietileno glicol (PEG).
- Não use o fio guia em doentes grávidas ou que possam estar grávidas (o raio X pode afetar o feto).
- Este fio guia deve ser utilizado numa instituição onde seja possível efetuar imediatamente uma cirurgia de emergência. Se não estiver disponível uma cirurgia de emergência, no pior dos cenários, podem ocorrer eventos potencialmente fatais.
- Este fio guia foi pré-esterilizado com gás de óxido de etileno (GOE) e destina-se apenas a uma utilização única. Não reutilize ou reesterilize. Se reutilizado ou reesterilizado, o desempenho ou a qualidade deste fio guia e respetiva embalagem podem ficar comprometidos, havendo o risco de ocorrência de complicações, incluindo infeção.

Advertências

- Este fio guia deve ser utilizado exclusivamente por um médico com a devida formação no tratamento por ICP.
- Nunca utilize este fio guia em combinação com cateteres com peças de metal que possam entrar em contacto direto com a superfície deste fio guia

(por exemplo, cateteres de aterectomia, dilatadores de metal), agulhas de metal ou introdutores de bainha metálica.

- Durante a utilização do fio guia, verificar e controlar o movimento da sua ponta sob fluoroscopia. Não utilize em áreas dos vasos que não sejam ou não possam ser visualizadas.
- Não ligue este fio guia a fios de extensão destacáveis disponibilizados por outros

fabricantes além da ASAHI INTECC. Não manipule este fio guia enquanto o fio de extensão destacável estiver ligado. De contrário, o arame guia poderá ser danificado ou o fio de extensão destacável poderá ser separado não intencionalmente.

- Não modifique este fio guia sob nenhum pretexto.

Precauções

- Não utilize o fio guia após o prazo de validade indicado na etiqueta. Elimine qualquer fio guia que ultrapasse o prazo de validade.
- Os fios-guia são instrumentos delicados e devem ser manuseados com cuidado.
- Não utilize o fio guia se a embalagem estiver aberta ou danificada. Abra a embalagem diretamente antes da utilização do produto. Utilize uma técnica asséptica no manuseamento e utilização do fio guia.
- Mantenha sempre o fio guia no estado húmido para evitar danos no revestimento hidrófilo.
- Não limpe este fio guia utilizando uma solução orgânica como álcool.
- Tome medidas preventivas contra infeções após a utilização. Descarte este fio guia e a embalagem como resíduos médicos.
- Nunca empurre, force, retire ou rode este fio guia a ponto de sentir resistência. Rodar ou empurrar este fio guia quando sentir resistência pode provocar danos e/ou a separação da ponta deste fio guia ou lesões diretas num vaso. Não seguir estas indicações poderá causar danos a este fio guia. Determine a causa da resistência sob fluoroscopia e adote quaisquer medidas necessárias.
- Introduza sempre ou retire os fios-guia devagar com cuidado.
- Ao rodar este fio guia dentro do vaso sanguíneo, não rode continuamente na mesma direção. Ao rodar o fio guia, faça-o alternadamente no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido inverso. Não exceda as duas rotações (720°) na mesma direção.
- Irrigue o fio guia com solução salina heparinizada e esterilizada ou outra solução adequada enquanto o remove e reinsere para evitar a entrada de ar no dispositivo de intervenção. Efetue a troca deste fio guia com cuidado para evitar a entrada de ar e/ou traumatismos. Ao reintroduzir o fio guia,

confirme se a ponta do dispositivo de intervenção está desobstruída no lúmen do vaso e não está a incidir contra a parede do vaso. A não observação desta regra pode resultar em trauma. Utilize o marcador radiopaco do dispositivo de intervenção para confirmar a posição.

- A liberdade de movimentos do fio guia dentro do dispositivo de intervenção é uma característica importante de um sistema de fio guia orientável porque fornece ao utilizador informações tácteis úteis. Teste o sistema para verificar se apresenta resistência antes da utilização. Regule ou substitua a válvula hemostática por uma válvula regulável caso se considere que esta inibe os movimentos do fio guia.
- Não efetue a administração do stent utilizando mais de um fio guia ou operação com fio através de um suporte do stent. De contrário, o stent poderá danificar-se ou o fio guia poderá partir-se ou partir-se.
- Antes de utilizar, confirme que este fio guia tem o tamanho e formato apropriados para o procedimento e se é compatível com o dispositivo a ser utilizado em combinação.
- Consulte as instruções de utilização anexas ao dispositivo médico (por exemplo, cateteres de dilatação por balão ou outros dispositivos de intervenção) a serem utilizados em combinação com este fio guia.
- Quando ligar o fio de extensão destacável a este fio guia, deverá ser firmemente inserido até à linha divisória entre os segmentos não revestidos com PTFE e os segmentos revestidos com PTFE na extremidade proximal do fio guia. Se alguma anormalidade for encontrada na conexão, deixe de utilizar o fio guia imediatamente.
- Inspeccione cuidadosamente o fio guia para verificar se apresenta dobras, vincos ou outros danos antes da utilização e sempre que possível durante o procedimento. Não utilize o fio guia se este estiver danificado.

- Ao moldar a ponta, tenha cuidado para não danificar a bobina.
- Antes de inserir o fio guia, verifique qual é a extremidade distal e certifique-se de o inserir a partir da extremidade distal.
- Mantenha uma solução salina contínua entre o cateter-guia e o dispositivo de intervenção e entre o dispositivo de intervenção e o fio guia durante o procedimento. A irrigação evita a formação e/ou coagulação do meio de contraste no fio guia e no lúmen do cateter.
- Para o suporte com tubo de proteção da extremidade distal (consulte Como utilizar,

Figura 1), não remova ou insira o tubo de proteção da extremidade distal enquanto o fio guia estiver alojado no suporte.

- Para o suporte com tubo de proteção da extremidade distal (consulte Como utilizar, Figura 1), remova o tubo de proteção da extremidade distal antes de alojar novamente o fio guia no suporte.
- Este dispositivo contém a seguinte substância definida como CMR 1A/1B e a substância desreguladora do sistema endócrino numa concentração superior a 0,1 % em massa por massa; Cobalto: N.º CAS 7440-48-4.

Avárias e eventos adversos

As possíveis avárias e eventos adversos resultantes da utilização deste fio guia incluem, sem carácter limitativo:

1. Avárias

Incapacidade para atravessar uma lesão	Quebra ou dobra do fio guia	Danos como separação
Dificuldade na remoção	Saída do revestimento	Fragmentos de um fio guia danificado

2. Eventos adversos

Morte	Infeção	Dissecção do vaso
Perfuração do vaso	Complicações de hemorragia	Embolia
Trombo	Enfarte	Isquemia
Arritmia	Vasoespasm	Oclusão vascular
Redução da pressão arterial	Reação alérgica	

Como utilizar

1. Inspeção antes da respetiva utilização

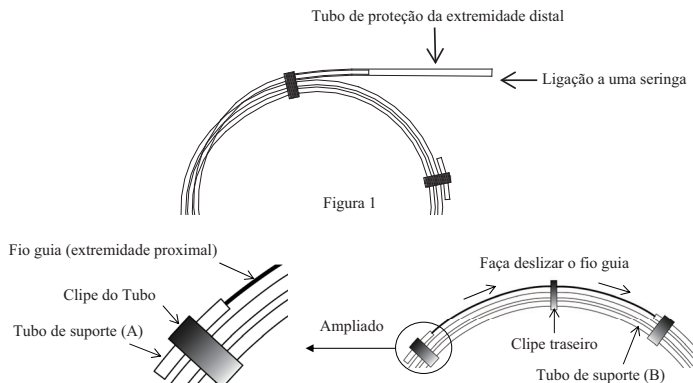
- Antes da utilização, inspecione e confirme cuidadosamente se o fio guia e a embalagem não estão danificados.
- Antes da utilização, confirme se o fio guia é compatível com o dispositivo de intervenção a utilizar.

Tenha em atenção que a solução salina heparinizada e esterilizada pode derramar do tubo de suporte durante esta ação. Para o suporte com o tubo de proteção da extremidade distal (Figura 1), uma seringa pode ser conectada ao tubo de proteção da extremidade distal.

2. Preparativos

- Selecione o fio guia mais adequado para a área afetada e remova o tubo de suporte que contém o fio guia da embalagem esterilizada.
- Encha o tubo de suporte com solução salina heparinizada e esterilizada utilizando, uma seringa para embeber o dispositivo completo.

- Encha o lúmen do dispositivo de intervenção com a solução salina heparinizada e esterilizada antes de inserir o fio guia.
- Liberte o fio guia do clipe traseiro e faça-o deslizar lentamente, empurre a extremidade distal do fio guia através do tubo de suporte (B) (Figura 2).



- e) Quando a extremidade distal do fio guia for superior a 5 a 6 cm para além da outra extremidade do tubo de proteção (ou o tubo de proteção da extremidade distal), caso seja necessário, deverá moldar a ponta em conformidade com a prática padrão.
- f) Segure gentilmente o fio guia que saiu da extremidade distal do tubo de proteção pela ponta, de modo a ficar o mais próximo possível do tubo de suporte, e puxe o fio guia lenta e cuidadosamente.
- g) Se sentir resistência ao remover o fio guia do tubo de suporte, volte a injetar a solução salina heparinizada e esterilizada no tubo de suporte. Continue a remover o fio guia depois de deixar de sentir resistência. Certifique-se de que injeta solução salina heparinizada e esterilizada suficiente no tubo de suporte, visto que o revestimento hidrófilo pode danificar-se ao remover o fio guia revestido com força excessiva.
- h) Depois de puxar o fio guia para fora do tubo de suporte, inspecione-o para garantir que não está danificado.

3. Procedimentos de inserção

- Sistema ao longo do fio
 - a) Insira a extremidade distal do fio guia

- cuidadosamente no lúmen do fio guia do dispositivo de intervenção.
- b) Faça avançar este fio guia cuidadosamente até a ponta ficar proximal à ponta do dispositivo de intervenção.
- c) Encaixe o cateter-guia e insira o sistema de dispositivo de intervenção (com o fio guia) no conector em Y.
- d) Faça avançar o sistema de dispositivo de intervenção pelo cateter-guia até a ponta do sistema de fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
- e) Aperte a válvula hemostática do conector em Y para criar um isolamento em torno do dispositivo de intervenção. Certifique-se de que o fio guia ainda apresenta liberdade de movimentos.
- f) Certifique-se de que o fio guia se move sem obstruções.
- g) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- h) Faça avançar este fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou pela lesão-alvo estreita.
- i) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- j) Faça avançar o dispositivo de intervenção até atingir a lesão, evitando que o fio guia se

movia. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

■ Sistema de troca rápida

- a) Encaixe o cateter-guia.
- b) Insira o introdutor do fio guia no conector em Y do cateter-guia.
- c) Insira cuidadosamente a ponta do fio guia no introdutor.
- d) Faça avançar o fio guia pelo cateter-guia sob fluoroscopia até a ponta do fio guia ficar proximal à ponta do cateter-guia.
- e) Coloque o dispositivo de rotação no fio guia, se necessário.
- f) Faça avançar o fio guia sob fluoroscopia para passar pela lesão. Através de angiografia, confirme se o fio guia passou

pela lesão-alvo estreita.

- g) Observe o movimento do fio guia nos vasos.
- h) Remova o dispositivo de rotação do fio guia e o introdutor do fio guia.
- i) Localize o dispositivo de intervenção no fio guia evitando que este se mova e faça-o avançar até atingir a lesão. Certifique-se de que a ponta distal do fio guia e a respetiva localização no vaso são visíveis durante as manipulações do dispositivo de intervenção.

4. Procedimentos para trocar o fio guia

■ Sistema ao longo do fio

- a) Remova este fio guia lentamente enquanto monitoriza o movimento deste fio guia sob fluoroscopia.
- b) Insira o fio guia seguinte de acordo com as instruções da secção “Procedimento recomendado”.

Método de armazenamento

Não mantenha o fio guia e a embalagem dobrados e/ou sob carga excessiva. Este fio guia e embalagem devem ser mantidos afastados de água. Guarde num local fresco, escuro e seco.

Data de validade

A data de validade é indicada na etiqueta da embalagem do fio guia.

Conteúdo

5 peças/caixa

Exoneração de responsabilidade

De modo algum deverá a “ASAHI INTECC CO., LTD. e a suas empresas afiliadas” (doravante designada como a “Empresa”) ser responsabilizada por acidentes, lesões pessoais, efeitos adversos devido ao uso inapropriado do(s) produto(s) ou outro uso inconsistente com estas instruções. Em circunstância alguma será a Empresa responsável por quaisquer danos (i) decorrentes do armazenamento do(s) produto(s) após a expedição por parte da Empresa ou (ii) devido à seleção dos doentes, técnicas cirúrgicas ou quaisquer outras intervenções médicas efetuadas pela instituição médica que utiliza o(s) produto(s).

“SION” e “SUOH” são marcas comerciais ou marcas registadas da ASAHI INTECC CO.,LTD. no Japão e noutros países.

*Os valores da carga da ponta representam os valores médios dos valores de especificação do produto medidos de acordo com o método de teste padrão interno, assumindo a força aplicada à lesão pela ponta do fio guia.

Alambre guía para ACP serie SION

Instrucciones de uso

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el alambre guía y tenga en cuenta las secciones Indicaciones para el uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Procedimientos recomendados de las Instrucciones de uso. Si no se hace de este modo, pueden surgir complicaciones, incluyendo lesiones graves del paciente o su muerte.

Si un usuario o paciente se entera de que ha ocurrido un incidente grave en relación con el alambre guía, informe el hecho al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro.

Estas instrucciones de uso se aplican al alambre guía para ACP serie SION. Para ver los detalles (longitud del alambre guía, longitud de la sección radiopaca, etc.), consulte la etiqueta del producto.

Descripciones

El alambre guía para ACP serie SION ha sido desarrollado como alambre guía de punta blanda para reducir el riesgo de perforación vascular cuando se mantiene en un vaso, ya que mantener un alambre guía con punta dura en un vaso puede producir perforación vascular.

La estructura básica de SION consiste en un alambre central cónico, dos tipos de espirales distales (una espiral exterior y una espiral interior) y un alambre de seguridad. El alambre central cónico, las espirales y el alambre de seguridad están soldados. Una longitud parcial de la espiral exterior es radiopaca, de modo que su posición puede confirmarse fácilmente mediante radiología. SION tiene una carga en la punta flexible de 0,7 gf* para garantizar la seguridad del vaso sanguíneo. Se coloca una espiral interior hecha de cuerda dentro de la espiral exterior, y el alambre de seguridad está unido a la espiral interior y a la punta de forma que el alambre guía no se desprende, incluso en el caso poco probable de que el alambre central cónico se desprenda de la punta, evitando que la espiral exterior y el alambre central cónico se desprendan. El lado distal de SION está revestido de polímero hidrófilo.

SION azul tiene la misma estructura básica que SION, pero parte del revestimiento de la punta de la espiral exterior es revestimiento de silicona, lo que hace que la punta sea más flexible que la de SION y la carga de la punta sea de 0,5 gf*.

La estructura básica del lado distal de SION azul ES es la misma que la de SION azul, y la carga de la punta es de 0,5 gf*, pero la longitud de la espiral exterior es más corta, y la rigidez de la varilla es más alta. La estructura interna no tiene un alambre de seguridad dentro, pero el diseño distal del alambre central cónico está hecho de modo que el lado proximal del alambre guía no se desprenda fácilmente. Al igual que SION azul, el revestimiento de SION azul ES es un revestimiento de silicona en la zona distal e hidrófilo en la zona proximal, y la longitud del revestimiento hidrófilo es mayor que la de SION azul.

La diferencia entre SION negro y SION y SION azul es que tiene un revestimiento de resina de poliuretano en la espiral exterior y un revestimiento hidrófilo encima. La carga de la punta es de 0,8 gf*.

La estructura básica de SUOH 03 es igual que la de SION azul y SION azul ES, pero en ella se usa una espiral exterior hecha de cuerda, lo que da como resultado la carga de la punta más baja de la serie SION, de 0,3 gf*. La superficie distal está recubierta de revestimiento hidrófilo.

En toda la serie SION de alambres guía para ACP, el lado proximal del alambre central cónico está revestido de PTFE (politetrafluoroetileno). El diámetro exterior nominal del producto es de 0,36 mm (0,014

pulgadas) en toda la longitud. En el extremo proximal de los dispositivos de menos de 300 cm, hay una conexión para un alambre de extensión, que se utiliza para reemplazar el dispositivo combinado; puede conectarse el alambre de extensión de ASAHI INTECC.

	Carga de la punta*	Diámetro exterior	Longitud del revestimiento	Longitud de la espiral	Longitud radiopaca
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 in)	Revestimiento hidrófilo: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION azul	0,5 gf	0,36 mm (0,014 in)	Revestimiento de silicona: 1,5 cm Revestimiento hidrófilo: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION azul ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 in)	Revestimiento de silicona: 2,5 cm Revestimiento hidrófilo: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION negro	0,8 gf	0,36 mm (0,014 in)	Revestimiento de poliuretano: 20,0 cm Revestimiento hidrófilo: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 in)	Revestimiento hidrófilo: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indicaciones para el uso

Este alambre guía fue concebido para la angioplastia coronaria percutánea (ACP) general. Este alambre guía está diseñado para facilitar la colocación de catéteres de dilatación con globo u otros dispositivos terapéuticos de intervención dentro de la cardiovascular. Se espera que la duración promedio de uso sea de 120 minutos.

Este alambre guía no fue concebido para usar en la neurovasculatura y la vasculatura periférica.

Población tratada objetivo

El alambre guía para ACP serie SION está diseñado para pacientes que cumplen con las indicaciones para los procedimientos de ACP. No está indicado para usarse en neonatos, bebés pequeños o niños, ni en pacientes embarazadas, con disfunción renal alterada o que tienen una reacción alérgica a los medios de contraste o al polietilenglicol (PEG).

Contraindicaciones

- Confirme la compatibilidad del diámetro del alambre guía con el de otro dispositivo quirúrgico antes de su uso real.
- No utilice el alambre guía en pacientes que presenten una reacción alérgica a los medios de contraste o que tengan disfunción renal alterada.
- Este alambre guía contiene PEG400 en su revestimiento hidrófilo. No utilice el alambre guía en pacientes que presenten reacciones alérgicas a polietilenglicol (PEG).
- No utilice el alambre guía en pacientes embarazadas o que puedan estarlo (los rayos X podrían afectar el feto).
- Este alambre guía se debe utilizar en lugares donde se pueda realizar de modo inmediato una operación quirúrgica de emergencia. Si no se puede ejecutar una operación quirúrgica de emergencia, en el peor de los casos, pueden producirse situaciones en las que se ponga en peligro la vida.
- Este alambre guía está esterilizado previamente con gas de óxido de etileno (EOG), habiéndose concebido solo para un único uso. No lo vuelva a utilizar ni a esterilizar. Si se reutiliza o se vuelve a esterilizar, el rendimiento o la calidad de este alambre guía y paquete puede verse afectada y existen riesgos de complicaciones, incluida una infección.

Advertencias

- Este alambre guía solo debe utilizarlo un médico con la adecuada formación en el tratamiento de ACP.
- Nunca utilice este alambre guía en combinación con catéteres con partes metálicas que puedan entrar en contacto directo con la superficie del alambre guía (p. ej., catéteres de aterectomía, dilatadores metálicos), agujas metálicas o insertadores de fundas metálicas.
- Durante el uso del alambre guía, verifique y controle el movimiento de esta punta bajo fluoroscopia. No lo utilice en zonas de vasos que no se visualicen o no se puedan visualizar.
- No conecte este alambre guía con alambres de extensión desmontables producidos por fabricantes distintos a ASAHI INTECC. No manipule este alambre guía mientras se encuentra conectado el alambre de extensión desmontable. En caso contrario, el alambre guía puede resultar dañado o se puede desacoplar accidentalmente el alambre de extensión desmontable.
- No modifique este alambre guía bajo ninguna circunstancia.

Precauciones

- No utilice el alambre guía después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. Deseche cualquier alambre guía después de su fecha de caducidad.
- Los alambres guía son instrumentos delicados y se deben manejar con cuidado.
- Si el envase está abierto o deteriorado, no utilice el alambre guía. No abra el envase hasta inmediatamente antes de proceder a su uso. Utilice técnicas asépticas en la manipulación y el empleo del alambre guía.
- Siempre mantenga el alambre guía en estado húmedo para evitar daños en su revestimiento hidrófilo.
- No limpie este alambre guía con una solución orgánica, como alcohol.
- Tras usar el alambre, tome medidas preventivas para evitar infecciones. Deseche este alambre guía y el envase como residuos médicos.
- No empuje, taladre, retire, ni presione nunca este alambre guía cuando note resistencia. Torsionar o empujar este alambre guía contra una resistencia puede dañar o separar la punta de este alambre guía o dañar directamente un vaso. Si no se hace de este modo, podría dañarse el alambre guía. Determine la causa de la resistencia bajo fluoroscopia y tome las medidas necesarias.
- Avance y retire el alambre guía siempre despacio y con cuidado.
- Al girar este alambre guía en el interior del vaso sanguíneo, no proceda a su rotación continua en el mismo sentido. Al girar el alambre guía, rótele en sentido horario y antihorario de forma alternativa. No gire más de dos vueltas (720°) en la misma dirección.
- Rocíe el alambre guía con una solución salina esterilizada y heparinizada o de otro tipo adecuado al proceder a la retirada y a la reintroducción para evitar que entre aire en el dispositivo quirúrgico. Tenga cuidado al cambiar este alambre guía para evitar que entre aire o que se produzcan traumatismos. Al reintroducir el alambre guía, confirme que la punta del dispositivo quirúrgico se encuentra libre en el vaso y no se apoya contra la pared del mismo. Si no se hace de este modo, se puede provocar un traumatismo. Utilice el marcador radiopaco del dispositivo quirúrgico para confirmar la posición.
- El movimiento libre del alambre guía dentro del dispositivo quirúrgico es una característica importante de un sistema de alambre guía direccionable, ya que da al usuario una información táctil valiosa. Pruebe la resistencia del sistema antes de utilizarlo. Ajuste o cambie la válvula hemostática con una válvula regulable si observa que inhibe el movimiento del alambre guía.
- No proceda a la colocación de un stent empleando más de un alambre guía ni a la operación del alambre a través del tirante de un stent. En caso contrario, el stent puede resultar dañado o el alambre guía se podría romper o quedar inservible.
- Antes de utilizarlo, confirme que este alambre guía es adecuado en tamaño y forma para el procedimiento y compatible con el dispositivo que se utilizará en combinación.
- Consulte las instrucciones de uso adjuntas al dispositivo médico (p. ej., catéteres de dilatación con balón u otros dispositivos de intervención)

que se usarán en combinación con este alambre guía.

- Al conectar el alambre de extensión desmontable con este alambre guía, se debe insertar firmemente en la línea límite que se encuentra entre los revestimientos de PTFE y distinto a PTFE en el extremo proximal del alambre guía. Si se encuentra alguna anomalía en la conexión, deje de usar el alambre guía inmediatamente.
- Revise el alambre guía atentamente por si tiene dobleces, torceduras, u otro daño, antes de utilizarlo y siempre que sea posible durante el procedimiento. No utilice el alambre guía si está dañado.
- Al conformar la punta, tenga cuidado de no dañar la espiral.
- Antes de insertar el alambre guía, verifique cuál es el extremo distal y asegúrese de insertarlo desde el extremo distal.
- Mantenga un rociado continuo de solución salina entre el catéter guía y el dispositivo quirúrgico y

entre el dispositivo quirúrgico y el alambre guía durante el procedimiento. El rociado evita la formación del medio de contraste o la coagulación en el alambre guía y en la luz del catéter.

- Para el sujetador con el tubo de protección del extremo distal (consulte Procedimientos recomendados, figura 1), no retire o inserte el tubo de protección del extremo distal mientras el alambre guía esté colocado en el sujetador.
- Para el sujetador con el tubo de protección del extremo distal (consulte Procedimientos recomendados, figura 1), retire el tubo de protección del extremo distal antes de volver a colocar el alambre guía en el sujetador.
- Este dispositivo contiene la siguiente sustancia definida como CMR 1A/1B y la sustancia que produce trastornos endocrinos en una concentración superior a 0,1 % peso a peso; cobalto: CAS n.º 7440-48-4.

Fallos de funcionamiento y efectos adversos

Se pueden producir posibles fallos de funcionamiento y efectos adversos en el uso de este alambre guía, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Fallos de funcionamiento

Fallo al atravesar una lesión	Rotura o curvatura del alambre guía	Daños como la separación
Dificultad de extracción	Desprendimiento del revestimiento	Restos de un alambre guía dañado

2. Efectos adversos

Muerte	Infección	Disección del vaso
Perforación del vaso	Complicaciones de hemorragia	Embolia
Trombo	Infarto	Isquemia
Arritmia	Vasoespasmó	Oclusión vascular
Reducción de la presión arterial	Reacción alérgica	

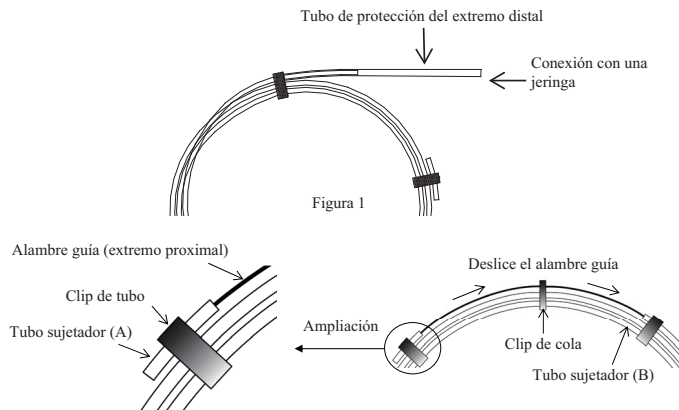
Procedimientos recomendados

1. Inspección antes de utilizarlo
 - a) Antes de utilizarlo, revise atentamente y confirme que ningún alambre guía o paquete está dañado.
 - b) Antes de utilizarlo, confirme que el alambre guía sea compatible con los dispositivos quirúrgicos que se utilizarán.
2. Preparación
 - a) Seleccione el alambre guía más adecuado para el área afectada y retire el tubo sujetador que contiene el alambre guía del paquete estéril.

b) Rellene el tubo sujetador con una solución salina esterilizada y heparinizada empleando una jeringuilla para empapar el dispositivo en su conjunto. Tenga en cuenta que la solución salina esterilizada y heparinizada se puede derramar del tubo sujetador en este momento. En el caso del sujetador con el tubo de protección del extremo distal (Figura 1), se

puede conectar una jeringa al tubo de protección del extremo distal.

c) Rellene la luz del dispositivo quirúrgico con solución salina esterilizada y heparinizada antes de insertar de nuevo la guía.
d) Suelte la guía del clip de cola y deslícela lentamente, presione el extremo distal de la guía a través del tubo sujetador (B) (Figura 2).



e) Cuando el extremo distal del alambre guía se extienda entre 5 y 6 cm más allá del otro extremo del tubo sujetador (o el tubo de protección del extremo distal), de ser necesario, conforme la punta de acuerdo con la práctica estándar.

f) Sujete suavemente, por el punto más cercano posible al tubo sujetador, el alambre guía que sale del extremo distal del tubo sujetador (o el tubo de protección del extremo distal), y extraiga el alambre guía lenta y cuidadosamente.

g) Si se siente resistencia al extraer el alambre guía del tubo sujetador, inyecte de nuevo una solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador. Continúe extrayendo el alambre guía cuando haya dejado de percibirse la resistencia. Asegúrese de inyectar suficiente solución salina esterilizada y heparinizada en el tubo sujetador, debido a que

el revestimiento hidrófilo puede dañarse al extraer con fuerza el alambre guía.

h) Después de sacar el alambre guía del tubo sujetador, compruebe que no esté dañado.

3. Procedimientos de inserción

■ Sistema del alambre

a) Inserte el extremo distal del alambre guía con cuidado en la luz del alambre guía del dispositivo quirúrgico.
b) Avance este alambre guía con cuidado hasta que su punta esté inmediatamente próxima a la punta del dispositivo quirúrgico.
c) Meta el catéter guía e inserte el sistema del dispositivo quirúrgico (con el alambre guía) en el conector en Y.
d) Avance el sistema del dispositivo quirúrgico a lo largo del catéter guía hasta que la punta del sistema del alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del

catéter guía.

e) Apriete la válvula hemostática del conector en Y para cerrar herméticamente alrededor del dispositivo quirúrgico. Compruebe que aún se pueda mover el alambre guía.

f) Asegúrese de que el alambre guía se mueva sin problemas.

g) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.

h) Avance este alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.

i) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.

j) Avance el dispositivo quirúrgico hasta que alcance la lesión mientras que evita que se mueva el alambre guía. Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

■ Sistema de intercambio rápido

a) Meta el catéter guía.
b) Inserte el introductor del alambre guía en el conector en Y del catéter guía.
c) Inserte con cuidado la punta del alambre guía en el introductor.
d) Avance el alambre guía a lo largo del catéter guía bajo fluoroscopia hasta que la punta del

alambre guía esté inmediatamente próxima a la punta del catéter guía.

e) Si es necesario, sujete el dispositivo de torsión al alambre guía.

f) Avance el alambre guía bajo fluoroscopia para que pase por la lesión. Confirme por angiografía que el alambre guía ha pasado la lesión objetivo más estrecha.

g) Observe el movimiento del alambre guía en los vasos.

h) Extraiga el dispositivo de torsión del alambre guía y el introductor del alambre guía.

i) Siga al dispositivo quirúrgico por el alambre guía mientras evita que este se mueva, y avance hasta que alcance la lesión.

Asegúrese de que la punta distal del alambre guía y su posición en el vaso estén visibles durante las manipulaciones del dispositivo quirúrgico.

4. Procedimientos para cambiar el alambre guía

■ Sistema del alambre

a) Extraiga este alambre guía despacio mientras controla su movimiento bajo fluoroscopia.
b) Inserte el siguiente alambre guía siguiendo las instrucciones de la sección Procedimientos recomendados.

Método de conservación

No conserve la guía y el envase doblados ni soportando cargas pesadas. Esta guía y su envase se deben mantener alejados del agua. Proceda a su almacenamiento en un lugar fresco, oscuro y seco.

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad se indica en la etiqueta del envase del alambre guía.

Contenido

5 unidades/caja

Exención de responsabilidad

“ASAHI INTECC CO., LTD. y sus empresas afiliadas” (en adelante, “la Compañía”) no se hace responsable bajo ningún concepto por accidentes, heridas personales, efectos adversos debido al mal uso de cualquier índole del producto o de los productos, o cualquier uso que no observe estas instrucciones. En ningún caso la Compañía será responsable por daños (i) procedentes de la conservación de los productos una vez enviados por la Compañía o (ii) debidos a la selección de pacientes, técnicas quirúrgicas o cualquier otra actividad médica de la institución médica que utilice los productos.

“SION” y “SUOH” son marcas comerciales o marcas registradas de ASAHI INTECC CO., LTD. en Japón y en otros países.

* Los valores de carga de la punta representan los valores medios de los valores de especificación del producto medidos de acuerdo con el método interno de prueba estándar que asume la fuerza que la punta del alambre guía aplica a la lesión.

PCI-ledare SION-serien

Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant före användning av denna ledare och följ bruksanvisningens avsnitt för Indikationer, Kontraindikationer, Varningar, Försiktighetsåtgärder och Användning. Om instruktionerna inte följs kan det leda till komplikationer inklusive allvarliga personskador för patienten eller till och med dödsfall.

Om en användare och/eller patient får kännedom om en allvarlig incident som har inträffat i samband med ledaren ska detta rapporteras till tillverkaren och medlemsstatens behöriga myndighet.

Denna bruksanvisning gäller för PCI-ledare SION-serien. Detaljerad information (ledarens längd, längd på röntgentät del, osv.), anges på produktens etikett.

Beskrivningar

PCI-ledare SION-serien har utvecklats som ledare med mjuk spets för att minska risken för vaskulär perforering när den hålls i ett kärl, eftersom en ledare med en hård spets i ett kärl kan resultera i vaskulär perforering.

SION:s grundläggande struktur består av en konisk kärntråd, två typer av distala spolar (en yttre spole och en inre spole) och en säkerhetstråd. Den koniska kärntråden, spolarna och säkerhetstråden är lödda. En partiell längd av den yttre spolen är röntgentät så att dess position enkelt kan bekräftas under röntgen. SION har en flexibel spetsbelastning på 0,7 gf* för att säkerställa säkerheten i blodkärlet. En inre spole av rep är placerad inuti den yttre spolen, och säkerhetstråden är bunden till den inre spolen och spetsen så att säkerhetstråden inte lossnar, även om den koniska kärntråden mot förmodan lossnar från spetsen, vilket förhindrar att den yttre spolen och den koniska kärntråden lossnar. Den distala sidan av SION är belagd med hydrofil polymer.

SION blue har samma grundläggande struktur som SION, men en del av beläggningen på den yttre spetspen är silikonbeläggning, vilket gör spetsen mer flexibel än den på SION, och spetsbelastningen är 0,5 gf*.

Den grundläggande strukturen på den distala sidan av SION Blue ES är densamma som för SION blue och spetsbelastningen är 0,5 gf*, men den yttre spolens längd är kortare och axelns styvhet är högre. Den inre strukturen har ingen säkerhetstråd inuti, men den distala designen på den koniska kärntråden är utformad så att den proximala sidan av styrtråden inte kan lossna så lätt. Precis som med SION blue är beläggningen av SION blue ES silikonbeläggning på den distala och hydrofil på den proximala, och den hydrofila beläggningens längd är längre än den för SION blue.

SION black skiljer sig från SION och SION blue genom att den har en polyuretanhartsbeläggning på den yttre spolen och en hydrofil beläggning ovanpå den. Spetsbelastningen är 0,8 gf*.

Den grundläggande strukturen på SUOH 03 är densamma som för SION blue och SION blue ES, men den använder en yttre spole gjord av rep, vilket resulterar i den lägsta spetsbelastningen i SION-serien vid 0,3 gf*. Den distala ytan är belagd med hydrofil beläggning.

I alla PCI-ledare SION-serien är den proximala sidan av den koniska kärntråden belagd med PTFE (polytetrafluoretylen). Produktens nominella ytterdiameter är 0,36 mm (0,014 tum) över hela längden. Vid

den proximala änden på enheter mindre än 300 cm finns en anslutning för en förlängningskabel som används för att ersätta den kombinerade enheten. ASAHI INTECC:s förlängningskabel kan anslutas.

	Spetsbelastning*	Ytterdiameter	Beläggningens längd	Spolens längd	Radiopak längd
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 tum)	Hydrofil beläggning : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014 tum)	Silikonbeläggning : 1,5 cm Hydrofil beläggning : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 tum)	Silikonbeläggning : 2,5 cm Hydrofil beläggning : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014 tum)	Polyuretanbeläggning : 20,0 cm Hydrofil beläggning : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 tum)	Hydrofil beläggning : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikationer

Denna ledare är avsedd för allmän perkutan kranskärlsintervention (PCI). Denna ledare är avsedd att underlätta placeringen av ballongdilationskatetrar eller andra interventionella terapeutiska enheter inom kardiovaskulaturen. Den genomsnittliga användningstiden förväntas vara 120 minuter.

Denna ledare är inte avsedd för användning i neurovaskulaturen och perifer vaskulaturen.

Mål behandlad population

PCI-ledare SION-serien är avsedd för patienter som uppfyller indikationer för PCI-ingrepp. Den är inte indicerad för användning på nyfödda, spädbarn eller barn samt patienter som är gravida, har nedsatt njurfunktion och som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller polyetylen glykol (PEG).

Kontraindikationer

- Bekräfta ledarens diameter är kompatibel med annan interventionsanordning före faktisk användning.
 - Använd inte ledaren i patienter som har en allergisk reaktion mot kontrastmedel eller som har nedsatt njurfunktion.
 - Denna ledare innehåller PEG400 i sin hydrofila beläggning. Använd inte ledaren i patienter som har allergiska reaktioner mot polyetylen glykol (PEG).
 - Använd inte ledaren för gravida patienter eller patienter som kan vara gravida (röntgen kan påverka fostret).
- Denna ledare måste användas på en institution där det finns omedelbar tillgång till nödkirurgi. Om det inte finns tillgång till nödkirurgi kan det i värsta fall uppstå livshotande situationer.
 - Denna ledare är försteriliserad med etylenoxidgas (EOG) och endast avsedd för engångsbruk. Får inte återanvändas eller omsteriliseras. Om den återanvänds eller steriliseras på nytt kan ledarens och förpackningens prestanda eller kvalitet försämrats vilket ger en risk för komplikationer, inklusive infektion.

Varningar

- Denna ledare får endast användas av en läkare som är fullständig utbildad i PCI-behandling.
- Använd aldrig denna ledare i kombination med katetrar som har delar av metall som kan komma i direkt kontakt med ledarens yta (tex.

- aterektomikatetrar, metalldilatorer), metallnålar eller metallhyslor.
- Vid användning av ledaren ska du kontrollera och övervaka rörelsen av dess spets under fluoroskopi. Använd inte i kärlområden som inte är visualiserade eller inte kan visualiseras.
- Anslut inte denna ledare till en avtagbar förlängningsledare tillverkad av en annan

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte ledaren efter utgångsdatumet på etiketten. Kassera alla ledare som har passerat utgångsdatumet.
- Ledare är ömtåliga instrument och ska hanteras försiktigt.
- Använd inte ledaren om förpackningen är öppen eller skadad. Öppna inte förpackningen förrän alldeles innan produkten ska användas. Använd aseptisk teknik vid hantering och användning av ledaren.
- Förvara alltid ledaren i vått tillstånd för att förhindra skador på dess hydrofila beläggning.
- Torka inte av ledaren med en organisk lösning, t.ex. alkohol.
- Vidta förebyggande åtgärder mot infektion efter användning. Kasta ledaren och förpackningen som medicinskt avfall.
- Du får aldrig trycka, borra, dra tillbaka eller vrida denna ledare vid motstånd. Om ledaren förs in eller trycks mot motstånd kan det orsaka skador på spetsen och/eller leda till att spetsen lossnar från ledaren eller orsaka direkta skador på ett kärl. Underlåtenhet att göra så kan orsaka skada på ledaren. Fastställ orsaken till motståndet under fluoroskopi och vidta alla nödvändiga korrigeringar åtgärder.
- För alltid in och dra tillbaka ledare långsamt och försiktigt.
- När ledaren vrids inuti blodkärlet ska den inte vridas i samma riktning hela tiden. Roter ledaren medurs och moturs om vartannat när du vrider den. Roter inte mer än två varv (720°) i samma riktning.
- Spola ledaren med steril hepariniserad koksaltlösning eller annan lämplig lösning när den dras ut eller förs in för att förhindra att det tränger in luft i interventionsinstrumentet. Byten av ledaren ska utföras försiktigt för att förhindra trauma och/eller att det tränger in luft. När ledaren förs in igen är det viktigt att säkerställa att interventionsinstrumentets spets är fri inom kärlets lumen och att den inte ligger mot kärlets

- producent än ASAHI INTECC. Manipulera inte denna ledare när den löstagbara förlängningsledaren är ansluten. Detta kan annars leda till att ledaren skadas eller att den avtagbara förlängningsledaren lossnar.
- Modifiera inte ledaren av något skäl.

- vägg. Om du inte gör detta kan det orsaka trauma. Använd interventionsinstrumentets röntgentäta markör för att bekräfta positionen.
- Ledarens fria rörelse inuti interventionsinstrumentet är en viktig funktion i ett styrbart ledarsystem eftersom det ger användaren värdefull känselinformation. Testa systemet för motstånd före användning. Justera eller ersätt hemostasventilen med en justerbar ventil om den förhindrar ledarens rörelse.
- Placera inte stenten med hjälp av mer än en ledare eller ledaranvändning genom stentstödet. Detta kan annars leda till att stenten skadas eller att ledaren bryts av eller går sönder.
- Kontrollera innan användning att ledaren har en lämplig storlek och form för proceduren och är kompatibel med enheten som den ska användas med.
- Se bruksanvisningen som är fäst vid den medicinska utrustningen (t.ex. ballongdilationskatetrar eller andra interventionsanordningar) som ska användas i kombination med denna ledare.
- Vid anslutning av den löstagbara förlängningskabeln till ledaren bör den föras in säkert till gränslinjen mellan icke-PTFE-höljet och PTFE-höljet i den proximala änden av ledaren. Om någon avvikelse upptäcks i anslutningen så ska du omedelbart sluta använda ledaren.
- Inspektera ledaren noggrant för böjningar, veck eller andra skador före användning och när det är möjligt under proceduren. Använd inte ledaren om den är skadad.
- När du formar spetsen ska du vara försiktig så att du inte skadar spolen.
- Innan du för in ledaren ska du ta reda på vilken ände som är den distala änden och se till att föra in den från den distala änden.
- Upprätthåll en kontinuerlig koksaltlösning mellan styrkatetern och interventionsanordningen samt mellan

- interventionsanordningen och ledaren under proceduren. Spolning förhindrar bildning av kontrastmedel och/eller koagulering på ledaren och i kateterlumen.
- För hållaren med skyddstuben för den distala änden (se Användning, figur 1), ta inte bort eller sätt inte in skyddstuben för den distala änden medan ledaren är placerad i hållaren.

- För hållaren med skyddstuben för den distala änden (se Användning, figur 1), ta bort skyddstuben för den distala änden innan du placerar styrtråden i hållaren igen.
- Denna enhet innehåller följande substans definierad som CMR 1A/1B och hormonstörande substans i en koncentration över 0,1 viktpcent; Kobolt: CAS-nr 7440-48-4.

Funktionsfel och biverkningar

Möjliga funktionsfel och biverkningar som kan uppstå vid användning av denna ledare inkluderar, men är inte begränsade till följande:

1. Funktionsfel

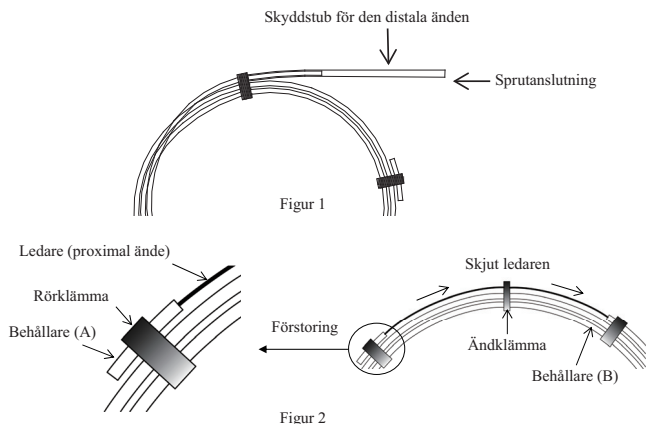
Misslyckande att korsa en lesion/skada	Brott eller böjning av ledaren	Skador såsom separation
Svår att avlägsna	Kommer av beläggningen	Skräp från en skadad ledare

2. Biverkningar

Dödsfall	Infektion	Kärldissektion
Kärlperforering	Blödningskomplikationer	Embolism
Trombos	Infarkt	Ischemi
Arytmi	Vasospasm	Vaskulär tilltäppning
Blodtryckssänkning	Allergisk reaktion	

Användning

- 1. Inspektion innan användning
 - a) Kontrollera noggrant att ledaren och förpackningen är oskadade före användning.
 - b) Bekräfta att ledaren är kompatibel med interventionsinstrumenten som ska användas före användning.
- 2. Förberedelse
 - a) Välj den lämpligaste ledaren för det drabbade området och avlägsna behållaren som innehåller ledaren från den sterila förpackningen.
 - b) Fyll behållaren med steril hepariniserad koksaltlösning med hjälp av en spruta för att blöta hela utrustningen. Tänk på att steril hepariniserad koksaltlösning kan rinna över ur behållaren när du gör detta. För hållaren med skyddsroret i den distala änden (Figur 1) kan en spruta anslutas till skyddsroret i den distala änden.
 - c) Fyll lumen på interventionsinstrumentet med steril hepariniserad koksaltlösning innan ledaren förs in.
 - d) Lossa ledaren från ändklämmen och skjut ledaren långsamt framåt. Tryck ledarens distala ände genom behållaren (B) (figur 2).



- e) När ledarens distala ände sticker ut 5 till 6 cm bortom den andra änden av hållartuben (eller skjuddstuben för den distala änden), forma vid behov spetsen i enlighet med vanlig praxis.
- f) Greppa försiktigt ledaren som sticker ut ur den distala änden av hållartuben (eller skjuddstuben för den distala änden), vid spetsen så nära hållartuben som möjligt och dra sakta och försiktigt ut ledaren.
- g) Om du känner ett motstånd när ledaren tas ur behållaren så injicerar du steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren igen. Fortsätt att ta bort ledaren när du inte längre känner motståndet. Se till att injicera tillräckligt med steril hepariniserad koksaltlösning i behållaren eftersom den hydrofila beläggningen kan skadas om den ytbehandlade ledaren dras ut med våld.
- h) När ledaren har dragits ut ur den rörformiga behållaren ska den inspekteras för att kontrollera att den inte är skadad.

3. Procedur för insättning

■ System med införsel via ledare

- För in den distala änden av ledaren försiktigt i ledarlumen för interventionsinstrumentet.
- För fram ledaren försiktigt tills dess spets befinner sig precis proximalt i relation till

interventionsinstrumentets spets.

- Anslut ledarkatetern och för in interventionsinstrumentssystemet (med ledare) i Y-anslutningen.
- För fram interventionsinstrumentssystemet genom ledarkatetern tills spetsen för ledarsystemet befinner sig precis proximalt i relation till spetsen för ledarkatetern.
- Stäng Y-anslutningens hemostasventil för att skapa en försegling runt interventionsinstrumentet. Säkerställ att det fortfarande går att röra ledaren.
- Kontrollera att det är möjligt att röra ledaren friktionsfritt.
- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.
- Observera ledarens rörelse i kärlen.
- För in interventionsinstrumentet tills lesionsområdet nås samtidigt som rörelse av ledaren förhindras. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

■ System för snabbt byte

- Anslut ledarkatetern.
- För in ledarens införsare i ledarkateterns Y-anslutning.
- För försiktigt in ledarens spets i införsaren.
- För in ledaren genom ledarkatetern under fluoroskopi tills ledarens spets befinner sig precis proximalt i relation till ledarkateterns spets.
- Fäst den medföljande vridenheten vid ledaren vid behov.
- För in ledaren under fluoroskopi för att passera genom lesionsområdet. Bekräfta via angiografi att ledaren har passerat det förträngda lesionsområdet.

- Observera ledarens rörelse i kärlet.
- Avlägsna ledarens vridenhet och införsare.
- För interventionsinstrumentet över ledaren samtidigt som rörelse av ledaren förhindras, tills lesionsområdet nås. Säkerställ att ledarens distala spets och dess läge i kärlet är synliga under manipulering av interventionsinstrumentet.

4. Procedurer för byte av ledaren

■ System med införsel via ledare

- Avlägsna ledaren långsamt, samtidigt som ledarens rörelser övervakas via fluoroskopi.
- För in nästa ledare i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Användning".

Förvaring

Ledaren och förpackningen får inte förvaras böjdd och/eller utsättas för stor belastning vid förvaring. Denna ledare och förpackning ska skyddas mot vatten. Förvara den på en sval, mörk och torr plats.

Utgångsdatum

Utgångsdatumet anges på etiketten på ledarens förpackning.

Innehåll

5 stycken/ask

Ansvarsfriskrivning

Under inga omständigheter är "ASAHI INTECC CO., LTD. och dess dotterbolag" (kallas nedan för "Företaget") ansvarig för olyckor, personskador, biverkningar som beror på felaktig användning av produkten/produkterna eller annan användning oförenlig med dessa instruktioner. I inget fall ska Företaget hållas ansvarigt för skador som antingen (i) uppstår från förvaring av produkten/produkterna efter transport från Företaget eller (ii) inträffar på grund av patientval, operationstekniker eller någon annan medicinsk aktivitet av den sjukvårdsinrättning som använder produkten/produkterna.

"SION" och "SUOH" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ASAHI INTECC CO., LTD. i Japan och andra länder.

*Spetsbelastningsvärden representerar medelvärdena för produktspecifikationsvärden som är uppmätta enligt den interna standardtestmetoden under antagande av den kraft som appliceras på lesionen av styrtrådspetsen.

Vodící drát pro PCI řady SION

Návod k použití

Před použitím výrobku si tyto pokyny důkladně přečtěte a v tomto návodu k použití věnujte pozornost sekci Indikace pro použití, Kontraindikace, Upozornění, Bezpečnostní pokyny a Doporučený postup při použití. V opačném případě může dojít ke komplikacím, včetně závažného poranění pacienta nebo smrti.

Pokud se uživatel a/nebo pacient dozví o závažné události, ke které došlo v souvislosti s vodícím drátem, oznamte tuto skutečnost výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

Tento návod k použití se týká vodícího drátu pro PCI řady SION. Detailní charakteristiku (délku vodícího drátu, délku radiokontrastní části atd.) naleznete na štítku na obalu výrobku.

Popis

Vodící drát pro PCI řady SION byl vyvinut jako vodící drát s měkkou špičkou, aby se snížilo riziko perforace cévy při držení v cévě, protože držení vodícího drátu s tvrdou špičkou v cévě může vést k perforaci cévy.

Základní struktura vodícího drátu SION se skládá z kuželového drátu, dvou typů distálních cívek (vnější cívka a vnitřní cívka) a bezpečnostního drátu. Kuželový drát, cívky a bezpečnostní drát jsou pájené. Částečná délka vnější cívky je radiopříhledná, takže její polohu lze snadno potvrdit při radioskopii. Vodící drát SION má flexibilní zatížení špičky 0,7 gf*, které zajišťuje bezpečnost v cévě. Vnitřní cívka vyrobená z lana je umístěna uvnitř vnější cívky a bezpečnostní drát je spojen s vnitřní cívkou a špičkou tak, aby se bezpečnostní drát neodpojil ani v nepravděpodobném případě, že se kuželový drát odpojí od špičky, a zabránil tak odpojení vnější cívky a kuželového drátu. Distální strana vodícího drátu SION je potažena hydrofilním polymerem.

Vodící drát SION blue má stejnou základní strukturu jako SION, ale část povlaku na vnější špičce cívky je potažena silikonem, takže špička je pružnější než u vodícího drátu SION a zatížení špičky je 0,5 gf*.

Základní struktura distální strany vodícího drátu SION blue ES je stejná jako u SION blue a zatížení hrotu je 0,5 gf*, ale vnější délka cívky je kratší a tuhost těla je vyšší. Vnitřní struktura nemá uvnitř bezpečnostní drát, ale distální konstrukce vodícího drátu s kuželovým jádrem je navržena tak, aby se proximální strana vodícího drátu nemohla snadno uvolnit. Stejně jako u vodícího drátu SION blue je povlak SION blue ES na distální straně silikonový a na proximální hydrofilní a délka hydrofilního povlaku je delší než u vodícího drátu SION blue.

Vodící drát SION black se od SION a SION blue liší tím, že má na vnějším závitě povlak z polyuretanové pryskyce a na něm hydrofilní povlak. Zatížení špičky je 0,8 gf*.

Základní konstrukce vodícího drátu SUOH 03 je stejná jako u SION blue a SION blue ES, ale používá vnější cívkou z lana, což vede k nejnižšímu zatížení špičky v řadě SION, to jest 0,3 gf*. Distální povrch je potažen hydrofilním povlakem.

U všech vodících drátů pro PCI řady SION je proximální strana kuželového drátu potažena PTFE (polytetrafluorethylenem). Jmenovitý vnější průměr výrobku je 0,36 mm (0,014 palce) po celé délce. Na proximálním konci zařízení kratších než 300 cm je připojení pro prodlužovací drát, který se používá k nahrazení kombinovaného zařízení. Připojit je možné prodlužovací drát společnosti ASAHI INTECC.

	Zatížení špičky*	Vnější průměr	Délka povlaku	Délka cívky	Radiopříhledná délka
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilní povlak: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonový povlak : 1,5 cm Hydrofilní povlak: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonový povlak : 2,5 cm Hydrofilní povlak: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polyuretanový povlak : 20,0 cm Hydrofilní povlak: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilní povlak: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikace pro použití

Tento vodící drát je určen k obecné perkutánní koronární intervenci (PCI). Tento vodící drát je určen k usnadnění zavádění balónkových dilatačních katétrů nebo jiných intervenčních terapeutických zařízení do kardiovaskulatury. Průměrná doba použití se očekává být 120 minut. Tento vodící drát není určen pro použití v neurovaskulárním systému ani periferních cévách.

Cílová léčená populace

Vodící drát pro PCI řady SION je určen pro pacienty, kteří splňují indikace pro PCI. Není indikován k použití u novorozenců, kojenčů nebo dětí a u pacientů, kteří jsou těhotní, mají poruchu funkce ledvin a alergickou reakci na kontrastní látku nebo polyetylen glykol (PEG).

Kontraindikace

- Před vlastním použitím ověřte kompatibilitu průměru vodícího drátu s jiným intervenčním zařízením.
- Nepoužívejte vodící drát u pacientů, kteří jsou alergičtí na kontrastní látku, nebo u pacientů s dysfunkcí ledvinou.
- Tento vodící drát obsahuje ve svém hydrofilním povlaku PEG400. Vodící drát nepoužívejte u pacientů, kteří jsou alergičtí na Polyethylen glykol (PEG).
- Vodící drát nepoužívejte u těhotných pacientek ani pacientek, které mohou být těhotné (rentgenové záření může ovlivnit plod).
- Tento vodící drát je nutné používat pouze ve zdravotnickém zařízení, které disponuje možností hned provést akutní chirurgický zákrok. Pokud není možnost provést akutní chirurgický zákrok, v nehorším případě může dojít k příchodům ohrožujícím pacienta na životě.
- Vodící drát je předem sterilizován plyným ethylenoxidem (EOG) a je určen na jedno použití. Nepoužívejte jej opakovaně ani neprovádějte opakovanou sterilizaci. V případě opakovaného použití nebo sterilizování vodícího drátu může být snížena jeho funkčnost nebo kvalita a může dojít ke komplikacím, včetně infekce.

Upozornění

- Tento vodící drát smí používat pouze lékař, který je plně vyškolen v terapii metodou PCI.
- Tento vodící drát nikdy nepoužívejte v kombinaci s katétrem obsahujícími kovové části, které se mohou přímo dotýkat povrchu tohoto vodícího drátu (např. aterosklerotické katétry, kovové dilatátory), kovovými jehlami nebo zaváděči s kovovými pouzdry.

- Během používání vodicího drátu kontrolujte a sledujte pohyb jeho špičky pod skiaskopickou kontrolou. Nepoužívejte v oblastech, které nejsou viditelné nebo je zviditelnit nelze.
- Vodicí drát nepripojujte k odnímatelným prodlužovacím drátům vyráběným jinými

- výrobci než společností než ASAHI INTECC. Vodicím drátem nemanipulujte, když je připojen odnímatelný prodlužovací drát. Jinak může dojít k poškození vodicího drátu nebo neúmyslnému uvolnění odnímatelného prodloužení.
- V žádném případě vodicí drát neupravujte.

Bezpečnostní pokyny

- Vodicí drát nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na štítku. Po datu použitelnosti je nutné vodicí drát zlikvidovat.
- Vodicí dráty jsou jemné nástroje a je nutné s nimi pracovat opatrně.
- Pokud je balení otevřeno nebo poškozeno, vodicí drát nepoužívejte. Obal otevřete až bezprostředně před použitím. Při manipulaci s vodicím drátem dodržujte aseptické podmínky.
- Vodicí drát udržujte vždy vlhký, aby nedošlo k poškození jeho hydrofilního povlaku.
- Vodicí drát neotírejte organickými roztoky (jako např. alkoholem).
- Po použití učiňte bezpečnostní opatření proti přenosu infekce. Vodicí drát a obaly likvidujte jako biologický odpad.
- Nikdy netlačte, nevytahujte ani nekruťte nebo nesnažte vrtat vodicím drátem, který narazil na odpor. Kroucení nebo zatlačování vodicího drátu proti odporu může vést k poškození nebo oddělení špičky vodicího drátu nebo přímému poškození cévy. V opačném případě může dojít k poškození tohoto vodicího drátu. Skiaskopem zjistíte důvod odporu a provedte veškeré potřebné nápravné akce.
- Vodicí dráty vždy zavádějte a vytahujte pomalu a opatrně.
- Při rotaci vodicího drátu uvnitř krevní cévy neotáčejte stále ve stejném směru. Při rotaci vodicího drátu jím otáčejte střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček. Neotáčejte o více než dvě otočení (do 720°) ve stejném směru.
- Při vyjímání a opakovaném zavádění vodicí drát propláchněte heparinizovaným sterilním fyziologickým roztokem nebo jinou vhodnou tekutinou, aby se zabránilo vniknutí vzduchu do intervenčního zařízení. Při výměně vodicího drátu postupujte opatrně, aby do systému nevnikl vzduch nebo nedošlo k poranění. Při opakovaném zavádění vodicího drátu se ujistěte, že je špička intervenčního zařízení volně umístěná v lumen cévy a nenaléhá na její stěnu. Jinak může dojít k poranění. Pro potvrzení

- polohy intervenčního zařízení použijte radiokontrastrní markery.
- Volný pohyb vodicího drátu uvnitř intervenčního zařízení představuje důležitou funkci řidičelského systému vodicího drátu, jelikož podává uživateli důležité taktické informace. Před použitím systém otestujte, jestli při průchodu necítíte žádný odpor. Pokud zjistíte, že hemostatický ventil zpomaluje pohyb vodicího drátu, upravte jej nebo jej nahraďte nastavitelným ventilem.
- K zavádění stentu nepoužívejte více než jeden vodicí drát ani drát nezavádějte mřížkovou stentu. V opačném případě může dojít k poškození stentu nebo poškození či zlomení vodicího drátu.
- Před použitím se ujistěte, že tento vodicí drát má odpovídající velikost a tvar pro daný zázrak a že je kompatibilní se zařízeními, v kombinaci s kterým má být použit.
- Přečtete si návod k použití přiložený ke zdravotnickému prostředku (např. balónkovému dilatačnímu katétru nebo jiným intervenčním prostředkům), který má být použit v kombinaci s tímto vodicím drátem.
- Při připojování k vodicímu drátu je nutné odnímatelný prodlužovací drát bezpečně zasunout k hraniční čáře mezi povrchovou úpravou bez PTFE a s PTFE na proximálním konci vodicího drátu. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu připojení, okamžitě přestaňte vodicí drát používat.
- Vodicí drát před použitím, a kdykoli to bude během zákroku možné, pečlivě kontrolujte, jestli není ohnutý, zalomený nebo poškozený jiným způsobem. Pokud je vodicí drát poškozený, nepoužívejte jej.
- Při tvarování špičky dávejte pozor, abyste nepoškodili vlnití.
- Před zavedením vodicího drátu zkontrolujte, který konec je distální, a ujistěte se, že provádíte zavádění z distálního konce.
- Během zákroku provádějte kontinuální proplachování fyziologickým roztokem mezi vodicím katétre a intervenčním zařízením a mezi intervenčním zařízením a vodicím drátem.

- Proplachování zabraňuje hromadění kontrastní látky a/nebo srážení na vodicím drátu a v lumen katétru.
- U drážku s ochrannou trubičkou distálního konce (viz Doporučený postup při použití, obr. 1) nevyjímajte ani nezasouvajte ochrannou trubičku distálního konce, pokud je vodicí drát umístěn v drážku.

- U drážku s ochrannou trubičkou distálního konce (viz Doporučený postup při použití, obr. 1) odstraňte ochrannou trubičku distálního konce před opětovným uložením vodicího drátu do drážku.
- Toto zařízení obsahuje následující látku definovanou jako CMR 1A/1B a látku narušující endokrinní systém v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních; kobalt: CAS-nr. 7440-48-4.

Poruchy funkce a nežádoucí příhody

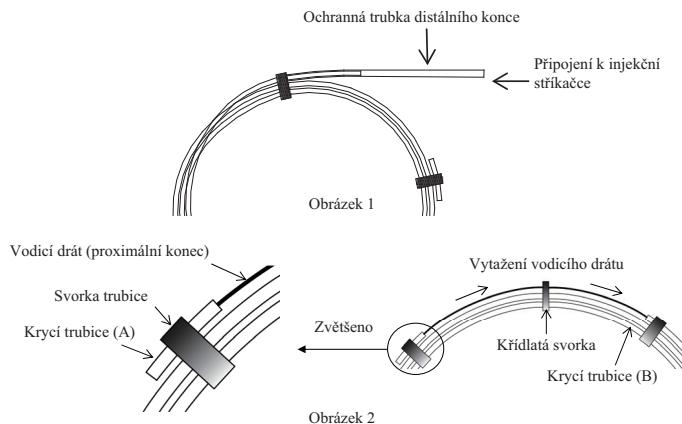
Poruchy funkce a nežádoucí příhody spojené s používáním tohoto vodicího drátu mohou mimo jiné zahrnovat následující:

1. Poruchy funkce

Nemožnost dostat se přes lézi	Odlovení nebo ohnutí vodicího drátu	Poškození, jako je oddělení
Potíže při vytahování	Odluňování povlaku	Úlomky z poškozeného vodicího drátu
2. Nežádoucí příhody		
Úmrtí	Infekce	Disekce cévy
Perforace cévy	Komplikace spojené s krvácením	Embolie
Krevní sraženina	Infarkt	Ischémie
Arytmie	Vasospasmus	Okluze cévy
Snížení krevního tlaku	Alergická reakce	

Doporučený postup při použití

1. Prohlídka před použitím
 - a) Před použitím pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou vodicí drát a obal poškozeny.
 - b) Před použitím se ujistěte, že je vodicí drát kompatibilní s používanými intervenčními zařízeními.
2. Příprava
 - a) Vyberte nejvhodnější vodicí drát pro postiženou oblast a vyjměte krycí trubicu s vodicím drátem ze sterilního obalu.
 - b) Pomocí injekční stříkačky naplňte krycí trubicu heparinizovaným, sterilním fyziologickým roztokem tak, aby se namočilo celé zařízení. Vezměte na vědomí, že heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok může z krycí trubice uniknout. U drážku s ochrannou trubicí na distálním konci (obrázek 1) lze k této ochranné trubicí na distálním konci připojit injekční stříkačku.
 - c) Před zavedením vodicího drátu, naplňte lumen intervenčního zařízení heparinizovaným, sterilním fyziologickým roztokem.
 - d) Vodicí drát uvolněte z křídlaté svorky a pomalu jej suňte, protlačte distální konec vodicího drátu přes krycí trubicu (B) (obrázek 2).



- e) Vyčivňá-li distální konec vodícího drátu o 5 až 6 cm z opačného konce trubky držáku (nebo ochranné trubky distálního konce), je možné v případě potřeby upravit jeho špičku v souladu s běžnou praxí.
- f) Jemně uchopte vodící drát vyčivňající z distálního konce trubky držáku (nebo ochranné trubky distálního konce) v nejbližším možném místě u držáku a pomalu a opatrně jej vytáhněte.
- g) Pokud při vytahování vodícího drátu z krycí trubice zjistíte odpor, znovu do krycí trubice vstříkněte heparinizovaný, sterilní fyziologický roztok. Jakmile odpor odezní, pokračujte ve vytahování vodícího drátu. Do krycí trubice je nutné vstříknout dostatečný objem heparinizovaného, sterilního fyziologického roztoku, aby nedošlo k poškození hydrofilního povlaku při vytahování vodícího drátu za použití síly.
- h) Po vytáhnutí vodícího drátu z krycí trubice jej zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozen.

3. Postupy při zavádění

■ Systém Over-the-wire

- a) Opatrně vložte distální konec vodícího drátu do lumen pro vodící drát intervenčního zařízení.

- b) Vodící drát opatrně zavádějte, dokud jeho špička nedosáhne polohy proximální ke špičce intervenčního zařízení.
- c) Zařaďte vodící katétr a vložte systém intervenčního zařízení (s vodícím drátem) do Y konektoru.
- d) Posunujte systém intervenčního zařízení skrze vodící katétr, dokud špička vodícího drátu nedosáhne proximální polohy vůči špičce vodícího katétru.
- e) Utáhněte hemostatický ventil Y konektoru, aby se vytvořilo těsné spojení kolem intervenčního zařízení. Ujistěte se, že je stále umožněn pohyb vodícího drátu.
- f) Zkontrolujte, že se vodící drát pohybuje hladce.
- g) V případě potřeby připojte k vodícímu drátu přiložené rotační zařízení.
- h) Za skioskopické kontroly posunujte tento vodící drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodící drát dosáhl zúžené cílové léze.
- i) Kontrolujte pohyb vodícího drátu v cévách.
- j) Posunujte intervenční zařízení, dokud nedosáhnete léze, při tom zajistěte, aby se vodící drát nepohyboval. Zajistěte, aby distální špička vodícího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním

zařízením viditelné.

■ Systém rychlé výměny

- a) Zařaďte vodící katétr.
- b) Vložte zavaděč vodícího drátu do Y konektoru vodícího katétru.
- c) Do zavaděče opatrně vložte špičku vodícího drátu.
- d) Za skioskopické kontroly posunujte vodící drát přes vodící katétr, dokud špička vodícího drátu nedosáhne polohy proximální od špičky vodícího katétru.
- e) V případě potřeby připojte k vodícímu drátu přiložené rotační zařízení.
- f) Za skioskopické kontroly posunujte vodící drát směrem k lézi. Angiograficky potvrďte, že vodící drát dosáhl zúžené cílové léze.

- g) Kontrolujte pohyb vodícího drátu v cévách.
- h) Vyměňte rotační zařízení vodícího drátu a zavaděč vodícího drátu.
- i) Intervenční zařízení posunujte po vodícím drátě, dokud nedosáhnete léze, při tom zamezte pohybu vodícího drátu. Zajistěte, aby distální špička vodícího drátu a její poloha v cévě byly při manipulaci s intervenčním zařízením viditelné.

4. Postupy při výměně vodícího drátu

■ Systém Over-the-wire

- a) Vodící drát pomalu vyjměte za skioskopického monitorování pohybu.
- b) Vložte další vodící drát v souladu s pokyny uvedenými v části „Doporučený postup při použití“.

Podmínky uchovávání

Vodící drát a obal se nesmí při uchovávání ohýbat ani silně zatěžovat. Tento vodící drát a obal musí být uchovávány mimo dosah vody. Uchovávejte v chladu, temnu a suchu.

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti je uvedeno na štítku na obalu vodícího drátu.

Obsah

5 kusů / krabička

Odmítnutí odpovědnosti

V žádném případě není „ASAHI INTECC CO., LTD. a přidružené společnosti“ (dále jen „Společnost“) odpovědná za nehody, zranění osob, nežádoucí příhody vzniklé v důsledku jakéhokoli nesprávného použití výrobku (výrobků) nebo za jakékoli jiné použití, které není v souladu s těmito pokyny. V žádném případě nebude Společnost odpovědná za škody (i) vzniklé v důsledku skladování výrobku nebo výrobků po dodání od Společnosti nebo (ii) v důsledku výběru pacientů, operačních technik nebo jakýchkoli jiných lékařských úkonů prováděných zdravotnickým zařízením, které výrobek nebo výrobky používá.

„SION“ a „SUOH“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ASAHI INTECC CO.,LTD. v Japonsku a dalších zemích.

*Hodnoty zatížení špičky představují průměrné hodnoty specifikací produktu naměřené podle testovací metody interního standardu za předpokladu síly působící na lézi hrotem vodícího drátu.

PCI-ledesonde SION-serien

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar ledesonden i bruk og overhold indikasjoner for bruk, advarsler, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler ved bruk og anbefalt prosedyre i disse instruksjonene for bruk. Unnatelse av å gjøre dette kan føre til komplikasjoner, inkludert alvorlig skade på pasienten eller død.

Hvis en bruker eller en pasient får kjennskap til en alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til ledesonden, må dette rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten.

Denne bruksanvisningen gjelder for PCI-ledesonde SION-serien. For detaljer (lengde av ledesonden, lengden på den røntgentette seksjonen, osv.), se produktetiketten.

Beskrivelser

PCI-ledesonde SION-serien er utviklet som en ledesonde med myk tupp for å redusere risikoen for vaskulær perforering når den holdes i et kar, ettersom det å holde en ledesonde med hard tupp i et kar kan føre til vaskulær perforering.

Den grunnleggende strukturen til SION består av en konisk kjernesonde, to typer distale spoler (en ytre spole og en indre spole) og en sikkerhetssonde. Den koniske kjernesonden, spolene og sikkerhetssonden er loddet. En del av den ytre spolen er røntgentett, slik at posisjonen enkelt kan bekreftes under røntgen. SION har en fleksibel tuppbelastning på 0,7 gf* for å ivareta sikkerheten i blodkaret. En indre spole laget av tau er plassert inne i den ytre spolen. Sikkerhetssonden er festet til den indre spolen og tuppen slik at sikkerhetssonden ikke løsner. Selv i det usannsynlige tilfellet at den koniske kjernesonden løsner fra tuppen, forhindres den ytre spolen og den koniske kjernesonden i å løsne. Den distale siden av SION er belagt med hydrofil polymer.

SION blå har samme grunnstruktur som SION, men noe av belegget på den ytre spoletuppen er silikonbelegg, noe som gjør tuppen mer fleksibel enn SION, og tuppbelastningen er 0,5 gf*.

Den grunnleggende strukturen til den distale siden av SION blå ES, er den samme som den til SION blå og tuppbelastningen er 0,5 gf*, men den ytre spoelengden er kortere og skaftet stivhet er høyere. Den indre strukturen har ikke en sikkerhetssonde inni, men den distale utformingen av den koniske kjernesonden er laget slik at den proksimale siden av ledesonden ikke lett kan løsnes. I likhet med SION blå har SION blå ES et silikonbelegg på den distale delen og et hydrofilt belegg på den proksimale delen, og lengden på det hydrofile belegget er lengre enn for SION blå.

SION svart skiller seg fra SION og SION blå ved at den har et polyuretanharpiksbelegg på den ytre spolen, og et hydrofilt belegg på toppen av det. Tuppbelastningen er 0,8 gf*.

SUOH 03 har samme grunnstruktur som SION blå og SION blå ES, men den har en ytre spole av tau, noe som gir den laveste tuppbelastningen i SION-serien på 0,3 gf*. Den distale overflaten er belagt med hydrofil belegg.

I alle PCI-ledesonder i SION-serien, er den proksimale siden av den koniske kjernesonden belagt med PTFE (polytetrafluoretylen). Den nominelle ytre diameteren til produktet er 0,36 mm (0,014 tommer) over hele lengden. Enheten er mindre enn 300 cm, men i den proksimale enden er det en kobling for en

forlengelsessonde. Denne kan brukes i stedet for den kombinerte enheten. ASAHI INTECCS forlengelsessonde kan kobles til.

	Tuppbelastning*	Ytre diameter	Belegglengde	Spolengde	Røntgentett lengde
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilt belegg : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blå	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonbelegg : 1,5 cm Hydrofilt belegg : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blå ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonbelegg : 2,5 cm Hydrofilt belegg : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION svart	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polyuretanbelegg : 20,0 cm Hydrofilt belegg : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilt belegg : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikasjoner for bruk

Denne ledesonden er beregnet for generell perkutan koronar intervensjon (PCI). Denne ledesonden er utformet for å gjøre det katetre å plassere ballongdilatasjonskatetre eller andre intervensjonelle terapeutiske enheter i kardiovaskulærsystemet. Gjennomsnittlig brukstid forventes å være 120 minutter.

Denne ledesonden er ikke beregnet for bruk i det nevrovaskulære eller det kardiovaskulære systemet.

Målgruppe for behandling

PCI-ledesonde SION-serien er beregnet på pasienter som møter indikasjonene for PCI-prosedyrer. Den er ikke beregnet for bruk på nyfødte, spedbarn eller barn, samt pasienter som er gravide, har nedsatt nyrefunksjon og som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler eller polyetylenglykol (PEG).

Kontraindikasjoner

- Bekreft kompatibiliteten til diameteren på ledesonden med andre enheter for intervensjon for faktisk bruk.
- Ikke bruk ledesonden til pasienter som har en allergisk reaksjon på kontrastmidler, eller som har nedsatt nyrefunksjon.
- Denne ledesonden inneholder PEG400 i sitt hydrofile belegg. Ikke bruk ledesonden hos pasienter som har allergiske reaksjoner på polyetylenglykol (PEG).
- Ikke bruk ledesonden til gravide pasienter eller pasienter som kan være gravide (røntgen kan påvirke fosteret).
- Denne ledesonden skal brukes i institusjoner der akuttkirurgi kan utføres umiddelbart. Hvis akuttkirurgi ikke er tilgjengelig, kan i verste fall livstruende situasjoner oppstå.
- Ledesonden og emballasjen er sterilisert på forhånd med etylenoksidgass (EOG) og er kun beregnet for engangsbruk. Skal ikke resteriliseres eller brukes på nytt. Hvis ledesonden brukes på nytt eller resteriliseres, kan det gå ut over ytelsen eller kvaliteten til denne ledesonden og pakken, og det er fare for komplikasjoner, inkludert infeksjon.

Advarsler

- Denne ledesonden må kun brukes av en lege som har full opplæring i PCI-prosedyrer.
- Bruk aldri denne ledesonden i kombinasjon med katetere som har metalldele som kan komme i direkte kontakt med overflaten av denne ledesonden (f.eks. atrektomikateret, metalldilatorer), metallnåler eller metallhysterinleggere.
- Når ledesonden brukes, kontroller og overvåk bevegelsen til tuppen under fluoroskopi. Enheten

må ikke brukes i blodåren som ikke kan sees eller visualiseres.

- Ledesonden skal ikke kobles til avtakbare forlengelsessonder produsert av andre enn ASAH! INTECC. Ledesonden må ikke

manipuleres mens den avtakbare forlengelsen er tilkoblet. Hvis ikke kan ledesonden bli skadet eller den avtakbare forlengelsessonden kan løse uten at det er meningen.

- Ikke endre denne ledesonden av noen årsaker.

Forholdsregler ved bruk

- Bruk ikke ledesonden etter holdbarhetsdatoen som er angitt på etiketten. Kast ledesonder som overskrider holdbarhetsdatoen.
- Ledesonder er ømfintlige instrumenter og bør behandles forsiktig.
- Ikke bruk ledesonden dersom emballasjen er åpnet eller skadet. Ikke åpne emballasjen før like før bruk. Bruk aseptisk teknikk ved håndtering og bruk av ledesonden.
- Hold alltid ledesonden i våt tilstand for å unngå skade på dets hydrofile belegg.
- Ledesonden må ikke tørkes med en organisk løsning som alkohol.
- Iverksett preventive tiltak mot infeksjon etter bruk. Kast ledesonden og emballasjen som medisinsk avfall.
- Ledesonder som møter motstand må aldri skyves, skrues, trekkes tilbake eller ettertrekkes. Hvis ledesonden skyves eller ettertrekkes mot motstand, kan dette forårsake skade og/eller separasjon av tuppen fra ledesonden eller direkte skader på blodårene. Unnlattelse av å gjøre det kan føre til skade på denne ledesonden. Fastslå årsaken til motstanden under gjennomlysning, og iverksett nødvendige tiltak.
- Før eller trekk alltid ledesondene sakte og forsiktig frem.
- Ved ettertrekking av denne ledesonden inne i blodåren, skal den ikke ettertrekkes kontinuerlig i samme retning. Når ledesonden ettertrekkes, skal den roteres vekselvis med klokken og mot klokken. Ikke overstig to rotasjoner (720°) i samme retning.
- Skyll ledesonden med heparinisert og sterilisert saltvann eller annet egnet løsning mens ledesonden fjernes og settes inn igjen for å hindre at det kommer luft inn i intervensjonsenheten. Utfør utveksling av denne ledesonden nøye for å hindre at det kommer luft inn og/eller traumer. Når ledesonden føres inn på nytt, må du bekrefte at tuppen på intervensjonsenheten er fri innenfor lumen til blodåren og ikke ligger mot åreveggen. Uten slik observasjon kan det oppstå skade. Bruk den røntgentette markøren på intervensjonsenheten til å bekrefte plasseringen.

- Fri bevegelse av ledesonden innen intervensjonsenheten er en viktig funksjon i en styrbar ledesonde fordi det gir brukeren verdifull informasjon. Systemet må testes for motstand før bruk. Juster eller bytt hemostaseventilen med en justerbar ventil dersom det hemmer bevegelsen til ledesonden.
- Ikke utfør stentplassering ved bruk av mer enn én ledesonde eller bruk av vaier gjennom stentveggen. Hvis ikke kan stenten bli skadet eller ledesonden kan brette.
- Før bruk, kontroller at denne ledesonden er passende i størrelse og form for prosedyren og er kompatibel med enheten som skal brukes i kombinasjon.
- Se instruksjonene som er festet til det medisinske utstyret (f.eks. ballongdilatasjonskatetere eller annet intervensjonstutyr) som skal brukes i kombinasjon med denne ledesonden.
- Når den avtakbare forlengelsessonden kobles sammen med denne ledesonden, bør ledesonden være satt godt inn i grenselinjen mellom ikke-PFTE-belegg og PRFE-belegg i den proksimale enden av ledesonden. Slutt å bruke ledesonden umiddelbart hvis det blir funnet noe unormalt i tilkoblingen.
- Sjekk ledesonden nøye for bend, knekk eller andre skader før bruk og når det er mulig under prosedyren. Ikke bruk ledesonden hvis den er skadet.
- Når du former tuppen, vær forsiktig så du ikke skader spolen.
- Før du setter inn ledesonden, sjekk hvilken ende som er den distale enden og sørg for å sette den inn fra den distale enden.
- Oppretthold en kontinuerlig saltvannsspyling mellom ledetekateteret og intervensjonsenheten, og mellom intervensjonsenheten og ledesonden under prosedyren. Skylling forhindrer dannelse av kontrastmidler og/eller koagulering på ledesonden og i kateterlumen.
- Før holderen med beskyttelseshylse på den distale enden (se Anbefalt prosedyre, figur 1), ikke fjern eller sett inn beskyttelseshylsen på den

distale enden mens ledesonden er plassert i holderen.

- For holderen med beskyttelseshylse på den distale enden (se Anbefalt prosedyre, figur 1), fjern beskyttelseshylsen på den distale enden før ledesonden plasseres i holderen igjen.

- Denne enheten inneholder følgende stoff definert som CMR 1A/1B og hormonforstyrrende stoff med en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent; Kobolt: CAS-nr. 7440-48-4.

Feilfunksjoner og ugunstige effekter

Mulige feilfunksjoner og ugunstige effekter ved bruk av denne ledesonden inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

1. Feilfunksjoner

Unnlattelse av å krysse en lesjon	Brudd eller bøyning av ledesonden	Skader som separasjon
Vanskeligheter med å fjerne	Belegget går av	Rester fra en skadet ledesonde

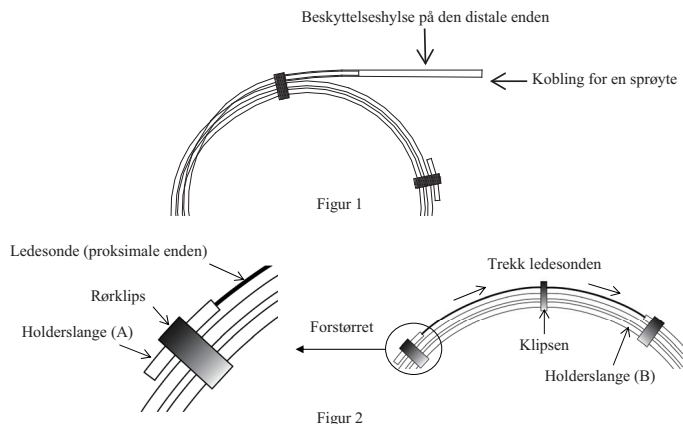
2. Ugunstige effekter

Dødsfall	Infeksjon	Disseksjon
Karperforering	Blodningskomplikasjoner	Emboli
Trombe	Infarkt	Ischemia
Arytmi	Vasospasme	Vaskulær okklusjon
Blodtrykksreduksjon	Allergisk reaksjon	

Anbefalt prosedyre

1. Inspeksjon før bruk
 - a) Før bruk, sjekk nøye og bekreft at alle ledesonder og pakker er uskadet.
 - b) Før bruk, bekreft at ledesonden er kompatibel med intervensjonsenheten som skal brukes.
2. Forberedelse
 - a) Velg den mest passende ledesonden for det berørte området; fjern holderslangen som inneholder ledesonden fra den sterile pakningen.
 - b) Fyll holderslangen med heparinisert og sterilisert saltvann ved bruk av en sprøyte, for å våte hele enheten. Merk deg at heparinisert og sterilisert saltvann kan søle ut av slangen på dette tidspunktet. For holderen med det distale endebeskytterrøret (figur 1) kan en sprøytespiss kobles til distalendens beskyttelsesør.
 - c) Fyll lumenen på intervensjonsenheten med heparinisert og sterilisert saltvann før du fører inn ledesonden.
 - d) Løsne ledesonden fra klipsen og trekk

ledesonden sakte mens du skyver den distale enden av ledesonden gjennom holderslangen (B) (Figur 2).



Figur 2

- e) Når ledesondens distale ende stikker mer enn 5–6 cm ut av den andre enden av holderslangen (eller beskyttelseshylsen på den distale enden), former du om nødvendig tuppen i samsvar med standard praksis.
 - f) Ta forsiktig tak i ledesonden som kom ut fra den distale enden av holderslangen (eller beskyttelseshylsen på den distale enden), på et punkt som er så nær holderslangen som mulig, og trekk ledesonden ut sakte og forsiktig.
 - g) Hvis du merker motstand når ledesonden fjernes fra holderslangen, skal du sprøyte inn heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen på nytt. Fortsett å fjerne ledesonden når du ikke lenger kjenner motstand. Pass på at du sprøyter inn tilstrekkelig heparinisert og sterilisert saltvann i holderslangen, da det hydrofile belegget kan bli skadet hvis du fjerner den belagte ledesonden med tvang.
 - h) Når ledesonden trekkes ut av holderslangen, sjekk for skader.
3. Prosedyrer for innsetting
 - Over-the-wire-systemet
 - a) Sett den distale enden av ledesonden forsiktig inn i lumen til intervensjonsenheten.
 - b) Flytt ledesonden forsiktig frem inntil tuppen er proksimalt til tuppen av intervensjonsenheten.
 - c) Aktiver ledekateret og sett intervensjonsenhetssystemet (med ledesonde) inn i Y-koblingen.
 - d) Før intervensjonsenhetssystemet fremover gjennom det ledekateret til tuppen av ledesondensystemet er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
 - e) Stram hemostaseventilen på Y-koblingen for å lage en forsegling rundt intervensjonsenheten. Sørg for at ledesonden fortsatt kan beveges.
 - f) Sjekk at ledesonden beveger seg jevnt.
 - g) Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
 - h) Før ledesonden fremover til du har passert lesjonen. Bruk flurosopi til å kontrollere fremdriften. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mällesjonen.
 - i) Observer ledesondens bevegelse i blodåren.
 - j) Før intervensjonsenheten fremover inntil lesjonen er nådd mens du hindrer ledesonden i å bevege seg. Sørg for at den distale tuppen av ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under

manipulasjoner av intervensjonsenheten.

- System for raskt bytte
 - a) Aktiver ledekateret.
 - b) Sett innføringssettet på ledesonden inn i Y-koblingen på ledekateret.
 - c) Sett tuppen forsiktig inn i innføringssettet.
 - d) Før ledesonden fremover gjennom det ledekateret under fluoroskopi inntil tuppen til ledesonden er proksimalt til tuppen av det ledekateret.
 - e) Fest enheten for dreiemoment til ledesonden om nødvendig.
 - f) Flytt ledesonden frem under fluoroskopi og passer gjennom lesjonen. Bekreft med angiografi at ledesonden har passert den innsnevrede delen av mällesjonen.
 - g) Observer ledesondens bevegelse i blodåren.

- h) Fjern ledesondens vridningsenhet og innføringssettet til ledesonden.
- i) Spor intervensjonsenheten over ledesonden mens du hindrer ledesonden i å bevege seg, og før den fremover inntil lesjonen er nådd. Sørg for at den distale tuppen til ledesonden og dens plassering i blodåren blir synlig under manipulasjon av intervensjonsenheten.

4. Prosedyrer for å bytte ut ledesonden

- Over-the-wire-systemet
 - a) Fjern ledesonden sakte mens ledesondens bevegelse overvåkes under fluoroskopi.
 - b) Sett inn den neste ledesonden i samsvar med retningslinjene i denne "Anbefalt prosedyre"-delen.

Oppbevaring

Ikke oppbevar ledesonden og emballasjen i bøyd stilling eller med svært tung belastning. Denne ledesonden og emballasjen skal holdes borte fra vann. Oppbevares mørkt, tørt og kjølig.

Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdatoen er angitt på etiketten på ledesondens emballasje.

Innhold

5 stk/eske

Ansvarsfraskrivelse

“ASAHI INTECC CO., LTD. og dets tilsluttede selskaper” (heretter kalt “selskapet”) skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for ulykker, personskader, ugunstige effekter fra uriktig bruk av produktet eller produktene eller annen bruk som ikke er i overensstemmelse med disse instruksjonene. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader (i) som oppstår på grunn av hvordan produktet/ene oppbevares etter forsendelse fra Selskapet, eller (ii) på grunn av pasientvalg, kirurgiske teknikker eller noen andre medisinske aktiviteter ved helseinstitusjonen som bruker produktet/ene.

“SION” og “SUOH” er varemerker eller registrerte varemerker for ASAHI INTECC CO., LTD. i Japan og andre land.

*Tuppbelastningsverdiene representerer gjennomsnittsverdier for produktspesifikasjonsverdiene målt iht. den interne standardtestmetoden, forutsatt at ledesondens tupp påfører kraften på lesjonen.

Vodiaci drôt PCI radu SION

Návod na použitie

Pred použitím vodiaceho drôtu si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte pokyny uvedené v častiach Indikácie na použitie, Kontraindikácie, Upozornenia, Bezpečnostné opatrenia a Spôsob použitia. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku komplikáciám, vrátane vážneho zranenia alebo smrti pacienta.

Ak sa používateľ a/alebo pacient dozvie o závažnom incidente, ku ktorému došlo v súvislosti s vodiacim drôtom, musí túto skutočnosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu.

Tento návod na použitie sa vzťahuje na vodiaci drôt PCI radu SION. Podrobnosti (dĺžka vodiaceho drôtu, dĺžka kontrastnej časti a pod.) nájdete na etikete výrobku.

Popis

Vodiaci drôt PCI radu SION bol vyvinutý ako vodiaci drôt s mäkkou špičkou na zníženie rizika perforácie cievky, keď sa drží v cieve, pretože držanie vodiaceho drôtu s tvrdou špičkou v cieve môže viesť k perforácii cievky.

Základná štruktúra pomôcky SION pozostáva z kužeľového jadrového drôtu, dvoch typov distálnych cievok (vonkajšia cievka a vnútorná cievka) a bezpečnostného drôtu. Kužeľový jadrový drôt, cievky a bezpečnostný drôt sú spájkované. Čiastočná dĺžka vonkajšej cievky je röntgenkontrastná, vďaka čomu možno ľahko potvrdiť jej polohu pomocou rádioskopie. Pomôcka SION má zaťaženie flexibilnej špičky 0,7 gf*, aby bola zaistená bezpečnosť v cieve. Vnútorná cievka vyrobená z lana je umiestnená vo vonkajšej cievke a bezpečnostný drôt je pripevnený k vnútornej cievke a špičke tak, aby sa bezpečnostný drôt neoddelil, a to ani v nepravdepodobnom prípade, že sa kužeľový jadrový drôt odpojí od špičky, čím sa zabráni odpojeniu vonkajšej cievky a kužeľového jadrového drôtu. Distálna strana pomôcky SION je potiahnutá hydrofilným polymérom.

Pomôcka SION blue má rovnakú základnú štruktúru ako pomôcka SION, ale časť povrchovej vrstvy na špičke vonkajšej cievky je silikónová povrchová vrstva, vďaka čomu je špička pružnejšia ako špička pomôcky SION a zaťaženie špičky je 0,5 gf*.

Základná štruktúra distálnej strany pomôcky SION blue ES je rovnaká ako v prípade pomôcky SION blue a zaťaženie špičky je 0,5 gf*, dĺžka vonkajšej cievky je však kratšia a tuhosť drieku je vyššia. Vnútorná štruktúra nemá vnútri bezpečnostný drôt, ale distálna konštrukcia kužeľového jadrového drôtu jadrom je navrhnutá tak, aby sa proximálna strana vodiaceho drôtu nedala ľahko uvoľniť. Rovnako ako v prípade pomôcky SION blue je povrchová vrstva pomôcky SION blue ES tvorená silikónovou povrchovou vrstvou na distálnej strane a hydrofilnou na proximálnej strane a dĺžka hydrofilnej povrchovej vrstvy je dlhšia ako v prípade pomôcky SION blue.

Pomôcka SION black sa od pomôcky SION a SION blue líši tým, že má na vonkajšej cievke povrchovú vrstvu z polyuretánovej živice a na nej hydrofilnú povrchovú vrstvu. Zaťaženie špičky je 0,8 gf*.

Základná štruktúra SUOH 03 je rovnaká ako v prípade pomôcky SION blue a SION blue ES, ale používa vonkajšiu cievku vyrobenú z lana, čo vedie k najnižšiemu zaťaženiu špičky v rade SION na úrovni 0,3 gf*. Distálny povrch je potiahnutý hydrofilnou povrchovou vrstvou.

Vo všetkých vodiacich drôtoch PCI radu SION je proximálna strana kužeľového jadrového drôtu potiahnutá PTFE (polytetrafluóretylénom). Menovitý vonkajší priemer produktu je 0,36 mm (0,014 palca) po celej dĺžke. Na proximálnom konci pomôcky, ktorá je kratšia ako 300 cm, sa nachádza prípojka pre predlžovací drôt, ktorý sa používa na nahradenie kombinovanej pomôcky. Je možné pripojiť predlžovací drôt od spoločnosti ASAHI INTECC.

	Zaťaženie špičky*	Vonkajší priemer	Dĺžka povrchovej vrstvy	Dĺžka cievky	Dĺžka röntgenkontrastnej časti
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilná povrchová vrstva: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikónová povrchová vrstva : 1,5 cm Hydrofilná povrchová vrstva: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikónová povrchová vrstva : 2,5 cm Hydrofilná povrchová vrstva: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polyuretánová povrchová vrstva : 20,0 cm Hydrofilná povrchová vrstva: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hydrofilná povrchová vrstva: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikácie na použitie

Tento vodiaci drôt je určený na všeobecnú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI). Tento vodiaci drôt je určený na uľahčenie umiestnenia balónikových dilatčných katétrov alebo iných intervenčných terapeutických pomôcok do kardiovaskulárneho systému. Očakáva sa, že priemerná doba používania bude 120 minút.

Tento vodiaci drôt nie je určený na použitie v neurovaskulatúre a periférnej vaskulatúre.

Cieľová liečená populácia

Vodiace drôty PCI radu SION sú určené pre pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na PCI. Nie je indikovaný na použitie u novorodencov, dojčiat alebo detí, ani u pacientiek, ktoré sú tehotné, majú poruchu funkcie obličiek a alergickú reakciu na kontrastné látky alebo polyetylénlyglykol (PEG).

Kontraindikácie

- Pred samotným použitím overte kompatibilitu priemeru vodiaceho drôtu s inou intervenčnou pomôckou.
- Vodiaci drôt nepoužívajte u pacientov s alergickou reakciou na kontrastnú látku alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
- Hydrofilná povrchová vrstva tohto vodiaceho drôtu obsahuje PEG400. Nepoužívajte vodiaci drôt u pacientov, u ktorých sa vyskytla alergická reakcia na polyetylénlyglykol (PEG).
- Nepoužívajte vodiaci drôt u tehotných pacientok alebo pacientok, ktoré môžu byť tehotné (röntgenové žiarenie môže ovplyvniť plod).
- Tento Vodiaci drôt sa smie používať v inštitúcii, kde sa môže okamžite vykonať pohotovostná chirurgická operácia. Ak nie je dostupná pohotovostná chirurgická operácia, v najhoršom prípade môže dôjsť k život ohrozujúcim udalostiam.
- Vodiaci drôt je vopred sterilizovaný plynným etylénoxidom (EOG) a je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte ani nesterilizuje opakovane. Keby sa opakovane použil alebo sterilizoval, mohla by sa narušiť funkčnosť alebo kvalita vodiaceho drôtu a hrozilo by riziko komplikácií, vrátane infekcie.

Upozornenia

- Vodiaci drôt smie používať výhradne lekár, ktorý je úplne vyskolovaný v oblasti liečby PCI.
- Nikdy nepoužívajte tento vodiaci drôt v kombinácii s katétami s kovovými časťami, ktoré sa môžu priamo dotýkať povrchu tohto vodiaceho drôtu (napr. aterosklerotické katétre, kovové dilatátory), kovovými ihlami alebo kovovými puzdrovými záväzákmi.
- Počas používania vodiaceho drôtu kontrolujte a monitorujte pohyb jeho špičku pod fluoroskopom. Nepoužívajte ho v oblastiach ciev, ktoré nemožno vizualizovať.
- Vodiaci drôt nespájajte s odnímateľnými predlžovacími drôtmí od iných výrobcov ako ASAHI INTECC. Nemanipulujte s vodiacim drôtom, kým je k nemu pripojený odnímateľný vodiaci drôt. Ináč sa vodiaci drôt poškodí alebo sa odpojiteľný predlžujúci drôt neúmyselne odpojí.
- Vodiaci drôt zo žiadneho dôvodu neupravujte.

Bezpečnostné opatrenia

- Vodiaci drôt nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na etikete obalu. Zlikvidujte všetky vodiace drôty, ktoré sú po dátume expirácie.
- Vodiace drôty sú citlivé nástroje a je potrebné narábať s nimi opatrne.
- Ak je obal otvorený alebo poškodený, vodiaci drôt nepoužívajte. Obal otvárajte až tesne pred použitím. Pri manipulácii s vodiacim drôtom, ako aj pri ich používaní, použite aseptickú techniku.
- Vodiaci drôt udržiavajte vždy vo vlhkom stave, aby ste zabránili poškodeniu jeho hydrofilnej povrchovej vrstvy.
- Vodiaci drôt neutierajte pomocou organického roztoku, napríklad alkoholu.
- Po použití podniknite protiinfekčné preventívne opatrenia. Vodiaci drôt a obal zlikvidujte ako zdravotný odpad.
- Nikdy netlačte, neskrúćajte, nevyťahujte ani netoťte vodiaci drôt takou silou, aby ste cítili odpor. Točenie alebo zatlačenie vodiaceho drôtu napriek odporu môže spôsobiť poškodenie vodiaceho drôtu a oddelenie jeho špičky alebo priame poškodenie ciev. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiaceho drôtu. Pod fluoroskopickým pozorovaním určite príčinu odporu a podniknite potrebný nápravný krok.
- Vodiace drôty vždy zasúvajte alebo vyťahujte pomaly a opatrne.
- Počas krútenia vodiacim drôtom vnútri krvnej cievy nekrúćte nim stále tým istým smerom. Pri krútení vodiacim drôtom ho striedavo otáčajte v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby ste nevykonali viac ako dve rotácie (720°) tým istým smerom.
- Pri odstraňovaní a opätovnom zavádzaní vodiaci drôt opláchnite heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom alebo iným vhodným roztokom, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do intervenčnej pomôcky. Výmenu vodiaceho drôtu vykonajte opatrne, aby nedošlo k vniknutiu vzduchu a/alebo vzniku traumy. Pri opakovanom zavádzaní vodiaceho drôtu sa presvedčte, že špička intervenčnej pomôcky je v lúmene cievy voľná a že nesmeruje k stene cievy. Ak tak neurobité, môže dôjsť k úrazu. Polohu potvrdte pomocou kontrastnej značky intervenčnej pomôcky.
- Voľný pohyb vodiaceho drôtu v intervenčnej pomôčke je dôležitým príznakom ovládacieho systému vodiaceho drôtu, pretože používateľovi poskytuje cenné dotykové informácie. Pred použitím systému vyskúšajte, ako sa správa pri odpore. Nastavte alebo vymeňte hemostatický ventil pomocou nastavovacieho ventilu, ak je prítomný, aby ste zamedzili pohybu vodiaceho drôtu.
- Stent neumiestňujte pomocou viacerých vodiacich drôtov ani nemanipulujte s drôtom prostredníctvom výstuh stentu. V opačnom prípade sa stent môže poškodiť a vodiaci drôt sa môže zlomiť alebo roztrhnúť.
- Pred použitím sa uistite, že vodiaci drôt má vhodnú veľkosť a tvar pre daný postup a je kompatibilný s pomôckou, ktoré sa má použiť v kombinácii s nim.
- Pozrite si návod na použitie priložený k zdravotníckej pomôčke (napr. balónikové dilatčné katétre alebo iné intervenčné pomôcky), ktorá sa má použiť v kombinácii s týmto vodiacim drôtom.
- Pri pripájaní odnímateľného predlžovacieho drôtu k tomuto vodiacemu drôtu by sa drôt mal bezpečne zavesiť po hraničnú líniu medzi vrstvou bez polytetrafluoretylénu (PTFE) a

vrstvou s PTFE na proximálnom konci vodiaceho drôtu. Ak sa v prípojke zistí akákoľvek abnormalita, okamžite prestaňte vodiaci drôt používať.

- Pred použitím vodiaceho drôtu a kedykoľvek je to možné počas zákroku dôkladne skontrolujte, či vodiaci drôt nie je ohnutý, zauzlený alebo inak poškodený. Ak je vodiaci drôt poškodený, nepoužívajte ho.
- Pri tvorení špičky dávajte pozor, aby ste nepoškodili cievy.
- Pred zavedením vodiaceho drôtu skontrolujte, ktorý koniec je distálny, a dbajte na to, aby ste ho zavádzali z distálneho konca.
- Počas zákroku vykonávajte priebežné preplachovanie fyziologickým roztokom medzi vodiacim katétrom a intervenčnou pomôckou a

medzi intervenčnou pomôckou a vodiacim drôtom. Preplachovanie zabraňuje tvorbe a/alebo zrážaniu kontrastnej látky na vodiacom drôte a v lúmene katétra.

- V prípade držiaka s ochrannou rúrkou distálneho konca (pozri časť Spôsob použitia, obrázok 1) neodstraňujte ani nevkladajte ochrannú rúrkou distálneho konca, kým je vodiaci drôt umiestnený v držiaku.
- V prípade držiaka s ochrannou rúrkou distálneho konca (pozri časť Spôsob použitia, obrázok 1) odstráňte ochrannú rúrkou distálneho konca pred opätovným vložení vodiaceho drôtu do držiaka.
- Táto pomôcka obsahuje nasledujúcu látku definovanú ako CMR 1A/1B a látku narúšajúcu endokrinnú sústavu v koncentracii vyššej ako 0,1 % hmotnosti; kobalt: Číslo CAS 7440-48-4.

Poruchy činnosti a nežiaduce účinky

K možným poruchám činnosti a nežiaducim účinkom pri používaní vodiaceho drôtu okrem iného patria:

1. Porucha činnosti

Neúspešný prechod léziou	Zlomenie alebo ohnutie vodiaceho drôtu	Poškodenie, ako napríklad oddelenie
Ťažkosti pri odstraňovaní	Odlúpenie povrchovej vrstvy	Úlomky z poškodeného vodiaceho drôtu

2. Nežiaduce účinky

Úmrtie	Infekcia	Disekcia ciev
Perforácia ciev	Krvácavé komplikácie	Embólia
Trombus	Infarkt	Ischémiá
Arytmia	Vazospazmus	Cievna oklúzia
Zníženie krvného tlaku	Alergická reakcia	

Spôsob použitia

1. Kontrola pred použitím

- a) Pred použitím dôkladne skontrolujte a overte, či vodiaci drôt a obal nie sú poškodené.
- b) Pred použitím sa presvedčte, že vodiaci drôt je kompatibilný s intervenčnými pomôckami, ktoré sa majú použiť.

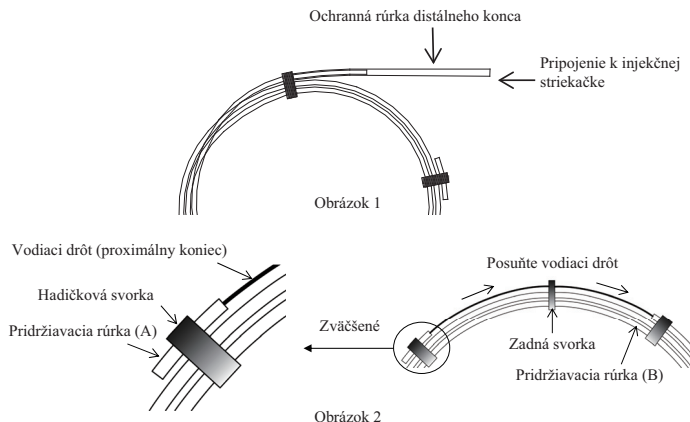
2. Príprava

- a) Zvoľte najvhodnejší vodiaci drôt pre postihnutú oblasť a pridržiavaciu rúrkou obsahujúcu vodiaci drôt vyberte zo sterilného obalu.

- b) Pridržiavaciu rúrkou pomocou injekčnej striekačky naplňte heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom, aby sa navlhčila celá pomôcka. Pripomíname, že počas tohto úkonu môže heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok vytiecť z pridržiavacej rúrky. V prípade držiaka s ochrannou rúrkou na distálnom konci (obrázok 1) je možné k ochranné rúrke na distálnom konci pripojiť striekačku.
- c) Pred zavedením vodiaceho drôtu naplňte lúmen intervenčnej pomôcky

heparinizovaným a sterilizovaným fyziologickým roztokom.
d) Vodiaci drôt uvoľnite zo zadnej svorky a

pomaly ho posúvajte, distálny koniec vodiaceho drôtu tlačte cez pridržiavaciu rúrku (B) (Obrázok 2).



- e) Ak sa distálny koniec vodiaceho drôtu vysunie o viac ako 5 – 6 cm za opačný koniec pridržiavacej rúrky (alebo ochranné rúrky distálneho konca), v prípade potreby upravte tvar špičky podľa štandardného postupu.
f) Jemne uchopte vodiaci drôt, ktorý vychádza z distálneho konca rúrky držačka (alebo ochranné rúrky distálneho konca) v bode, ktorý je čo najbližšie k pridržiavacej rúrke, a vodiaci drôt pomaly a opatrne vytiahnite.
g) Ak pri vytáňovaní vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky pociťte odpor, znovu vstreknite do pridržiavacej rúrky heparinizovaný a sterilizovaný fyziologický roztok. Keď sa odpor stratí, pokračujte vo vytáňovaní vodiaceho drôtu. Dbajte na to, aby ste do pridržiavacej rúrky vstrekli dostatok heparinizovaného a sterilizovaného fyziologického roztoku, pretože pri násilnom vytáňovaní potiahnutého vodiaceho drôtu sa môže poškodiť jeho hydrofilná povrchová vrstva.
h) Po vytiahnutí vodiaceho drôtu z pridržiavacej rúrky sa presvedčte, či nie je poškodený.

3. Postupy pre zavedenie

■ Systém Over the wire (OTW)

- a) Distálny koniec vodiaceho drôtu opatrne zaveďte do lúmenu pre vodiaci drôt intervenčnej pomôcky.
b) Opatrne zasúvajte vodiaci drôt, až kým sa jeho špička nedostane najbližšie k špičke intervenčnej pomôcky.
c) Nasaďte vodiaci katéter a zaveďte systém intervenčnej pomôcky (s vodiacim drôtom) do Y-konektora.
d) Systém intervenčnej pomôcky zasúvajte cez vodiaci katéter, až kým sa špička systému vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
e) Utiachnite hemostatický ventil Y-konektora, aby sa vytvorilo utesnenie okolo intervenčnej pomôcky. Ubezpečte sa, že pohyb vodiaceho drôtu je ešte stále možný.
f) Kontrolou sa presvedčte, že sa vodiaci drôt hladko pohybuje.
g) V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.
h) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým neprejde cez léziu.

Angiografiu overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.

- i) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v ciechach.
j) Intervenčnú pomôcku zasúvajte, až kým sa nedostane k lézii, pričom zabránite pohybu vodiaceho drôtu. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

■ Systém Rapid exchange (RX)

- a) Nasaďte vodiaci katéter.
b) Zavádzač vodiaceho drôtu zaveďte do Y-konektora vodiaceho katétra.
c) Opatrne zaveďte špičku vodiaceho drôtu do zavádzača.
d) Vodiaci drôt zasúvajte cez vodiaci katéter pod fluoroskopickým pozorovaním, až kým sa špička vodiaceho drôtu nedostane najbližšie k špičke vodiaceho katétra.
e) V prípade potreby pripevnite k vodiacemu drôtu torzné zariadenie.

- f) Vodiaci drôt zasúvajte pod fluoroskopickým pozorovaním tak, aby prešiel cez léziu. Angiografiu overte, či vodiaci drôt prešiel zúženou cieľovou léziou.
g) Sledujte pohyb vodiaceho drôtu v ciechach.
h) Odstráňte torzné zariadenie vodiaceho drôtu a zavádzač vodiaceho drôtu.
i) Veďte intervenčnú pomôcku po vodiacom drôte, pričom zabránite pohybu vodiaceho drôtu, a zasúvajte ju až kým sa nedostane k lézii. Zabezpečte, aby bola distálna špička vodiaceho drôtu a jej poloha v cieve viditeľná počas manipulácie s intervenčnou pomôckou.

4. Postupy na výmenu vodiaceho drôtu

■ Systém Over the wire (OTW)

- a) Vodiaci drôt pomaly odstraňujte, pričom sledujte pohyb vodiaceho drôtu pod fluoroskopickým pozorovaním.
b) Zaveďte ďalší vodiaci drôt v súlade s pokynmi v časti Spôsob použitia.

Spôsob uschovávania

Vodiaci drôt a jeho obal nenechávajte ohnúty a/alebo vystavený príliš veľkej záťaži. Vodiaci drôt a jeho obal chráňte pred vodou. Uchovávajte na chladnom, tmavom a suchom mieste.

Dátum expirácie

Dátum expirácie je vyznačený na štítku na obale vodiaceho drôtu.

Obsah

5 kusov v jednej škatuli

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť „ASAHI INTECC CO., LTD. a jej pridružené spoločnosti“ (ďalej len „Spoločnosť“) nebude niesť žiadnu zodpovednosť za úrazy, osobné zranenia, nežiaduce účinky zapríčinené nesprávnym používaním produktu (produktov) alebo iným používaním, ktoré nie je v súlade s týmto návodom. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce (i) zo skladovania produktu (produktov) po odoslaní zo spoločnosti ani (ii) z dôvodu výberu pacientov, chirurgických postupov alebo iných lekárskeho činností zo strany zdravotníckych zariadení, kde sa produkt (produkty) používa.

„SION“ a „SUOH“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti ASAHI INTECC CO., LTD. v Japonsku a ďalších krajinách.

* Hodnoty zaťaženia špičky predstavujú priemerné hodnoty hodnôt špecifikácie produktu namerané podľa internej štandardnej testovacej metódy za predpokladu sily pôsobiacej na léziu špičkou vodiaceho drôtu.

PCI juhtetraat, seeria SION

Kasutusjuhend

Enne juhtetraadi kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid ja järgige selle kasutusjuhendi peatükke „Kasutusnäidustused“, „Vastunäidustused“, „Hoiatused“, „Ettevaatusabinõud“ ja „Kasutamine“. Selle teabe eiramine võib viia tüsistusteni, kaasa arvatud patsiendi tõsine vigastus või surm.

Kui kasutaja ja/või patsient saab teada tõsisest vahejuhtumist, mis juhtetraadiga seoses aset leidis, tuleb tootjat ja liikmesriigi pädevat asutust sellest teavitada.

See kasutusjuhend kehtib PCI juhtetraadi seeria SION kohta. Andmeid (juhtetraadi pikkus, röntgenkontrastse osa pikkus jne) vaadake tootesildilt.

Kirjeldused

PCI juhtetraadi seeria SION on välja töötatud kui pehme otsaga juhtetraat, mille eesmärk on vähendada vaskulaarse perforatsiooni riski veresoones hoidmisel, kuna kõva otsaga juhtetraadi hoidmisel võib tekkida vaskulaarne perforatsioon.

Seeria SION põhistruktuur koosneb koonilisest südamiku traadist, kahte tüüpi distaalsest spiraalist (välisest ja sisemisest spiraalist) ning ohutustraadist. Kooniline südamiku traat, spiraalid ja ohutustraad on joodetud. Välise spiraali osa on röntgenkontrastne, nii et selle asendit saab radioskoopilise vaatlusega hõlpsasti kontrollida. Seeria SION painduva otsa koormus on 0,7 gf* ohutuse tagamiseks veresoones. Trossist sisemine spiraal on paigutatud välisesse spiraali ning ohutustraad on seotud sisemise spiraali ja otsaga nii, et ohutustraati ei tule ära isegi sellisel ebatõenäolisel juhul, kui kooniline südamiku traat tuleb otsa küljest lahti – nõnda ei saa väline spiraal ega kooniline südamiku traat ära tulla. Seeria SION distaalne ots on kaetud hüdrofiilse polümeeriga.

SION blue põhistruktuur on sama nagu seerial SION, kuid osa välise spiraali otsa kattest on silikoonkate, nii et ots on paindlikum kui seerial SION, otsa koormus on 0,5 gf*.

SION blue ES-i distaalse külje põhistruktuur on sama nagu seerial SION blue ning otsa koormus on 0,5 gf*, kuid väline spiraal on lühem ja varras jäigem. Sisestruktuuris puudub ohutustraad, kuid koonilise südamiku traadi distaalne ehitus on välja töötatud nii, et juhtetraadi proksimaalne ots ei nihku kergesti paigast. Nagu seerial SION blue, on SION blue ES-il distaalses otsas silikoonkate ja proksimaalses otsas hüdrofiilne kate ning hüdrofiilne kate on pikem kui seerial SION blue.

SION black erineb seeriatest SION ja SION blue selle poolest, et selle välisel spiraalil on polüuretaanvaigust kate ja selle peal hüdrofiilne kate. Otsa koormus on 0,8 gf*.

SUOH 03 põhistruktuur on sama nagu seerial SION blue ja SION blue ES, kuid sellel on trossist väline spiraal, nii et seeria SION väikseim otsa koormus on 0,3 gf*. Distaalne pind on kaetud hüdrofiilse kattega.

Kogu PCI juhtetraadi seerias SION on koonilise südamiku traadi proksimaalne ots kaetud PTFE-ga (polütetrafluorietüleen). Toote väline nimiläbimõõt on kogupikkuses 0,36 mm (0,014 tolli). Alla 300 cm seadmete proksimaalses otsas on ühendus pikendusjuhtme jaoks, mida kasutatakse kombineeritud seadme asendamiseks; sellega saab ühendada ASAHI INTECC-i pikendusjuhtme.

	Otsa koormus*	Välisläbimõõt	Katte pikkus	Spiraali pikkus	Röntgenkontrastse osa pikkus
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hüdrofiilne kate: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikoonkate: 1,5 cm Hüdrofiilne kate: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikoonkate: 2,5 cm Hüdrofiilne kate: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Polüuretaankate: 20,0 cm Hüdrofiilne kate: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hüdrofiilne kate: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Näidustused

See juhtetraat on mõeldud üldiseks perkutaanseks koronaarinterventsiooniks (PCI). See juhtetraat on ette nähtud balloondilatatsiooniga kateetrite või muude sekkumisraviseadmete paigutamiseks kardiovaskulaarsüsteemi. Keskmine eeldatav kasutuskestus on 120 minutit.

See juhtetraat ei ole ette nähtud kasutamiseks neurovaskulaarses ja perifeerses veresoontkonnas.

Ravi sihtrühm

PCI juhtetraadi seeria SION on ette nähtud patsientidele, kes vastavad PCI protseduuride näidustustele. See ei ole ette nähtud kasutamiseks vastündinutel, imikutel, lastel ega rasedatel, neerufunktsiooni häirega patsientidel ega neil, kel on allergiline reaktsioon kontrastaine või polüetüleenlülükooli (PEG) suhtes.

Vastunäidustused

- Kontrollige enne tegelikku kasutamist juhtetraadi läbimõõdu ühilduvust muu sekkumiseadmega.
- Ärge kasutage juhtetraati patsientidel, kellel on kontrastaine suhtes allergiline reaktsioon või kellel on neerufunktsiooni häire.
- Juhtetraat sisaldab hüdrofiilset kattel ainet PEG400. Ärge kasutage juhtetraati patsientidel, kes on polüetüleenlülükooli (PEG) suhtes allergilised.
- Ärge kasutage juhtetraati rasedate või potentsiaalselt rasedate patsientide puhul (röntgenikiirgus võib loodet mõjutada).
- Seda juhtetraati tohib kasutada vaid asutuses, kus on võimalik erakorralise kirurgilise operatsiooni viivitamatu teostamine. Kui erakorralise kirurgilise operatsiooni tegemise võimalus puudub, võivad halvalmal juhul tekkida surmaga lõppevad tüsistused.
- See juhtetraat on eelsteriliseeritud etüleenoksiidiga (EO) ja on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ega steriliseerige korduvalt. Korduv kasutamine või korduv steriliseerimine võib halvendada juhtetraadi kvaliteeti ja kahjustada selle pakendit, ning sellega kaasneb komplikatsioonide risk, kaasa arvatud infektsioonirisk.

Hoiatused

- Seda juhtetraati tohib kasutada vaid PCI protseduuri ajal täieliku koolituse saanud arst.
- Ärge kunagi kasutage seda juhtetraati koos kateetritega, millel on metallosad, mis võivad otsa selle juhtetraadi pinnaga kokku puutuda (nt aterektomia kateetrid, metallist dilataatorid), metallist nõelte ega metallist hülsiga sisestajatega.
- Juhtetraadi kasutamise ajal kontrollige ja jälgige selle otsa liikumist röntgenoloogiliselt. Ärge

59

- Ärge ühendage selle juhtetraadi külge eemaldatavaid pikendustraate, mille tootja on muu kui ettevõtte ASAHI INTECC. Ärge

käsitsege seda juhtetraati, kui eemaldatav
pikendustraati on ühendatud. Vastasel juhul võite
kahjustada juhtetraati või eemaldatava
pikendustraadi tahtmatult lahti ühendada.
Ärge muutke juhtetraati ühelgi põhjusel.

Ettevaatusabinõud

- Ärge kasutage juhtetraati pärast sildil toodud aegumiskuupäeva möödumist.
- Aegumiskuupäeva ületanud juhtetraadid tuleb ära visata.
- Juhtetraadid on õrnad instrumendid ja neid tuleb käsitseda ettevaatlikult.
- Ärge kasutage juhtetraati, kui pakend on avatud või kahjustatud. Avage pakend alles vahetult enne kasutamist. Kasutage juhtetraadi käsitsesimise asetsilist tehnikat.
- Hoidke juhtetraati alati märjana, et vältida selle hüdrofiilse kate kahjustamist.
- Ärge pühkige juhtetraati orgaanilise lahusega, näiteks alkoholiga.
- Võtke tarvitusele ennetavad meetmed kasutusjärgse infektsioonihoo vältimiseks.
- Kõrvaldage juhtetraat ja pakend kui meditsiinilised jättemärgid.
- Ärge kunagi lükake, keerake, tõmmake välja ega pöörake juhtetraati, mille osas on tunda takistust. Juhtetraadi pööramine või lükkamine takistuse vastu võib juhtetraati kahjustada ja/või põhjustada juhtetraadi otsa eraldumist või otseselt kahjustada vereosent. Selle eiramine võib juhtetraati kahjustada. Tehke takistuse põhjus röntgenoloogiliselt kindlaks ja kõrvaldage see.
- Lükake juhtetraati edasi ja tõmmake välja alati aeglaselt ja ettevaatlikult.
- Juhtetraadi pööramisele vereosone sees ärge pöörake seda pidevalt üht suunas. Seadme pööramise pöörake seda vaheldumisi päripäeva ja vastupäeva. Ärge pöörake üht suunas järjest rohkem kui kaks täispöört (kuni 720°).
- Juhtetraadi eemaldamisel ja uuesti sisestamisel loputage seda hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahuse või muu sobiva lahusega, et takistada õhu sattumist röntgenoloogilisse seadmesse. Vahetage juhtetraati ettevaatlikult, et vältida õhu sisenemist ja/või trauma tekkimist. Juhtetraadi uuesti sisestamisel veenduge, et röntgenoloogilisse seadme ots oleks vabalt vereosone valendikus ega puutuks vastu vereosone seinale. Vastasel juhul tekib vigastuste oht. Asukoha kinnitamiseks kasutage

röntgenoloogilise seadme röntgenkontrastset markerit.

Juhtetraadi vaba liikumine röntgenoloogilises seadmes on juhitava juhtetraadi süsteemi oluline funktsioon, kuna see annab kasutajale väärtuslikku teavet. Enne kasutamist kontrollige süsteemi mis tahes takistuste suhtes. Kui hemostaatiline klapp takistab juhtetraadi liikumist, reguleerige hemostaatilist klappi või vahetage see välja reguleeritava klapi vastu.

Ärge sisestage stenti kasutades enam kui ühte juhtetraadi või kui käsitsete traati läbi stendi seina. Vastasel juhul võib stent kahjustuda või juhtetraadi võib puruneda või lahti lulla.

Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat oleks protseduuri jaoks sobiva suuruse ja kujuga ning ühilduks kombineeritult kasutatava seadmega. Vaadake selle juhtetraadi jaoks kasutatava selle külge kinnitatava meditsiiniseadme (nt balloondilatatsiooni kateetri või muud sekkumisseadme) kasutusjuhendit.

Katkestage ühendamiseks tuleb eemaldatav juhtendstraat kindlasti sisestada juhtetraadi proksimaalse otsa mitte-PTFE katte ja PTFE katte piirile. Kui ühenduses avastatakse häired, lõpetage juhtetraadi kasutamine kohe.

Katkestage juhtetraadi hoolikalt painutuskohtade, keerdude ja muude kahjustuste suhtes enne kasutamist ja igal võimalikul ajal protseduuri jooksul. Ärge kasutage juhtetraati, kui see on kahjustatud.

Olge otsa vormimisel ettevaatlik, et spiraali mitte kahjustada.

Enne juhtetraadi sisestamist kontrollige, milline ots on distaalse otsa, ja sisestage see kindlasti distaalsest otsast.

Protseduuri ajal säilitage juhtekateetri ja sekkumisseadme ning sekkumisseadme ja juhtetraadi vaheline pidev loputamine.

Loputamine hoiab ära kontrastaine moodustumise ja/või hüübimise juhtetraadil ja katteetri luumenis.

Kui hoidikud on distaalse otsa kaitsetoru (vt Kasutamine, lõigus 11), ärge eemaldage ega

- Kui hoidikul on distaalse otsa kaitsetoru (vt Kasutamine, joonis 1), eemaldage distaalse otsa kaitsetoru enne juhtetraadi uuesti hoidikusse paigutamist.

- See seade sisaldab järgmist 1A/1B kategooria sisesekreetsioonisüsteemi kahjustavat CMR-ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi; koobalt: CASi nr 7440-48-4.

Tõrked ja kõrvaltoimed

Juhtetraadi kasutamisest tingitud võimalike tõrgete ja kõrvaltoimete hulka kuuluvad muuhulgas järgmised.

1. Talitlushäired

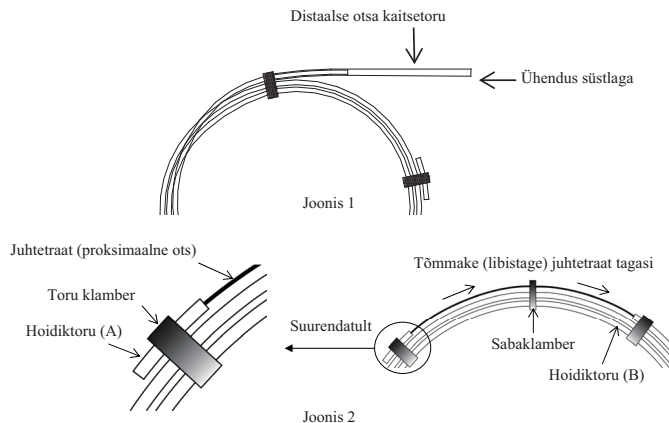
Kahjustuskoha läbimise ebaõnnestumine	Juhttraadi purunemine või kõverdumine	Kahjustus, näiteks eraldumine
Keeruline eemaldada	Katte eraldumine	Kahjustatud juhttraadi jäägid

2. Kõrvaltoimed

Surm	Infektsioon	Veresoone dissektsioon
Veresoone perforatsioon	Veritsustüsistused	Emboolia
Tromb	Kärbumine	Isheemia
Arütmia	Vasospasm	Vaskulaarne oklusioon
Vererõhu langus	Allergiline reaktsioon	

Kasutamine

1. Kasutusseelne kontrollimine
 - a) Enne kasutamist kontrollige juhtetraati ja pakendit hoolikalt ja veenduge, et need oleksid kahjustamata.
 - b) Enne kasutamist veenduge, et juhtetraat ühilduks kasutatavate menetlusradioloogiliste seadmetega.
2. Ettevalmistus
 - a) Valige kahjustatud ala jaoks sobivaim juhtetraat ja eemaldage hoidiktoru koos juhtetraadiga steriilselt pakendist.
 - b) Täitke hoidiktoru hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega, kasutades kogu seadme märjaks tegemiseks süstalt. Arvestage, et sellel ajal võib hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogiline lahus hoidiktorust välja pritsida. Distaalse otsa kaitsevoolikuga hoidiku (joonis 1) puhul saab distaalse otsa kaitsevoolikuga ühendada süstla.
 - c) Täitke röntgenoloogilise seadme valendik hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilise lahusega enne juhtetraadi sisestamist.



- e) Kui juhetraadi distaalne ots on hoidiktoru teisest otsast (või distaalse otsa kaitsetorust) rohkem kui 5 kuni 6 cm väljas, siis võite vajaduse korral muuta otsa kuju tavapärase praktika kohaselt.
- f) Haarakke õrnalt juhetraadist, mis väljus hoidiktoru distaalsest otsast (või distaalse otsa kaitsetorust), võimalikult hoidiku toru lähedalt ning tõmmake juhetraat aeglaselt ja ettevaatlikult välja.
- g) Kui juhetraadi eemaldamisel hoidiktorust on tunda takistust, süstige hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust uuesti hoidiktorusse. Jätke juhetraadi eemaldamist kui takistust pole enam tunda. Veenduge, et süstiksite hoidiktorusse piisavalt hepariniseeritud ja steriliseeritud füsioloogilist lahust, sest hüdrofiilne kate võib kahjustuda, kui kattega juhetraadi eemaldamisel kasutatakse jõudu.
- h) Pärast juhetraadi hoidiktorust välja tõmbamist kontrollige, et see ei oleks kahjustatud.

3. Sisestamismeetodid

■ Üle traadi süsteem

- a) Sisestage juhetraadi distaalne ots ettevaatlikult röntgenoloogilise seadme juhetraadi valendikku.

- b) Lükake juhetraati ettevaatlikult edasi, kuni selle ots on röntgenoloogilise seadme otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
- c) Haarakke juhtekateeter ja sisestage röntgenoloogilise seadme süsteem (koos juhetraadiga) Y-konnektoris.
- d) Lükake röntgenoloogilise seadme süsteemi läbi juhtekateetri kuni juhetraadi süsteemi ots on juhtekateetri otsa suhtes täpselt proksimaalselt.
- e) Pinguldage Y-konnektori hemostaatilist klappi, et röntgenoloogilise seadme ümber tekiks tihend. Veenduge, et juhetraati saaks siiski liigutada.
- f) Kontrollige, et juhetraat liiguks sujuvalt.
- g) Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhetraadi külge.
- h) Lükake seda juhetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogilisel kontrollil edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.
- i) Jälgige juhetraadi liikumist veresoones.
- j) Lükake röntgenoloogilist seadet edasi kuni kahjustuseni ja hoidke samas juhetraati liikumatuna. Veenduge, et juhetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

ajal nähtav.

■ Kiire vahetamise süsteem

- a) Kinnitage juhtekateeter.
- b) Sisestage juhetraadi sisestaja juhtekateetri Y-konnektoris.
- c) Sisestage juhetraadi ots ettevaatlikult sisestajasse.
- d) Lükake röntgenoloogilisel kontrollil edasi juhetraati läbi juhtekateetri kuni juhetraadi ots on juhtekateetri otsaga täpselt proksimaalselt.
- e) Vajaduse korral kinnitage traadipööramise seade juhetraadi külge.
- f) Lükake juhetraati kahjustusest läbi minemiseks röntgenoloogilisel kontrollil edasi. Veenduge angiograafiliselt, et juhetraat oleks läbinud vastava kitsenenud kahjustuskolde.

g) Jälgige juhetraadi liikumist veresoones.

h) Eemaldage juhetraadi pööramise seade ja juhetraadi sisestaja.

i) Tuvastage juhetraadi olev röntgenoloogiline seade, hoidke samas juhetraati liikumatuna, ja lükake edasi kuni kahjustuseni. Veenduge, et juhetraadi distaalne ots ja selle asukoht veresoones oleks röntgenoloogilise seadme kasutamise ajal nähtav.

4. Viisid juhetraadi vahetamiseks

■ Üle traadi süsteem

- a) Eemaldage see juhetraat aeglaselt ja jälgige samas juhetraadi liikumist röntgenoloogiliselt.
- b) Sisestage järgmine juhetraat vastavalt peatükis „Kasutamine“ toodud juhiste.

Hoiustamine

Ärge hoidke juhetraati ja pakendit painutatuna ega suure raskuse all. Juhetraati ja pakendit peab veest emal hoidma. Hoidke jahedas, pimedas ja kuivas kohas.

Aegumiskuupäev

Aegumiskuupäev on toodud juhetraadi pakendi etiketil.

Pakendi sisu

5 tükki karbis

Vastutusest loobumise säte

„ASAHI INTECC CO., LTD.“ ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi „ettevõtte“) ei vastuta mingil viisil õnnetuste, vigastuste ega kõrvaltoimete eest, mille põhjuseks on toote sobimatu kasutamine või käesoleva juhendi eiramine. Mitte ühelgi juhul ei ole ettevõtte vastutav mis tahes kahjude eest, mis tulenevad kas i) toote (toodete) hoiustamisest pärast ettevõttepoolset tarnimist või ii) patsiente, operatsioonitehnikate või mis tahes muude meditsiiniliste tegevuste valikust toodet (tooteid) kasutava meditsiinasutuse poolt.

„SION“ ja „SUOH“ on ettevõtte ASAHI INTECC CO., LTD. registreeritud kaubamärgid Jaapanis ja teistes riikides.

* Otsa koormuse väärtused tähistavad keskmisi toote tehnilisi väärtusi, mis on mõõdetud standardse rahvusvahelise testimismeetodiga, mille kohaselt avaldatakse juhetraadi otsaga lesioonile jõudu.

PCI vadītājstīgu SION sērija

Lietošanas norādījumi

Pirms izmantot šos vadītājstīgu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus un ievērojiet Lietošanas norādījumos ietvertu sadaļu “Lietošanas indikācijas”, “Kontrindikācijas”, “Brīdinājumi”, “Piesardzības pasākumi” un “Kā lietot” informāciju. To neievērojot, var izraisīt sarežģījumus, tajā skaitā nopietnu pacienta savainojumus vai nāvi.

Ja lietotājs un/vai pacients uzzina par nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar vadītājstīgu, ziņojiet par šo faktu ražotājam un kompetentajai iestādei attiecīgajā dalībvalstī.

Šie Lietošanas norādījumi attiecas uz PCI vadītājstīgu SION sēriju. Detalizētu informāciju (vadītājstīgas garumu, starojumu neaizsargātās daļas garumu u. c.) skatiet izstrādājuma etiķetē.

Apraksts

PCI vadītājstīgu SION sērijā ietilpstošās vadītājstīgas ir izstrādātas kā vadītājstīgas ar mīkstu uzgali, lai samazinātu asinsvadu perforācijas risku, kad tā tiek turēta asinsvadā, jo vadītājstīgas ar cietu uzgali turēšana asinsvadā var izraisīt asinsvada perforāciju.

SION pamatstruktūra sastāv no koniskās stīgas serdes, divu veidu distālajiem tinumiem (ārējā tinuma un iekšējā tinuma) un drošības stīgas. Koniskā stīgas serde, tinumi un drošības stīga ir lodētas. Daļa ārējā tinuma ir rentgenkontrastējosa, lai tā novietojumu varētu viegli apstiprināt rentgenoskopijas kontrolē. Lai nodrošinātu drošību asinsvadā, SION elastīgā uzgala slodze ir 0,7 gf*. Iekšējais tinums, kas izgatavots no auklas, ir ievietots ārējā tinumā, un drošības stīga ir savienota ar iekšējo tinumu un uzgali, lai drošības stīga neatdalītos pat mazticamajā gadījumā, ja koniskā stīgas serde atdalītos no gala, novēršot ārējā tinuma un koniskās stīgas atdalīšanos. SION distālā puse ir pārklāta ar hidrofilu polimēru.

SION Blue ir tāda pati pamatkonstrukcija kā SION, bet daļa no ārējā tinuma uzgala pārklājuma ir silikona pārklājums, kas padara uzgali elastīgāku nekā SION vadītājstīgām, un uzgala slodze ir 0,5 gf*.

SION Blue ES distālās puses pamatkonstrukcija ir tāda pati kā SION Blue pamatkonstrukcija, un uzgala slodze ir 0,5 gf *, bet ārējā tinuma garums ir mazāks un vārpstas stingrums ir lielāks. Iekšējā konstrukcijā nav iekšējās drošības stīgas, bet koniskās stīgas serdes distālā konstrukcija ir izstrādāta tā, lai vadītājstīgas proksimālā puse nevarētu viegli izkustēties no vietas. Tāpat kā SION Bue gadījumā, SION Blue ES pārklājums ir silikona pārklājums distālajā daļā un hidrofilis pārklājums proksimālajā daļā, un tās hidrofilā pārklājuma garums ir lielāks nekā SION Blue hidrofilā pārklājuma garums.

SION Black atšķiras no SION un SION Blue ar to, ka tai ir poliuretāna sveķu pārklājums uz ārējā tinuma un hidrofilis pārklājums virs tā. Uzgala slodze ir 0,8 gf*.

SUOH 03 pamatkonstrukcija ir tāda pati kā SION Blue un SION Blue ES pamatkonstrukcija, bet tajā ir izmantojums no auklas izgatavots ārējais tinums, kā rezultātā tiek iegūta zemākā uzgala slodze SION sērijā — 0,3 gf*. Distālā virsma ir pārklāta ar hidrofilu pārklājumu.

Visās PCI vadītājstīgu SION sērijās koniskās stīgas serdes proksimālā puse ir pārklāta ar PTFE (politetrafluoretilēnu). Izstrādājuma nominālais ārējais diametrs visā tā garumā ir 0,36 mm (0,014 collas). Ierīces, kas ir īsāka par 300 cm, proksimālajā galā ir savienojuma vieta stīgas pagarinājumam, kas tiek izmantots, lai aizstātu kombinēto ierīci. Šajā vietā var pievienot ASAHI INTECC stīgas pagarinājumu.

	Uzgala slodze*	Ārējais diametrs	Pārklājuma garums	Tinuma garums	Rentgenkontrastējosa daļas garums
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilais pārklājums : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION Blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikona pārklājums : 1,5 cm Hidrofilais pārklājums : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION Blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikona pārklājums : 2,5 cm Hidrofilais pārklājums : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION Black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Poliuretāna pārklājums : 20,0 cm Hidrofilais pārklājums : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilais pārklājums : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Lietošanas indikācijas

Šo vadītājstīgu ir paredzēts izmantot vispārīgās perkutānās koronārās intervences (PCI) procedūrās. Šī vadītājstīga ir paredzēta, lai atvieglotu balondilatācijas katetru vai citu invazīvu terapeitisko ierīču ieviešanu sirds un asinsvadu sistēmā. Paredzamais vidējais lietošanas ilgums ir 120 minūtes.

Vadītājstīgu nav paredzēts izmantot neirovaskulārās un perifēro asinsvadu procedūrās.

Ārstējamā mērķa populācija

PCI vadītājstīgu SION sērija ir paredzēta pacientiem, kuri atbilst PCI procedūru indikācijām. Tā nav indicēta lietošanai jaundzimušajiem, zīdaiņiem vai bērniem, kuri ir grūtnieces, kuriem ir nieru darbības traucējumi un kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu vai polietilēnglikolu (PEG).

Kontrindikācijas

- Pirms faktiskās izmantošanas pārbaudiet vadītājstīgas diametra atbilstību citām ķirurģiskajām ierīcēm.
- Neizmantojiet šo vadītājstīgu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija pret kontrastvielu vai kuriem ir nieru darbības traucējumi.
- Šīs vadītājstīgas hidrofilajā pārklājumā ir savienojums PEG400. Nelietojiet vadītājstīgu pacientiem, kuriem ir alerģiska reakcija uz polietilēna glikolu (PEG).
- Neizmantojiet vadītājstīgu grūtniecēm vai pacientiem, kurām varētu būt iestājusies grūtniecība (rentgenstari var ietekmēt augli).
- Šī vadītājstīga jāizmanto iestādē, kur var tūlītīgi veikt ķirurģisku operāciju. Ja nav pieejama tūlītējās ķirurģiskas operācijas iespēja, launākajā gadījumā var tikt izraisīti dzīvībai bīstami notikumi.
- Šī vadītājstīga ir iepriekš sterilizēta ar etilēnoksidu gāzi (EOG) un paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantojiet nesterilizēti atkārtoti. Ja to izmanto atkārtoti vai atkārtoti sterilizē, šīs vadītājstīgas un iepakojuma veiktspēja vai kvalitāte var tikt apdraudēta, un pastāv komplikācijas, tostarp, infekcijas risks.

Brīdinājumi

- Šo vadītājstīgu drīkst lietot tikai ārsts, kas ir pilnībā apmācīts PCI.
- Nekad neizmantojiet vadītājstīgu kopā ar katetriem, kam ir metāla detaļas, kas var tieši saskarties ar šīs vadītājstīgas virsmu (piemēram, aterektomijas katetri, metāla dilatatori), metāla adatām vai metāla apvalka ievadītājiem.
- Vadītājstīgas lietošanas laikā pārbaudiet un uzraugiet tās uzgala kustību fluoroskopijas kontrolē. Nelietojiet tajās asinsvadu vietās, kuras netiek vizualizētas vai nevar vizualizēt.

- Nepievienojiet šo vadītājstīgu atvienojamiem stīgas pagarinājumiem, kas nav ASAHI INTECC ražojums. Neveiciet manipulācijas ar vadītājstīgu, kamēr ir pievienots atvienojamais

Piesardzības

- Nelietojiet vadītājstīgu pēc etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām. Izmetiet visas vadītājstīgas, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
- Vadītājstīgas ir traušli instrumenti, tāpēc ar tām jārikojas uzmanīgi.
- Ja iesaiņojums ir atvērts vai bojāts, nelietojiet šo vadītājstīgu. Neatveriet iesaiņojumu līdz pašai lietošanai. Pārviotiet un izmantojot vadītājstīgu, izmantojiet aseptisku tehniku.
- Vadītājstīgai vienmēr jābūt mitrai, lai novērstu tās hidrofilā pārklājuma bojājumus.
- Neslaukiet vadītājstīgu, izmantojot organisku šķidrumu, piemēram, alkoholu.
- Pēc lietošanas veiciet profilakses pasākumus, lai nepieļautu infekciju. Izmetiet vadītājstīgu un tās iepakojumu kā medicīnas atkritumus.
- Nekādā gadījumā nestumiet, negrieziet, neizvelciet un nespiediet šo vadītājstīgu, ja ir jūtama pretestība. Stumjot vai spiežot šo vadītājstīgu ar spēku, iespējama vadītājstīgas sabojāšana un/vai uzgaļa atdalīšanās, kā arī iespējami tieši asinsvadu bojājumi. To neievērojot, šai vadītājstīgai var rasties bojājumi. Ar fluoroskopijas palīdzību nosakiet pretestības cēloni un veiciet visas nepieciešamās korektīvās darbības.
- Vienmēr virziet vai izņemiet vadītājstīgas lēnām un uzmanīgi.
- Grozot šo vadītājstīgu asinsvadā, negroziet to nepārtraukti vienā virzienā. Griezt vadītājstīgu, grieziet to pamīšus pulksteņrādītāju kustīgas virzienā un pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Neveiciet vairāk nekā divus apgriezienus (720°) vienā virzienā.
- Neņemot un no jauna ievietojot vadītājstīgu, noskalojiet to ar sterilizētu heparinizētu fizioloģisko šķidrumu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi ķirurģiskajā ierīcē. Uzmanīgi veiciet šīs vadītājstīgas nomaigu, lai nepieļautu gaisa iekļūvi un/vai traumas. Ievadot vadītājstīgu no jauna, pārliecinieties, vai ķirurģiskās ierīces gals ir brīvs asinsvada lūmenā un nepieskaras asinsvada sienai. To neievērojot, var izraisīt asinsvadu traumas. Lai apstiprinātu pozīciju, izmantojiet starojuma necaurlaidīgu ķirurģiskās ierīces marķieri.

- stīgas pagarinājums. Pretējā gadījumā var sabojāties vadītājstīga vai var netīšām atvienoties atvienojamais vadītājstīgas pagarinājums.
- Nekādā gadījumā nemodificējiet šo vadītājstīgu.

- Brīva vadītājstīgas kustība ķirurģiskajā ierīcē ir svarīga vadāmas vadītājstīgas sistēmas funkcija, jo lietotājam tā nodrošina vērtīgu taustes informāciju. Pirms lietošanas pārbaudiet sistēmu, vai nav nekādas pretestības. Ja konstatējat, ka hemostatiskais vārsts kavē vadītājstīgas kustību, koriģējiet to vai aizstājiet ar regulējamu vārstu.
- Neveiciet stenta ievietošanu, izmantojot vairāk nekā vienu vadītājstīgu vai asinsvada operāciju cauri stenta sienai. Pretējā gadījumā stents var tikt bojāts vai vadītājstīga var salūzt vai pārlūzt.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir izvēlēts procedūrai atbilstošs vadītājstīgas izmērs un forma un vai tā ir saderīga ar ierīci, ko paredzēts lietot kombinācijā ar šo vadītājstīgu.
- Skatiet lietošanas instrukciju, kas pievienota medicīnas ierīcei (piemēram, balona dilatācijas katetri vai citas iejaukšanās ierīces), ko paredzēts lietot kopā ar šo vadītājstīgu.
- Savienojot ar vadītājstīgu atvienojamo vadītājstīgas pagarinājumu, tas stingri jāievieto līdz robežlīnijai starp ne PTFE un PTFE pārklājumu vadītājstīgas proksimālajā galā. Ja savienojumā ir novērojama jebkāda problēma, nekavējoties pārtrauciet vadītājstīgas izmantošanu.
- Pirms lietošanas un procedūras veikšanas laikā (kad vien iespējams) uzmanīgi pārbaudiet vadītājstīgu, vai nav liekumu, mezglu vai citu bojājumu. Nelietojiet vadītājstīgu, ja tai ir bojājumi.
- Uzgaļa veidošanas laikā rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tīnumu.
- Pirms vadītājstīgas ievietošanas pārbaudiet, kurš ir distālais gals, un sāciet ievietošanu ar distālo galu.
- Procedūras laikā uzturiet nepārtrauktu skalošanu ar fizioloģisko šķidrumu starp virzītājkatetru un ķirurģisko ierīci, kā arī starp ķirurģisko ierīci un vadītājstīgu. Skalošana novērš kontrastvielas krāšanos un/vai recēšanu uz vadītājstīgas un katetra lūmenā.
- Ja turētājs ir aprīkots ar distālā uzgaļa aizsargcauruli (skatiet 1. attēlu sadaļā Lietošana), nenonemiet un neievietojiet distālā gala

- aizsargcauruli, kamēr vadītājstīga ir ievietota turētājā.
- Ja turētājs ir aprīkots ar distālā uzgaļa aizsargcauruli (skatiet 1. attēlu sadaļā Lietošana), nenemiet distālā uzgaļa aizsargcauruli, pirms vadītājstīga no jauna tiek ievietota turētājā.

- Šī ierīce satur tālāk norādīto vielu, kas definēta kā CMR 1A/1B viela un endokrīnais disruptors, kura koncentrācija pārsniedz 0,1 % masas procentu: kobalts, CAS Nr. 7440-48-4.

Darbības traucējumi un blakusparādības

Izmantojot šo vadītājstīgu, iespējamie darbības traucējumi un blakusparādības ietver, bet neaprobežojas ar tālāk norādītajiem.

1. Darbības traucējumi

Nespēja šķērsot bojājuma vietu	Vadītājstīgas salūšana vai saliekšanās	Bojājums, piemēram, atdalīšanās
Grūtības izņemt	Pārklājuma atdalīšanās	Bojātas vadītājstīgas fragmenti

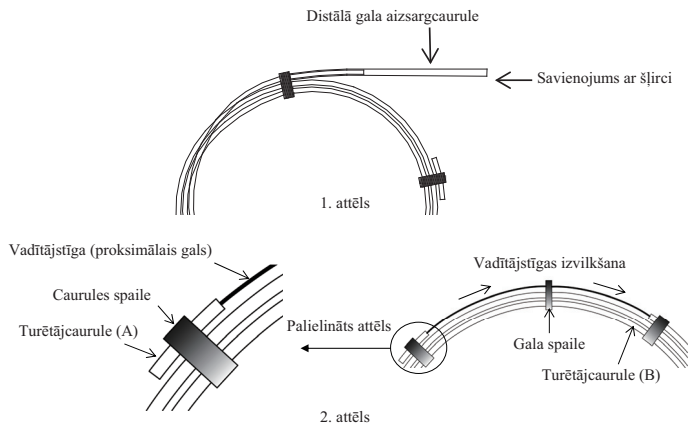
2. Blakusparādības

Nāve	Infekcija	Asinsvada disekcija
Asinsvada perforācija	Asiņošanas sarežģītījumi	Embolija
Trombi	Infarkts	Išēmija
Aritmija	Asinsvadu spazmas	Asinsvadu aizsprostojums
Asinsspiediena pazemināšanās	Alerģiska reakcija	

Lietošana

1. Pārbaude pirms lietošanas
 - a) Pirms lietošanas uzmanīgi pārbaudiet vadītājstīgu un iepakojumu un pārliecinieties, vai nav bojājumu.
 - b) Pirms lietošanas pārliecinieties, vai vadītājstīga ir saderīga ar izmantojamo ķirurģisko ierīci.
2. Sagatavošana
 - a) Izvēlieties attiecīgajai vietai vispiemērotāko vadītājstīgu un izņemiet no sterila iepakojuma turētājcauruli, kurā ir vadītājstīga.
 - b) Piepildiet turētājcauruli ar heparinizētu, sterilu fizioloģisko šķidrumu, izmantojot šļirci, lai samērētu visu ierīci. Ievērojiet, ka, to darot, no turētājcaurules var izlīst heparinizētais, sterila fizioloģiskais šķidums. Ja turētājam ir distālā gala aizsardzības caurulīte (1. attēls), pie tās var pievienot šļirci.
 - c) Pirms ievietojat vadītājstīgu, piepildiet ķirurģiskās ierīces lūmenu ar heparinū saturu sterilizētu fizioloģisko šķidrumu.
 - d) Atbrīvojiet vadītājstīgu no gala spaiļes un lēni

kustiniet vadītājstīgu, izstumiet vadītājstīgas distālo galu caur turētājcauruli (B) (2. attēls).



e) Kad vadītājstīgas distālais gals ir izvērsts 5–6 cm aiz turētājcaurules otra gala (vai distālā gala aizsargcaurules), ja nepieciešams, veidojiet uzgaļa formu atbilstoši standarta praksei.

f) Vadītājstīgu, kas tika izvērsta no turētājcaurules distālā gala (vai distālā gala aizsargcaurules), saudzīgi satveriet pēc iespējas tuvāk turētājcaurulei un lēnām un uzmanīgi izvelciet.

g) Ja, izņemot vadītājstīgu no turētājcaurules, jūtama pretestība, injicējiet turētājcaurulē no jauna heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģisko šķīdumu. Kad vairs nav jūtama pretestība, turpiniet vadītājstīgas izņemšanu. Noteikti injicējiet turētājcaurulē pietiekamu heparīnu saturošu sterilizētu fizioloģiskā šķīduma daudzumu, jo ar spēku noņemt pārklāto vadītājstīgu, var sabojāt hidrofilo pārklājumu.

h) Pēc vadītājstīgas izvilkšanas no turētājcaurules pārbaudiet to, lai pārliecinātos, vai nav bojājumu.

3. Ieviešanas procedūras

■ Stīgas sistēma

a) Uzmanīgi ievietojiet vadītājstīgas distālo galu ķirurģiskās ierīces vadītājstīgas lūmenā.

b) Uzmanīgi virziet šo vadītājstīgu, līdz tās gals ir tieši pie ķirurģiskās ierīces gala.

c) Izmantojiet virzītājkatetru un ievietojiet ķirurģiskās ierīces sistēmu (ar vadītājstīgu) Y veida savienotājā.

d) Virziet ķirurģiskās ierīces sistēmu caur virzītājkatetru, līdz vadītājstīgas sistēmas gals ir tieši pie virzītājkatetra gala.

e) Savelciet Y veida savienotāja hemostatisko vārstu, lai izveidotu ķirurģiskās ierīces izolāciju. Pārliecinieties, vai vadītājstīgas kustība netiek traucēta.

f) Pārbaudiet, vai vadītājstīgas kustība notiek bez aizķeršanās.

g) Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājstīgai pagriešanas ierīci.

h) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājstīga ir pārvirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.

i) Novērojiet vadītājstīgas virzību asinsvados.

j) Virziet ķirurģisko ierīci, līdz tiek sasniegts bojājums, vienlaikus nepieļaujot vadītājstīgas kustību. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājstīgas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

■ Straujas nomaiņas sistēma

a) Izmantojiet virzītājkatetru.

b) Ievietojiet vadītājstīgas ievadītāju virzītājkatetra Y veida savienotājā.

c) Uzmanīgi ievietojiet vadītājstīgas galu ievadītājā.

d) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu caur virzītājkatetru, līdz vadītājstīgas gals ir tieši pie virzītājkatetra gala.

e) Ja nepieciešams, pievienojiet vadītājstīgai pagriešanas ierīci.

f) Izmantojot fluoroskopiju, virziet vadītājstīgu, lai tā izietu cauri bojājumam. Izmantojot angiogrāfiju, pārliecinieties, vai vadītājstīga ir pārvirzīta garām sašaurinātajam mērķa bojājumam.

g) Novērojiet vadītājstīgas virzību asinsvados.

h) Izmēriet vadītājstīgas pagriešanas ierīci un vadītājstīgas ievadītāju.

i) Virziet ķirurģisko ierīci pa vadītājstīgu, vienlaikus nepieļaujot vadītājstīgas kustību, un virziet to, līdz tiek sasniegts bojājums. Nodrošiniet, lai, veicot manipulācijas ar ķirurģisko ierīci, būtu redzams vadītājstīgas distālais gals un tā atrašanās vieta asinsvadā.

4. Vadītājstīgas maiņas procedūras

■ Stīgas sistēma

a) Izmēriet vadītājstīgu lēni, vienlaikus novērojot tās kustību ar fluoroskopijas palīdzību.

b) Ievietojiet nākamo vadītājstīgu atbilstoši norādījumiem šajā sadaļā “Lietošana”.

Uzglabāšanas metode

Neglabājiet vadītājstīgu un iesaiņojumu saliektā un/vai noslogotā stāvoklī. Šī vadītājstīga un iesaiņojums jāsgargā no ūdens. Glabājiet tos vēsā, tumšā un sausā vietā.

Derīguma termiņš

Derīguma termiņš norādīts uz vadītājstīgas iesaiņojuma etiķetes.

Saturs

5 gabali/kaste

Saistību atruna

“ASAHI INTECC CO., LTD. un tā filiāles” (tālāk tekstā — “Uzņēmums”) nekādā gadījumā neatbild par negadījumiem, personāla traumām un blakusparādībām, kas radušās, nepareizi vai jebkā citādi šiem norādījumiem neatbilstoši lietojot produktu(s). Uzņēmums nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem bojājumiem, kas (i) rodas, produktu(-s) glabājot pēc nosūtīšanas no Uzņēmuma, vai (ii) rodas, medicīnas iestādei, kura izmanto produktu(-s), izvēloties pacientus, ķirurģiskās iejaukšanās pagēmienu vai jebkādas citas medicīniskas darbības.

“SION” un “SUOH” ir uzņēmuma “ASAHI INTECC CO.,LTD.” reģistrēta preču zīme Japānā un citās valstīs.

*Uzgaļa slodzes vērtības atspoguļo produkta specifikācijas vērtību vidējās vērtības, kas izmērītas saskaņā ar iekšējo standarta testēšanas metodi, nosakot spēku, ar kādu vadstīgas uzgali iedarbojas uz bojājumu.

PKI kreipiamoji viela SION serija

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami šią kreipiamąją vielą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykitės šios naudojimo instrukcijos skyriuose „Naudojimo indikacijos“, „Kontraindikacijos“, „Įspėjimai“, „Atsargumo priemonės“ ir „Kaip naudoti“ pateiktų nurodymų. To nepadarius gali kilti komplikacijų, įskaitant sunkius paciento sužalojimus arba mirtį.

Jei naudotojas ir (arba) pacientas sužino apie rimtą incidentą, susijusį su kreipiamąja viela, jie turi pranešti apie tai gamintojui ir kompetentingai šalies narės institucijai.

Ši naudojimo instrukcija taikoma SION serijos PKI kreipiamajai vielai. Išsamios informacijos (kreipiamosios vielos ilgis, rentgenokontrastinės dalies ilgis ir t. t.) ieškokite gaminio etiketėje.

Aprašas

SION serijos PKI kreipiamoji viela buvo sukurta kaip kreipiamoji viela su minkštu galiuku, kad būtų sumažinta kraujagyslės perforacijos rizika, nes laikant vielą kietu galiuku kraujagyslėje gali įvykti kraujagyslės perforacija.

Pagrindinę SION konstrukciją sudaro kūginė pagrindinė viela, dviejų tipų distalinės ritės (išorinė ritė ir vidinė ritė) ir apsauginė viela. Kūginė pagrindinė viela, ritės ir apsauginė viela yra sulituotos. Dalis išorinės ritės ilgio yra rentgenokontrastinė, todėl atliekant rentgenoskopiją galima lengvai patvirtinti jos padėtį. SION turi lankstų galiuką, kurio apkrova yra 0,7 gf*, kad būtų užtikrintas saugumas kraujagyslėje. Vidinė ritė, pagaminta iš lino, yra išorinės ritės viduje, o apsauginė viela yra priklijuota prie vidinės ritės ir galiuko taip, kad apsauginė viela nenutrūktų (net jei kūginė pagrindinė viela nutrūksta nuo galiuko) ir apsaugotų išorinę ritę bei kūginę pagrindinę vielą nuo nutrūkimo. Distalinė SION pusė padengta hidrofiliniu polimeru.

„SION blue“ pagrindinė konstrukcija yra tokia pati kaip „SION“, tačiau dalis išorinio ritės galiuko dangos yra silikoningė, todėl galiukas yra lankstesnis nei „SION“, o galiuko apkrova yra 0,5 gf*.

Pagrindinė „SION blue ES“ distalinės pusės konstrukcija yra tokia pati kaip „SION blue“, o galiuko apkrova yra 0,5 gf*, tačiau jo išorinė ritė yra trumpesnė, o veleno standumas didesnis. Vidinėje konstrukcijoje nėra apsauginės vielos, tačiau distalinė kūginės pagrindinės vielos konstrukcija sukurta taip, kad proksimalinė kreipiamosios vielos pusė negalėtų lengvai išslysti. Kaip ir „SION blue“ atveju, „SION blue ES“ danga yra silikoninga distalinėje dalyje ir hidrofilinė danga proksimalinėje dalyje, o hidrofilinė danga yra ilgesnė nei „SION blue“.

„SION black“ skiriasi nuo SION ir „SION blue“ tuo, kad ant išorinės ritės yra poliuretano dervos danga, o ant jos – hidrofilinė danga. Galiuko apkrova yra 0,8 gf*.

Pagrindinė „SUOH 03“ konstrukcija yra tokia pati kaip „SION blue“ ir „SION blue ES“, tačiau joje naudojama išorinė ritė, pagaminta iš lino, todėl šio modelio galiuko apkrova yra mažiauusia visoje SION serijoje – 0,3 gf*. Distalinis paviršius padengtas hidrofiline danga.

Visų SION serijos PKI kreipiamųjų vielų proksimalinė kūginės pagrindinės vielos pusė yra padengta PTFE (politetrafluoretilenu). Nominalus išorinis gaminio skersmuo per visą ilgį yra 0,36 mm (0,014 colio). Proksimalinėmis prietaisais, trumpesnio nei 300 cm, gale yra jungtis, skirta ilginamajai vielai, kuri naudojama siekiant pakeisti sudėtinį prietaisą. Galima prijungti ASAHI INTECC ilginamąją vielą.

	Galiuko apkrova*	Išorinis skersmuo	Dangos ilgis	Ritės ilgis	Rentgenokontrastinis ilgis
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 col.)	Hidrofilinė danga: 28,5 cm	28 cm	3 cm
„SION blue“	0,5 gf	0,36 mm (0,014 col.)	Silikoningė danga: 1,5 cm Hidrofilinė danga: 19,0 cm	20 cm	3 cm
„SION blue ES“	0,5 gf	0,36 mm (0,014 col.)	Silikoningė danga: 2,5 cm Hidrofilinė danga: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
„SION black“	0,8 gf	0,36 mm (0,014 col.)	Poliuretano danga: 20,0 cm Hidrofilinė danga: 40,0 cm	12 cm	3 cm
„SUOH 03“	0,3 gf	0,36 mm (0,014 col.)	Hidrofilinė danga: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Naudojimo indikacijos

Ši kreipiamoji viela skirta bendrajai perkutaninei koronarinei intervencijai (PKI) atlikti. Ši kreipiamoji viela skirta balioninių dilatacinių kateterių ar kitų intervencinių gydymų prietaisų įvedimui į širdies ir kraujagyslių sistemą palengvinti. Vidutinė naudojimo trukmė turėtų būti 120 minučių.

Ši kreipiamoji viela neskirta naudoti neurovaskulinėse ir periferinėse kraujagyslėse.

Tikslinė gydymų asmenų grupė

SION serijos PKI kreipiamosios vielos skirtos pacientams, kurie atitinka perkutaninės koronarinės intervencijos (PKI) procedūrų indikacijas. Šio įtaiso negalima naudoti naujagimiams, kūdikiams ar vaikams, taip pat nėščioms pacientėms, pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi ir kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai ar polietilenglikoliui (PEG).

Kontraindikacijos

- Prieš naudodami patikrinkite kreipiamosios vielos skersmens suderinamumą su kitu intervenciniu prietaisu.
- Kreipiamosios vielos negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški kontrastinei medžiagai arba kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas.
- Šios kreipiamosios vielos hidrofilinėje dangoje yra PEG400. Nenaudokite kreipiamosios vielos pacientams, kurie yra alergiški polietilenglikoliui (PEG).
- Nenaudokite kreipiamosios vielos nėščioms arba galimai nėščioms pacientėms (rentgeno spinduliai gali paveikti vaisių).
- Ši kreipiamoji viela turi būti naudojama įstaigoje, kurioje nedelsiant galima atlikti neatidėliotą chirurginę operaciją. Jei neatidėliotinos chirurginės operacijos atlikti negalima, blogiausiu atveju gali įvykti gyvybei pavojingų įvykių.
- Ši kreipiamoji viela iš anksto sterilizuota etileno oksido dujomis (EOG) ir yra skirta naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite ir nesterilizuokite pakartotinai. Pakartotinai naudojant ar pakartotinai sterilizuojant šią kreipiamąją vielą gali pablogėti jos veikimas ar kokybė ir gali padidėti komplikacijų, įskaitant infekciją, rizika.

Įspėjimai

- Šią kreipiamąją vielą gali naudoti tik gydytojas, išmokytas atlikti PKI procedūras.
- Niekada nenaudokite šios kreipiamosios vielos su kateteriais, turinčiais metalinių dalių, kurios gali tiesiogiai liestis su šios kreipiamosios vielos paviršiumi (pvz., aterektomijos kateteriais, metaliniais plėtikliais), metalinėmis adatomis arba metaliniais apvalkalų įvedimo įtaisais.

- Naudodami kreipiamąją vielą tikrinkite ir stebėkite jos galiuko judėjimą fluoroskopu. Nenaudokite kraujagyslės srityse, kurios nėra arba negali būti atvaizduotos.
- Nejunkite šios kreipiamosios vielos prie nuimamų ilginamųjų vielų, kurias pagamino ne ASAHI INTECC. Nevadylkite šios

kreipiamosios vielos, kai prijungta nuimama ilginamoji vielą. Priešingu atveju galite sugadinti kreipiamąją vielą arba gali netyčia atsijungti nuimama ilginamoji vielą.

- Nmodifikuokite šios kreipiamosios vielos dėl bet kokios priežasties.

Atsargumo priemonės

- Nenaudokite kreipiamosios vielos pasibaigus etiketėje nurodytam galiojimo terminui. Išmeskite visas kreipiamasias vielas, kurių galiojimo terminas praėjęs.
- Kreipiamosios vielos yra jautrūs instrumentai ir su jomis reikia elgtis atsargiai.
- Jei pakuoatė atidaryta arba pažeista, kreipiamosios vielos nenaudokite. Pakuoatė atidarykite tik prieš pat naudojimą. Imdami ir naudodami kreipiamąją vielą, naudokite aseptinius metodus.
- Kreipiamąją vielą visada laikykite drėgnai, kad nepažeistumėte jos hidrofilinės dangos.
- Nevalykite kreipiamosios vielos organiniu tirpalu, pvz., alkoholiu.
- Panaudoję prietaisą imkitės prevencinių priemonių, kad užkirstumėte kelią infekcijai. Kreipiamąją vielą ir pakuoatę išmeskite kaip medicininės atliekas.
- Nebandykite stumti, sukti, ištraukinėti ir sukiooti kreipiamosios vielos, jeigu jaučiamas pasipriešinimas. Sukant ar stumiant per jėgą kyla gali būti pažeista kreipiamoji vielą ir (arba) gali atsirūkti jos galiukas, arba gali būti tiesiogiai pažeista kraujagyslė. Nesilaikydami šių nurodymų, galite sugadinti šią kreipiamąją vielą. Fluoroskopu nustatykite pasipriešinimo priežastį ir imkitės visų reikalingų taisomųjų veiksmų.
- Kreipiamąsias visas visada stumkite arba traukite lėtai ir atsargiai.
- Sukdami šią kreipiamąją vielą kraujagyslėje, nesukite jos pastoviai ta pačia kryptimi. Kai sukatę kreipiamąją vielą, pakaitomis sukatę prieš laikrodžio rodyklę ir pagal laikrodžio rodyklę. Nesukite daugiau nei du sukimus (720°) ta pačia kryptimi.
- Kreipiamąją vielą ištraukdami ir vėl įstatydami praplaukite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu arba kitu atitinkamu tirpalu, kad išvengtumėte oro patekimo į intervencinį prietaisą. Atsargiai pakeiskite šią kreipiamąją vielą, kad išvengtumėte oro patekimo ir (arba) traumos. Vėl kišdami kreipiamąją vielą įsitikinkite, kad intervencinio prietaiso galiukas

- kraujagyslės spindyje juda laisvai ir nėra prie kraujagyslės sienelės. Tuo nepadarę galite sukelti traumą. Padėtį patvirtinkite naudodamiesi intervencinio prietaiso rentgenokontrastiniais žymekliais.
- Tai, kad kreipiamoji vielą gali lengvai judėti intervenciniame prietaise, yra svarbi valdomosios kreipiamosios vielos sistemos savybė, nes suteikia naudotojui vertingos taktilinės informacijos. Prieš naudodami patikrinkite, ar sistemoje nėra pasipriešinimo. Sureguliuokite arba pakeiskite hemostazinį vožtuvą reguliuojamą vožtuvu, jei jis trukdo kreipiamąją vielą judėti.
 - Įvesdami stentą naudokite tik vieną kreipiamąją vielą ir nebandykite kišti vielos pro stento atramą. Priešingu atveju stentas gali būti pažeistas arba kreipiamoji vielą gali sulūžti arba perlūžti.
 - Prieš naudodami įsitikinkite, kad ši kreipiamoji vielą yra tinkamo dydžio ir formos, kad būtų galima atlikti procedūrą, ir yra suderinama su prietaisu, kuris bus naudojamas kartu.
 - Žr. prie medicinos priemonės (pvz., balioninių dilatacijos kateterių ar kitų intervencinių prietaisų), kuri bus naudojama kartu su šia kreipiamąją vielą, pridėtą naudojimo instrukciją.
 - Nuimamą ilginamąją vielą prijungiant prie šios kreipiamosios vielos, kreipiamąją vielą gali reikėti tvirtai įstatyti prie ribinės linijos tarp dangos be PTFE ir PTFE dangos proksimaliniame kreipiamosios vielos galiuke. Jei jungtyje aptinkama kokių nors anomalijų, nedelsdami nustokite naudoti kreipiamąją vielą.
 - Prieš naudodami ir, jei įmanoma, per procedūrą atidžiai patikrinkite, ar kreipiamoji vielą nėra sulenka, susisukusi ar kitaip pažeista. Nenaudokite kreipiamosios vielos, jei ji pažeista.
 - Formuodami galiuką būkite atsargūs, kad nepažeistumėte ritės.

- Prieš įvesdami kreipiamąją vielą patikrinkite, kuris galiukas yra distalinis, ir įsitikinkite, kad ją vedate pradėdami nuo distalinio galiuko.
- Per procedūrą užtikrinkite fiziologinio tirpalo leidimą tarp kreipiamosio kateterio ir intervencinio prietaiso ir tarp intervencinio prietaiso ir kreipiamosios vielos. Fiziologinio tirpalo leidimas apsaugo nuo kontrastinės medžiagos susidarymo ir (arba) krešulių susidarymo ant kreipiamosios vielos ir kateterio spindžio.
- Jei naudojate laikiklį su distalinio galo apsauginiu vamzdeliu (žr. „Kaip naudoti“, 1

pav.), neišimkite ir neikiškite distalinio galo apsauginio vamzdelio, kol kreipiamoji vielą yra laikiklyje.

- Jei naudojate laikiklį su distalinio galo apsauginiu vamzdeliu (žr. „Kaip naudoti“, 1 pav.), prieš vėl įdėdami kreipiamąją vielą į laikiklį, išimkite distalinio galo apsauginį vamzdelį.
- Šiame prietaise yra toliau nurodytos medžiagos, kuri apibrėžiama kaip CMR 1A/1B ir kaip endokrininę sistemą ardanti medžiaga, kurios koncentracija viršija 0,1 % masės dalies; kobaltas: CAS Nr. 7440-48-4.

Sutrikimai ir nepageidaujami reiškiniai

Naudojant šią kreipiamąją vielą gali pasitaikyti toliau išvardytų sutrikimų ir nepageidaujamų reiškinių, tačiau šis sąrašas nėra išsamus.

1. Sutrikimai

Negebėjimas kirsti pažeidimo vietas	Kreipiamosios vielos lūžis arba sulinkimas	Pažeidimas, pavyzdžiui, atsiskyrimas
Sunku pašalinti	Dangos atsiskyrimas	Pažeistos kreipiamosios vielos nuolaužas

2. Nepageidaujami reiškiniai

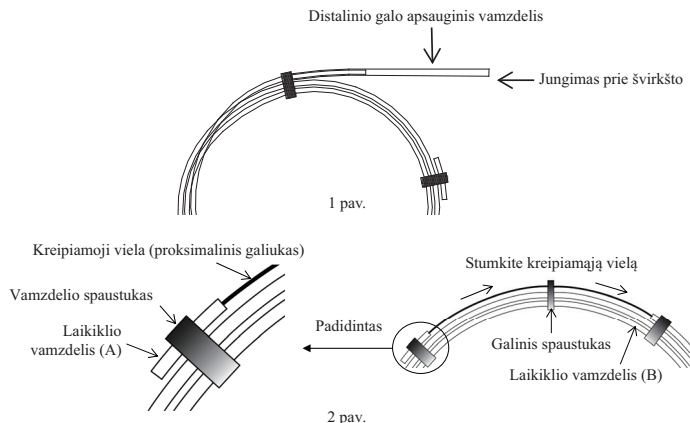
Mirtis	Infekcija	Kraujagyslės disekcija
Kraujagyslės perforacija	Komplikacijos dėl kraujavimo	Embolija
Trombas	Infarktas	Išemija
Aritmija	Vazospazmas	Kraujagyslių okliuzija
Sumažėjęs kraujo spaudimas	Alerginė reakcija	

Kaip naudoti

1. Apžiūra prieš naudojant
 - a) Prieš naudodami atidžiai apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad kreipiamoji vielą ir pakuoatę nepažeisti.
 - b) Prieš naudodami patikrinkite, ar kreipiamoji vielą yra suderinama su intervenciniu prietaisu, kurį planuojama naudoti.
2. Paruošimas
 - a) Pasirinkite pažeistai sričiai tinkamiausią kreipiamąją vielą ir iš sterilios pakuoatės išimkite laikiklio vamzdelį, kuriame yra kreipiamoji vielą.
 - b) Laikiklio vamzdelį švirkštu užpildykite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu

tirpalu, kad sudrėkintumėte visą prietaisą. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu heparinizuotas ir sterilizuotas fiziologinis tirpalas neišsilietų iš laikiklio vamzdelio. Laikikliui su distalinio galiuko apsaugos vamzdeliu (1 pav.) švirkštą galima sujungti su distalinio galiuko apsaugos vamzdeliu.

- c) Prieš įvesdami kreipiamąją vielą intervencinio prietaiso spindį užpildykite heparinizuotu ir sterilizuotu fiziologiniu tirpalu.
- d) Atjunkite kreipiamąją vielą nuo galinio spaustuvo ir lėtai slinkite kreipiamąją vielą, kreipiamosios vielos distalinį galą stumkite pro laikiklio vamzdelį (B) (2 pav.).



- e) Kai kreipiamosios vielos distalinis galas išlenda 5–6 cm pro kitą laikiklio vamzdelio galą (arba distalinio galo apsauginio vamzdelio galą), jei reikia, galiuką galite suformuoti įprastai.
- f) Švelniai suimkite kreipiamąją vielą, išlindusią pro distalinio galo laikiklio vamzdelį (arba distalinio galo apsauginį vamzdelį), kuo arčiau laikiklio vamzdelio, ir lėtai bei atsargiai ištraukite kreipiamąją vielą.
- g) Jeigu kreipiamąją vielą ištraukiant iš laikiklio vamzdelio juntamas pasipriešinimas, į laikiklio vamzdelį vėl suleiskite heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo. Kai nebejausite pasipriešinimo, toliau traukite kreipiamąją vielą. Būtinai į laikiklio vamzdelį suleiskite pakankamai heparinizuoto ir sterilizuoto fiziologinio tirpalo, nes stipriai traukiant kreipiamąją vielą su danga galima pažeisti hidrofilinę dangą.
- h) Ištraukę iš laikiklio vamzdelio kreipiamąją vielą, patikrinkite, ar ji nepažeista.

3. Įstatymo procedūros

■ „Over-the-wire“ sistema

- a) Atsargiai įstatykite distalinį kreipiamosios vielos galiuką į intervencinio prietaiso kreipiamosios vielos spindį.

- b) Stumkite kreipiamąją vielą, kol jos galiukas bus prie intervencinio prietaiso galiuko.
- c) Prijunkite kreipiamąjį kateterį į įstatykite intervencinio prietaiso sistemą (su kreipiamąja viela) į Y formos jungiamąją dalį.
- d) Stumkite intervencinio prietaiso sistemą pro kreipiamąjį kateterį, kol kreipiamosios vielos sistemos galiukas bus šalia kreipiamąjo kateterio galiuko.
- e) Užsukite Y formos jungiamosios dalies hemostazinį vožtuvą, kad intervencinis prietaisas būtų sandarus. Įsitinkite, kad kreipiamoji viela vis dar gali judėti.
- f) Patikrinkite, ar kreipiamoji viela sklandžiai juda.
- g) Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
- h) Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitinkinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią tikslinį pažeidimą.
- i) Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- j) Nejudindami kreipiamosios vielos, stumkite intervencinį prietaisą, kol pasieksite pažeidimo vietą. Įsitinkinkite, kad

kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

■ Greitojo pakeitimo sistema

- a) Prijunkite kreipiamąjį kateterį.
- b) Įstatykite kreipiamosios vielos stūmklį į kreipiamąjo kateterio Y formos jungiamąją dalį.
- c) Atsargiai įstumkite kreipiamosios vielos galiuką į stūmklį.
- d) Stumkite kreipiamąją vielą pro kreipiamąjį kateterį stebėdami fluoroskopu, kol kreipiamosios vielos galiukas atsidsurs šalia kreipiamąjo kateterio galiuko.
- e) Jei reikia, prie kreipiamosios vielos prijunkite sukimo prietaisą.
- f) Stebėdami fluoroskopu prakiškite kreipiamąją vielą pro pažeidimą. Naudodami angiografiją įsitinkinkite, kad kreipiamoji viela praėjo pro siauriausią

tikslinį pažeidimą.

- g) Stebėkite kreipiamosios vielos judėjimą kraujagyslėje.
- h) Nuimkite kreipiamosios vielos sukimo prietaisą ir kreipiamosios vielos stūmklį.
- i) Stumkite intervencinį prietaisą virš kreipiamosios vielos saugodami, kad kreipiamoji viela nejudėtų, kol bus pasiekta pažeidimas. Įsitinkinkite, kad kreipiamosios vielos distalinis galiukas ir jo padėtis kraujagyslėje yra matoma atliekant manipuliacijas intervenciniu prietaisu.

4. Kreipiamosios vielos pakeitimo procedūros

■ „Over-the-wire“ sistema

- a) Lėtai ištraukite kreipiamąją vielą stebėdami jos judėjimą fluoroskopu.
- b) Remdamiesi skyriuje „Kaip naudoti“ pateiktais nurodymais, įstatykite kitą kreipiamąją vielą.

Sandėliavimo būdas

Kreipiamosios vielos ir pakuotės nelaikykite sulenktų ir (arba) labai suspaustų. Šią kreipiamąją vielą ir pakuotę reikia laikyti atokiau nuo vandens. Laikykite vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.

Galiojimo terminas

Galiojimo terminas nurodytas kreipiamosios vielos pakuotės etiketėje.

Turiny

5 vienetai dėžutėje

Atsakomybės atsisakymas

Bendrovė ASAHI INTECC CO., LTD. ir su ja susijusios bendrovės (toliau – „Bendrovė“) nėra atsakingos už nelaimingus atsitikimus, kūno sužalojimus ar kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukėlė bet kokio gaminio (-ių) netinkamas naudojimas ar bet koks kitas naudojimas, kuris neatitinka šių nurodymų. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalą, kuri atsiranda dėl i) netinkamo gaminio (-ių) laikymo po įsigijimo iš Bendrovės dienos arba ii) dėl netinkamo sveikatos priežiūros įstaigos, kuri naudoja gaminį (-ius), pacientų, operacinių technikos ar medicininių procedūrų pasirinkimo.

„SION“ ir „SUOH“ yra ASAHI INTECC CO. „LTD. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Japonijoje ir kitose šalyse.

*Galiuko apkrovos vertės yra vidutinės gaminio specifikacijos vertės, išmatuotos pagal vidinį standartinį bandymų metodą, darant prielaidą, kad kreipiamosios vielos galiukas veikia pažeidimą jėga.

PCI Kılavuz Teli SION serisi

Kullanım Talimatları

Bu kılavuz teli kullanmadan önce Kullanım Talimatlarının Kullanım Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uyarıları, Kullanım Önemleri ve Kullanma Şekli bölümlerini dikkatle okuyun ve talimatlara uyun. Aksi durumda hastanın ciddi şekilde yaralanması veya ölümlü dâhil komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bir kullanıcı ve/veya hasta kılavuz teli ilgili ciddi bir olaydan haberdar olursa bu durumu üreticiye ve Üye Devletin yetkili makamına bildirsin.

Bu Kullanım Talimatları, PCI Kılavuz Teli SION serisi için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için (kılavuz tel uzunluğu, radyopak bölüm uzunluğu, vb.), ürün etiketine bakın.

Açıklamalar

PCI Kılavuz Teli SION serisi, damar içindeyken vasküler perforasyon riskinin azaltılmasını sağlamak için yumuşak uçlu bir kılavuz teli olarak geliştirilmiştir, aksi hâlde sert uçlu bir kılavuz teli damar içindeyken vasküler perforasyona neden olabilmektedir.

SION'un temel yapısı konik bir çekirdek tel, iki çeşit distal halka (bir dış halka ve bir iç halka) ve bir güvenlik telinden oluşur. Konik çekirdek tel, halkalar ve güvenlik teli lehimlidir. Dış halkanın bir kısmı radyopaktır, böylece radyoskopi ile yeri kolayca tespit edilebilir. SION, kan damarında güvenliği sağlamak için 0,7 gf* esnek uç yüküne sahiptir. Dış halkanın içine ipten yapılmış bir iç halka yerleştirilir ve güvenlik teli iç halkaya ve uca bağlanır, böylece konik çekirdekli telin uçtan çıkması gibi çok düşük olasılıklı bir durumda bile güvenlik teli çıkmaz ve dış halka ile konik çekirdek telin çıkmasını önler. SION'un distal tarafı hidrofilik polimer ile kaplıdır.

SION blue, SION ile aynı temel yapıya sahiptir ancak dış halka uçundaki kaplamanın bir kısmı silikon kaplamadır, bu sayede uç SION'a göre daha esnek hâle gelir ve uç yükü 0,5 gf*'dir.

SION blue ES'de distal tarafın temel yapısı, SION blue ile aynıdır ve uç yükü 0,5 gf*'dir ancak dış halka uzunluğu daha kısadır ve şaft sertliği daha fazladır. İç yapının içinde bir güvenlik teli yoktur ancak konik çekirdek telin distal tasarımı, kılavuz telin proksimal tarafının kolayca yerinden çıkamayacağı şekilde geliştirilmiştir. SION blue'da olduğu gibi, SION blue ES'nin kaplaması da distal tarafta silikon kaplama ve proksimal tarafta hidrofiliktir ve hidrofilik kaplama uzunluğu SION blue'dan daha uzundur.

SION black'te SION ve SION blue'dan farklı olarak dış halka üzerinde polietilen rezin kaplama ve bunun üzerinde bir hidrofilik kaplama bulunmaktadır. Uç yükü 0,8 gf*'dir.

SUOH 03'un temel yapısı SION blue ve SION blue ES ile aynıdır ancak ipten yapılmış bir dış halka içerir ve bu da 0,3 gf* ile SION serisindeki en hafif uç yükünün elde edilmesini sağlar. Distal yüzey, hidrofilik kaplama ile kaplıdır.

Tüm PCI Kılavuz Teli SION serisinde konik çekirdek telin proksimal tarafı PTFE (politetrafloroetilen) ile kaplıdır. Ürünün nominal dış çapı baştan sona tamamı boyunca 0,36 mm'dir (0,014 inç). Cihazların 300 cm'den kısa olan proksimal ucu, birleşik cihazı değiştirmek için kullanılan bir uzatma teli için bir bağlantı vardır; ASAHI INTECC'in Uzatma Teli bağlanabilir.

	Uç Yüğü*	Dış Çap	Kaplama Uzunluğu	Halka Uzunluğu	Radyopak Uzunluk
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014 inç)	Hidrofilik kaplama: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014 inç)	Silikon kaplama : 1,5 cm Hidrofilik kaplama: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014 inç)	Silikon kaplama : 2,5 cm Hidrofilik kaplama: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014 inç)	Poliüretan kaplama : 20,0 cm Hidrofilik kaplama: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014 inç)	Hidrofilik kaplama: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Kullanım Endikasyonları

Bu kılavuz tel, yaygın perkütan koroner girişimler (PCI) için tasarlanmıştır. Bu kılavuz teli, balon dilatasyon kateterlerinin veya diğer girişimsel terapötik cihazların kardiyovaskülatür içine yerleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ortalama kullanım süresi 120 dakika olarak öngörülmektedir. **Bu kılavuz tel nörovaskülatürde ve periferik vaskülatürde kullanım için tasarlanmamıştır.**

Tedaviye Yönelik Hedef Kitle

PCI Kılavuz Teli SION serisi, PCI prosedürlerine ilişkin endikasyonlara sahip hastalar için tasarlanmıştır. Yenidoganlarda, bebeklerde veya çocuklarda ve hamile olan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve kontrast maddelere veya polietilen glikole (PEG) karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanım için endike değildir.

Kontrendikasyonlar

- Gerçek kullanımdan önce kılavuz tel çapının diğer girişimsel cihazlarla uyumluluğunu onaylayın.
- Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gösteren veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Bu kılavuz tel, hidrofilik kaplamasında PEG400 içerir. Polietilen glikole (PEG) karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kılavuz teli kullanmayın.
- Kılavuz teli hamile hastalar veya hamile olma ihtimali olan hastalar için kullanmayın (Röntgen testü etkilenebilir).
- Bu kılavuz tel, acil cerrahi işlemlerin hemen gerçekleştirilebileceği bir tıbbi kurumda kullanılmalıdır. Bir acil cerrahi işlem yapılmazsa en kötü durumda yaşamı tehdit edici olaylar meydana gelebilir.
- Bu kılavuz tel, etilen oksit gazıyla (EOG) önceden sterilize edilmiştir ve yalnızca tek kullanımlıktır. Tekrar kullanmayın veya tekrar sterilize etmeyin. Tekrar kullanıldığında veya tekrar sterilize edildiğinde kılavuz telin ve paketin performansı veya kalitesi bozulabilir ve enfeksiyon dâhil komplikasyon riski oluşabilir.

Uyarılar

- Bu kılavuz tel, yalnızca PCI tedavisi konusunda tam eğitilmiş bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Bu kılavuz teli asla bu kılavuz telin yüzeyine doğrudan temas edilecek metal parçalarla sahip kateterler (ör. aterektomi kateterleri, metal dilatörler), metal iğneler veya metal kılıf yerleştiriciler ile birlikte kullanmayın.
- Kılavuz telin kullanımı sırasında ucunun hareketini floroskopi altında kontrol edin ve izleyin. Görselleştirilmemiş veya

görselleştirilemeyen damar bölgelerinde kullanımayın.

- Bu kılavuz teli, ASAHI INTECC dışındaki üreticilerin ürettiği ayrılabilir uzatma telleriyle bağlamayın. Bu kılavuz teli, ayrılabilir uzatma

- teli bağlarken hareket ettirmeyin. Aksi halde kılavuz teli hasar görebilir veya ayrılabilir uzatma teli kazara çıkabilir.
- Bu kılavuz tel üzerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapmayın.

Kullanım Önemleri

- Bu kılavuz teli etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmayın. Son kullanma tarihi geçmiş telleri atın.
- Kılavuz teller hassas aletlerdir ve dikkatle kullanılmalıdır.
- Ambalajı açılmış veya hasar görmüş kılavuz teli kullanmayın. Kullanımın hemen öncesine kadar ambalajı açmayın. Kılavuz teli taşırken ve kullanırken aseptik teknik kullanın.
- Hidrofilik kaplamanın zarar görmesini önlemek için kılavuz teli daima ıslak halde tutun.
- Bu kılavuz teli alkol gibi organik bir solüsyon kullanarak silmeyin.
- Kullanım sonrası enfeksiyona karşı önleyici tedbirleri alın. Bu kılavuz teli ve ambalajı tıbbi atık olarak bertaraf edin.
- Bu kılavuz teli direnç hissedilebilecek şekilde hiçbir zaman itmeyin, bükmeyin, geri çekmeyin veya bastırmayın. Bu kılavuz telin dirence karşı torklanması veya itilmesi, bu kılavuz telin hasar görmesine ve/veya ucunun ayrılmasına veya bir kaba doğrudan zarar vermesine neden olabilir. Bunun yapılmaması bu kılavuz telin hasar görmesine neden olabilir. Direncin nedenini floreskopik altında belirleyin ve durumu düzeltmek için gereken önlemleri alın.
- Kılavuz telleri daima yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerletin veya çekin.
- Bu kılavuz tele kan damarının içinde tork uygularken tork sürekli aynı yönde uygulamayın. Bu kılavuz tele tork uygularken teli sırayla saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürün. Kılavuz teli aynı yönde ikiden fazla kez (720°) döndürmeyin.
- Kılavuz teli çıkarırken veya yeniden takarken girişimsel cihaza hava girmesini önlemek için kılavuz teli heparinize salın veya uygun başka solüsyonla yıkayın. Hava girmesini ve/veya travma oluşmasını önlemek için bu kılavuz teli dikkatle değiştirin. Kılavuz teli yeniden yerleştirirken girişimsel cihazın ucunun damar lümeninin içinde serbest olduğunu ve damar duvarına yaslanmadığını teyit edin. Bunun yapılmaması travmaya neden olabilir. Konumu

- doğrulamak için girişimsel cihazın radyopak işaretçiyi kullanın.
- Kılavuz telin girişimsel cihazın içerisinde serbest hareket etmesi, yönlendirilebilir bir kılavuz tel sisteminin önemli bir özelliğidir, çünkü bu, kullanıcıya değerli dokunma bilgileri verir. Sistemi kullanmadan önce direnç olup olmadığını test edin. Kılavuz telin hareketini engellediği görülüyorsa hemostaz valfini ayarlayın veya ayarlanabilir bir valfle değiştirin.
- Birden fazla kılavuz tel kullanarak veya stent desteği aracılığıyla teli kullanarak stent yerleştirmeyin. Aksi durumda stent hasar görebilir, kılavuz tel kopabilir veya kırılabilir.
- Kullanmadan önce, bu kılavuz telin boyut ve şekil olarak prosedür için uygun olduğunu ve birlikte kullanılacak cihazla uyumlu olduğunu onaylayın.
- Bu kılavuz tel ile birlikte kullanılacak tıbbi cihaza (ör. balon dilatasyon kateterleri veya diğer girişimsel cihazlar) ekli Kullanım Talimatlarına bakın.
- Ayrılabilir uzatma telini bu kılavuz tele bağlarken ayrılabilir uzatma teli PTFE olmayan kaplama ve kılavuz telin proksimal undaki PTFE kaplama arasındaki sınır çizgisine güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bağlantıda herhangi bir anormallik tespit edilirse kılavuz teli kullanmayı derhal bırakın.
- Kullanmadan önce ve mümkün olduğu her durumda işlem sırasında kılavuz teli bükülmeler, kıvrılmalar ve başka hasarlar açısından dikkatle inceleyin. Kılavuz tel hasarlıysa kullanmayın.
- Ucu sekillendirirken bobine zarar vermeye dikkat edin.
- Kılavuz teli yerleştirmeden önce hangi ucun distal uç olduğunu kontrol edin ve distal uçtan yerleştirdiğinizden emin olun.
- İşlem sırasında kılavuz kateter ile girişimsel cihaz arasında ve girişimsel cihaz ile kılavuz tel arasında sürekli bir şekilde salın yıkama sağlayın. Yıkama, kılavuz tel üzerinde ve kateter lümeninde kontrast madde oluşumunu ve/veya pıhtılaşmayı önler.

- Distal uç koruma tüpüne sahip tutucu için (bkz. Kullanma Şekli, Şekil 1), kılavuz tel tutucu içindeyken distal uç koruma tüpünü çıkarmayın veya takmayın.
- Distal uç koruma tüpüne sahip tutucu için (bkz. Kullanma Şekli, Şekil 1), kılavuz tel tekrar

- tutucuya yerleştirmeden önce distal uç koruma tüpünü çıkarın.
- Bu cihaz, ağırlığına oranla %0,1'in üzerinde bir yoğunluğa sahip CMR 1A/1B ve endokrin bozucu madde olarak tanımlanan Kobalt: CAS No. 7440-48-4 maddesini içerir.

Arızalar ve Advers Olaylar

Bu kılavuz teli kullanırken ortaya çıkabilecek arızalar ve advers olaylar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler bulunmaktadır:

1. Arızalar

Bir lezyonu geçememek	Kılavuz telin kırılması veya bükülmesi	Ayrılma gibi hasarlar
Çıkarma işleminde güçlük	Kaplamanın çıkması	Hasarlı kılavuz telinden kaynaklı kalıntılar

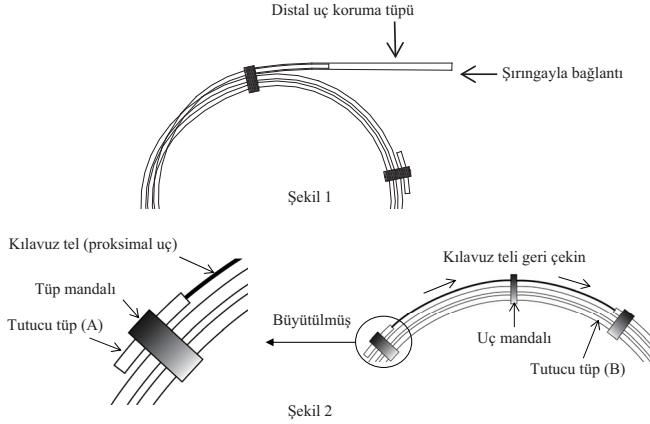
2. Advers olaylar

Ölüm	Enfeksiyon	Damar kesilmesi
Damar delinmesi	Kanamam komplikasyonları	Emboli
Trombüs	Enfarktüs	İskemik
Aritmi	Vazospazm	Damar tıkanıklığı
Kan basıncında azalma	Alerjik reaksiyon	

Kullanma Şekli

- Kullanım öncesi denetim
 - Kullanmadan önce, kılavuz telin ve ambalajının hasarsız olduğunu dikkatle inceleyin ve onaylayın.
 - Kullanmadan önce, kılavuz telin kullanılacak girişimsel cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Hazırlık
 - Etkilenen bölge için en uygun kılavuz teli seçin ve kılavuz teli içeren tutucu tüpü steril ambalajdan çıkarın.
 - Tüm cihazı ısıtmak için bir sırığa kullanarak tutucu tüpü heparinize ve sterilize salinle doldurun. Bu sırada tutucu tüpten heparinize ve sterilize salin dökülebileceğini unutmayın. Distal uç koruma tüpüne sahip tutucu için (Şekil 1), distal uç koruma tüpüne bir sırığa bağlanabilir.
 - Kılavuz teli yerleştirmeden önce, girişimsel cihazın lümenini heparinize ve sterilize salinle doldurun.

d) Kılavuz teli arkadaki mandaldan serbest bırakın ve kılavuz teli yavaşça kaydırarak kılavuz telin distal ucunu tutucu tüpten itin (B) (Şekil 2).



e) Kılavuz telin distal ucu, tutucu tüpün (veya distal uç koruma tüpü) diğer ucundan 5-6 cm uzaklıktaysa, gerektiği takdirde standart uygulamaya uygun şekilde ucu şekillendirin.

f) Tutucu tüpün (veya distal uç koruma tüpü) distal ucundan çıkan kılavuz telini hafifçe kavrayın, tutucu tüpe mümkün olduğunca yakın bir noktada kılavuz teli yavaş ve dikkatli şekilde dışarı çekin.

g) Kılavuz teli tutucu tüpten çıkarırken direnç hissederseniz, tutucu tüpe yeniden heparinize ve sterilize salın ekleyin. Direnç hissetmeyece kadar kılavuz teli çıkarmaya devam edin. Kaplamalı kılavuz tel kuvvetlice çıkarılırken hidrofilik kaplama hasar görebileceğinden, tutucu tüpe heparinize ve sterilize salın eklemeyi unutmayın.

h) Kılavuz teli tutucu tüpten çekip çıkardıktan sonra, hasar görmediğinden emin olmak için kılavuz teli inceleyin.

3. Yerleştirme işlemleri

■ Tel üzeri sistem

a) Kılavuz telin distal ucunu, girişimsel cihazın kılavuz tel lümeninin içine dikkatle yerleştirin.

b) Bu kılavuz teli, ucu girişimsel cihazın ucuna tam proksimal olana kadar dikkatle ilerletin.

c) Kılavuz kateter takın ve girişimsel cihaz sistemini (kılavuz telle birlikte) Y konektörüne yerleştirin.

d) Kılavuz tel sistemi kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar girişimsel cihaz sistemini kılavuz katetere ilerletin.

e) Y konektörünün hemostaz valfini sıkarak, girişimsel cihazın etrafından bir mühür oluşmasını sağlayın. Kılavuz telin halen hareket edebildiğinden emin olun.

f) Kılavuz telin pürüzsüz bir şekilde hareket ettiğini kontrol edin.

g) Gereirse tork cihazını kılavuz tele takın.

h) Bu kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.

i) Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.

j) Girişimsel cihazı, lezyona ulaşana kadar ilerletin ve bu sırada kılavuz telin hareket etmesini önleyin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

■ Hızlı değiştirme sistemi

a) Kılavuz kateteri takın.

b) Kılavuz tel yerleştiricisini kılavuz kateterin Y konektörüne yerleştirin.

c) Kılavuz telin ucunu yerleştiricinin içine dikkatle yerleştirin.

d) Kılavuz teli, kılavuz telin ucu kılavuz kateterin ucuna tam proksimal olana kadar kılavuz katetere floroskopi altında ilerletin.

e) Gereirse tork cihazını kılavuz tele takın.

f) Kılavuz teli, lezyondan geçene dek floroskopi altında ilerletin. Kılavuz telin hedef lezyonun dar bölümünden geçtiğini anjiyografiyle doğrulayın.

g) Kılavuz telin damarlardaki hareketini gözlemleyin.

h) Kılavuz tel tork cihazını ve kılavuz tel

yerleştiricisini çıkarın.

i) Kılavuz telin hareket etmesini önleyerek, girişimsel cihazı kılavuz telin üzerinden izleyin ve lezyona ulaşana kadar ilerletin. Kılavuz telin distal ucunun ve damardaki konumunun girişimsel cihazın kullanılması sırasında görünür olduğundan emin olun.

4. Kılavuz tel değiştirme işlemleri

■ Tel üzeri sistem

a) Bu kılavuz telin hareketini floroskopi altında gözlemleyerek bu kılavuz teli yavaşça çıkarın.

b) Sonraki kılavuz teli, bu “Kullanma şekli” bölümündeki talimatlara göre yerleştirin.

Saklama Biçimi

Kılavuz teli ve paketini bükülmüş ve/veya aşırı yüklü bir durumda muhafaza etmeyin. Bu kılavuz tel ve paket suyun dışında tutulmalıdır. Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklayın.

Son Kullanma Tarihi

Son kullanma tarihi, kılavuz tel ambalajının etiketinde gösterilmiştir.

Paket İçeriği

5 adet/kutu

Yükümlülük Feragati

“ASAHI INTECC CO., LTD. ve bağlı şirketleri” (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ürünün/ürünlerin hatalı kullanımından veya bu talimatlara uygun olmayan her türlü kullanımdan kaynaklanan kazalarda, bedensel yaralanmalarda ve advers olaylarda hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmez. Şirket, şu nedenlere bağlı olarak meydana gelen zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz: (i) Ürün veya ürünlerin şirket tarafından sevkiyatı tamamlandıktan sonraki saklama ve depolama koşullarına bağlı olarak meydana gelen zarar(lar) veya (ii) ürün veya ürünleri kullanan sağlık kuruluşunun hasta, cerrahi teknik ve diğer tıbbi cihazlara ilişkin seçimine bağlı olarak meydana gelen zarar(lar).

“SION” ve “SUOH”, ASahi INTECC CO., LTD.’nin Japonya’da ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

*Uç yükü değerleri, kılavuz telin ucu tarafından lezyona uygulanan kuvvet varsayılarak iç standart test yöntemiye göre ölçülen ürün spesifikasyon değerlerine ilişkin ortalama değerleri ifade eder.

Проволочный проводник для ЧКВ серии SION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием проволочного проводника внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по применению и придерживайтесь содержащихся в ней показаний к применению, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности, а также указаний в разделах процедуры применения. Несоблюдение этих требований может привести к осложнениям, включая серьезные травмы или смерть пациента.

Если пользователю и/или пациенту стало известно о серьезном происшествии, связанном с данным проволочным проводником, следует сообщить об этом производителю и в уполномоченную организацию государства-члена ЕС.

Данная инструкция по применению относится к проволочному проводнику для ЧКВ серии SION. Дополнительные сведения (длина проволочного проводника, рентгеноконтрастной части и т. д.) указаны на этикетке изделия.

Описание

Проволочный проводник для ЧКВ серии SION был разработан как проводник с мягким наконечником для снижения риска перфорации сосудов при удержании в сосуде, так как удержание в сосуде проводника с жестким наконечником может привести к перфорации сосудов.

Основная структура SION состоит из конического сердечника, двух типов дистальных спиралей (внешней и внутренней) и страховочной провода. Конический сердечник проводника, спирали и страховочный провод спаяны. Часть длины внешней спирали рентгеноконтрастна, поэтому ее положение можно легко подтвердить при рентгенокопии. SION имеет гибкий наконечник с нагрузкой 0,7 гс* для обеспечения безопасности в кровеносном сосуде. Внутренняя спираль из троса помещена внутрь внешней спирали, а страховочный провод прикреплен к внутренней спирали и наконечнику таким образом, что страховочный провод не отсоединится даже в том маловероятном случае, если конусный сердечник проводника оторвется от наконечника, предотвращая отсоединение внешней спирали и конусного сердечника. Дистальная сторона SION покрыта гидрофильным полимером.

SION blue имеет ту же основную структуру, что и SION, но часть покрытия на внешнем наконечнике спирали — силиконовое, что делает наконечник более гибким, чем у SION, а нагрузка на наконечник составляет 0,5 гс*.

Основная структура дистальной стороны SION blue ES такая же, как у SION blue, и нагрузка на наконечник составляет 0,5 гс*, но длина внешней спирали короче, а жесткость стержня выше. Внутренняя структура не имеет страховочного провода внутри, но дистальная конструкция конического сердечника разработана таким образом, чтобы проксимальная сторона проводника не могла легко сместиться. Как и в случае с SION blue, покрытие SION blue ES является силиконовым в дистальной части и гидрофильным в проксимальной, а длина гидрофильного покрытия больше, чем у SION blue.

SION black отличается от SION и SION blue тем, что имеет покрытие из полиуретановой смолы на внешней спирали и гидрофильное покрытие поверх него. Нагрузка на наконечник составляет 0,8 гс*.

Базовая структура SUON 03 такая же, как у SION blue и SION blue ES, но в ней используется внешняя спираль из веревки, благодаря чему нагрузка на наконечник самая низкая в серии SION - 0,3 гс*. Дистальная поверхность имеет гидрофильное покрытие.

Во всех сериях проволочный проводник для ЧКВ серии SION проксимальная сторона конического сердечника проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Номинальный внешний диаметр изделия составляет 0,36 мм (0,014 дюйма) по всей длине. На проксимальном конце устройства длиной менее 300 см имеется соединитель для удлинительного провода, который используется с целью замены комбинированного устройства. Можно подсоединить удлинитель ASAHI INTECC.

	Нагрузка на наконечник*	Внешний диаметр	Длина покрытия	Длина спирали	Длина рентгеноконтрастной части
SION	0,7 гс	0,36 мм (0,014 дюйм.)	Гидрофильное покрытие : 28,5 см	28 см	3 см
SION blue	0,5 гс	0,36 мм (0,014 дюйм.)	Силиконовое покрытие : 1,5 см Гидрофильное покрытие : 19,0 см	20 см	3 см
SION blue ES	0,5 гс	0,36 мм (0,014 дюйм.)	Силиконовое покрытие : 2,5 см Гидрофильное покрытие : 39,5 см	8,5 см	3 см
SION black	0,8 гс	0,36 мм (0,014 дюйм.)	Полууретановое покрытие : 20,0 см Гидрофильное покрытие : 40,0 см	12 см	3 см
SUON 03	0,3 гс	0,36 мм (0,014 дюйм.)	Гидрофильное покрытие : 52,0 см	19 см	3 см

Показания к применению

Данный проволочный проводник предназначен для общего чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Этот проволочный проводник предназначен для облегчения установки баллонных дилатационных катетеров или других интервенционных терапевтических устройств в сердечно-сосудистой системе. Средняя продолжительность использования составляет 120 минут. Данный проволочный проводник не предназначен для использования в нейрососудистой системе и периферической сосудистой сети.

Целевая группа пациентов

Проволочный проводник для ЧКВ серии SION предназначен для пациентов, отвечающих показаниям к процедуре ЧКВ. Он не показан для использования у новорожденных, младенцев и детей, а также у беременных, пациентов с нарушением функции почек и аллергической реакцией на контрастное вещество или полиэтиленгликоль (ПЭГ).

Противопоказания

- Перед использованием проверить соответствие диаметра проволочного проводника другому интервенционному устройству.
- Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергической реакцией на контрастное вещество или с нарушением функции почек.
- В гидрофильном покрытии данного проволочного проводника содержится ПЭГ400. Запрещается использовать проволочный проводник для пациентов с аллергическими реакциями на полиэтиленгликоль (ПЭГ).
- Запрещается использовать проволочный проводник для беременных пациенток или

пациентов, которые предположительно могут быть беременны (рентгеновское излучение может повлиять на плод).

- Данный проволочный проводник разрешается использовать только в тех учреждениях, где может быть выполнено неотложное хирургическое вмешательство. Если неотложное хирургическое вмешательство невозможно, то при самом худшем варианте развития событий могут возникнуть явления, представляющие угрозу жизни пациента.

Предупреждения

- Проволочный проводник должен использоваться только врачом, владеющим техникой выполнения ЧКВ.
- Запрещается использовать данный проволочный проводник в сочетании с катетерами, содержащими металлические детали, которые могут непосредственно соприкасаться с поверхностью проводника (например, катетеры для атерэктомии, металлические расширители), металлическими иглами или металлическими инструментами для введения интродьюсера.
- В процессе использования проволочного проводника проверяйте и контролируйте движение его наконечника посредством рентгеноскопии. Запрещается применение в

тех областях сосуда, которые не визуализированы или не могут быть визуализированы.

- Запрещается подсоединять к данному проволочному проводнику съемные удлинители проводника, изготовленные не компанией ASAHI INTECC. Запрещается производить манипуляции проволочным проводником с присоединенным съемным удлинителем проводника. В противном случае можно повредить проволочный проводник или случайно отделить съемный удлинитель проводника.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию проволочного проводника независимо от причин.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать проволочный проводник по истечении срока годности, указанного на этикетке. Если срок годности истек, утилизируйте проволочный проводник.
- В силу своей хрупкости проволочные проводники требуют осторожного обращения.
- Запрещается использовать проволочный проводник, если упаковка вскрыта или повреждена. Упаковку разрешается вскрывать только непосредственно перед использованием. При обращении с проволочным проводником и его использовании обязательно применение асептического способа.
- Чтобы не повредить гидрофильное покрытие проводника, постоянно держите его во влажном состоянии.
- Проволочный проводник перед отгрузкой стерилизуется этиленоксидом и предназначен только для одноразового использования. Запрещается повторное использование или стерилизация. Повторное использование или стерилизация могут отрицательно влиять на эксплуатационные характеристики и качество проволочного проводника и его упаковки, что сопряжено с риском осложнений, в частности инфекции.
- Запрещается протирать проволочный проводник органическим раствором, например, спиртом.
- После использования примите профилактические меры во избежание инфицирования. Утилизируйте проволочный проводник и его упаковку в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
- Запрещается прилагать силу при проталкивании, ввинчивании, извлечении или вращении проволочного проводника, если ощущается сопротивление. Вращение или проталкивание проволочного проводника при наличии сопротивления может привести к повреждению и/или отделению наконечника проволочного проводника или непосредственному повреждению сосуда. Невыполнение этого требования может привести к повреждению проволочного проводника. Определите причину

сопротивления с помощью рентгеноскопии и выполните соответствующие действия для исправления ситуации.

- Во всех случаях продвигайте или извлекайте проволочные проводники медленно и осторожно.
- Запрещается вращать проволочный проводник внутри кровеносного сосуда постоянно в одном направлении. При вращении проволочного проводника чередуйте повороты по часовой стрелке с поворотами против часовой стрелки. Запрещается делать более двух оборотов (720°) в одном направлении.
- В целях предотвращения попадания воздуха в интервенционное устройство промывайте проволочный проводник гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором или иным подходящим раствором при извлечении и повторном введении. При замене проволочного проводника проявляйте осторожность, чтобы не допустить попадания воздуха и/или нанесения травмы. При повторном введении проволочного проводника убедитесь, что наконечник интервенционного устройства свободно расположен в просвете сосуда и не упирается в ее стенку. Невыполнение этого требования может привести к травме. Для определения положения следите за рентгеноконтрастным маркером интервенционного устройства.
- Свободное движение проволочного проводника внутри интервенционного устройства является важной характеристикой системы управляемого проволочного проводника, дающей пользователю ценную осязательную информацию. Перед применением проверьте систему на наличие сопротивления. Если гемостатический клапан ограничивает движение проволочного проводника, то отрегулируйте его или замените на регулируемый клапан.
- Запрещается выполнять установку стента с помощью более чем одного проволочного проводника или перемещать проволочный проводник через каркас стента. В противном случае можно повредить стент, а также повредить или сломать проволочный проводник.
- Перед применением убедитесь, что размер и форма данного проволочного проводника

соответствуют проволочной процедуре, а также устройству, в сочетании с которым он будет использоваться.

- Ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к медицинскому изделию (например, к баллонным дилатационным катетерам или другим интервенционным устройствам), которое должно использоваться в сочетании с данным проволочным проводником.
- При подсоединении съемного удлинителя к проволочному проводнику следует надежно вставить его до граничной линии между покрытием не из ПТФЭ и покрытием из ПТФЭ на проксимальном конце проволочного проводника. Немедленно прекратите использование проволочного проводника при обнаружении каких-либо неисправностей в соединении.
- Перед использованием и по мере возможности во время проведения процедуры внимательно осматривайте проволочный проводник на предмет изгибов, перекручивания или иных повреждений. Запрещается использовать поврежденный проволочный проводник.
- Во время придания формы наконечнику будьте осторожны, чтобы не повредить спираль.
- Перед введением проволочного проводника проверьте, какой конец является дистальным и удостоверьтесь, что устройство вводится именно дистальным концом.
- При выполнении процедуры обеспечивайте постоянную промывку физиологическим раствором участка между проволочным катетером и интервенционным устройством, а также между интервенционным устройством и проволочным проводником. Промывка позволяет предотвратить образование и/или коагуляцию контрастного вещества на проводнике и в просвете катетера.
- Для держателя с защитной трубкой на дистальном конце (см. раздел «Процедура применения», рис. 1) не вынимайте и не вставляйте защитную трубку на дистальном конце, пока проводник находится в держателе.
- Для держателя с защитной трубкой на дистальном конце (см. раздел «Процедура применения», рис. 1), снимите защитную трубку на дистальном конце, прежде чем

снова помещать проволочный проводник в держатель.

- Данное устройство содержит следующее вещество, обозначенное как CMR 1A/1B, а

также вещество, нарушающее работу эндокринной системы, в концентрации более 0,1 % по массе; кобальт: CAS № 7440-48-4.

Неправильное функционирование и неблагоприятные явления

К возможным случаям неправильного функционирования и неблагоприятным явлениям для данного проволочного проводника относятся, в частности, следующие:

1. Неправильное функционирование

Невозможность пройти участок поражения	Повреждение или изгиб проволочного проводника	Повреждение, как например, отделение
Затруднение при извлечении	Отслоение покрытия	Обломки поврежденного направляющего проводника

2. Неблагоприятные явления

Смерть	Инфекция	Расщепление сосуда
Перфорация сосуда	Геморрагические осложнения	Эмболия
Тромб	Образование инфаркта	Ишемия
Аритмия	Спазм сосудов	Окклюзия сосудов
Снижение кровяного давления	Аллергическая реакция	

Процедура применения

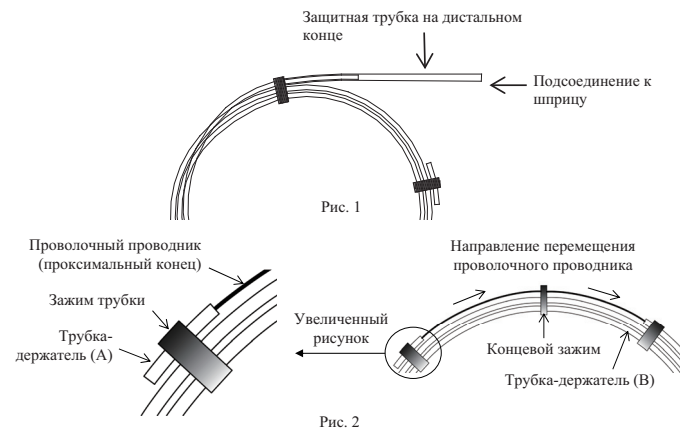
1. Осмотр перед использованием

- Перед использованием внимательно осмотрите и проверьте проволочный проводник и упаковку на предмет повреждений.
- Перед использованием убедитесь, что проволочный проводник совместим с используемым интервенционным устройством.

2. Подготовка

- Выберите проволочный проводник, наиболее подходящий для пораженного участка, и извлеките из стерильной упаковки трубку-держатель, в которой находится проволочный проводник.
- С помощью шприца полностью заполните трубку-держатель гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором для промывки всего устройства. Имейте в виду, что во время этой процедуры гепаринизированный и стерильный

- физиологический раствор может выливаться из трубки-держателя. В случае держателя с трубкой для защиты дистального конца (рис. 1), к трубке для защиты дистального конца можно подсоединить шприц.
- Перед введением проволочного проводника заполните просвет интервенционного устройства гепаринизированным и стерильным физиологическим раствором.
 - Извлеките проволочный проводник из зажима, затем медленно и плавно перемещайте проволочный проводник, проталкивая дистальный конец проволочного проводника через трубку-держатель (B) (рис. 2).



- Когда дистальный конец проволочного проводника выступит на 5–6 см за другой конец трубки-держателя (защитной трубки на дистальном конце), при необходимости придайте наконечнику форму в соответствии со стандартным методом.
- Осторожно захватите проволочный проводник, который выступил из трубки-держателя на дистальном конце (или защитной трубки на дистальном конце), как можно ближе к трубке-держателю и вытните проволочный проводник медленно и осторожно.
- Если при извлечении проволочного проводника из трубки-держателя чувствуется сопротивление, снова шприцом введите гепаринизированный и стерильный физиологический раствор в трубку-держатель. Продолжайте извлечение проволочного проводника, только если не будете чувствовать сопротивления при его перемещении. Убедитесь, что выписываете в трубку-держатель достаточное количество гепаринизированного и стерильного физиологического раствора, поскольку при извлечении проволочного проводника с усилением его гидрофильное покрытие может

- быть повреждено.
- После извлечения проволочного проводника из трубки-держателя осмотрите его на предмет повреждений.

3. Процедуры введения

- Система доставки по проводнику
- а) Осторожно вставьте дистальный конец проволочного проводника в просвет для проволочного проводника в интервенционном устройстве.
- б) Осторожно продвигайте проволочный проводник, пока его наконечник не окажется проксимальным к концу интервенционного устройства.
- в) Присоедините проводниковый катетер и вставьте систему интервенционного устройства (с проволочным проводником) в Y-образный соединитель.
- д) Продвигайте систему интервенционного устройства через проводниковый катетер, пока наконечник системы проволочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.
- е) Затяните гемостатический клапан Y-образного соединителя, чтобы создать герметичную среду вокруг интервенционного устройства.

- Убедитесь, что проволочный проводник все еще можно перемещать.
- f) Убедитесь, что проволочный проводник движется плавно.
- g) По мере необходимости присоедините к проволочному проводнику устройство для вращения.
- h) Под контролем рентгеноскопии продвигайте проволочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- i) Следите за продвижением проволочного проводника в сосудах.
- j) Продвигайте интервенционное устройство до участка поражения, предотвращая движение проволочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволочного проводника и его положение в сосуде.

■ Система быстрой замены

- a) Присоедините проводниковый катетер.
- b) Вставьте интродьюсер проволочного проводника в Y-образный соединитель проводникового катетера.
- c) Осторожно вставьте наконечник проволочного проводника в интродьюсер.
- d) Под контролем рентгеноскопии продвигайте проволочный проводник через проводниковый катетер, пока

наконечник проволочного проводника не окажется проксимальным к наконечнику проводникового катетера.

- e) По мере необходимости присоедините к проволочному проводнику устройство для вращения.
- f) Под контролем рентгеноскопии продвигайте проволочный проводник, пока он не пройдет участок поражения. С помощью ангиографии убедитесь, что проволочный проводник прошел суженный целевой участок поражения.
- g) Следите за продвижением проволочного проводника в сосудах.
- h) Извлеките устройство для вращения и интродьюсер проволочного проводника.
- i) Продвигайте интервенционное устройство по проволочному проводнику до участка поражения, предотвращая движение проволочного проводника. При манипулировании интервенционным устройством должны быть видны дистальный конец проволочного проводника и его положение в сосуде.

4. Процедура замены проволочного проводника

■ Система доставки по проводнику

- a) Медленно извлеките проволочный проводник, контролируя его перемещение с помощью рентгеноскопии.
- b) Согласно указаниям раздела «Процедура применения» вставьте следующий проволочный проводник.

неправильного использования изделия (изделий) или любого другого действия с нарушением требований этой инструкции. Компания ни при каких условиях не несет ответственность за какие-либо повреждения, (i) возникшие в результате хранения данного изделия (изделий) после доставки его Компанией или (ii) в связи с выбором медицинским учреждением, использующим данное изделие (изделия), определенных пациентов, методик операций или каких-либо других медицинских действий.

«SION» и «SUOH» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ASAHI INTECC CO.,LTD в Японии и других странах.

* Значения нагрузки на наконечник представляют собой средние значения технических характеристик продукта, измеренные в соответствии с методом испытаний по внутреннему стандарту с учетом силы, прилагаемой к очагу поражения наконечником проволочного проводника.

Условия хранения

Запрещается хранить проволочный проводник и его упаковку в изогнутом виде и/или подвергая их избыточной нагрузке. Запрещается хранить данный проволочный проводник и его упаковку вблизи воды. Храните их в прохладном, сухом и темном месте.

Срок годности

Срок годности изделия указан на этикетке на упаковке проволочного проводника.

Содержимое упаковки

5 шт. / коробка

Отказ от ответственности

Компания ASAHI INTECC CO., LTD и ее дочерние компании (в дальнейшем вместе именуемые «Компания») никоим образом не несут ответственности за несчастные случаи, травмирование персонала и неблагоприятные явления, произошедшие вследствие

Водач за PCI серия SION

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този водач и спазвайте разделите Показания за употреба, Противопоказания, Предупреждения, Предпазни мерки и Как да използвате в тези Инструкции за употреба. Непазването на тези инструкции може да доведе до усложнения, включително сериозно нараняване на пациента или смърт.

Ако даден потребител и/или пациент разбере за сериозен инцидент, възникнал във връзка с водача, той следва да докладва този факт на производителя и компетентния орган на държавата членка.

Тези инструкции за употреба се отнасят за Водач за PCI серия SION. За подробности (дължина на водача, дължина на рентгеноконтрастната част и т.н.) направете справка с етикетата на продукта.

Описание

Водачът за PCI серия SION е разработен като управляем водач с мек връх, за да се намали рискът от съдова перфорация, когато се държи в съд, тъй като задържането на водач с твърд връх в съд може да доведе до съдова перфорация.

Основната структура на SION се състои от конусовидна сърцевина на проводника, два вида дистални намотки (външна намотка и вътрешна намотка) и предпазен водач. Конусовидната сърцевина на проводника, намотките и предпазният водач са запоени. Една част от дължината на външната намотка е рентгеноконтрастна, така че нейната позиция може лесно да бъде потвърдена при рентгеноскопия. SION изпитва натоварване на гъвкавия връх от 0,7 gf*, за да се гарантира безопасност в кръвоносния съд. Вътрешна намотка, направена от влакно, е поставена вътре във външната намотка, а предпазният водач е свързан към вътрешната намотка и върха, така че предпазният водач да не се отдели, дори в малко вероятния случай конусовидната сърцевина на проводника да се отдели от върха , предотвратявайки отделянето на външната намотка и конусовидната сърцевина на проводника. Дисталната страна на SION е покрита с хидрофилен полимер.

SION blue има същата основна структура като SION, но част от покритието на външния връх на намотката е силиконово покритие, което прави върха по-гъвкав от този на SION, а натоварването на върха е 0,5 gf*.

Основната структура на дисталната страна на SION blue ES е същата като тази на SION blue и натоварването на върха е 0,5 gf*, но дължината на външната намотка е по-къса и твърдостта на вала е по-голяма. Вътрешната структура няма предпазен водач вътре, но дисталният дизайн на конусовидната сърцевина на проводника е проектиран така, че проксималната страна на водача да не се измества лесно. Като при SION blue, покритието на SION blue ES е силиконово покритие в дисталната част и хидрофилно в проксималната част, а дължината на хидрофилното покритие е по-голяма от тази на SION blue.

SION black се различава от SION и SION blue по това, че има покритие от полиуретанова смола върху външната намотка и хидрофилно покритие отгоре. Натоварването на върха е 0,8 gf*.

Основната структура на SUOH 03 е същата като тази на SION blue и SION blue ES, но използва външна намотка, направена от влакно, което води до най-ниското натоварване на върха в серията SION от 0,3 gf*. Дисталната повърхност е покрита с хидрофилно покритие.

Във всички водачи за PCI серия SION, проксималната страна на конусовидната сърцевина на проводника е покрита с PTFE (политетрафлуороетилен). Номиналният външен диаметър на продукта е 0,36 мм (0,014 инча) по цялата дължина. В проксималния край на изделието, който е под 300 см, има връзка за удължител, който се използва за заместване на комбинираното изделие; Удължителът на ASAHI INTECC може да бъде свързан.

	Натоварване на върха*	Външен диаметър	Дължина на покритието	Дължина на намотката	Рентгеноконтрастна дължина
SION	0,7 gf	0,36 мм (0,014")	Хидрофилно покритие: 28,5 см	28 см	3 см
SION blue	0,5 gf	0,36 мм (0,014")	Силиконово покритие: 1,5 см Хидрофилно покритие: 19,0 см	20 см	3 см
SION blue ES	0,5 gf	0,36 мм (0,014")	Силиконово покритие: 2,5 см Хидрофилно покритие: 39,5 см	8,5 см	3 см
SION black	0,8 gf	0,36 мм (0,014")	Полиуретаново покритие : 20,0 см Хидрофилно покритие: 40,0 см	12 см	3 см
SUOH 03	0,3 gf	0,36 мм (0,014")	Хидрофилно покритие: 52,0 см	19 см	3 см

Инструкции за употреба

Този водач е предназначен за обща перкутанна коронарна интервенция (PCI). Този водач е предназначен да улесни поставянето на балонни дилатационни катетри или други интервенционални терапевтични устройства в сърдечно-съдовата система. Средната продължителност на използване се очаква да бъде 120 минути.

Този водач не е предназначен за използване в невровакулатурата и периферната васкулатура.

Целева популация, подлежаща на лечение

Водачът за PCI серия SION е предназначен за пациенти, които отговарят на показания за PCI процедури. Той не е предназначен за употреба при новородени, кърмачета или деца, както и пациенти, които са бременни, имат увредена бъбречна функция и които имат алергична реакция към контрастни вещества или полиетилен гликол (PEG).

Противопоказания

- Потвърдете съвместимостта на диаметъра на водача с друго интервенционално устройство преди реална употреба.
- Не използвайте водача при пациенти, които имат алергична реакция към контрастни вещества или които имат нарушена бъбречна функция.
- Този водач съдържа PEG400 в своето хидрофилно покритие. Не използвайте водача при пациенти, които имат алергични реакции към полиетилен гликол (PEG).
- Не използвайте водача при бременни пациентки или пациентки, които може да са бременни (рентгеновите лъчи могат да засегнат плода).
- Този водач трябва да се използва в здравно заведение, където може незабавно да бъде извършена спешна хирургична операция. Ако не е възможна спешна хирургична операция, в най-лошия случай може да настъпят животозастрашаващи събития.
- Този водач е подложен на предварителна газова стерилизация с етилен оксид (EOG) и е предназначен само за еднократна употреба. Не използвайте повторно или не стерилизирайте повторно. Ако се използва или стерилизира повторно, работата или качеството на този водач и опаковка могат да бъдат компрометирани и съществува риск от усложнения, включително инфекция.

Предупреждения

- Този водач трябва да се използва само от лекар, който е напълно обучен за лечение чрез RSI.
- Никога не използвайте този водач в комбинация с катетри, които имат метални части, които могат да влязат в директен контакт с повърхността на този водач (напр. катетри за атеректомия, метални дилататори), метални игли или изделия за поставяне на метални обвивки.
- По време на използване на водача проверявайте и наблюдавайте движението на

- върха му под флуороскопия. Не използвайте в тези части на съда, които не са или не могат да бъдат визуализирани.
- Не свързвайте този водач с подвижни удължители от производители, различни от ASAHI INTECC. Не манипулирайте този водач, докато подвижният удължител е свързан. В противен случай водачът може да се повреди или подвижният удължител може неволно да се откачи.
- Не модифицирайте този водач по каквато и да е причина.

Предпазни мерки

- Не използвайте водача след изтичане на срока на годност, посочен на етикета. Изхвърлете всеки водач с изтекъл срок на годност.
- Водачите са деликатни инструменти и с тях трябва да се работи внимателно.
- Ако опаковката е отворена или повредена, не използвайте водача. Отворете опаковката точно преди непосредствена употреба. Използвайте асептична техника при боравене и използване на водача.
- Винаги дръжте водача в мокро състояние, за да предотвратите повреда на хидрофилното му покритие.
- Не бършете този водач с органичен разтвор като спирт.
- Вземете превантивни мерки срещу инфекция след употреба. Изхвърлете този водач и опаковката като медицински отпадък.
- Никога не натискайте, не използвайте като свредло, не изтегляйте или не затягайте водач, който среща съпротивление. Затягането или натискането на този водач срещу съпротивление може да причини повреда и/или отделение на върха на водача, или директно увреждане на съд. Неспазването на това предупреждение може да причини повреда на този водач. Определете причината за резистентност под флуороскопия и извършете всички необходими коригиращи действия.
- Винаги придвижвайте напред или изтегляйте водачите бавно и внимателно.
- Когато затягате този водач вътре в кръвоносния съд, не затягайте непрекъснато в една и съща посока. Когато затягате водача,

- завъртете го последователно по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. Не правете повече от две завъртания (720°) в една и съща посока.
- Промийте водача с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор или друг подходящ разтвор, докато го изваждате и поставяте отново, за да предотвратите навлизането на въздух в интервенционалното устройство. Извършете внимателно смяната на този водач, за да предотвратите навлизане на въздух и/или нараняване. При повторно въвеждане на водача се уверете, че върхът на интервенционалното устройство е свободен в лумена на съда и не е срещу стената на съда. Ако не го направите, това може да доведе до травма. Използвайте рентгеноконтрастния маркер на интервенционалното устройство, за да потвърдите позицията.
- Свободното движение на водача в рамките на интервенционалното устройство е важна характеристика на системата с управляем водач, тъй като дава на потребителя ценна тактична информация. Тествайте системата за устойчивост преди употреба. Регулирайте или сменете хемостазната клапа с регулируема клапа, ако се установи, че въпрепятства движението на водача.
- Не извършвайте поставяне на стент, като използвате повече от един водач или операция с водач през опора на стент. В противен случай стентът може да се повреди или водачът да се счупи или да се разпадне.
- Преди употреба се уверете, че този водач е подходящ по размер и форма за процедурата

и е съвместим с изделието, което ще използвате в комбинация.

- Обърнете се към Инструкцията за употреба, приложена към медицинското изделие (напр. катетри за балонна дилатация или други интервенционални устройства), което ще се използва в комбинация с този водач.
- Когато свързвате подвижния удължител с този водач, той трябва да бъде здраво поставен в граничната линия между покритието без PTFE и покритието с PTFE в проксималния край на водача. Ако се открие някаква неизправност във връзката, незабавно спрете да използвате водача.
- Проверете внимателно водача за огъвания, прегъвания или други повреди преди употреба и когато е възможно по време на процедурата. Не използвайте водача, ако е повреден.
- Когато оформяте върха, внимавайте да не повредите намотката.
- Преди да въведете водача, проверете кой край е дисталният край и се уверете, че сте го поставили от дисталния край.

- Поддържайте непрекъснато промиване с физиологичен разтвор между водещия катетър и интервенционалното устройство и между интервенционалното устройство и водача по време на процедурата. Промиването предотвратява образуването на контрастна материя и/или съсирването върху водача и в лумена на катетъра.
- За държача със защитната тръба на дисталния край (вижте Как да използвате, Фигура 1), премахвайте и не поставяйте защитната тръба на дисталния край, докато водачът е поставен в държача.
- За държача със защитната тръба на дисталния край (вижте Как да използвате, Фигура 1), премахнете защитната тръба на дисталния край преди да поставите водача отново в държача.
- Това изделие съдържа следното вещество, определено като CMR 1A/1B и вещество, нарушаващо функционирането на ендокринната система, в концентрация над 0,1 % от теглото; Кобалт: CAS No. 7440-48-4.

Неизправности и нежелани събития

Възможните неизправности и нежелани събития при използването на този водач включват, но не се ограничават до следното:

1. Неизправности

Неуспех при преминаване на лезия	Счупване или огъване на водача	Повреда като отделение
Трудности при отстраняването	Отлепване от покритието	Парчета от повреден водач

Смърт	Инфекция	Дисекция на съда
Перфорация на съда	Усложнения, свързани с кръвене	Емболия
Тромб	Инфаркт	Ишемия
Аритмия	Вазоспазъм	Съдова оклузия
Спадане на кръвното налягане	Алергична реакция	

Как да използвате

1. Проверка преди употреба
 - а) Преди употреба проверете внимателно и се уверете, че водачът и опаковката не са повредени.

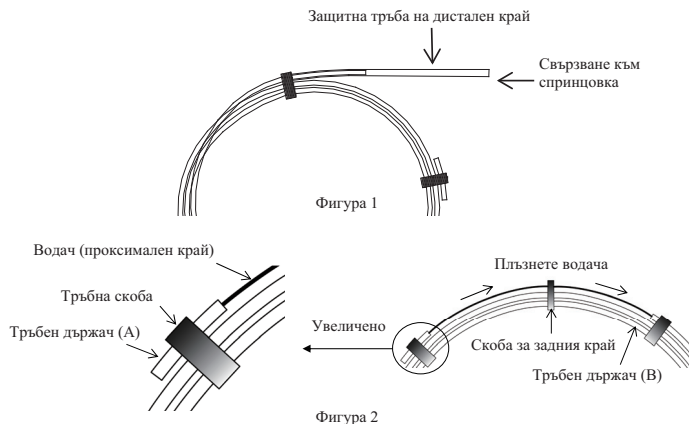
- б) Преди употреба потвърдете, че водачът е съвместим с интервенционалните устройства, които ще използвате.

2. Подготовка

- а) Изберете най-подходящия водач за засегнатата област и извадете тръбния държач, съдържащ водача, от стерилната опаковка.
- б) Напълнете тръбния държач с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор, като използвате спринцовка, за да намокрите цялото изделие. Обърнете внимание, че през това

време хепаринизираният и стерилизиран физиологичен разтвор може да се разлее от тръбния държач. При държача с дистална крайна защитна тръба (Фигура 1) може да се свърже спринцовка към дисталната крайна защитна тръба.

- с) Напълнете лумена на интервенционалното устройство с хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор, преди да поставите водача.
- д) Освободете водача от тръбния държач и го плъзнете бавно, бутнете дисталния край на водача през тръбния държач (В) (Фигура 2).



- е) Когато дисталният край на водача е удължен 5 до 6 см извън другия край на тръбния държач (или защитната тръба на дисталния край), ако е необходимо, оформете върха в съответствие със стандартната практика.
- ф) Внимателно хванете водача, който е излязъл от дисталния край на тръбния държач (или защитната тръба на дисталния край) в точката, която е възможно най-близо до тръбния държач, и издърпайте водача бавно и внимателно.
- г) Ако почувствате съпротивление при отстраняване на водача от тръбния държач,

инжектирайте отново хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач. Продължете да отстранявате водача, след като съпротивлението вече не се усеща. Уверете се, че сте инжектирали достатъчно хепаринизиран и стерилизиран физиологичен разтвор в тръбния държач, тъй като хидрофилното покритие може да се повреди при силно отстраняване на водача с покритие.

- h) След като издърпате водача от тръбния държач, проверете го, за да се уверите, че не е повреден.

3. Процедури по въвеждане

■ Система над проводника

- а) Вкарайте дисталния край на водача внимателно в лумена на водача на интервенционалното устройство.
- б) Внимателно придвижете напред този водач, докато върхът му е точно проксимално до върха на интервенционалното устройство.
- с) Захванете водещия катетър и поставете системата за интервенционалното устройство (с водач) в Y-образния конектор.
- д) Придвижете напред системата на интервенционалното устройство през водещия катетър, докато върхът на системата на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
- е) Затегнете хемостазната клапа на Y-образния конектор, за да създадете уплътнение около интервенционното устройство. Уверете се, че движението на водача все още е допустимо.
- ф) Проверете дали водачът се движи гладко.
- г) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- h) Придвижете напред този водач под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- и) Наблюдавайте движението на водача в съдовите.
- j) Придвижете напред интервенционалното устройство, докато се достигне лезията, като същевременно предотвратявате движението на водача. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с

интервенционалното устройство.

■ Система за бърз обмен

- а) Включете водещия катетър.
- б) Поставете интродюсера на водача в Y-образния конектор на водещия катетър.
- с) Внимателно поставете върха на водача в интродюсера.
- д) Придвижете напред водача през водещия катетър под флуороскопия, докато върхът на водача е точно проксимално до върха на водещия катетър.
- е) Прикрепете устройството за затягане към водача, ако е необходимо.
- ф) Придвижете напред водача под флуороскопия, за да премине през лезията. Потвърдете чрез ангиография, че водачът е преминал през стеснената целева лезия.
- г) Наблюдавайте движението на водача в съдовите.
- h) Отстранете устройството за затягане на водача и интродюсера на водача.
- и) Проследете интервенционалното устройство през водача, като същевременно предотвратявате движението на водача, и придвижете напред, докато се достигне лезията. Уверете се, че дисталният връх на водача и местоположението му в съда са видими по време на манипулации с интервенционалното устройство.

4. Процедури по смяна на водача

■ Система над проводника

- а) Отстранете този водач бавно, докато наблюдавате движението му под флуороскопия.
- б) Поставете следващия водач в съответствие с указанията в този раздел „Как да използвате“.

Начин на съхранение

Не дръжте водача и опаковката в огънато положение и/или в състояние под тежко натоварване. Този водач и опаковката трябва да се пазят от вода. Съхранявайте на хладно, тъмно и сухо място.

Срок на годност

Срокът на годност е посочен на етикета на опаковката на водача.

Съдържание

5 броя / купия

Отказ от отговорност

По никакъв начин „ASAHI INTECC CO., LTD. и неговите дъщерни дружества” (наричани по-нататък „Компанията”) не носят отговорност за злоупотреки, лични наранявания, нежелани събития, дължащи се на неправилна употреба на продукта(ите) или всяка друга употреба, несъвместима с тези инструкции. В никакъв случай Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети или (i) произтичащи от съхранението на продукта(ите) след изпращането от Компанията, или (ii) поради подбор на пациенти, хирургични техники или всякакви други медицински дейности от лечебното заведение, което използва продукта(ите).

„SION” и „SUOH” са търговски марки или регистрирани търговски марки на ASAHI INTECC CO., LTD. в Япония и други страни.

*Стойностите за натоварване на върха представляват средните стойности на стойностите на продуктовата спецификация, измерени съгласно вътрешния стандартен метод за изпитване, като се приема силата, приложена върху лезията от върха на водача.

PCI vodilica serije SION

Upute za uporabu

Prije uporabe ove vodilice pažljivo pročitajte i pridržavajte se odjeljaka Indikacije za uporabu, Kontraindikacije, Upozorenja, Mjere opreza i Kako se koristi u ovim Uputama za uporabu. Ako ih se ne budete pridržavali, može doći do komplikacija, uključujući ozbiljne ozljede pacijenta ili smrtnog ishoda.

Ako korisnik i/ili pacijent dođe do saznanja o ozbiljnoj nezgodi koja se javila vezano s ovom vodicom, prijavite tu činjenicu proizvođaču i nadležnom tijelu zemlje članice.

Ove upute za uporabu primjenjuju se na PCI vodicu serije SION. Za pojedinosti (duljina vodilice, duljina radionepropusnog dijela, itd.), pročitajte etiketu proizvoda.

Opis

PCI vodilica serije SION razvijena je kao vodilica s mekim vrhom koji služi za smanjenje rizika od perforacije vaskularnih organa kada se drži u žili, jer držanje vodilice s krutim vrhom u žili može rezultirati perforacijom u vaskularnom sustavu.

Osnovna struktura serije SION sastoji se od konusne žice s jezgrom, dvije vrste distalnih namotaja (vanjski namotaj i unutarnji namotaj) i sigurnosne žice. Konusna žica s jezgrom, namotaji i sigurnosna žica su zalemljeni. Djelomična duljina vanjskog namotaja je radionepropusna tako da se njegov položaj može lako potvrditi radioskopijom. SION ima opterećenje fleksibilnog vrha od 0,7 gf* kako bi se osigurala sigurnost u krvnoj žili. Unutarnji namotaj napravljen od užeta nalazi se unutar vanjskog namotaja, a sigurnosna žica je spojena na unutarnji namotaj i vrh tako da se sigurnosna žica ne bi odvojila, čak ni u malo vjerojatnom slučaju da se konusna žica s jezgrom odvoji od vrha, sprječavajući spadanje vanjskog namotaja i konusne žice s jezgrom. Distalna strana SION-a obložena je hidrofilnim polimerom.

SION blue ima istu osnovnu strukturu kao SION, ali dio obloga na vanjskom vrhu namotaja je silikonski oblog, što vrh čini fleksibilnijim od onog kod SION-a, a opterećenje vrha je 0,5 gf*.

Osnovna struktura distalne strane SION blue ES ista je kao i kod SION blue i opterećenje vrha je 0,5 gf*, ali je duljina vanjskog namotaja kraća, a krutost osovine veća. Unutarnja struktura nema unutarnju sigurnosnu žicu, ali je distalni dizajn konusne žice s jezgrom osmišljen tako da se proksimalna strana vodilice ne može lako pomjeriti. Kao i kod SION blue, oblog SION blue ES je silikonski oblog na distalnom dijelu i hidrofilan na proksimalnom dijelu, a duljina hidrofilnog obloga dulja je nego kod SION blue.

SION black razlikuje se od SION i SION blue po tome što ima oblog od poliuretanske smole na vanjskom namotaju, a povrh toga hidrofilni oblog. Opterećenje vrha je 0,8 gf*.

Osnovna struktura SUOH 03 ista je kao kod SION blue i SION blue ES, ali koristi vanjski namotaj napravljen od užeta, što rezultira najnižim opterećenjem vrha u seriji SION od 0,3 gf*. Distalna površina SION-a obložena je hidrofilnim oblogom.

U svim PCI vodicama serije SION, proksimalna strana konusne žice s jezgrom obložena je materijalom PTFE (politetrafluoretilen). Nominalni vanjski promjer proizvoda je 0,36 mm (0,014 inča) preko cijele duljine. Na proksimalnom kraju uređaja kraćih od 300 cm, nalazi se priključak za produžnu žicu, koja služi za zamjenu kombiniranog uređaja; moguće je spojiti produžnu žicu tvrtke ASAHI INTECC.

	Opterećenje vrha*	Vanjski promjer	Duljina obloga	Duljina namotaja	Duljina radionepropusnosti
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilni oblog: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonski oblog : 1,5 cm Hidrofilni oblog: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonski oblog : 2,5 cm Hidrofilni oblog: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Poliuretanski oblog : 20,0 cm Hidrofilni oblog: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilni oblog: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikacije za uporabu

Ova je vodilica namijenjena za opću perkutanu koronarnu intervenciju (PCI). Ova vodilica namijenjena je za olakšavanje plasiranja balon dilatacijskih katetera ili drugih intervencijskih terapijskih uređaja u kardiovaskularni sustav. Očekivana prosječna dužina uporabe je 120 minuta.

Ova vodilica nije namijenjena za uporabu u neurovaskularnom i perifernom vaskularnom sustavu.

Ciljana liječena populacija

PCI vodilica serije SION namijenjena je za pacijente koji imaju indikacije za PCI postupke. Nije indicirana za primjenu kod novorođenčadi, dojenčadi ili djece, kao ni kod pacijenata koje su trudne, pacijenata koji imaju oštećenu funkciju bubrega i koji imaju alergijsku reakciju na kontrastna sredstva ili polietilen glikol (PEG).

Kontraindikacije

- Potvrdite kompatibilnost promjera vodilice s drugim intervencijskim uređajem prije konkretne uporabe.
- Nemojte koristiti vodicu na pacijentima koji imaju alergijsku reakciju na kontrastne medije ili koji imaju poremećenu funkciju bubrega.
- Ova vodilica sadrži PEG400 u svojoj hidrofilnoj oblozi. Nemojte koristiti vodicu na pacijentima koji imaju alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Nemojte koristiti vodicu na trudnicama ili pacijenticama koje bi mogle biti trudne (rendgenske zrake mogu utjecati na fetus).
- Ova se vodilica mora se koristiti u ustanovi gdje se hitna kirurška operacija može obaviti odmah. Ako hitna kirurška operacija nije dostupna, u najgorem slučaju može doći do događaja opasnih po život.
- Ova vodilica prethodno je sterilizirana plinom etilen oksid (EOG) i namijenjena je samo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno koristiti ili ponovno sterilizirati. Ako se ponovno koristi ili ponovno sterilizira, učinkovitost ili kvaliteta ove vodilice i pakiranja može biti narušena i postoji rizik od komplikacija, uključujući infekciju.

Upozorenja

- Ovu vodicu smije koristiti samo liječnik koji je prošao kompletnu obuku za PCI tretman.
- Nikada ne koristite ovu vodicu u kombinaciji s kateterima s metalnim dijelovima koji mogu doći u izravan kontakt s površinom ove vodilice (npr. kateteri za aterektomiju, metalni dilatatori), metalnim iglama ili metalnim uvodnim ovojnicama.
- Za vrijeme korištenja vodilice, provjeravajte i pratite kretanje njenog vrha pod fluoroskopijom.

Nemojte koristiti u područjima žila koje nisu ili se ne mogu vizualizirati.

- Nemojte spajati vodilicu s odvojivim produžnim žicama, a koje je proizveo neki drugi proizvođač a ne ASAHI INTECC. Nemojte rukovati vodilicom dok je spojena odvojiva produžna žica.

Mjere opreza

- Nemojte koristiti vodilicu nakon isteka roka označenog na etiketi. Odbacite svaku vodilicu kojoj je istekao rok trajanja.
- Vodilice su osjetljivi instrumenti i njima se mora rukovati pažljivo.
- Ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno, nemojte koristiti vodilicu. Pakiranje otvorite isključivo neposredno prije uporabe. Pri rukovanju i korištenju vodilice koristite aseptičnu tehniku.
- Vodilica uvijek mora biti vlažna kako bi se spriječilo oštećenje njenog hidrofilnog obloga.
- Ne brišite vodilicu organskim rastvorima kao što je alkohol.
- Nakon uporabe poduzmite preventivne mjere protiv infekcije. Zbrinite vodilicu i pakiranje kao medicinski otpad.
- Nikada nemojte gurati, bušiti, povlačiti ili zatezati vodilicu koja nailazi na otpor. Zatezanje ili guranje vodilice protiv otpora može uzrokovati oštećenje i/ili odvajanje vrha vodilice ili izravnu štetu na žili. Ako se ne pridržavate ovih savjeta, može doći do oštećenja vodilice. Pod fluoroskopijom utvrdite uzrok otpora i poduzmite potrebne mjere za uklanjanje.
- Vodilice uvijek uvodite ili povlačite polako i pažljivo.
- Pri zakretanju vodilice unutar krvne žile, nemojte zakretati stalno u istom smjeru. Pri zakretanju vodilice, okrećite je naizmjenično u smjeru kazaljke i suprotno od smjera kazaljke na satu. Nemojte okretati više od dva okreta (720°) u istom pravcu.
- Vodilicu isperite hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom ili drugom prikladnom otopinom dok je uklanjate i ponovno uvodite, kako biste spriječili ulazak zraka u intervencijski uređaj. Pažljivo obavite zamjenu vodilice kako biste spriječili ulazak zraka i/ili ozljedu. Prilikom ponovnog uvođenja vodilice, uvjerite se da je vrh intervencijskog uređaja slobodan unutar lumena krvne žile i da nije prislonjen na stijenku žile. Ako ne postupite tako, moglo bi doći do ozljede. Za potvrdu položaja, koristite radionepropusni marker intervencijskog uređaja.

U suprotnom, vodilica se može oštetiti ili bi se odvojiva produžna žica mogla nenamjerno odvojiti.

- Ni iz kakvog razloga ne smijete obavljati preinake ove vodilice.

- Slobodno kretanje vodilice unutar intervencijskog uređaja važna je značajka upravljivog sustava žice za navođenje jer korisniku daje vrijedne taktične informacije. Prije korištenja ispitajte nailazi li sustav na bilo kakav otpor. Podesite ili zamijenite ventil za hemostazu podesivim ventilom ako se ustanovi da onemogućuje kretanje vodilice.
- Nemojte postavljati stent korištenjem više od jedne vodilice ili operaciju žice kroz mrežicu stenta. U suprotnom, stent se može oštetiti ili se vodilica može slomiti ili se raspasti.
- Prije uporabe, potvrdite da je vodilica odgovarajuće veličine i oblika za taj postupak i da je kompatibilna s uređajem s kojim će se koristiti.
- Pročitajte Upute za uporabu priložene uz medicinski uređaj (npr. balon dilatirajući kateteri ili drugi intervencijski uređaji) koji će se koristiti u kombinaciji s ovom vodilicom.
- Prilikom spajanja odvojive produžne žice s ovom vodilicom, treba je sigurno umetnuti u graničnu liniju između premaza koji nije PTFE i PTFE premaza na proksimalnom kraju vodilice. Ako se u spoju otkrije abnormalnost, odmah prestanite koristiti vodilicu.
- Prije korištenja i kad god je to moguće tijekom postupka, pažljivo pregledajte ima li vodilica savijena, usukana ili ima neko drugo oštećenje. Nemojte koristiti vodilicu ako je oštećena.
- Prilikom oblikovanja vrha, pazite da ne oštetite namotaj.
- Prije uvođenja vodilice, provjerite koji kraj je distalni kraj i osigurajte da ćete uvesti sa distalnog kraja.
- Održavajte kontinuirano ispiranje fiziološkom otopinom između katetera za navođenje i intervencijskog uređaja te između intervencijskog uređaja i vodilice tijekom postupka. Ispiranje sprječava stvaranje kontrastnog sredstva i/ili zgrušavanje na vodilici i u lumenu katetera.
- Za držač sa zaštitnom cijevi distalnog kraja (pogledajte Kako se koristi, Slika 1), nemojte

vaditi niti umetati zaštitnu cijev distalnog kraja dok je vodilica smještena u držač.

- Za držač sa zaštitnom cijevi distalnog kraja (pogledajte Kako se koristi, Slika 1) izvadite zaštitnu cijev distalnog kraja prije nego što se vodilica ponovo smjesti u držač.

- Proizvod sadrži sljedeću tvar definiranu kao CMR 1A/1B i endokrinu disruptivnu tvar u koncentraciji iznad 0,1 % masenog udjela; kobalt: CAS br. 7440-48-4.

Nepravilno funkcioniranje i štetni učinci

Moguće neispravno funkcioniranje i nuspojave zbog korištenja vodilice uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

1. Neispravno funkcioniranje

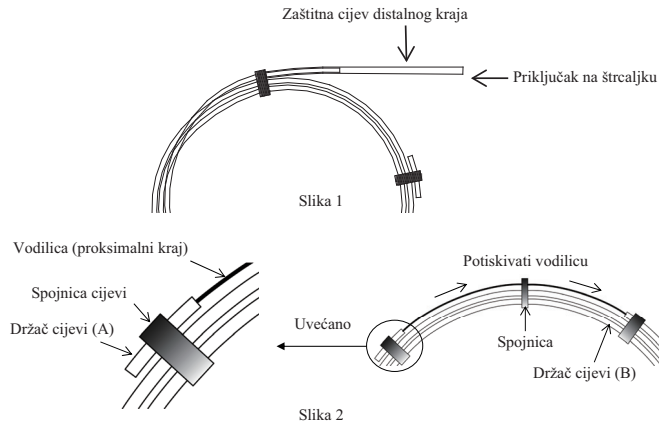
Nije prođeno kroz leziju	Prijelom ili savijanje vodilice	Oštećenje poput odvajanja
Poteškoće pri uklanjanju	Spadanje obloga	Talag sa oštećene vodilice

2. Štetni učinci

Smrt	Infekcija	Disekcija žile
Perforacija žile	Komplikacije krvarenja	Embolija
Tromb	Infarkcija	Ishemija
Aritmija	Vazospazam	Vaskularna okluzija
Snizavanje krvnog tlaka	Alergijska reakcija	

Kako se koristi

- Pregled prije uporabe
 - Prije uporabe, pažljivo pregledajte i potvrdite da su vodilica i pakiranje neoštećeni.
 - Prije uporabe, potvrdite da je vodilica kompatibilna s intervencijskim uređajima koji će se koristiti.
- Priprema
 - Izaberite najprikladniju vodilicu za zahvaćeno područje i uklonite držač cijevi u kojem je vodilica iz sterilnog pakiranja.
 - Napunite držač cijevi hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom pomoću štrcaljke kako biste natopili cijeli uređaj. Napominjemo da se heparinizirana i sterilizirana fiziološka otopina za to vrijeme može izliti iz držača cijevi. Za držač sa zaštitnom cijevi distalnog kraja (Slika 1), štrcaljka se može spojiti na zaštitnu cijev distalnog kraja.
 - Napunite lumen intervencijskog uređaja hepariniziranim i steriliziranim fiziološkom otopinom prije umetanja vodilice.
 - Otpustite vodilicu iz spojnice i lagano potiskujte vodilicu, gurnite distalni kraj vodilice kroz držač cijevi (B) (Slika 2).



- e) Kada se distalni kraj vodilice produži 5 do 6 cm izvan drugog kraja držača cijevi (ili zaštitne cijevi distalnog kraja), po potrebi oblikujte vrh u skladu sa standardnom praksom.
- f) Nježno uhvatite vodilicu koja je izašla iz držača distalnog kraja zaštitne cijevi distalnog kraja (ili zaštitne cijevi distalnog kraja), na mjestu što je moguće bliže držaču cijevi i polako i pažljivo izvlačite vodilicu.
- g) Ako osjetite otpor pri vađenju vodilice iz držača cijevi, ponovo ubrizgajte hepariniziranu i steriliziranu fiziološku otopinu u držač cijevi. Nastavite s vađenjem vodilice kada prestanete osjećati otpor. Obavezno ubrizgajte dovoljno heparinizirane i sterilizirane fiziološke otopine u držač cijevi jer se hidrofilni oblog može oštetiti prilikom nasilnog vađenja obložene vodilice.
- h) Nakon povlačenja vodilice iz držača cijevi, pregledajte ju kako biste se uvjerali da nije oštećena.

3. Postupci za uvođenje

- Sustav preko žice
 - a) Pažljivo umetnite distalni kraj vodilice u lumen vodilice intervencijskog uređaja.
 - b) Pažljivo uvodite vodilicu sve dok vrh ne

- bude proksimalan u odnosu na vrh intervencijskog uređaja.
- c) Zahvatite vodeći kateter i umetnite sustav intervencijskog uređaja (s vodilicom) u priključak Y.
- d) Uvodite sustav intervencijskog uređaja kroz vodeći kateter sve dok vrh sustava vodilice ne bude proksimalan u odnosu na vrh vodećeg katetera.
- e) Zategnite ventil za hemostazu priključka Y kako biste stvorili brtvu oko intervencijskog uređaja. Osigurajte da je pomicanje vodilice i dalje dopušteno.
- f) Provjerite kako biste osigurali glatko pomicanje vodilice.
- g) Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- h) Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- i) Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.
- j) Uvodite intervencijski uređaj dok ne dođe do lezije, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

■ Sustav brze zamjene

- a) Zahvatite vodeći kateter.
- b) Umetnite uvodnicu vodilice u priključak Y vodećeg katetera.
- c) Pažljivo umetnite vrh vodilice u uvodnicu.
- d) Uvodite vodilicu kroz vodeći kateter pod fluoroskopijom dok vrh vodilice ne bude proksimalan vrhu vodećeg katetera.
- e) Ako je potrebno, pričvrstite uređaj za zakretni moment na vodilicu.
- f) Uvodite vodilicu pod fluoroskopijom kako bi prošla kroz leziju. Angiografijom potvrdite da je vodilica prošla kroz suženu ciljnu leziju.
- g) Promatrajte pomicanje vodilice u žilama.

- h) Uklonite uređaj za zakretni moment vodilice i uvodnicu vodilice.
- i) Pratite intervencijski uređaj preko vodilice, istodobno sprječavajući pomicanje vodilice i uvođenje dok ne dođe do lezije. Osigurajte da su distalni vrh vodilice i njegova lokacija vidljivi tijekom manipulacije intervencijskim uređajem.

4. Postupci zamjene vodilice

- Sustav preko žice
 - a) Lagano vadite vodilicu dok nadzirete pomicanje ove vodilice pod fluoroskopijom.
 - b) Umetnite sljedeću vodilicu prema uputama iz dijela „Kako se koristi”.

Način skladištenja

Ne smijete čuvati vodilicu i pakiranje u savijenom i/ili pod teškim teretom. Vodilica i pakiranje moraju se čuvati dalje od vode. Čuvati na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Rok trajanja

Rok trajanja označen je na etiketi pakiranja vodilice.

Sadržaj

5 komada / kutija

Odricanje od odgovornosti

Ni u kojem slučaju „ASAHI INTECC CO., LTD. i njegove pridružene tvrtke” (u daljnjem tekstu „Tvrtka”) biti odgovorni za nezgode, osobne ozljede, štetne učinke uslijed bilo kakve nepravilne uporabe proizvoda ili bilo koje druge uporabe koja nije u skladu s ovim uputama. Ni u kojem slučaju Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (i) koja proizlazi iz skladištenja proizvoda nakon otpreme iz Tvrtke ili (ii) zbog odabira pacijenata, kirurških tehnika ili bilo koje druge medicinske aktivnosti od strane medicinske ustanove koja koristi proizvod(e).

„SION” i „SUOH” su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci ASAHI INTECC CO., LTD. u Japanu i drugim zemljama.

*Vrijednosti opterećenja vrha predstavljaju srednje vrijednosti od vrijednosti specifikacije proizvoda izmjerene u skladu s internom standardnom metodom ispitivanja uz pretpostavku sile koju na leziju primjenjuje vrh vodilice.

FIR DE GHIDAJ PCI Seria SION

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest fir de ghidaj și respectați secțiunile Indicații pentru utilizare, Contraindicații, Avertismente, Precauții și Modul de utilizare din aceste Instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la complicații, inclusiv la lezarea gravă a pacientului sau la deces.

În cazul în care un utilizator și/sau un pacient ia la cunoștință de un incident grav care a avut legătură cu firul de ghidaj, raportați acest lucru producătorului și autorității competente din statul membru.

Aceste Instrucțiuni de utilizare se aplică Firului de ghidaj PCI pentru intervenția coronariană percutanată din seria SION. Pentru detalii (lungimea firului de ghidaj, lungimea secțiunii radioopace etc.), a se consulta eticheta produsului.

Descrieri

Firul de ghidaj PCI din seria SION a fost conceput ca un fir de ghidaj cu vârf moale pentru a reduce riscul perforării vaselor atunci când străbate un vas, întrucât un fir de ghidaj cu vârful dur într-un vas poate duce la perforarea vaselor.

Structura de bază a seriei SION consistă dintr-un miez conic al firului, două tipuri de bobine distale (o bobină exterioră și una interioară) și un fir de siguranță. Miezul conic al firului, bobinele și firul de siguranță sunt lipite. Pe lungime, o porțiune din bobina exterioră este radioopacă, astfel încât poziția acesteia să poată fi confirmată sub radioscopie. SION are un vârf flexibil cu o grosime de 0,7 gf* pentru a asigura în interiorul vasului de sânge siguranță. O bobină interioară realizată din frânghie este plasată în interiorul bobinei exterioare, iar firul de siguranță este lipit de bobina interioară și de vârf, astfel încât firul de siguranță să nu se desprindă, chiar și în cazul improbabil în care miezul conic al firului se desprinde de vârf, împiedicând astfel desprinderea bobinei exterioare și a miezului conic al firului. Partea distală a SION este acoperită cu un polimer hidrofili.

SION blue are aceeași structură de bază ca și SION, dar o parte din stratul de acoperire de pe vârful bobinei exterioare este un strat de silicon, ceea ce face ca vârful să fie mai flexibil decât cel al SION, iar sarcina vârfului este de 0,5 gf*.

Structura de bază a părții distale a SION blue ES este aceeași cu cea a SION blue, iar sarcina vârfului este de 0,5 gf*, dar lungimea bobinei exterioare este mai scurtă și rigiditatea axei este mai mare. Structura internă nu conține un fir de siguranță în interior, dar designul distal al miezului conic al firului este conceput astfel încât partea proximală a firului de ghidaj să nu fie ușor de dislocat. Ca și în cazul SION blue, stratul de acoperire al SION blue ES este un strat de silicon în partea distală și un strat hidrofili în partea proximală, iar lungimea stratului de acoperire hidrofili este mai mare decât cea a SION blue.

SION black diferă de SION și de SION blue prin faptul că are un strat de acoperire din rășină poliuretanică pe bobina exterioră și un strat de acoperire hidrofili deasupra acesteia. Sarcina vârfului este de 0,8 gf*.

Structura de bază a SUOH 03 este aceeași cu cea a SION blue și SION blue ES, dar folosește o bobină exterioră realizată din frânghie, ceea ce duce la cea mai mică sarcină de vârf din seria SION, de 0,3 gf*. Suprafața distală este acoperită cu un strat de acoperire hidrofili de acoperire.

În toate seriile de fire de ghidaj PCI SION, partea proximală a miezului conic al firului este acoperită cu PTFE (politetrafluoroetilenă). Diametrul exterior nominal al produsului este de 0,36 mm (0,014 inci) pe întreaga lungime. La capătul proximal al dispozitivelor mai mici de 300 cm, există o conexiune pentru un fir de extensie, care este utilizat pentru a înlocui dispozitivul combinat; poate fi conectat firul de extensie de la ASAHI INTECC.

	Sarcina vârfului*	Diametrul exterior	Lungimea stratului de acoperire	Lungimea bobinei	Lungimea radioopacă
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Strat de acoperire hidrofili : 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Strat de acoperire din silicon : 1,5 cm Strat de acoperire hidrofili : 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Strat de acoperire din silicon : 2,5 cm Strat de acoperire hidrofili : 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Strat de acoperire din poliuretan: 20,0 cm Strat de acoperire hidrofili : 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Strat de acoperire hidrofili : 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indicații pentru utilizare

Acest fir de ghidaj este destinat intervenției coronariene percutanate (PCI) generale. Acest fir de ghidaj este destinat să faciliteze plasarea cateterelor de dilatare cu balon sau a altor dispozitive de intervenție terapeutică în cadrul sistemului cardiovascular. Durata medie de utilizare este preconizată a fi de 120 de minute.

Acest fir de ghidaj nu este destinat utilizării în sistemul neuro-vascular și în sistemul vascular periferic.

Populația țintă tratată

Seria de fire de ghidaj PCI SION este destinată pacienților care îndeplinesc indicațiile pentru proceduri de ICP. Nu este indicată pentru utilizare la nou-născuți, sugari sau copii, precum și la pacienții care sunt gravide, au funcția renală afectată și care au o reacție alergică la substanța de contrast sau la polietilenglicol (PEG).

Contraindicații

- Confirmați compatibilitatea diametrului firului de ghidaj cu alt dispozitiv de intervenție înainte de utilizarea efectivă.
- Nu folosiți firul de ghidaj la pacienții care au o reacție alergică la substanța de contrast sau care au funcția renală afectată.
- Acest fir de ghidaj conține PEG400 în stratul său de acoperire hidrofili. Nu utilizați firul de ghidaj la pacienții care au reacții alergice la polietilenglicol (PEG).
- Nu utilizați firul de ghidaj la pacientele gravide sau la pacientele care ar putea fi gravide (razele X pot afecta fătul).
- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat într-o instituție în care se poate efectua imediat intervenții chirurgicale de urgență. În cazul în care o intervenție chirurgicală de urgență nu este posibilă, în cel mai rău caz, pot apărea evenimente care pun viața în pericol.
- Acest fir de ghidaj este pre-sterilizat cu gaz de oxid de etilenă (EOG) și este destinat unei singure utilizări. A nu se reutiliza sau resteriliza. Dacă este reutilizat sau resterilizat, performanța sau calitatea acestui fir de ghidaj și a ambalajului poate fi compromisă și există riscul apariției unor complicații, inclusiv a unei infecții.

Avertismente

- Acest fir de ghidaj trebuie utilizat numai de către un medic care este pe deplin instruit în tratamentul pacienților supuși intervenției coronariene percutanate (PCI).
- Nu utilizați niciodată acest fir de ghidaj în combinație cu catetere care au părți metalice care pot intra în contact direct cu suprafața acestui fir de ghidaj (de exemplu, catetere de aterectomie, dilatare metalice), ace metalice sau inserții cu învelișuri plătate cu metal.
- În timpul utilizării firului de ghidaj, verificați și monitorizați mișcarea vârfului acestuia sub

- fluoroscopie. A nu se utiliza în zone ale vasului care nu sunt sau nu pot fi vizualizate.
- A nu se conecta acest fir de ghidaj cu fire de extensie detașabile produse de alți producători decât ASAHI INTECC. A nu se manevra acest fir de ghidaj în timp ce firul de extensie detașabil este conectat. În caz contrar, firul de ghidaj se poate deteriora sau firul de extensie detașabil se poate desprinde involuntar.
 - A nu se modifica acest fir de ghidaj pentru niciun motiv.

Precauții

- A nu se folosi firul de ghidaj după data de expirare indicată pe etichetă. Aruncați orice fir de ghidaj care depășește data de expirare.
- Firele de ghidaj sunt instrumente delicate și trebuie manevrate cu grijă.
- Dacă ambalajul este deschis sau deteriorat, nu folosiți firul de ghidaj. A nu se deschide ambalajul decât cu puțin timp înainte de utilizare. Folosiți o tehnică aseptică la manevrarea și utilizarea firului de ghidaj.
- Păstrați întotdeauna firul de ghidaj în stare umedă pentru a preveni deteriorarea stratului său de acoperire hidrofil.
- Nu ștergeți acest fir de ghidaj folosind o soluție organică, cum ar fi alcoolul.
- Luați măsuri de prevenire a infecțiilor după utilizare. Aruncați acest fir de ghidaj și ambalajul ca deșeu medical.
- Nu împingeți, nu trageți, nu retrageți și nu răsuciți niciodată acest fir de ghidaj care întâmpină rezistență. Răscirea sau împingerea acestui fir de ghidaj care întâmpină rezistență poate provoca deteriorarea și/sau separarea vârfului acestui fir de ghidaj sau deteriorarea directă a unui vas. În caz contrar, acest fir de ghidaj poate fi deteriorat. Determinați cauza rezistenței sub fluoroscopie și luați orice măsură de remediere necesară.
- Întotdeauna introduceți sau retrageți firele de ghidaj încet și cu atenție.
- Atunci când răsuciți acest fir de ghidaj în interiorul vasului de sânge, nu răsuciți în mod continuu în aceeași direcție. Atunci când răsuciți firul de ghidaj, rotiți-l alternativ în sensul acelor

- de ceasornic și în sens invers. Nu efectuați mai mult de două rotații (720°) în aceeași direcție.
- Spălați firul de ghidaj cu soluție salină heparinizată și sterilizată sau cu o altă soluție potrivită în timp ce îl scoateți și îl reintroduceți pentru a preveni pătrunderea aerului în dispozitivul de intervenție. Efectuați schimbarea acestui fir de ghidaj cu atenție pentru a preveni pătrunderea aerului și/sau traumatisme. Când reintroduceți firul de ghidaj, confirmați că vârful dispozitivului de intervenție nu este blocat în lumenul vasului și nu se sprijină pe peretele vasului. În caz contrar, se pot produce traumatisme. Utilizați marker-ul radioopac al dispozitivului de intervenție pentru a confirma poziția.
 - Mișcarea liberă a firului de ghidaj în cadrul dispozitivului de intervenție este o caracteristică importantă a unui sistem de fire de ghidaj dirijabile, deoarece oferă utilizatorului informații tactile valoroase. Testați sistemul pentru a detecta orice rezistență înainte de utilizare. Reglați sau înlocuiți valva hemostatică cu o valvă reglabilă dacă se constată că aceasta împiedică mișcarea firului de ghidaj.
 - Nu efectuați plasarea stentului folosind mai mult de un fir de ghidaj sau operația cu fire prin suportul stentului. În caz contrar, stentul poate fi deteriorat sau firul de ghidaj se poate rupe sau desprinde.
 - Înainte de utilizare, confirmați că acest fir de ghidaj este adecvat ca dimensiune și formă pentru procedură și este compatibil cu dispozitivul care urmează să fie utilizat în combinație.

- Consultați instrucțiunile de utilizare atașate dispozitivului medical (de exemplu, catetere de dilatare cu balon sau alte dispozitive de intervenție) care urmează să fie utilizate în combinație cu acest fir de ghidaj.
- Atunci când conectați firul de extensie detașabil cu acest fir de ghidaj, acesta trebuie să fie introdus în siguranță până la linia de demarcație dintre stratul de acoperire fără PTFE și stratul de acoperire cu PTFE de la capătul proximal al firului de ghidaj. În cazul în care se constată orice anomalie la conectare, întrerupeți imediat utilizarea firului de ghidaj.
- Inspectați cu atenție firul de ghidaj pentru a vedea dacă există îndoiri, noduri sau alte deteriorări înainte de utilizare și ori de câte ori este posibil în timpul procedurii. Nu utilizați firul de ghidaj dacă este deteriorat.
- Atunci când modelați vârful, aveți grijă să nu deteriorați bobina.
- Înainte de a introduce firul de ghidaj, verificați care este capătul distal și asigurați-vă că îl introduceți de la capătul distal.
- Asigurați o clătire continuă cu soluție salină între cateterul de ghidaj și dispozitivul de intervenție și între dispozitivul de intervenție și firul de ghidaj în timpul procedurii. Clătirea previne formarea substanței de contrast și/sau formarea de cheaguri pe firul de ghidaj și în lumenul cateterului.
- Pentru suportul cu tubul de protecție a capătului distal (consultați Modul de utilizare, Figura 1), nu îndepărtați sau introduceți tubul de protecție a capătului distal în timp ce firul de ghidaj este găzduit în suport.
- Pentru suportul cu tubul de protecție a capătului distal (consultați Modul de utilizare, Figura 1), îndepărtați tubul de protecție a capătului distal înainte de a găzdui din nou firul de ghidaj în suport.
- Acest dispozitiv conține următoarele substanțe definite ca CMR 1A/1B, care afectează sistemul endocrin într-o concentrație de peste 0,1 % din greutate; Cobalt: CAS Nr. 7440-48-4.

Defecțiuni și efecte adverse

Possibilele defecțiuni și efecte adverse cauzate de utilizarea acestui fir de ghidaj includ, dar nu se limitează la următoarele:

1. Defecțiuni

Imposibilitatea de a străbate o leziune	Ruperea sau îndoirea firului de ghidaj	Deteriorări, cum ar fi separarea
Dificultăți la îndepărtare	Desprinderea stratului de acoperire	Resturi de la un fir de ghidaj deteriorat

2. Efecte adverse

Deces	Infecții	Disecția vaselor
Perforarea vaselor	Complicații hemoragice	Embolie
Dezvoltarea trombilor	Infarct	Ischemie
Aritmie	Spasm vascular	Ocluzii vasculare
Scăderea tensiunii arteriale	Reacții alergice	

Mod de utilizare

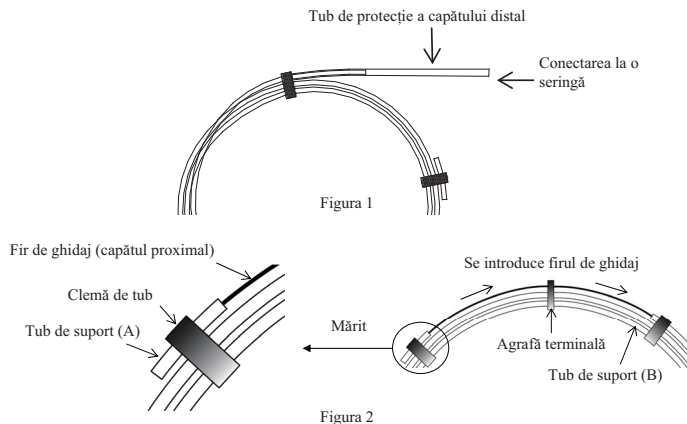
1. Inspectația înainte de utilizare
 - a) Înainte de utilizare, inspectați cu atenție și confirmați că firul de ghidaj și ambalajul nu sunt deteriorate.
 - b) Înainte de utilizare, asigurați-vă că firul de ghidaj este compatibil cu dispozitivele de intervenție care urmează să fie utilizate.
2. Pregătirea
 - a) Selectați cel mai potrivit fir de ghidaj pentru

zona afectată și îndepărtați tubul suport care conține firul de ghidaj din ambalajul steril.

- b) Umpleți tubul de suport cu soluție salină heparinizată și sterilizată cu ajutorul unei seringi pentru a îmbiba întregul dispozitiv. Rețineți că soluția salină heparinizată și sterilizată se poate vărsa din tubul de suport în acest moment. Pentru suportul prevăzut cu tub de protecție la capătul distal (Figura 1), o

seringă poate fi conectată la tubul de protecție distal.

- c) Umpleți lumenul dispozitivului de intervenție cu soluție salină heparinizată și sterilizată înainte de a introduce firul de ghidaj.
d) Eliberați firul de ghidaj din agrafa terminală și introduceți-l încet, împingeți capătul distal al firului de ghidaj prin tubul de suport (B) (Figura 2).



- e) Atunci când capătul distal al firului de ghidaj se extinde cu 5 până la 6 cm dincolo de celălalt capăt al tubului de suport (sau al tubului de protecție a capătului distal), dacă este necesar, modelați vârful în conformitate cu practica standard.

- f) Prindeți ușor firul de ghidaj care a ieșit din capătul distal al tubului de suport (sau al tubului de protecție a capătului distal), în punctul cât mai apropiat de tubul de suport și extrageți firul de ghidaj încet și cu grijă.
g) Dacă la scoaterea firului de ghidaj din tubul de suport se întâmpină rezistență, se injectează din nou soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport. Continuați să îndepărtați firul de ghidaj după ce nu mai întâmpinați rezistență. Asigurați-vă că injectați suficientă soluție salină heparinizată și sterilizată în tubul de suport, deoarece stratul de acoperire

hidrofil poate fi deteriorat atunci când îndepărtați cu forța firul de ghidaj căușuit.

- h) După ce ați extras firul de ghidaj din tubul de suport, inspectați-l pentru a vă asigura că nu este deteriorat.

3. Proceduri de inserție

■ Sistem cu cateter peste firul de ghidaj

- a) Introduceți cu grijă capătul distal al firului de ghidaj în lumenul firului de ghidaj al dispozitivului de intervenție.
b) Înaintați acest fir de ghidaj cu atenție până când vârful său este chiar în apropierea vârfului dispozitivului de intervenție.
c) Conectați cateterul de ghidaj și introduceți sistemul dispozitivului de intervenție (cu firul de ghidaj) în conectorul în Y.
d) Înaintați sistemul dispozitivului de intervenție prin cateterul de ghidaj până

când vârful sistemului cu fir de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.

- e) Strângeți valva hemostatică a conectorului în Y pentru a crea o etanșare în jurul dispozitivului de intervenție. Asigurați-vă că mișcarea firului de ghidaj este încă posibilă.
f) Verificați dacă firul de ghidaj se mișcă fără probleme.
g) Atașați dispozitivul de torsione la firul de ghidaj, dacă este necesar.
h) Înaintați acest fir de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.
i) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
j) Înaintați dispozitivul de intervenție până când se ajunge la leziune, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

■ Sistem de schimbare rapidă

- a) Conectați cateterul de ghidaj.
b) Inserați liderul firului de ghidaj în conectorul în Y al cateterului de ghidaj.
c) Introduceți cu grijă vârful firului de ghidaj

în lider.

- d) Înaintați firul de ghidaj prin cateterul de ghidaj sub fluoroscopie până când vârful firului de ghidaj este chiar în apropierea vârfului cateterului de ghidaj.
e) Atașați dispozitivul de torsione la firul de ghidaj, dacă este necesar.
f) Înaintați firul de ghidaj sub fluoroscopie pentru a străbate leziunea. Confirmați cu ajutorul angiografiei că firul de ghidaj a parcurs leziunea țintă îngustată.
g) Observați mișcarea firului de ghidaj în vase.
h) Îndepărtați dispozitivul de torsione a firului de ghidaj și liderul firului de ghidaj.
i) Urmăriți dispozitivul de intervenție peste firul de ghidaj, împiedicând în același timp mișcarea firului de ghidaj, și avansați până când se ajunge la leziune. Asigurați-vă că vârful distal al firului de ghidaj și locația acestuia în vas sunt vizibile în timpul manevrelor dispozitivului de intervenție.

4. Proceduri de schimbare a firului de ghidaj

- Sistem cu cateter peste firul de ghidaj
a) Îndepărtați încet acest fir de ghidaj în timp ce monitorizați mișcarea acestuia sub fluoroscopie.
b) Inserați următorul fir de ghidaj în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune "Instrucțiuni de utilizare".

Metoda de depozitare

Nu păstrați firul de ghidaj și ambalajul în stare îndoită și/sau în condiții de sarcini foarte mari. Acest fir de ghidaj și ambalajul trebuie păstrate departe de apă. Depozitați-le într-un loc răcoros, întunecat și uscat.

Data de expirare

Data de expirare este indicată pe eticheta ambalajului firului de ghidaj.

Conținut

5 bucăți / cutie

Clauza privind exonerarea de răspundere

În niciun caz „ASAHI INTECC CO., LTD. și companiile sale afiliate” (denumite în continuare „Compania”) nu vor fi răspunzătoare pentru accidente, vătămări corporale, reacții adverse datorate utilizării necorespunzătoare a produsului (produselor) sau oricărei alte utilizări neconforme cu aceste instrucțiuni. În niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune (i) care rezultă din depozitarea produsului (produselor) după expedierea de către Companie sau (ii) datorate selecției pacienților, tehnicilor chirurgicale sau oricăror alte activități medicale desfășurate de către instituția medicală care utilizează produsul (produsele).

„SION” și „SUOH” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale ASAHI INTECC CO., LTD. în Japonia și în alte țări.

*Valorile sarcinii vârfului reprezintă valorile medii ale valorilor specificațiilor produsului măsurate în conformitate cu metoda de testare a standardului intern, presupunând forța aplicată pe leziune de către vârful firului de ghidaj.

Vodilna žica PCI serije SION

Navodila za uporabo

Pred uporabo te vodilne žice natančno preberite ta navodila in upoštevajte razdelke Indikacije za uporabo, Kontraindikacije, Opozorila, Previdnostni ukrepi in Kako se uporablja v teh navodilih za uporabo. Če tega ne storite, lahko pride do zapletov, vključno z resnimi poškodbami bolnika ali smrtjo.

Če uporabnik in/ali bolnik izve za resen incident, ki se je zgodil v zvezi z vodilno žico, o tem obvesti proizvajalca in pristojni organ države članice.

Ta navodila za uporabo veljajo za vodilno žico PCI serije SION. Za podrobnosti (dolžina vodilne žice, dolžina radioopakega odseka itd.) glejte etiketo izdelka.

Opisi

Vodilna žica PCI serije SION je bila razvita kot vodilna žica z mehko konico za zmanjšanje tveganja vaskularne perforacije, ko jo držite v žili, saj lahko držanje vodilne žice s trdo konico v žili povzroči vaskularno perforacijo.

Osnovno strukturo SION sestavljajo zožena jedrna žica, dve vrsti distalnih tuljav (zunanje tuljave in notranje tuljave) in varnostna žica. Zožena jedrna žica, tuljave in varnostna žica so spajkani. Delna dolžina zunanje tuljave je radioopaka, tako da je njeno lego mogoče enostavno potrditi z radioskopijo. Serija SION ima prožno obremenitev konice 0,7 gf*, ki zagotavlja varnost v krvni žili. Notranja tuljava iz vrvi je nameščena znotraj zunanje tuljave, varnostna žica pa je pritrjena na notranjo tuljavo in konico, tako da se varnostna žica ne sname, tudi v malo verjetnem primeru, da se zožena jedrna žica odlepi od konice, kar preprečuje, da bi se zunanja tuljava in zožena jedrna žica sneli. Distalna stran serije SION je prevlečena s hidrofilnim polimerom.

Serija SION blue ima enako osnovno strukturo kot SION, vendar je del prevleke na zunanji konici tuljave silikonska prevleka, zaradi česar je konica bolj prožna kot pri SION, obremenitev konice pa je 0,5 gf*.

Osnovna struktura distalne strani serije SION blue ES je enaka kot pri SION blue in obremenitev konice je 0,5 gf*, vendar je dolžina zunanje tuljave krajša in togost grede je večja. Notranja struktura nima varnostne žice, vendar je distalna zasnova zožene jedrne žice zasnovana tako, da proksimalne strani vodilne žice ni zlahka premakniti. Tako kot pri seriji SION blue je prevleka pri SION blue ES silikonska prevleka na distalnem delu in hidrofilna na proksimalnem delu, dolžina hidrofilne prevleke pa je daljša kot pri SION blue.

Serija SION black se od SION in SION blue razlikuje po tem, da ima na zunanji tuljavi prevleko iz poliuretanske smole, poleg tega pa še hidrofilno prevleko. Obremenitev konice je 0,8 gf*.

Osnovna struktura SUOH 03 je enaka kot pri SION blue in SION blue ES, vendar uporablja zunanjo tuljavo iz vrvi, kar ima za posledico najnižjo obremenitev konice v seriji SION pri 0,3 gf*. Distalna površina je prevlečena s hidrofilno prevleko.

Pri vseh vodilnih žicah PCI serije SION je proksimalna stran zožene jedrne žice prevlečena s PTFE (politetrafluoroetilen). Nazivni zunanji premer izdelka je 0,36 mm (0,014 palca) po celotni dolžini. Na proksimalnem koncu pripomočka, ki je manjši od 300 cm, je priključek za podaljševalno žico, ki se uporablja za zamenjavo kombiniranega pripomočka. Priključite lahko podaljševalno žico ASAHI INTECC.

	Obremenitev konice*	Zunanji premer	Dolžina prevleke	Dolžina tuljave	Radioopaka dolžina
SION	0,7 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilna prevleka: 28,5 cm	28 cm	3 cm
SION blue	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonska prevleka : 1,5 cm Hidrofilna prevleka: 19,0 cm	20 cm	3 cm
SION blue ES	0,5 gf	0,36 mm (0,014")	Silikonska prevleka : 2,5 cm Hidrofilna prevleka: 39,5 cm	8,5 cm	3 cm
SION black	0,8 gf	0,36 mm (0,014")	Poliuretanska prevleka : 20,0 cm Hidrofilna prevleka: 40,0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0,3 gf	0,36 mm (0,014")	Hidrofilna prevleka: 52,0 cm	19 cm	3 cm

Indikacije za uporabo

Ta vodilna žica je namenjena splošnemu perkutnemu koronarnemu posegu (PCI). Ta vodilna žica je namenjena olajšanju namestitve balonskih dilatacijskih katetrov ali drugih interventnih terapevtskih pripomočkov v kardiovaskularni sistem. Pričakuje se, da bo povprečno trajanje uporabe 120 minut. **Ta vodilna žica ni namenjena uporabi v nevrovaskularnem sistemu in v perifernem vaskularnem sistemu.**

Ciljna zdravljena populacija

Vodilne žice PCI serije SION so namenjene bolnikom, ki izpolnjujejo indikacije za postopke s PCI. Ni indicirano za uporabo pri novorojenčkih, dojenčkih ali otrocih ter bolnicah, ki so noseče, bolnikih, ki imajo okvarjeno ledvično funkcijo in imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali polietilen glikol (PEG).

Kontraindikacije

- Pred dejansko uporabo potrdite združljivost premera vodilne žice z drugimi intervencijskimi pripomočki.
- Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijsko reakcijo na kontrastna sredstva ali pri tistih, ki imajo oslabiljeno delovanje ledvic.
- Ta vodilna žica vsebuje PEG400 v svoji hidrofilni prevleki. Vodilne žice ne uporabljajte pri bolnikih, ki imajo alergijske reakcije na polietilen glikol (PEG).
- Vodilne žice ne uporabljajte pri nosečih bolnicah ali bolnicah, ki bi lahko bile noseče (rentgensko slikanje lahko vpliva na plod).
- To vodilno žico je treba uporabiti v ustanovi, kjer je mogoče takoj izvesti nujni kirurški poseg. Če nujni kirurški poseg ni na voljo, lahko v najslabšem primeru pride do smrtno nevarnih dogodkov.
- Ta vodilna žica je predhodno sterilizirana s plinom etilen oksidom (EOG) in je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ponovno ali ponovno sterilizirajte. Pri ponovni uporabi ali ponovni sterilizaciji je lahko učinkovitost ali kakovost te vodilne žice in embalaže ogrožena in obstaja tveganje za zapletov, vključno z okužbo.

Opozorila

- To vodilno žico sme uporabljati le zdravnik, ki je v celoti usposobljen za zdravljenje PCI.
- Nikoli ne uporabljajte te vodilne žice v kombinaciji s katetri, ki imajo kovinske dele, ki bi lahko prišli neposredno v stik s površino te vodilne žice (npr. katetri za aterektomijo, kovinski dilatatorji), kovinskimi iglami ali uvajalniki iz kovinskega ovoja.
- Med uporabo vodilne žice preverite in spremljajte gibanje njene konice pod

fluoroskopijo. Ne uporabljajte na območjih žile, ki niso vidna ali jih ni mogoče videti.

- Te vodilne žice ne povežite s snemljivimi podaljševalnimi žicami, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki niso ASAHI INTECC. Ne manipulirajte s to vodilno žico, medtem ko je

snemljiva podaljševalna žica priključena. V nasprotnem primeru se lahko vodilna žica poškoduje ali pa se snemljiva podaljševalna žica nenamerno sname.

- Ne spreminjajte te vodilne žice iz kakršnega koli razloga.

Previdnostni ukrepi

- Vodilne žice ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na etiketi. Zavrzite vse vodilne žice, katerim je potekel rok uporabe.
- Vodilne žice so občutljivi instrumenti, zato je treba z njimi ravnati previdno.
- Vodilne žice ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Embalažo odprite šele tik pred uporabo. Pri rokovanju in uporabi vodilne žice uporabljajte aseptično tehniko.
- Vodilna žica naj bo vedno mokra, da preprečite poškodbe njene hidrofilne prevleke.
- Ne brišite te vodilne žice z organsko raztopino, kot je alkohol.
- Po uporabi izvajajte preventivne ukrepe proti okužbam. To vodilno žico in embalažo zavrzite kot medicinske odpadke.
- Te vodilne žice, ki naleti na upor, nikoli ne potiskajte, vlečite, izvlecite ali zasukajte. Vrtenje ali potiskanje te vodilne žice proti upor lahko povzroči poškodbe in/ali ločitev konice te vodilne žice ali neposredno poškodbo žile. Če tega ne storite, lahko poškodujete to vodilno žico. Ugotovite vzrok upora pod fluoroskopijo in izvedite vse potrebne popravne ukrepe.
- Vodilne žice vedno premikajte ali izvlecite počasi in previdno.
- Ko zasukate to vodilno žico znotraj krvne žile, je na vrtilne neprekinjeno v isto smer. Ko zasukate vodilno žico, jo izmenično vrtilne v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca. Ne zavrtite za več kot dva obrata (720°) v isto smer.
- Med odstranjevanjem in ponovnim uvajanjem vodilno žico sperite s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino ali drugo primerno raztopino, da preprečite vstop zraka v intervencijski pripomoček. Pazljivo zamenjajte to vodilno žico, da preprečite vstop zraka in/ali poškodbe. Pri ponovnem uvajanju vodilne žice se prepričajte, da je konica intervencijskega pripomočka prosta v lumnu žile in ni ob steni žile. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe. Uporabite radioopaki označevalec na intervencijskem pripomočku, da potrdite položaj.

- Prosto gibanje vodilne žice znotraj intervencijskega pripomočka je pomembna značilnost vodilnega sistema vodilne žice, saj daje uporabniku dragocene občutljive informacije. Pred uporabo preizkusite sistem glede kakršnega koli upora. Prilagodite ali zamenjajte ventil za hemostazo z nastavljenim ventilom, če ugotovite, da zavira gibanje vodilne žice.
- Ne izvajajte nameščanja stenta z uporabo več kot ene vodilne žice ali postopka z žico skozi opornik stenta. V nasprotnem primeru se lahko stent poškoduje ali pa se vodilna žica zlomi ali razpade.
- Pred uporabo se prepričajte, da je ta vodilna žica po velikosti in obliki primerna za postopek in je združljiva s pripomočkom, s katerim jo boste uporabljali.
- Glejte navodila za uporabo, ki so priložena medicinskemu pripomočku (npr. balonskim dilatacijskim katetrom ali drugim intervencijskim pripomočkom), ki ga želite uporabiti v kombinaciji s to vodilno žico.
- Pri povezovanju snemljive podaljševalne žice s to vodilno žico mora biti ta varno postavljena na mejno črto med prevleko brez PTFE in prevleko iz PTFE na proksimalnem koncu vodilne žice. Če opazite kakršno koli nepravilnost v povezavi, takoj prenehajte uporabljati vodilno žico.
- Pred uporabo in med postopkom, kadar koli je to mogoče, skrbno preglejte vodilno žico glede prepogjenosti, pregibov ali drugih poškodb. Ne uporabljajte vodilne žice, če je poškodovana.
- Pri oblikovanju konice pazite, da ne poškodujete tuljave.
- Pred uvajanjem vodilne žice, preverite, kateri konec je distalni konec, in poskrbite, da jo uvedete z distalnega konca.
- Med postopkom vzdržujte neprekinjeno izpiranje s fiziološko raztopino med vodilnim katetrom in intervencijskim pripomočkom ter med intervencijskim pripomočkom in vodilno žico. Izpiranje prepreči nastajanje kontrastnega

sredstva in/ali strjevanje na vodilni žici in v lumnu katetra.

- Pri držalu z zaščitno cevjo na distalnem koncu (glejte Kako se uporablja, slika 1) ne odstranjujte ali vstavljajte zaščitne cevke na distalnem koncu, dokler je vodilna žica nameščena v držalo.
- Pri držalu z zaščitno cevjo na distalnem koncu (glejte Kako se uporablja, slika 1) odstranite

zaščitno cevko na distalnem koncu, preden namestite vodilno žico v držalo.

- Ta pripomoček vsebuje naslednjo snov, opredeljeno kot CMR 1A/1B, in endokrini motilec v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso; kobalt: CAS št. 7440-48-4.

Motnje delovanja in neželeni učinki

Možne motnje delovanja in neželeni učinki zaradi uporabe te vodilne žice vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:

1. Motnje delovanja

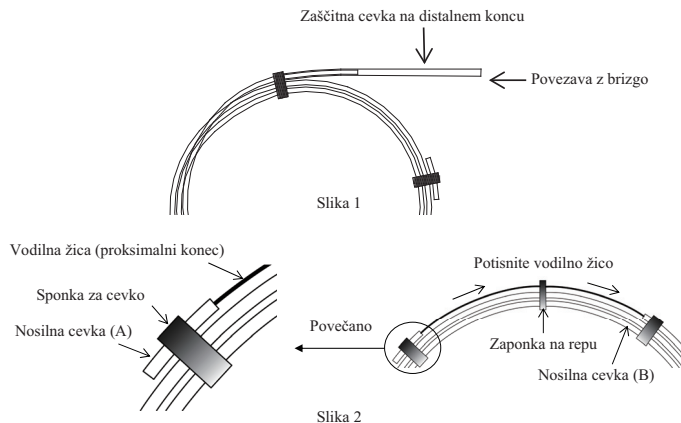
Nemožnost prehoda lezije	Zlom ali upogibanje vodilne žice	Poškodba kot je ločevanje
Težave pri odstranjevanju	Odstopanje prevleke	Ostanki poškodovane vodilne žice

2. Neželeni učinki

Smrt	Okužba	Disekcija žil
Perforacija žil	Zapleti krvavenja	Embolija
Strdek	Infarkt	Ishemija
Aritmija	Vazospazem	Vaskularna okluzija
Znižanje krvnega tlaka	Alergijska reakcija	

Kako se uporablja

1. Pregled pred uporabo
 - a) Pred uporabo natančno preglejte in se prepričajte, da sta vodilna žica in embalaža nepoškodovani.
 - b) Pred uporabo preverite, če je vodilna žica združljiva z intervencijskimi pripomočki, ki jih boste uporabili.
2. Priprava
 - a) Izberite najprimernejšo vodilno žico za prizadeto območje in odstranite nosilno cevko, ki vsebuje vodilno žico iz sterilnega ovoja.
 - b) Z brizgo napolnite nosilno cevko s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino, da namočite celotni pripomoček. Upoštevajte, da se lahko heparinizirana in sterilizirana fiziološka raztopina v tem času razlije iz nosilne cevke. Za držalo z zaščitno cevko distalnega konca (slika 1) se lahko na zaščitno cevko distalnega konca priključi brizga.
 - c) Preden vstavite vodilno žico, napolnite lumen intervencijskega pripomočka s heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino.
 - d) Sprostite vodilno žico iz zaponke na repu in počasi potisnite vodilno žico, potisnite distalni konec vodilne žice skozi nosilno cevko (B) (Slika 2).



- e) Ko je distalni konec vodilne žice podaljšán 5 do 6 cm čez drugi konec nosilne cevke (ali čez zaščitno cevko na distalnem koncu), po potrebi oblikujte konico v skladu s standardno prakso.
- f) Vodilno žico, ki je izšla iz distalnega konca nosilne cevke na distalnem koncu (ali zaščitne cevke na distalnem koncu), nežno primate na mestu, ki je čim bližje nosilni cevki, in počasi in previdno izvlecite vodilno žico.
- g) Če pri odstranjevanju vodilne žice iz nosilne cevke začutite upor, ponovno vbrizgajte heparinizirano in sterilizirano fiziološko raztopino v nosilno cevko. Nadaljujte z odstranjevanjem vodilne žice, ko ni več čutiti upora. Prepričajte se, da ste v nosilno cevko vbrizgali dovolj heparinizirane in sterilizirane fiziološke raztopine, ker se lahko hidrofilna prevleka poškoduje, ko na silo odstranite prevlečeno vodilno žico.
- h) Ko vodilno žico izvlečete iz nosilne cevke, jo pregledajte, da se prepričate, da ni poškodovana.

3. Postopki za uvajanje

■ Sistem preko žice

- a) Distalni konec vodilne žice previdno uvajajte v lumen vodilne žice intervencijskega pripomočka.
- b) Previdno pomaknite to vodilno žico, dokler

ni njena konica tik proksimalno od konice intervencijskega pripomočka.

- c) Vstavite vodilni kateter in uvedite sistem intervencijskega pripomočka (z vodilno žico) v priključek Y.
- d) Pomaknite sistem intervencijskega pripomočka skozi vodilni kateter, dokler konica sistema vodilne žice ni tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- e) Zategnite ventil za hemostazo priključka Y, da ustvarite tesnjenje okoli intervencijskega pripomočka. Prepričajte se, da je premikanje vodilne žice še dovoljeno.
- f) Preverite, če se vodilna žica premika gladko.
- g) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- h) Pomaknite to vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- i) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.
- j) Pomaknite intervencijski pripomoček naprej, dokler ne dosežete lezije, pri tem pa preprečite premikanje vodilne žice. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim

pripomočkom.

■ Sistem hitre menjave

- a) Vstavite vodilni kateter.
- b) Uvajalnik vodilne žice vstavite v priključek Y vodilnega katetra.
- c) Konico vodilne žice previdno vstavite v uvajalnik.
- d) Pomaknite vodilno žico skozi vodilni kateter pod fluoroskopijo, dokler ni konica vodilne žice tik proksimalno od konice vodilnega katetra.
- e) Po potrebi pritrdite navorno napravo na vodilno žico.
- f) Pomaknite vodilno žico pod fluoroskopijo, da gre skozi lezijo. Z angiografijo potrdite, da je vodilna žica prešla skozi zoženo ciljno lezijo.
- g) Opazujte gibanje vodilne žice v žilah.

h) Odstranite navorno napravo vodilne žice in uvajalnik vodilne žice.

- i) Sledite intervencijskemu pripomočku preko vodilne žice, medtem ko preprečujete premikanje vodilne žice, in pomikajte, dokler ne dosežete lezije. Zagotovite, da sta distalna konica vodilne žice in njena lokacija v žili vidni med manipulacijami z intervencijskim pripomočkom.

4. Postopki za zamenjavo vodilne žice

■ Sistem preko žice

- a) Počasi odstranite to vodilno žico, medtem ko spremljate gibanje te vodilne žice pod fluoroskopijo.
- b) Uvedite naslednjo vodilno žico v skladu z navodili v tem razdelku »Kako se uporablja«.

Način shranjevanja

Vodilne žice in embalaže ne hranite v upognjenem in/ali močno obremenjenem stanju. Ta vodilna žica in embalaža ne smeta biti v vodi. Hraniti v hladnem, temnem in suhem prostoru.

Rok uporabnosti

Rok uporabnosti je naveden na etiketi embalaže vodilne žice.

Vsebina

5 kosov/škatla

Zavrnitev odgovornosti

Podjetje „ASAHI INTECC CO., LTD. in njegova pridružena podjetja“ (v nadaljevanju „podjetje“) ne odgovarjajo za nesreče, telesne poškodbe, neželene učinke zaradi kakršne koli nepravilne uporabe izdelka(-ov) ali katere koli druge uporabe, ki ni v skladu s temi navodili. Podjetje v nobenem primeru ni odgovorno za kakršno koli škodo bodisi (i) zaradi shranjevanja izdelka(-ov) po odpremi iz podjetja bodisi (ii) zaradi izbire bolnikov, kirurških tehnik ali katere koli druge zdravstvene dejavnosti s strani zdravstvene ustanove, ki uporablja izdelek(-e).

„SION“ in „SUOH“ sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja ASAHI INTECC CO., LTD. na Japonskem ali v drugih državah.

*Vrednosti obremenitve konice predstavljajo povprečne vrednosti od vrednosti specifikacije izdelka, izmerjene v skladu z interno standardno preskusno metodo, ob predpostavki sile, ki deluje na lezijo s konico vodilne žice.

Wajer Gwida PCI serje SION

Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra dawn l-istruzzjonijiet b'attenzjoni qabel ma tuża dan il-wajer gwida u osserva t-taqsimiet Indikazzjonijiet għall-Użu, Kontraindikazzjonijiet, Twissijiet, Prekawzjonijiet, u Kif Tuża l-Prodott f'dawn l-Istruzzjonijiet għall-użu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta f'kumplikazzjonijiet, inkluż korrimtent serju għall-pazjent jew mewt.

Jekk utent u/jew pazjent isir jaf dwar incident serju li sehħ b'rabta mal-wajer gwida, dan għandu jirrapporta l-fatt lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membra.

Dawn l-Istruzzjonijiet għall-Użu japplikaw għall-Wajer Gwida PCI serje SION. Għal dettalji (tul tal-wajer gwida, tul tas-sezzjoni radjopaka, eċċ.), irreferi għat-tikketta tal-prodott.

Deskrizzjonijiet

Il-Wajer Gwida PCI serje SION ġie żviluppat bħala wajer gwida b'ponta ratba biex inaqqs ir-riskju ta' perforazzjoni vaskulari meta jinżamm f'vażu, billi z-żamma ta' wajer gwida b'ponta iebes f'vażu tista' twassal għal perforazzjoni vaskulari.

L-istruttura bażika ta' SION tikkonsisti minn wajer bil-qalba ġej għall-ponta, żewġ tipi ta' kojls distali (kojl ta' barra u kojl ta' ġewwa) u wajer tas-sikurezza. Il-wajer bil-qalba ġej għall-ponta, il-kojls u l-wajer tas-sikurezza huma sldajti. Ammont parzjali tal-kojl ta' barra huwa radjopak halli l-pożizzjoni tiegħu tkun tista' tiġi kkonfermata faċilment bir-radjokopija. SION għandu tagħbija flessibbli fil-ponta ta' 0.7 gF* biex tiġi żgurata s-sikurezza fil-vażu. Fil-kojl ta' barra jitqiegħed kojl ta' ġewwa tal-habel, u l-wajer tas-sikurezza jitwahhal mal-kojl ta' ġewwa u l-ponta b'tali mod li l-wajer tas-sikurezza ma jinqalax, anki fil-każ improbabbli li l-wajer bil-qalba ġej għall-ponta jinqala' minn mal-ponta, halli jiġi evitat li l-kojl ta' barra u l-wajer bil-qalba ġej għall-ponta ma jinqalgħux. In-naha distali ta' SION hija miksija b'polimeru idrofiliċu.

Is-SION blu għandu l-istess struttura bażika bħal SION, imma parti mill-kisi fuq il-ponta tal-kojl ta' barra huwa kisi tas-silikon, li jagħmel il-ponta aktar flessibbli minn dik ta' SION, u t-tagħbija fuq il-ponta hija ta' 0.5 gF*.

L-istruttura bażika tan-naha distali ta' SION blu ES hija l-istess bħal dik ta' SION blu u t-tagħbija fuq il-ponta hija ta' 0.5 gF*, iżda l-kojl ta' barra hija iqsar u x-xaft huwa aktar riġidu. L-istruttura interna ma fihix wajer tas-sikurezza, imma d-disinn distali tal-wajer bil-qalba ġej għall-ponta huwa mfassal b'tali mod li n-naha prossimali tal-wajer gwida ma tiċcaqlaqx minn postha faċilment. Bħal fil-każ ta' SION blu, il-kisi ta' SION blu ES huw kisi tas-silikon fin-naha distali u kisi idrofiliċu fin-naha prossimali, u l-kisi idrofiliċu huwa itwal minn dak ta' SION blu.

Is-SION iswed huwa differenti minn SION u SION blu peress li għandu kisi ta' reżina tal-poliuretan fuq il-kojl ta' barra, u kisi idrofiliċu fuqu. It-tagħbija fuq il-ponta hija ta' 0.8 gF*.

L-istruttura bażika ta' SUOH 03 hija l-istess bħal dawk ta' SION blu u SION blu ES, imma tuża kojl ta' barra magħmul mill-habel, li jwassal għall-aktar tagħbija fuq il-ponta baxxa fis-serje SION, dik ta' 0.3 gF*. Il-wieċ distali huwa miksì b'kisi idrofiliċu.

Fil-Wajer Gwida PCI serje SION, in-naha prossimali tal-wajer bil-qalba ġej għall-ponta hija miksija bil-PTFE (politetrafluworoeċilen). Id-dijametru nominali ta' barra tal-prodott huwa ta' 0.36 mm (0.014 pulzier) fuq it-tul shh. Fit-tarj prossimali tal-apparat iqsar minn 300 cm, hemm konnessjoni għal wajer ta'

estensjoni, li jintuża biex jissostitwixxi l-apparat ikkombinat; il-Wajer ta' Estensjoni ta' ASAHI INTECC jista' jiġi konness.

	Tagħbija fuq il-Ponta*	Dijametru ta' Barra	Tul tal-Kisi	Tul tal-Kojl	Tul Radjopak
SION	0.7 gf	0.36 mm (0.014")	Kisi idrofiliċu: 28.5 cm	28 cm	3 cm
SION blu	0.5 gf	0.36 mm (0.014")	Kisi tas-silikon : 1.5 cm Kisi idrofiliċu: 19.0 cm	20 cm	3 cm
SION blu ES	0.5 gf	0.36 mm (0.014")	Kisi tas-silikon: 2.5 cm Kisi idrofiliċu: 39.5 cm	8.5 cm	3 cm
SION iswed	0.8 gf	0.36 mm (0.014")	Kisi tal-poliuretan: 20.0 cm Kisi idrofiliċu: 40.0 cm	12 cm	3 cm
SUOH 03	0.3 gf	0.36 mm (0.014")	Kisi idrofiliċu: 52.0 cm	19 cm	3 cm

Indikazzjonijiet għall-użu

Dan il-wajer gwida huwa mahsub għal interventi koronarji perkutanji (PCI) ġenerali. Dan il-wajer gwida huwa mahsub biex jiffaċilita t-tqegħid tal-kateters tad-dilatazzjoni bil-bużzieqa jew ta' apparat iehor ta' intervent terapeutiku fil-kardjovaskulatura. It-tul medju tal-użu huwa mistenni li jkun 120 minuta.

Dan il-wajer gwida ma huwiex mahsub għall-użu fin-newrovaskulatura u fil-vaskulatura periferika.

Popolazzjoni Ttrattata fil-Mira

Il-Wajer Gwida PCI serje SION huwa mahsub għal pazjenti li jissodisfaw l-indikazzjonijiet għall-proċeduri ta' PCI. Mhuwiex indikat għall-użu fi trabi tat-twelid, tfal żgħar, jew tfal kif ukoll f'pazjenti tqal, b'insuffiċjenza renali, u b'reazzjoni allergika għal aġent ta' kuntrast jew għall-polietilenglikol (PEG).

Kontraindikazzjonijiet

- Ikkonferma l-kompatibbiltà tad-dijametru tal-wajer gwida ma' apparati ta' intervent oħrajn qabel l-użu proprju.
- Tużax il-wajer gwida f'pazjenti b'reazzjoni allergika għal aġenti ta' kuntrast jew li għandhom insuffiċjenza renali.
- Dan il-wajer gwida fih PEG400 fil-kisi idrofiliċu tiegħu. Tużax il-wajer gwida f'pazjenti b'reazzjoni allergika għall-polietilenglikol (PEG).
- Tużax il-wajer gwida għal pazjenti tqal jew pazjenti li jistgħu jkunu tqal (ir-raġġi X jistgħu jaffettwaw lill-fetu).
- Dan il-wajer gwida għandu jintuża f'istituzzjoni fejn tista' titwettaq operazzjoni kirurġika ta' emerġenza minnufih. Jekk operazzjoni kirurġika ta' emerġenza ma tkunx disponibbli, fl-aġhar xenarju possibbli, jistgħu jsehhu avvenimenti li jheddu l-hajja.
- Dan il-wajer gwida huwa sterilizzat minn qabel bil-gass tal-ossidu etilen (EOG) u huwa mahsub biex jintuża darba biss. Terġax tuża jew tisterilizza mill-ġdid. Jekk jintuża iktar minn darba jew ikun sterilizzat mill-ġdid, il-prestazzjoni jew il-kwalità ta' dan il-wajer gwida jistgħu jiġu kompromessi u hemm riskju ta' kumplikazzjonijiet, inkluża l-infezzjoni.

Twissijiet

- Dan il-wajer gwida għandu jintuża biss minn tabib li huwa kompletament inharreġ fit-trattament PCI.
- Qatt tuża dan il-wajer gwida flimkien ma' kateters b'partijiet tal-metall li jistgħu jiġu f'kuntatt dirett mal-wieċ ta' dan il-wajer gwida (eż. kateters tal-aterettomija, dilators tal-metall)),

- labar tal-metall jew apparat tal-metall għall-inserzjoni tal-ghantijiet.
- Waqt l-użu tal-wajer gwida, ivverifika u ssorvelja l-moviment tal-ponta tiegħu permezz tal-fluoroskopija. Tuzax f'żoni ta' važi li ma humiex jew ma jistgħux jiġu viżwalizzati.
- Tikkonnettjax dan il-wajer gwida ma' wajers ta' estensjoni li jinqalghu prodotti minn manifatturi

Prekawzjonijiet

- Tuzax il-wajer gwida wara d-data ta' skadenza indikata fuq it-tikkett. Armi kwalunkwe wajer gwida li jaqbeż din id-data ta' skadenza.
- Il-wajers gwida huma strumenti delikati u għandhom jiġu mmanigġjati b'attenzjoni.
- Jekk il-pakkett ikun miftuħ jew dannegġat, tuzax il-wajer gwida. Iflah il-pakkett biss eżatt qabel l-użu. Uża teknika asettika għall-immaniġġjar u l-użu tal-wajer gwida.
- Dejjem zomm il-wajer gwida fi stat imxarrab biex tipprevjeni l-hsara għall-kisi idrofiliġu tiegħu.
- Timsahx dan il-wajer gwida b'soluzzjoni organika bħall-alkohol.
- Hu miżuri preventivi kontra l-infezzjoni wara l-użu. Armi dan il-wajer gwida u l-pakkett mal-iskart mediku.
- Qatt timbotta, tittrapan, tiġbej jew iddawwar dan il-wajer gwida jekk issib reżistenza. It-tidwir jew l-imbottar ta' dan il-wajer gwida meta juri reżistenza jista' jikkawża hsara u/jew is-separazzjoni tal-ponta ta' dan il-wajer gwida jew hsara diretta lil važu. Jekk dan ma jsirx, tista' ssir hsara lil dan il-wajer gwida. Iddetermina l-kawża tar-reżistenza bl-użu tal-fluoroskopija u hu kwalunkwe azzjoni rimedjali meħtieġa.
- Dejjem mexxi l-wajers gwida 'l quddiem jew lura bil-mod u b'attenzjoni.
- Meta ddawwar dan il-wajer gwida ġewwa l-važu, iddawwarx kontinwament fl-istess direzzjoni. Meta ddawwar il-wajer gwida, alterna bejn tidwir skont l-arloġġ u kontra l-arloġġ. Iddawwarx aktar minn żewġ rotazzjonijiet (720°) fl-istess direzzjoni.
- Naddaf il-wajer gwida b'soluzzjoni salina jew soluzzjoni xierqa oħra eparinizzata u sterilizzata waqt li tnehhix u terġa' ddaħlu sabiex tipprevjeni milli tidhol l-arja fl-apparat ta' intervent. Skambja dan il-wajer gwida b'attenzjoni biex tipprevjeni dħul tal-arja u/jew trauma. Meta tintroduċi l-wajer gwida mill-ġdid, ikkonferma li l-ponta tal-apparat ta'

- ghajr ASAHI INTECC. Timmanipulax dan il-wajer gwida waqt li jkun konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala'. Jekk le, il-wajer gwida jista' jsirli l-hsara, jew il-wajer ta' estensjoni li jinqala' jista' jinqala' involontarjament.
- Timmodifikax dan il-wajer gwida għall-ebda raġuni.

- intervent huwa hieles ġewwa l-lumen tal-važu u li mhux qed imiss mal-ġenb tal-važu. Jekk dan ma jsirx, jista' jirriżulta fi trauma. Uża l-markatur radjopak tal-apparat ta' intervent biex tikkonferma l-pożizzjoni.
- Il-moviment hieles tal-wajer gwida fl-apparat ta' intervent huwa karatteristika importanti ta' sistema ta' wajer gwida orjentabbli għaliex jagħti lill-utent informazzjoni tattili ta' valur. Ittestja s-sistema għal kwalunkwe reżistenza qabel l-użu. Aġġusta jew issostitwixxi l-valvola emostatika b'valvola aġġustabbli jekk tinsab li tostakola l-moviment tal-wajer gwida.
- Tqeghidx stent bl-użu ta' aktar minn wajer gwida wiehej jew operazzjoni ta' wajer wahda bl-użu ta' stent strut. Jekk le, tista' ssir hsara lill-istent jew il-wajer gwida jista' jtkisser jew jiffrax.
- Qabel l-użu, ikkonferma li dan il-wajer gwida huwa ta' daqs u forma xierqa għall-proċedura u li huwa kompatibbli mal-apparat li għandu jintuza flimkien miegħu.
- Irreferi għall-Istruzzjonijiet għall-Użu meħmużin mal-apparat mediku (eż. kateters tad-dilatazzjoni b'bużżeġa jew apparati ta' intervent oħrajn) li għandu jintuza flimkien ma' dan il-wajer gwida.
- Meta jiġi konness il-wajer ta' estensjoni li jinqala' ma' dan il-wajer gwida, għandu jiddaħhal b'mod sikur fil-linja konfinali bejn il-kisi mhux tal-PTFE u l-kisi tal-PTFE fit-tarf prossimali tal-wajer gwida. Jekk tinstab xi anomalija fil-konnessjoni, waqqaf l-użu tal-wajer gwida minnufih.
- Spezzjona l-wajer gwida b'attenzjoni għal liwi, għoġiedi jew hsara oħra qabel l-użu u meta possibbli waqt il-proċedura. Tuzax il-wajer gwida jekk ikun dannegġat.
- Meta tiffirma l-ponta, oqgħod attent li ma tagħmilx hsara lill-kojl.
- Qabel ma ddaħhal il-wajer gwida, ivverifika liema tarf huwa t-tarf distali u kun cert li ddaħhli mit-tarf distali.

- Żomm fluss tas-salina bejn il-kateter ta' gwida u l-apparat ta' intervent, u bejn l-apparat ta' intervent u l-wajer gwida waqt il-proċedura. Il-fluss jipprevjeni l-formazzjoni ta' aġent ta' kuntrast radjografiku u/jew il-koagulazzjoni fuq il-wajer gwida u fil-lumen tal-kateter.
- Għad-detentur bit-tubu protettur tat-tarf distali (irreferi għal Kif Tuża l-Prodott, Figura 1), la għandek tneħhi u lanqas iddaħhal it-tubu

- protettur tat-tarf distali waqt li l-wajer gwida jkun fid-detentur.
- Għad-detentur bit-tubu protettur tat-tarf distali (irreferi għal Kif Tuża l-Prodott, Figura 1), neħhi t-tubu protettur tat-tarf distali qabel ma terġa' tpoġġi l-wajer gwida fid-detentur.
- Dan l-apparat fih is-sustanza li ġeġja definita bħala CMR 1A/1B u sustanza li tfixxkel is-sistema endokrinali f'konċentrazzjoni ta' aktar minn 0.1 % skont il-piż; Kobalt: Nru tas-CAS 7440-48-4.

Hsarat u Avvenimenti Avversi

Il-hsarat u l-avvenimenti avversi possibbli mill-użu ta' dan il-wajer gwida jinkludu, iżda ma humiex limitati għal dan li ġej:

1. Hsarat

Nuqqas ta' tislib ta' leżjoni	Ksur jew liwi tal-wajer gwida	Hsara bħal separazzjoni
Diffikultà fit-tneħħija	Tneħħija tal-kisi	Debris minn wajer gwida bil-hsara

2. Avvenimenti avversi

Mewt	Infezzjoni	Dissezzjoni tal-važu
Perforazzjoni tal-važu	Kumplikazzjonijiet ta' emorraġġja	Embolizmu
Trombożi	Infart	Iskemija
Arritmija	Važospazmu	Okkluzjoni vaskulari
Pressjoni baxxa	Reazzjoni allergika	

Kif Tuża l-prodott

1. Spezzjoni qabel l-użu

- a) Qabel l-użu, spezzjona b'attenzjoni u kkonferma li ma hemmx hsara fil-wajer gwida u fil-pakkett.
- b) Qabel l-użu, ikkonferma li l-wajer gwida huwa kompatibbli mal-apparati ta' intervent li għandhom jintużaw.

2. Preparazzjoni

- a) Aghżel l-aktar wajer gwida xieraq għaž-żona affettwata u neħhi t-tubu detentur li fih il-wajer gwida mill-pakkett sterili.
- b) Imla t-tubu detentur b'salina eparinizzata u sterilizzata bl-użu ta' siringa biex ixarrab l-apparat shiħ. Innota li s-salina eparinizzata u sterilizzata tista' tfur mit-tubu detentur f'dan il-mument. Għad-detentur bit-tubu għall-protezzjoni tat-tarf distali (Figura 1), tista' titqabbad siringa mat-tubu għall-protezzjoni tat-tarf distali.

- c) Imla l-lumen tal-apparat ta' intervent bis-salina eparinizzata u sterilizzata qabel ma ddaħhal il-wajer gwida.
- d) Neħhi l-wajer gwida mill-klipp tat-tarf u żerżaq il-wajer gwida bil-mod, imbotta t-tarf distali tal-wajer gwida minn ġot-tubu detentur (B) (Figura 2).

a) Dahhal it-tarf distali tal-wajer gwida
b'attenzjoni fil-lumen tal-wajer gwida tal-
apparat ta' intervent.

j) Mexxi l-apparat ta' intervent 'il quddiem sakemm tinklehaq il-leżjoni filwaqt li

f) Mexxi l-wajer gwida 'l quddiem bl-użu tal-fluworoskopija biex jgħaddi minn goll-eżjoni. Ikkonferma bl-użu tal-aŋgjografija li l-wajer gwida ikun għadda mil-leżjoni

gwiđa milli jimxi, u mexxi 'l quddiem sakemm tintlehaq il-leżjoni. Kun ċert li l-ponta distali tal-wajer gwiđa u l-pożizzjoni tagħha fil-vażu jkunu viżibbli waqt il-manipulazzjonijiet tal-apparat ta' intervent.

b) Dahhal il-wajer gwida li jmiss skont id-direzzjonijiet fit-taqsima "Kif Tuza l-Prodott".

*Il-valuri tat-tagħbija fuq il-ponta jirrappreżentaw il-valuri medji tal-valuri tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott imkejla skont il-metodu tal-ittestjar intern standard fejn tiġi preżunta l-forza applikata lil-leżjoni mill-ponta tal-wajer gwida.



ASAHI INTECC CO.,LTD.

3-100 Akatsuki-cho, Seto, Aichi 489-0071 JAPAN



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands

Basic UDI-DI:4547327BGW011N8
<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>



<https://medical.asahi-intecc.com/en>

©2024 ASAHI INTECC CO., LTD.
2026-01-23 (2nd edition)